

BỆNH CHỐC

(Impetigo)

1. ĐẠI CƯƠNG

1.1. Khái niệm

Chốc là bệnh lý nhiễm trùng nông cấp tính trên da rất phổ biến, đặc trưng bởi tổn thương cơ bản là các bọt nước nông, rải rác, nhanh chóng hoá mủ, dập vỡ đóng vảy tiết. Bệnh có thể gây các biến chứng tại chỗ và toàn thân nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.

1.2. Dịch tễ

- Chốc là bệnh da nhiễm khuẩn thường gặp ở trẻ em.
- Yếu tố thuận lợi thường gặp là tuổi nhỏ, thời tiết nóng ẩm, mùa hè, điều kiện vệ sinh kém, bệnh da phối hợp như chấy rận, ghẻ, côn trùng cắn, viêm da cơ địa... hoặc suy giảm miễn dịch hay đang sử dụng các thuốc ức chế miễn dịch.

1.3. Căn nguyên/Cơ chế bệnh sinh

Do tụ cầu vàng, liên cầu hoặc phối hợp cả hai.

2. CHẨN ĐOÁN

2.1. Triệu chứng lâm sàng

- Chốc được phân thành 2 nhóm chính: Chốc không có bọt nước và chốc bọt nước
- + Chốc không có bọt nước: tổn thương ban đầu là các sẩn đỏ, tiến triển thành mụn nước nhỏ hóa mủ nhanh hoặc mụn mủ nhỏ, nhanh chóng dập vỡ đóng vảy tiết màu vàng mật ong, nền đỏ ửng. Tổn thương thường xuất hiện quanh các hốc tự nhiên (mắt, mũi, miệng...) và các chi, có xu hướng lan nên thường có nhiều tổn thương, có thể liên kết với nhau thành mảng lớn.
- + Chốc bọt nước: tổn thương ban đầu là bọt nước nông, nhăn nheo, chứa dịch vàng trong. Khi dập vỡ để lại viền vảy xung quanh dát đỏ ửng nhưng không có vảy tiết, sau đó chuyển sang màu nâu bóng hoặc màu da. Tổn thương thường xuất hiện ở mặt, chi, thân mình, nách và xung quanh vùng hậu môn của trẻ sơ sinh.
- Chốc loét: ban đầu là chốc thông thường, nếu không được điều trị bọt nước lan rộng, sau khi vỡ để lại vết loét sâu xuống trung bì với dấu hiệu “đục lỗ” (“punched-out” trên phủ vảy tiết màu vàng xám bẩn, bờ rần, gờ cao, màu tím, hay gặp ở chi dưới. Nếu không điều trị, loét có thể rộng trên 2-3cm, tổn thương lâu lành, để lại sẹo xấu.
- Tổn thương phối hợp khác như: viêm bờ mi, chốc mép hoặc viêm cầu thận nhất là ở trẻ em nhưng tiên lượng lành tính.

- Trường hợp nặng có thể kèm theo sốt, nổi hạch bạch huyết vùng, tiêu chảy, mệt mỏi, kém ăn.

- Tiến triển: các bọt nước lành sau 1-2 tuần, nhưng bệnh có thể dai dẳng do tự lây truyền, vệ sinh kém. Bệnh có thể tiến triển thành viêm mô bào, viêm bạch mạch, viêm mũ hạch bạch huyết, nhiễm khuẩn huyết, viêm phổi do tụ cầu nếu không được điều trị gì.

2.2. Cận lâm sàng

- Xét nghiệm đánh giá tình trạng viêm: bạch cầu, máu lắng, CRP, procalcitonin có thể tăng.

- Xét nghiệm tế bào Tzanck: có thể có tế bào gai lệch hình, nhiều bạch cầu đa nhân trung tính.

- Nhuộm Gram dịch hoặc mũ tại tổn thương thấy cầu khuẩn gram dương xếp thành chuỗi hoặc từng đám, kèm theo là bạch cầu đa nhân trung tính.

- Nuôi cấy dịch hoặc mũ xác định chủng gây bệnh, làm kháng sinh đồ giúp điều trị những trường hợp khó.

2.3. Chẩn đoán xác định

Chủ yếu dựa vào triệu chứng lâm sàng.

2.4. Chẩn đoán phân biệt

- Nấm da
- Thủy đậu
- Herpes simplex
- Hội chứng bong vảy da do tụ cầu
- Bệnh zona
- Pemphigus vulgaris
- Pemphigoid

3. ĐIỀU TRỊ

3.1. Nguyên tắc

- Kết hợp thuốc điều trị tại chỗ và toàn thân.
- Chống ngứa: tránh tự lây truyền.
- Điều trị biến chứng nếu có.

3.2. Điều trị cụ thể

3.2.1. Điều trị tại chỗ

- Ngâm tắm ngày một lần bằng nước thuốc tím loãng 1/10.000 hoặc các dung dịch sát khuẩn khác.
- Bọng nước, bọng mủ: tắm gạc đắp dung dịch Jarish vào tổn thương ngày 2 lần sáng tối, mỗi lần trong 30 phút.
- Trường hợp nhiều vảy tiết: đắp nước muối sinh lý 9‰, dung dịch Jarish hoặc gạc mỡ vaselin lên tổn thương, đắp liên tục đến khi bong hết vảy.
- Kháng sinh tại chỗ: mupirocin, acid fusidic hoặc retapamulin bôi ngày 2 lần sáng – tối tại tổn thương, thường dùng trong 7 ngày.

3.2.2. Điều trị toàn thân

- Kháng sinh:

+ Chỉ định khi tổn thương nhiều, lan tỏa: lựa chọn một trong các phác đồ sau:

Kháng sinh	Liều lượng	
	Người lớn	Trẻ em
Cephalexin	Uống 250mg/lần x 4 lần/ ngày	Uống 25 mg/kg/ngày chia 4 lần
Dicloxacillin	Uống 500mg/lần x 4 lần/ ngày	Uống 25-50 mg/kg/ngày chia 4 lần
Cloxacillin	250-500mg/lần, 3-4 lần/ngày	50-100mg/kg/ngày, chia 3-4 lần
Oxacillin	Uống 0.5-1g/lần mỗi 4-6 giờ	Uống 12.5 – 25mg/kg/ lần mỗi 6 giờ
Amoxicillin/ clavulanic	Uống 1 -2 g chia 2 – 3 lần/ngày	40-80 mg/kg/ngày , chia 2-3 lần
Cefazolin	250-500mg/lần, 3-4 lần/ngày	25-50mg/kg/ngày chia 3-4 lần
Ceftriaxon	1-2g/ngày, tối đa 4g/ngày, truyền 1 lần	20-80mg/kg/ngày, tiêm tĩnh mạch, ngày 1 lần
Trường hợp do tụ cầu vàng kháng methicilin		
Trimetroprim/ sulfamethaxol	160/800mg/lần x 2 lần/ngày	6-8mg Trimetroprim/kg/ngày chia 2 lần
Vancomycin	500mg/lần x 4 lần/ngày Hoặc 1g/lần x 2 lần/ngày	40mg/kg/ngày chia 4 lần
Linezolid	600mg/lần x 2 lần/ngày	10mg/kg/lần x 3 lần/ngày

+ Trong trường hợp không đáp ứng với các nhóm kháng sinh trên: có thể dùng nhóm

quinolon, macrolid hoặc aminoglycosid

+ Nếu chốc kháng thuốc hoặc chốc loét phải điều trị theo kháng sinh đồ

- Điều trị biến chứng nếu có.

4. PHÒNG BỆNH

- Chú ý phòng bệnh cho trẻ nhỏ, nhất là sau khi mắc bệnh do virus như sởi.

- Tắm rửa vệ sinh ngoài da, cắt tóc, cắt móng tay sạch sẽ.

- Tránh ở lâu những nơi ẩm thấp, thiếu ánh sáng.

- Điều trị sớm và tích cực, tránh chà xát, gãi nhiều gây biến chứng.

- Tránh côn trùng đốt.

NHỌT, ÁP XE DA (Furuncle, Cutaneous abscess)

1. ĐẠI CƯƠNG

1.1. Khái niệm

- Nhọt là tình trạng viêm cấp tính gây hoại tử nang lông và tổ chức xung quanh.
- Áp xe da là một ổ mủ khu trú trong trung bì hoặc tổ chức dưới da, có thể gặp ở bất kỳ ở vị trí nào nhưng hay gặp hơn ở các vị trí nếp kẽ như nách, quanh sinh dục và hậu môn.

1.2. Dịch tễ

- Nhọt thường gặp về mùa hè, nam nhiều hơn nữ. Mọi lứa tuổi đều có thể mắc bệnh, tuy nhiên, bệnh thường gặp hơn ở trẻ em.
- Áp xe da có thể gặp cả ở những người khỏe mạnh, nhưng hay gặp hơn ở các đối tượng: béo phì, nghiện thuốc lá, tiểu đường, suy giảm miễn dịch, tiêm truyền thuốc.

1.3. Căn nguyên/ Cơ chế bệnh sinh

- Nhọt: căn nguyên gây bệnh là tụ cầu vàng (*Staphylococcus aureus*). Bình thường, vi khuẩn này sống ký sinh trên da, nhất là các nang lông ở các nếp gấp (rãnh mũi má, rãnh liên móng...) hoặc các hốc tự nhiên (lỗ mũi...). Khi nang lông bị tổn thương kết hợp với những điều kiện thuận lợi như tình trạng miễn dịch kém, suy dinh dưỡng, mắc bệnh tiểu đường, hút thuốc... vi khuẩn sẽ phát triển và gây bệnh.

- Áp xe da:

+ Chủ yếu do nhiễm khuẩn. Vi khuẩn xâm nhập qua da bị tổn thương. Các căn nguyên phổ biến nhất là:

- Tụ cầu vàng: căn nguyên thường gặp nhất, tụ cầu vàng kháng methicillin: gây áp xe da tái phát
- *Streptococcus pyogenes*
- Vi khuẩn gram âm, vi khuẩn kỵ khí
- Các căn nguyên ít gặp hơn: *Mycobacterium tuberculosis* và *Mycobacteria* không điển hình, nấm

+ Áp xe vô khuẩn:

- Có thể do các mô hoại tử, mô chết và các tế bào viêm sau khi hết nhiễm trùng
- Một số bệnh da viêm gây phá hủy mô và hình thành áp xe mà không có mặt vi khuẩn gây bệnh như viêm tuyến mồ hôi mủ, trứng cá bọc và trứng cá tối cấp, bệnh Crohn da, viêm mô mỡ dưới da.
- Áp xe vô khuẩn cũng có thể xảy ra sau tiêm corticosteroid.

2. CHẨN ĐOÁN

2.1. Triệu chứng lâm sàng

- Nhọt: tổn thương ban đầu là sẩn nhỏ, màu đỏ, sưng nề, chắc, tấy đỏ ở nang lông. Sau đó, tổn thương lan rộng hóa mủ tạo thành ổ áp xe, ở giữa hình thành ngòi mủ. Thường đau nhức, nhất là khi nhọt khu trú ở mũi, vành tai. Vị trí thường gặp là ở đầu, mặt, cổ, lưng, mông và chân, tay. Số lượng tổn thương có thể một hoặc nhiều, kèm theo các triệu chứng toàn thân như sốt, mệt mỏi, hội chứng nhiễm trùng.
- Nhọt cụm còn gọi là nhọt bầy hay hậu bối gồm một số nhọt xếp thành đám. Bệnh thường gặp ở những người suy dinh dưỡng, giảm miễn dịch hoặc mắc các bệnh mạn tính như tiểu đường, hen phế quản, lao phổi.
- Áp xe da thường có biểu hiện sưng, nóng, đỏ, đau. Kích thước thay đổi thường từ 1-3cm, đôi khi có thể rất lớn. Ban đầu phản ứng viêm đỏ cương tụ nên rất cứng, sau đó, các ổ mủ hình thành, lớp da bên trên trở nên mỏng hơn và sờ cảm giác mềm hơn, có thể tự vỡ và chảy mủ. Có thể có sưng hạch vùng, sốt.

2.2. Cận lâm sàng

- Mô bệnh học: ổ áp xe ở nang lông, cấu trúc nang lông bị phá vỡ, giữa là tổ chức hoại tử, xung quanh thâm nhập nhiều các tế bào viêm, chủ yếu là bạch cầu đa nhân trung tính.
- Siêu âm (áp xe): đánh giá kích thước và sự khu trú của khối áp xe.
- Vi sinh: nhuộm gram, nuôi cấy định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ
- Xét nghiệm đánh giá tình trạng viêm: bạch cầu, máu lắng, CRP, procalcitonin có thể tăng

2.3. Chẩn đoán xác định

Chủ yếu dựa vào triệu chứng lâm sàng

2.4. Chẩn đoán phân biệt

- Viêm nang lông
- Herpes da lan tỏa
- Trứng cá
- Viêm tuyến mồ hôi mủ
- Kén thượng bì
- Viêm cân cơ hoại tử
- Viêm mô bào

3. ĐIỀU TRỊ

3.1. Nguyên tắc điều trị

- Vệ sinh cá nhân.
- Điều trị chống nhiễm khuẩn tại chỗ và toàn thân.
- Nâng cao thể trạng.
- Với ổ áp xe: cần trích rạch dẫn lưu và dùng kháng sinh toàn thân.

3.2. Điều trị cụ thể

3.2.1. Điều trị tại chỗ

- Vệ sinh cá nhân: rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, tránh tự lây nhiễm ra các vùng da khác.
- Điều trị tại chỗ:
 - + Ở giai đoạn sớm, chưa có mủ: không nặn, kích thích vào tổn thương; bôi dung dịch sát khuẩn ngày 2-4 lần.
 - + Giai đoạn có mủ: chích rạch làm sạch, dẫn lưu trong trường hợp ổ áp xe.
 - + Sử dụng dung dịch sát khuẩn (povidon-iod 10%, hexamidin 0,1%, chlorhexidin 4%...) và thuốc kháng sinh tại chỗ (axít fusidic 2%, mupirocin 2%, neomycin, silver sulfadiazin 1%).

3.2.2. Điều trị toàn thân

- Kháng sinh toàn thân: lựa chọn một trong các kháng sinh sau:

Kháng sinh	Liều lượng	
	Người lớn	Trẻ em
Cloxacilin	Uống hoặc tiêm bắp hoặc tĩnh mạch (TM) cứ 6 giờ dùng 250-500mg	Dưới 20 kg, uống hoặc tiêm bắp hoặc TM cứ 6 giờ dùng 12,5 - 25 mg/kg. Trên 20kg, liều dùng như người lớn
Amoxicillin/ clavulanic	Uống 875/125mg x 2 lần/ ngày	Uống 25 mg/kg/ngày chia hai lần
Roxithromycin	Uống 150mg/lần x lần/ngày	Uống 5 – 8mg/kg/ngày chia 2 lần
Azithromycin	Uống 500mg ngày đầu, sau đó 250mg/ngày trong 4 ngày tiếp	Uống 10mg/kg/ngày x 3 ngày
Clindamycin	Tiêm TM, 600mg x 3 lần/ ngày hoặc uống 300 -450mg x 4 lần/ngày	Uống hoặc truyền TM, 10-20mg/kg/ngày chia ba lần
Trường hợp do tụ cầu vàng kháng methicilin		
Vancomycin	Truyền TM chậm 30 mg/kg/ngày, chia 4 lần (không dùng quá 2g/ngày).	Tiêm TM chậm 40mg/ngày chia 4 lần (cứ 6 giờ/lần) hoặc truyền TM 10mg/kg
Trimethoprim/ sulfamethoxazol (TMP/SMX)	Uống 160/800mg x 2 lần/ngày	Uống 8 (TMP)/40 (SMX) mg/kg chia 2 lần/ngày
Linezolid	Uống hoặc truyền tĩnh mạch 600mg x 2 lần/ngày	Dưới 12 tuổi: uống hoặc truyền tĩnh mạch 10mg/kg (tối đa 600mg) x 3 lần/ngày Trên 12 tuổi: dùng liều như người lớn

- Thời gian điều trị kháng sinh từ 7- 10 ngày.
- Có thể sử dụng các thuốc chống viêm giảm đau NSAIDs hoặc corticosteroid trong

một số trường hợp.

4 . PHÒNG BỆNH

- Vệ sinh cá nhân sạch sẽ: cắt móng tay, rửa tay thường xuyên.
- Tránh sử dụng các sản phẩm gây kích ứng da.
- Nâng cao thể trạng.

syt_hochiminh_vt_Van thu SYT TP.Ho Chi Minh 09/11/2023 16:01:22

VIÊM NANG LÔNG (Folliculitis)

1. ĐẠI CƯƠNG

1.1. Khái niệm

Viêm nang lông là tình trạng viêm nông một hoặc nhiều nang lông.

1.2. Dịch tễ

Bệnh gặp ở bất kỳ chủng tộc nào, tỷ lệ nam, nữ tương đương. Bệnh gặp ở bất kỳ lứa tuổi nào, nhất là thanh thiếu niên và người trẻ.

1.3. Căn nguyên/ Cơ chế bệnh sinh

- Nguyên nhân chủ yếu là tụ cầu vàng (*Staphylococcus aureus*) và trực khuẩn mủ xanh (*Pseudomonas aeruginosa*).
- Các nguyên nhân khác:
 - + Nấm: *Trichophyton rubrum* hoặc *Malassezia folliculitis* (*Pityrosporum folliculitis*).
 - + *Herpes simplex virus* thường gây viêm nang lông vùng quanh miệng.
 - + Viêm nang lông không do nhiễm khuẩn:
 - Pseudo-folliculitis (giả viêm nang lông) hay gặp ở vùng cằm do cạo râu gây hiện tượng lông chọc thít.
 - Viêm nang lông tăng bạch cầu ái toan thường gặp ở những người suy giảm miễn dịch.
 - Viêm nang lông Decanvans hay gặp vùng da đầu gây rụng tóc vĩnh viễn.
 - Viêm nang lông ở những người công nhân tiếp xúc với dầu mỡ như thợ lọc dầu, thợ máy...
- Một số yếu tố thuận lợi:
 - + Tại chỗ: mặc quần áo quá chật, da ẩm ướt, tăng tiết mồ hôi, gãi, cào, cạo râu, nhổ lông, các thuốc hoặc mỹ phẩm gây kích ứng, dùng thuốc bôi corticosteroid lâu ngày.
 - + Toàn thân: béo phì, tiểu đường, suy giảm miễn dịch bẩm sinh hay mắc phải, suy thận, chạy thận nhân tạo, thiếu máu do thiếu sắt đôi khi kết hợp đối với những trường hợp viêm nang lông mạn tính.

2. CHẨN ĐOÁN

2.1. Triệu chứng lâm sàng

- Tổn thương là những sẩn nhỏ ở nang lông, trên có vảy tiết, không đau, sau vài ngày tiến triển, tổn thương có thể khỏi không để lại sẹo.
- Vị trí ở bất kỳ vùng da nào của cơ thể, trừ ở lòng bàn tay bàn chân, thường gặp nhất là ở đầu, mặt, cổ, lưng, mặt ngoài cánh tay, đùi, sinh dục, cẳng tay và cẳng chân....
- Số lượng tổn thương nhiều hay ít tùy theo từng trường hợp. Hầu hết các trường hợp chỉ có một vài tổn thương đơn độc và dễ dàng bỏ qua. Một số người bệnh có nhiều tổn thương, tái phát nhiều lần làm ảnh hưởng đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống.

2.2. Cận lâm sàng

Các xét nghiệm xác định nguyên nhân

- Nuôi cấy vi khuẩn
- Soi nấm trực tiếp
- Nuôi cấy nấm
- Sinh thiết trong một số trường hợp

2.3. Chẩn đoán xác định

Chủ yếu dựa vào lâm sàng

2.4. Chẩn đoán phân biệt

- Nhọt
- Sẩn ngứa
- Trứng cá

3. ĐIỀU TRỊ

3.1. Nguyên tắc điều trị

- Điều trị theo căn nguyên (nhiễm khuẩn, không nhiễm khuẩn)
- Loại bỏ các yếu tố thuận lợi
- Vệ sinh cá nhân: rửa tay thường xuyên bằng xà phòng sát khuẩn...
- Tránh cào gãi, kích thích tổn thương.
- Tùy từng bệnh nhân cụ thể mà chỉ cần dùng dung dịch sát khuẩn kết hợp với kháng sinh bôi tại chỗ hoặc kháng sinh toàn thân.

3.2. Điều trị cụ thể

3.2.1. Điều trị tại chỗ

- Dung dịch sát khuẩn: sử dụng 2-4 lần/ngày, có thể lựa chọn một trong các dung dịch sát khuẩn sau: povidon-iod 10%; hexamidin 0,1%; chlorhexidin 4%.
- Thuốc kháng sinh bôi tại chỗ: dùng một trong các thuốc sau:
 - + Kem hoặc mỡ axít fusidic, bôi 1- 2 lần/ngày
 - + Mỡ mupirocin 2%, bôi 3 lần/ngày
 - + Mỡ neomycin, bôi 2- 3 lần/ngày
 - + Kem silver sulfadiazin 1%, bôi 1-2 lần/ngày
 - + Dung dịch erythromycin, bôi 1-2 lần/ngày
 - + Dung dịch clindamycin, bôi 1-2 lần/ngày

Bôi thuốc lên tổn thương sau khi sát khuẩn, thời gian điều trị từ 7-10 ngày.

3.2.2. Điều trị toàn thân

- Trường hợp nặng cần phối hợp điều trị tại chỗ kết hợp với toàn thân bằng một trong các kháng sinh sau:

Kháng sinh	Liều lượng	
	Người lớn	Trẻ em
Cloxacilin	Uống hoặc tiêm bắp hoặc tĩnh mạch (TM) cứ 6 giờ dùng 250-500mg	Dưới 20 kg, uống hoặc tiêm bắp hoặc TM cứ 6 giờ dùng 12,5 - 25 mg/kg. Trên 20kg, liều dùng như người lớn
Amoxicillin/ clavulanic	Uống 875/125mg x 2 lần/ ngày	Uống 25 mg/kg/ngày chia hai lần
Clindamycin	Uống hoặc truyền TM, 300-400mg x 3 lần/ ngày	Uống hoặc truyền TM, 10-20mg/kg/ngày chia ba lần
Trường hợp do tụ cầu vàng kháng methicilin		
Vancomycin	Truyền TM chậm 30 mg/kg/ngày, chia 4 lần (không dùng quá 2g/ngày)	Tiêm TM chậm 40mg/ngày chia 4 lần (cứ 6 giờ/lần) hoặc truyền TM 10mg/kg

Thời gian điều trị từ 7-10 ngày.

- Trường hợp do nấm hoặc nguyên nhân khác cần điều trị theo nguyên nhân cụ thể.
 - + Do nấm: dùng các thuốc đường toàn thân như fluconazol hoặc itraconazol kết hợp với các loại dầu gội hoặc tắm chứa selenium sulfide, ketoconazol hay ciclopirox.

+ Do virus *Herpes simplex*: uống aciclovir liều 200mg/lần x 5 lần/ngày hoặc valaciclovir 500mg/lần x 3 lần/ngày hoặc famciclovir 500mg/lần x 3 lần/ngày trong 5 – 10 ngày.

+ Do *Demodex*: dùng permethrin 5% tại chỗ, uống ivermectin 200µg/kg liều duy nhất, uống khi đói hoặc metronidazol uống 500mg/ngày trong 15 ngày.

4. PHÒNG BỆNH

- Vệ sinh cá nhân.
- Tránh các yếu tố thuận lợi như môi trường nóng ẩm, các hóa chất dầu mỡ.
- Điều trị sớm khi có tổn thương ở da.
- Trường hợp tái phát cần lưu ý vệ sinh tốt loại bỏ các ổ vi khuẩn trên da như vùng rãnh mũi má, rãnh liên lông...

HỘI CHỨNG BONG VẢY DA DO TỤ CẦU

(Staphylococcal Scalded Skin Syndrome)

1. ĐẠI CƯƠNG

1.1. Khái niệm

Hội chứng bong vảy da do tụ cầu (Staphylococcal Scalded Skin Syndrome - SSSS) là bệnh nhiễm trùng da cấp tính do ngoại độc tố của tụ cầu vàng theo đường máu đến da gây nên. Bệnh có tên gọi khác là bệnh Ritter, được bác sĩ người Đức Gotfried Ritter von Rittershain mô tả lần đầu vào năm 1878.

1.2. Dịch tễ

Bệnh thường gặp ở trẻ em dưới 5 tuổi (hay gặp nhất là 2-3 tuổi), ở các nước đang phát triển, có thể thành dịch nhỏ tại nhà trẻ hoặc phòng nuôi dưỡng trẻ sơ sinh. Bệnh cũng có thể xuất hiện trên người lớn, đặc biệt người bị suy thận hoặc suy giảm miễn dịch.

1.3. Căn nguyên/ Cơ chế bệnh sinh

Tụ cầu vàng (*Staphylococcus aureus*) tiết ra ngoại độc tố lưu hành trong máu người bệnh. Có 2 loại độc tố khác nhau là exfoliative toxin A và B (ETA, ETB). Các độc tố làm phân cắt desmoglein 1 (thường nằm ở lớp hạt của thượng bì) gây ra các bong nước khu trú nông, dễ vỡ và bong vảy nhanh.

2. CHẨN ĐOÁN

2.1. Triệu chứng lâm sàng

Có 2 hình thái lâm sàng: thể khu trú và thể lan tỏa

- Thể khu trú:

- + Không có dấu hiệu toàn thân, vùng da xung quanh tổn thương bình thường.
- + Ban đỏ dạng tinh hồng nhiệt, mềm, tập trung chủ yếu ở các nếp gấp (vùng quanh rốn hoặc vùng hăm kẽ, vùng đáy chậu, tầng sinh môn ở trẻ sơ sinh) nhưng không tiến triển thành bong nước.

- Thể lan tỏa:

- + Thường xảy ra sau một nhiễm trùng ở bất kỳ vị trí nào như viêm mũi họng, viêm tai giữa, viêm kết mạc, viêm rốn. Một số trường hợp hiếm gặp, xảy ra sau viêm phổi do tụ cầu, viêm màng trong tim, áp xe vú sau sinh, viêm khớp...

- + Toàn thân: trẻ mệt mỏi, bú kém, kích thích, sốt.

+ Ban đỏ, mịn dạng tinh hồng nhiệt lan tỏa ở các hốc tự nhiên hoặc các nếp gấp. Sau 24 - 48 giờ hình thành các bóng nước, tạo thành các nếp nhăn trên da làm da trông thô sần và ráp, sờ như tờ giấy nhám. Sau đó tiến triển thành bóng nước mềm, nông, nhão, ranh giới không rõ và liên kết với nhau thành mảng rộng, dễ vỡ khi va chạm và thường vô khuẩn (dấu hiệu Nikolsky dương tính). Các bóng nước sau khi trợt để lộ nền da đỏ ẩm ướt, vẩy bong ra mỏng, cuộn lại như giấy cuốn thuốc lá và rất đau.

+ Tổn thương niêm mạc ít gặp, đây là đặc điểm quan trọng chẩn đoán phân biệt SSSS với dị ứng thuốc thể nặng.

- Bệnh thường đáp ứng tốt với điều trị và thường khỏi hoàn toàn sau 5-7 ngày mà không để lại sẹo. Trường hợp nặng có thể gây tử vong, nhất là ở trẻ suy dinh dưỡng, người suy thận hay suy giảm miễn dịch do các biến chứng nặng như nhiễm khuẩn huyết, viêm phổi...

2.2. Cận lâm sàng

- Các xét nghiệm đánh giá tình trạng viêm: bạch cầu, máu lắng, CRP, procalcitonin có thể tăng.

- Nuôi cấy tìm vi khuẩn và làm kháng sinh đồ: vị trí lấy bệnh phẩm nuôi cấy, phân lập tìm vi khuẩn: dịch kết mạc, mũi họng, phân, ổ mủ trên da. Kháng sinh đồ có ý nghĩa trong trường hợp vi khuẩn đã kháng kháng sinh.

- Cây máu: thường âm tính ở trẻ nhỏ, có thể dương tính ở người lớn.

- Mô bệnh học: có khe tách ở thượng bì phía dưới và trong lớp hạt. Các khe tách có chứa dịch và tế bào ly gai. Các phần còn lại của thượng bì không thấy thay đổi đặc hiệu và không thấy xâm nhiễm tế bào viêm trong trung bì. Mô bệnh học có ý nghĩa trong trường hợp chẩn đoán chưa rõ ràng.

- Kỹ thuật phát hiện gen mã hóa ETA, ETB bằng kỹ thuật lai DNA và PCR.

2.3. Chẩn đoán xác định

Dựa vào:

- Lâm sàng
- Cận lâm sàng

2.4. Chẩn đoán phân biệt

- Hội chứng Lyell
- Bỏng nắng
- Ban đỏ do virus
- Bệnh Kawasaki
- Ban đỏ nhiễm độc trẻ sơ sinh

- Ly thượng bì bong nước bẩm sinh
- Pemphigus vảy lá

3. ĐIỀU TRỊ

3.1 . Nguyên tắc điều trị

- Đánh giá toàn trạng bệnh nhân, mức độ nặng của bệnh để có hướng xử lý thích hợp.
- Trẻ sơ sinh mắc SSSS cần được cách ly với các trẻ khác để tránh lây nhiễm chéo.
- Điều trị tại chỗ và toàn thân
- Bồi phụ dinh dưỡng, nước, điện giải.
- Phát hiện và điều trị các ổ nhiễm trùng khu trú để ngăn ngừa vi khuẩn lan vào máu.

3.2 . Điều trị cụ thể

3.2.1. Điều trị tại chỗ

_ Chăm sóc tại chỗ:

+ Dung dịch sát khuẩn: Tắm rửa hàng ngày bằng dung dịch sát khuẩn (thuốc tím pha loãng 1/10.000 hoặc dầu tắm nhẹ nhàng, tránh làm tổn thương da thêm.

+ Chăm sóc mắt, miệng khi có tổn thương.

_ Kháng sinh bôi tại chỗ (acid fusidic, mupirocin...), bôi 2 lần/ngày trong 7-10 ngày.

3.2.2. Điều trị toàn thân

_ Kháng sinh toàn thân: lựa chọn một trong các kháng sinh sau:

Kháng sinh	Liều lượng	
	Người lớn	Trẻ em
Cloxacillin	250-500mg/lần, 3-4 lần/ngày	50-100mg/kg/ngày chia 3-4 lần
Oxacillin	250-500 mg/lần mỗi 4-6 giờ	12.5 – 25mg/kg/ lần mỗi 6 giờ
Cefazolin	250-500mg/lần, 3-4 lần/ngày	25-50mg/kg/ngày chia 3-4 lần
Ceftriaxon	1-2g/ngày, tối đa 4g/ngày, truyền 1 lần	20-80mg/kg/ngày, truyền 1 lần
Trường hợp do tụ cầu vàng kháng methicilin		
Vancomycin	500mg/lần x 4 lần/ngày Hoặc 1g/lần x 2 lần/ngày	40mg/kg/ngày chia 4 lần
Linezolid	600mg/lần x 2 lần/ngày	10mg/kg/lần x 3 lần/ngày

+ Lựa chọn khác: kháng sinh nhóm quinolon, macrolid hoặc aminoglycosid dựa vào kết quả kháng sinh đồ.

- Điều trị biến chứng nếu có

3.3. Điều trị hỗ trợ

- _ Hạ sốt
- _ Bù dịch, điện giải: đánh giá mức độ mất nước, điện giải do sốt và mất nước qua da.
- _ Dinh dưỡng: chế độ dinh dưỡng đầy đủ để tăng cường cung cấp năng lượng và protein cho việc lành vết thương.

4. PHÒNG BỆNH

- _ Cách ly bệnh nhân cho đến khi khỏi bệnh.
- _ Nâng cao thể trạng.
- _ Điều trị sớm các ổ nhiễm khuẩn.
- _ Vệ sinh cá nhân.

BỆNH GHẺ

(Scabies)

1. ĐẠI CƯƠNG

1.1. Khái niệm

Bệnh ghẻ là bệnh da phổ biến, do ký sinh trùng ghẻ có tên khoa học là *Sarcoptes scabiei* var. *hominis* gây ra.

1.2. Dịch tễ học

Bệnh thường xuất hiện ở những vùng dân cư đông đúc, nhà ở chật hẹp, điều kiện vệ sinh kém. Bệnh lây từ người này sang người khác thông qua tiếp xúc trực tiếp hoặc qua quần áo, chăn màn, chiếu dín, trứng ghẻ.

1.3. Căn nguyên/ Cơ chế bệnh sinh

Ký sinh trùng gây bệnh ghẻ có tên khoa học là *Sarcoptes scabiei hominis*.

2. CHẨN ĐOÁN

2.1. Triệu chứng lâm sàng

- Thời gian ủ bệnh: Khó xác định, trung bình 2-6 tuần ở từng người khác nhau, phụ thuộc vào khả năng miễn dịch. Nhiễm ghẻ lần đầu, thời gian ủ bệnh có thể đến 3 tuần. Trong trường hợp tái nhiễm ghẻ, thời gian ủ bệnh thường là từ 1-3 ngày.

- Yếu tố dịch tễ: nhiều thành viên trong gia đình có biểu hiện tương tự.

- Thở điển hình:

+ Mụn nước: xuất hiện trên nền da lành, sắp xếp rải rác, riêng rẽ từng cái một. Mụn nước thường ở vùng da mỏng như ở kẽ ngón tay, mặt trước cổ tay, cẳng tay, vú, quanh thắt lưng, rốn, kẽ mông, mặt trong đùi và bộ phận sinh dục. Ở trẻ sơ sinh mụn nước ở lòng bàn tay, chân, ở quai đầu. Ở vùng sinh dục tổn thương thường tròn, 5-7 mm đường kính, ở giữa có thể trợt được gọi là săng ghẻ, dễ nhầm với săng giang mai.

+ Sản cục hay sản huyết thanh: hay gặp ở nách, bẹn, bẹn.

+ Đường hầm ghẻ: còn gọi là “luống ghẻ”, đặc hiệu nhưng không phải lúc nào cũng dễ tìm thấy. Luống ghẻ do con ghẻ cái tạo thành dài 3 -5mm, bên trên mặt da là một mụn nước nhỏ, lấy kim chích dịch chảy ra, để lộ màu xám hoặc đen, dùng kim khâu sẽ bắt được cái ghẻ bám trên đầu kim, di động khi đặt lên mặt kính

+ Tại nơi gãi do ngứa, xuất hiện những vết xước, vảy da, đỏ da, dát thâm. Có thể có bội nhiễm, chàm hoá, mụn mủ.

- Thở Ghẻ vảy/Ghẻ sừng hóa hay Ghẻ Na Uy (Norwegian Scabies)

+ Thường gặp ở những bệnh nhân suy giảm miễn dịch: điều trị bằng corticosteroid dài ngày, HIV/AIDS, người được ghép tạng, dùng các thuốc ức chế miễn dịch, suy dinh dưỡng, người già.

+ Biểu hiện lâm sàng có thể dưới dạng viêm da mạn tính, viêm da dạng vảy nến, viêm da tiết bã hoặc đỏ da toàn thân kèm bong vảy nhiều.

+ Tổn thương cơ bản: các lớp vảy chồng lên nhau và lan toả gần như toàn cơ thể, có thể tìm thấy hàng nghìn cái ghẻ trong các vảy nhỏ này. Tại các khu vực bị nhiễm ghẻ vảy nặng, các mảng có ranh giới rõ được bao phủ bởi một lớp vảy rất dày. Ở tay, chân có thể gây nên bệnh da dạng hạt com, với dấu hiệu tăng sừng ở giường móng. Tổn thương phân bố toàn thân (thậm chí ở đầu và cổ) hoặc khu trú từng vùng chủ yếu ở các khu vực nếp kẽ. Lớp vảy da, vảy tiết được tìm thấy trên mặt đuôi bàn tay, cổ tay, ngón tay, khớp bàn ngón tay, lòng bàn tay, mặt đuôi của khuỷu tay, da đầu, lòng bàn chân và ngón chân.

- Triệu chứng cơ năng: ngứa nhiều, đặc biệt về đêm, có thể gây mất ngủ.

2.2. Cận lâm sàng

- Soi tìm ký sinh trùng ghẻ trên kính hiển vi thông thường.
- Soi da trên Dermoscopy: hình ảnh như vệt khói máy bay.
- Xét nghiệm huyết học: có thể thấy tăng bạch cầu ái toan trong ghẻ vảy.

2.3. Chẩn đoán xác định

Dựa vào triệu chứng lâm sàng và cận lâm sàng.

2.4. Chẩn đoán phân biệt

- Sẩn ghẻ: có thể cần chẩn đoán phân biệt với một số bệnh da có sẩn kèm theo ngứa như: Mày đay sắc tố (ở trẻ nhỏ), bệnh Darier, sẩn ngứa, sẩn trong giang mai II, viêm hạch lympho giả u, u bạch huyết dạng sẩn.

- Tổ đũa

- Sẩn giang mai

- Ngứa, phát ban khu trú hoặc lan toả: phát ban do thuốc, viêm da cơ địa, viêm da tiếp xúc, bệnh vẩy phấn hồng, viêm da dạng herpes, bệnh rận mu.

- Bệnh viêm da mủ: chốc, chốc loét, bệnh nhọt khi có bội nhiễm

- Ghẻ vảy: phân biệt với vảy nến, viêm da dạng chàm, bệnh đỏ da có vảy.

3. ĐIỀU TRỊ

3.1. Nguyên tắc điều trị

- Bệnh nhân và những người tiếp xúc gần bệnh nhân cần được điều trị đồng thời (dù có triệu chứng hay không).
- Vệ sinh đồ dùng để hạn chế lây nhiễm: Giặt, phơi, luộc quần áo, chăn đệm, màn, đồ dùng.
- Ngứa có thể kéo dài thêm 1-2 tuần sau khi kết thúc quá trình điều trị hiệu quả.

3.2. Điều trị cụ thể

3.2.1. Điều trị tại chỗ

- Lựa chọn thứ nhất:
 - + Permethrin 5%: là thuốc điều trị ghẻ hiệu quả và an toàn. Dạng kem hoặc dạng xịt được sử dụng ở tất cả các vùng của cơ thể từ cổ trở xuống. Sau 8-12 giờ tắm rửa lại. Thuốc ít có tác dụng phụ, có thể gặp kích ứng nhẹ tại chỗ xoa thuốc. Có thể nhắc lại sau 7-14 ngày. Thuốc được cho là an toàn cho phụ nữ có thai, phụ nữ cho con bú và được phép dùng cho trẻ từ 2 tháng tuổi trở lên.
 - + Lotion benzyl benzoat 10-25% dùng vào buổi đêm trong 2 ngày liên tiếp, có thể nhắc lại sau 7 ngày.
 - + Malathion 0,5% lotion có thể sử dụng nếu không dung nạp với kem permethrin. Bôi toàn bộ cơ thể, tắm lại sau 24h, có thể lặp lại sau 1 tuần. Thuốc có thể gây viêm da kích ứng, đặc biệt là trên mặt và cơ quan sinh dục.
- Lựa chọn thứ hai:
 - + Dung dịch DEP (Diethyl – phtalat) bôi lên tổn thương mụn nước tối trước khi đi ngủ.
 - + Crotamiton 10% cream: Thoa lớp kem mỏng lên toàn bộ cơ thể từ cổ xuống, bôi liên tiếp 2 đêm, tắm rửa sạch sau 24 tiếng sau khi bôi lần 2.
 - + Sulfur 2–10% in petrolatum: Bôi lên da từ 2 đến 3 ngày.
 - + Benzyl benzoat kết hợp với sulfiram.
 - + Sulfiram 25% lotion: có thể tác dụng tương tự như thuốc điều trị nghiện rượu; không được uống đồ uống có cồn trong ít nhất 48 giờ.
 - + Ivermectin 0,8% lotion.

3.2.2. Điều trị toàn thân

- Ivermectin đường uống:
 - + Liều dùng: 200 µg/kg; chỉ sử dụng liều duy nhất. Thuốc không dùng cho phụ nữ có

thai, phụ nữ cho con bú và trẻ em dưới 15kg.

+ Liều lặp lại sau 1-2 tuần nếu cần thiết

- Thuốc điều trị triệu chứng:

+ Kháng histamin: dùng để giảm triệu chứng ngứa.

+ Kháng sinh: khi có bội nhiễm.

3.2.3 Điều trị ghẻ ở những trường hợp đặc biệt:

- Ghẻ vảy:

+ Ngâm, tắm toàn thân, bôi mỡ salicylic để bong sừng, sau đó bôi thuốc ghẻ. Bôi thuốc trị ghẻ nhiều lần lên da.

+ Ivermectin đường uống kết hợp với liệu pháp bôi thuốc là phương pháp hiệu quả nhất.

+ Kiểm soát lây nhiễm: cách ly bệnh nhân, vệ sinh nơi ở, điều trị dự phòng đối với những người đã tiếp xúc với bệnh nhân.

- Ghẻ chàm hóa:

+ Kháng histamin: dùng thuốc kháng histamin an thần như hydroxyzin, doxepin, hoặc diphenhydramin khi đi ngủ.

+ Thuốc mỡ corticosteroid: bôi các tổn thương viêm da chàm hóa do ghẻ.

- Ghẻ bội nhiễm: điều trị với thuốc mỡ mupirocin, acid fusidic. Có thể dùng thêm các loại thuốc kháng sinh đường toàn thân nếu cần.

- Sẩn ghẻ: có thể tồn tại cùng với ngứa đến một năm sau khi loại bỏ ghẻ. Có thể sử dụng triamcinolon tiêm nội tổn thương, 5-10 mg/ml trên từng tổn thương; lặp lại mỗi 2 tuần (nếu cần thiết); thuốc mỡ corticosteroid phối hợp axit salicylic...

4. PHÒNG BỆNH

- Vệ sinh cá nhân sạch sẽ. Giáo dục cộng đồng, giữ vệ sinh da, diệt nguồn ghẻ sinh sống, tắm, thay đồ hàng ngày, dọn sạch giường, giặt chăn màn.

- Khi bị ghẻ cần điều trị sớm, tránh tiếp xúc với người xung quanh trong thời gian điều trị.

- Giáo dục đối tượng có nguy cơ tránh tiếp xúc. Khi phát hiện ra có người trong gia đình bệnh nhân ghẻ cần điều trị sớm, tránh tiếp xúc và dùng chung các đồ dùng của người bị bệnh.

- Chẩn đoán sớm, điều trị đầy đủ, thích hợp.

- Điều trị biến chứng, phòng tái phát.

VIÊM DA DO DEMODEX (Demodicosis)

1. ĐẠI CƯƠNG

1.1. Khái niệm

Viêm da do *Demodex* là bệnh da do ký sinh trùng thuộc họ *Demodex* ký sinh và phát triển với số lượng lớn ở nang lông, tuyến bã và vảy da.

1.2. Dịch tễ

Demodex có thể thường gặp ở trẻ lớn và người trưởng thành, hiếm khi quan sát thấy ở trẻ em dưới 5 tuổi. Viêm da do *Demodex* thường được chẩn đoán ở người lớn tuổi, hoặc người có tình trạng suy giảm miễn dịch.

1.3. Căn nguyên/Cơ chế bệnh sinh

- Bệnh gây ra do *Demodex* thuộc họ ve mạt, giống *Demodex*, thường có hai loài ký sinh trên người là *D.folliculorum* và *D.brevis*.
- Khi xâm nhập vào da người, *Demodex* ký sinh ở nang lông, tuyến bã, dùng mô sắc nhọn chọc thủng tế bào biểu bì và tiết ra men lipase thủy phân chất bã làm nguồn thức ăn. Khi lượng *Demodex* tập trung nhiều làm nang lông giãn rộng, hình thành nút sừng gây tắc nghẽn nang lông và giảm bài tiết chất bã ra ngoài khiến da trở nên khô ráp và bong vảy.

2. CHẨN ĐOÁN

2.1. Triệu chứng lâm sàng

- Gồm viêm da do *Demodex* nguyên phát và viêm da do *Demodex* thứ phát:
 - + Viêm da do *Demodex* nguyên phát: khởi phát muộn, thường sau 40 tuổi hoặc người cao tuổi, ảnh hưởng đến mặt, quanh miệng, quanh mắt hoặc quanh tai. Tổn thương thường phân bố không đối xứng, được nhóm lại theo hình dạng không đều có tổn thương vệ tinh. Người bệnh không có triệu chứng hoặc ngứa nhẹ. Không thấy các biểu hiện điển hình của trứng cá đỏ như ban đỏ, cơn đỏ bừng thoáng qua, giãn mạch.
 - + Viêm da do *Demodex* thứ phát xuất hiện sớm hơn, tổn thương phân bố ở mặt hoặc thân mình viêm nhiều và lan tỏa hơn. Người bệnh thường có tiền sử hoặc kèm theo bệnh trứng cá đỏ, viêm da quanh miệng
- Triệu chứng của viêm da do *Demodex* thường không đặc hiệu:
 - + Vảy mỏng vùng nang lông
 - + Dát, sẩn, mụn mủ, viêm nang lông
 - + Có thể kèm theo ngứa, vảy vùng quanh mắt, viêm kết mạc mắt, giảm thị lực.

2.2. Cận lâm sàng

Soi tìm *Demodex* dưới kính hiển vi:

- Nếu độ tập trung của *Demodex* ≥ 5 con trên một vi trường: *Demodex* là căn nguyên gây bệnh.
- Nếu độ tập trung của *Demodex* < 5 con trên một vi trường: *Demodex* không phải căn nguyên gây bệnh.

2.3. Chẩn đoán xác định

Dựa vào biểu hiện lâm sàng và cận lâm sàng.

2.4. Chẩn đoán thể

- Viêm nang lông vảy phấn: Tổn thương chủ yếu là vảy mỏng, màu hơi trắng hoặc hơi vàng, sờ thô ráp như giấy ráp ở vùng nang lông (nhất là vùng da đầu) có thể kèm hoặc không dát đỏ nhạt hoặc viêm nhẹ. Thường gặp ở phụ nữ trung niên ít có thói quen rửa mặt, trang điểm nhiều
- *Demodex* dạng trứng cá đỏ, *Demodex* giống viêm da quanh miệng, quanh mắt, quanh tai: Tổn thương là sẩn, mụn mủ thường ở trên mặt quanh miệng, mắt, tai. Kích thước nhỏ hơn trứng cá đỏ. Có thể kèm vảy ở nang lông, ngứa. Phân bố thường không đối xứng. Tổn thương thường không có da dai dẳng (khác với trứng cá đỏ triệu chứng đỏ da hay gặp)
- *Demodex* áp xe: Bệnh nhân có sẩn đỏ, mụn mủ, áp xe sâu và ở một bên mặt, phân bố không đối xứng, tồn tại dai dẳng.

2.5. Chẩn đoán phân biệt

- Viêm da dầu.
- Viêm da tiếp xúc dị ứng.
- Trứng cá đỏ.
- Nhiễm nấm da.

3. ĐIỀU TRỊ

3.1. Nguyên tắc điều trị

- Dùng dầu gội dịu nhẹ.
- Làm sạch da mặt hai lần mỗi ngày bằng sữa rửa mặt không chứa xà phòng, tẩy tế bào chết định kỳ để loại bỏ tế bào da chết.
- Dùng các thuốc có tác dụng diệt *Demodex*.

3.2. Điều trị cụ thể

3.2.1. Điều trị tại chỗ

- Thuốc bong vảy: thuốc bong vảy thường dùng trong các trường hợp viêm da do *Demodex* dạng viêm nang lông dạng vảy phần nhẹ.

+ Acid salicylic 5%

+ Thuốc bôi vitamin A acid.

- Thuốc có tác dụng diệt ký sinh trùng: các thuốc bôi có thể lựa chọn gồm:

+ Dung dịch benzyl benzoat

+ Kem permethrin, kem crotamiton

+ Gel metronidazol

3.2.2. Điều trị toàn thân

- Metronidazol: uống 500mg/ngày trong 15 ngày.

- Ivermectin: liều duy nhất 200 μ g/kg, uống khi đói.

4. PHÒNG BỆNH

- Sử dụng các sản phẩm làm sạch mặt dịu nhẹ hàng ngày

- Không tự ý sử dụng thuốc bôi có chứa corticosteroid, thuốc bôi không rõ thành phần, nguồn gốc.

BỆNH LANG BEN **(Pityriasis versicolor)**

1. ĐẠI CƯƠNG

1.1. Định nghĩa

Bệnh lang ben là bệnh phổ biến do *Malassezia* - một loài nấm nông bề mặt trên da gây nên. Bệnh đáp ứng tốt với điều trị, nhưng thường hay tái phát và có thể cần điều trị dự phòng lâu dài.

1.2. Dịch tễ

Bệnh xuất hiện ở khắp nơi trên thế giới, hay gặp hơn ở khu vực có khí hậu nhiệt đới.

1.3. Căn nguyên/Cơ chế bệnh sinh

Lang ben do nấm thuộc nhóm *Malassezia* gây nên. Hiện nay đã xác định và phân loại được 14 chủng *Malassezia* khác nhau, trong đó có 8 chủng hay gây bệnh cho người là *M. sympodialis*, *M. globosa*, *M. restricta*, *M. slooffiae*, *M. furfur*, *M. obtusa* và các chủng mới được phân lập là *M. dermatis*, *M. japonica*, *M. yamatoensis*, *M. nana*, *M. caprae* và *M. equina*.

2. CHẨN ĐOÁN

2.1. Triệu chứng lâm sàng

- Tổn thương cơ bản là các dát, mảng hình tròn hoặc bầu dục kích thước 1-3cm, màu hồng, nâu hoặc trắng trên da, có thể liên kết với nhau thành các tổn thương lớn, cào nhẹ xuất hiện vảy da (dấu hiệu vỏ bào).
- Vị trí thường gặp: ở người lớn thường gặp ở vùng chi trên, ngực, lưng; ở trẻ em thường gặp ở mặt.
- Thường không có triệu chứng cơ năng, một số trường hợp có thể ngứa.
- Nếu không điều trị, lang ben có thể dai dẳng hằng năm, bệnh hay tái phát vào mùa nắng nóng.

2.2. Cận lâm sàng

- Soi tươi: Bệnh phẩm vẩy da được lấy bằng băng dính trong hoặc cạo da bằng dao cùn, soi tươi với KOH 10% hoặc KOH + Parker ink.
- Đèn Wood: Dưới ánh sáng đèn Wood, tổn thương lang ben có huỳnh quang màu vàng sáng. Màu huỳnh quang được phát hiện ở vùng rìa của tổn thương.
- Nuôi cấy và định loại: Bệnh phẩm là vẩy da của bệnh nhân lang ben. Các môi trường nuôi cấy có thể sử dụng bao gồm: thạch Sabouraud, thạch m-Dixon, thạch Leeming-Notman.

2.3. Chẩn đoán xác định

Dựa vào triệu chứng lâm sàng và cận lâm sàng.

2.4. Chẩn đoán phân biệt

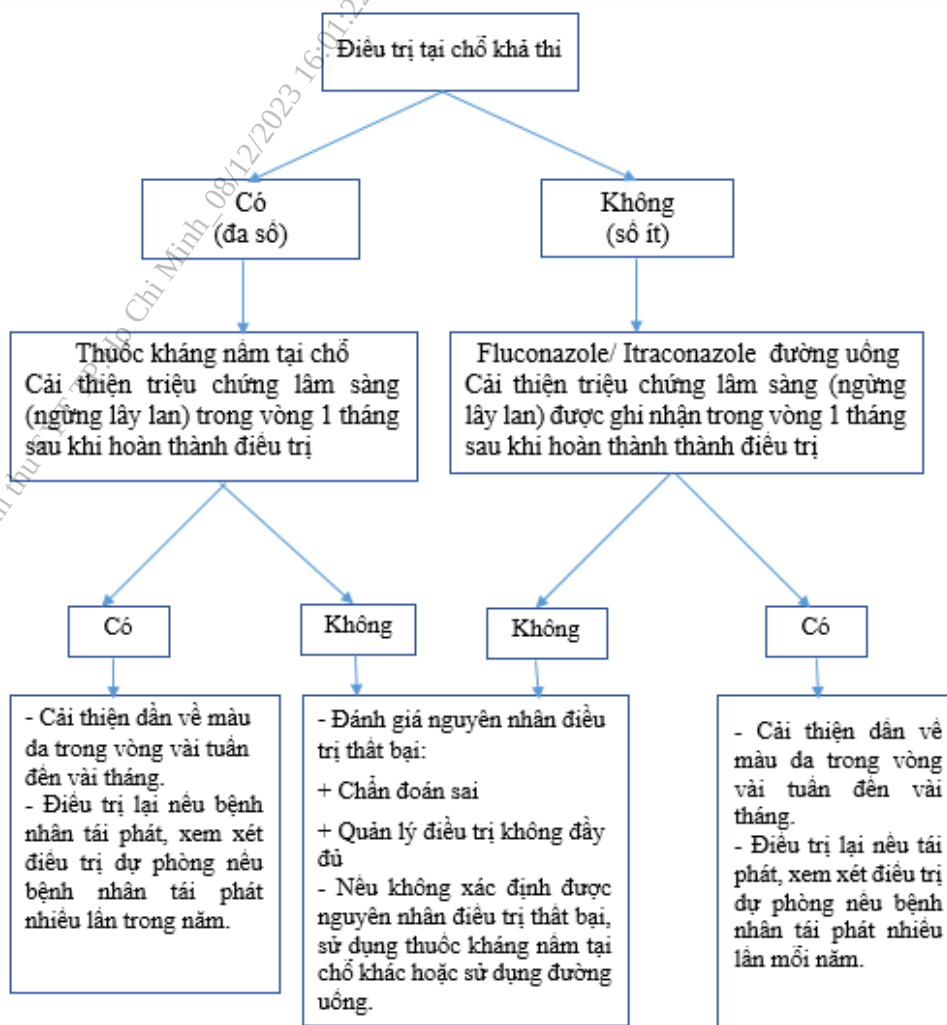
- Vẩy phấn trắng
- Vẩy phấn hồng
- Viêm da dầu
- Erythrasma
- Giang mai II
- Bạch biến
- Phong thể I
- U sùi dạng nấm (mycosis fungoides)

3. ĐIỀU TRỊ

3.1. Nguyên tắc điều trị

- Vệ sinh cá nhân
- Điều trị thuốc bôi chống nấm tại chỗ.
- Điều trị toàn thân áp dụng trong trường hợp tái phát hoặc tổn thương rộng, thất bại với điều trị bằng thuốc bôi.
- Điều trị dự phòng tái phát
- Dát tăng/giảm sắc tố có thể tồn tại thêm một vài tháng sau khi kết thúc điều trị.

3.2. Điều trị cụ thể



- Lựa chọn thứ nhất: Thuốc chống nấm tại chỗ: terbinafin, nhóm azole; bôi ngày 2 lần, trong 2-4 tuần.

- Lựa chọn thứ hai: Điều trị thuốc kháng nấm đường toàn thân (với các trường hợp nặng, lan tỏa hoặc kháng trị với thuốc bôi). Thuốc kháng nấm đường toàn thân chỉ dùng cho người lớn.

Thuốc	Liều điều trị
Itraconazol	200mg/ngày x 5-7 ngày, hoặc 400mg liều duy nhất
Fluconazol	300mg x 1 lần/tuần x 2-3 tuần

- Điều trị hỗ trợ: có thể dùng một trong các dầu gội sau:

Dầu gội có thành phần ketoconazol 2%, selenium sulfid 2,5% hoặc zinc pyrithion 1%.

4. PHÒNG BỆNH

- Loại bỏ và hạn chế các yếu tố thuận lợi; vệ sinh hàng ngày: giữ cơ thể khô ráo, tránh ẩm ướt...

- Bệnh có thể tái phát, đặc biệt là mùa nắng nóng trong năm, dự phòng tái phát bằng cách sử dụng thuốc bôi hoặc uống.

- + Sử dụng dầu gội kháng nấm 1-2 lần/tuần (dầu gội ketoconazol 2%, selenium sulfid 2,25% hoặc zinc pyrithion 1%)
- + Nếu dùng dầu gội không hiệu quả để dự phòng tái phát thì có thể uống itraconazol 200mg x 2 lần/ ngày x 1 ngày/ tháng.

BỆNH DA DO NẤM SỢI

(Dermatophytosis)

1. ĐẠI CƯƠNG

1.1. Khái niệm

Bệnh da do nấm sợi (dermatophyte) là tình trạng nhiễm nấm ngoài da, bao gồm nấm thân, nấm mặt, nấm bẹn, nấm bàn tay, nấm bàn chân.

1.2. Dịch tễ

- Gặp chủ yếu ở vùng nhiệt đới.
- Yếu tố nguy cơ: nuôi hoặc tiếp xúc với động vật; thể trạng béo và ra nhiều mồ hôi; sử dụng xà phòng có chứa alkaline; thường xuyên đi giày, sử dụng bồn tắm hoặc bể bơi công cộng.

1.3. Căn nguyên/ Cơ chế bệnh sinh

Nấm sợi dermatophyte gây bệnh ở da gồm 3 chủng: *Microsporum*, *Trichophyton* và *Epidermophyton*.

2. CHẨN ĐOÁN

2.1. Triệu chứng lâm sàng

- Tổn thương là dát, mảng đỏ, hình tròn hay hình nhiều cung, có vảy da, xu hướng lành giữa và lan rộng ra xung quanh, ngứa nhiều. Một số trường hợp có mụn nước hoặc mụn mủ.
- Tùy từng vị trí tổn thương (mặt, bẹn, tay, chân, thân mình) các triệu chứng có thể khác nhau.

2.2. Cận lâm sàng

- Soi tươi tìm sợi nấm: phát hiện các sợi nấm chia đốt trên nền tế bào sừng.
- Nuôi cấy trên các môi trường để định loại chủng nấm dựa vào đặc điểm khuẩn lạc của từng loại nấm.
- Xét nghiệm chức năng gan thận

2.3. Chẩn đoán xác định

Dựa vào triệu chứng lâm sàng và cận lâm sàng.

2.4. Chẩn đoán thể

- Nấm thân
- Nấm bàn chân

- Nấm ben

- Nấm mặt

- Nấm bàn tay

+ Dạng tổ đĩa: biểu hiện các mụn nước tập trung thành hình đồng xu hoặc phân bố rải rác.

+ Dạng dày sừng: thường không có biểu hiện viêm, có dày sừng lan tỏa lòng bàn tay và ngón tay mà không đáp ứng với dưỡng ẩm đơn thuần.

- Nấm bàn chân:

+ Nấm kẽ ngón: Đây là thể hay gặp nhất của nấm bàn chân, hầu hết biểu hiện gồm dày sừng và ẩm ướt, màu trắng hoặc đỏ da, bong vảy, nứt kẽ vùng giữa và dưới các ngón chân, đặc biệt giữa ngón 3-4, và 4-5. Vùng mu chân thường không bị ảnh hưởng.

+ Dạng dày sừng: vảy da khô dày sừng có thể toàn bộ lòng bàn chân và lan đến bờ bên; vùng mu chân ít gặp. Hội chứng hai chân một tay: khi kèm biểu hiện tương tự ở 1 lòng bàn tay.

+ Dạng mụn nước, bong nước: Biểu hiện là các mụn nước sâu trong thượng bì, căng >3 mm, mụn nước có thể hợp lại với nhau thành bong nước lớn, dễ chẩn đoán nhầm với các bệnh khác

2.5. Chẩn đoán phân biệt

- Nấm thân: chàm đồng tiền, viêm da cơ địa, viêm da ứ trệ, viêm da tiếp xúc, viêm da dầu, lang ben, vẩy phấn hồng Gilbert, á vẩy nến, hồng ban nhẩn ly tâm, vẩy nến thể đồng tiền, u hạt.

- Nấm mặt: viêm da dầu, viêm da quanh miệng, viêm da tiếp xúc, rosacea, lupus ban đỏ, trứng cá, vẩy nến đồng tiền (trẻ nhỏ).

- Nấm ben: Candida da, chốc, viêm da dầu, vẩy nến, erythrasma, viêm da tiếp xúc, Lichen đơn dạng mạn tính, mycosis fungoides, bệnh Hailey–Hailey, bệnh mô tế bào Langerhans.

- Nấm bàn chân: tổ đĩa, viêm da tiếp xúc, vẩy nến, giang mai II, erythrasma, nhiễm khuẩn.

- Nấm bàn tay: vẩy nến, tổ đĩa, phản ứng nấm “dermatophytid”.

3. ĐIỀU TRỊ

3.1. Nguyên tắc điều trị

- Vệ sinh cá nhân

- Điều trị tại chỗ: sử dụng thuốc bột sừng, bong vảy, kháng nấm

- Điều trị toàn thân: sử dụng các thuốc kháng nấm đường toàn thân

- Điều trị dự phòng

3.2. Điều trị cụ thể

3.2.1 Điều trị tại chỗ

- Điều trị tại chỗ với các trường hợp tổn thương khu trú.
- Bôi thuốc kháng nấm 1-2 lần/ngày x 2-4 tuần. Tiếp tục sử dụng thêm 2 tuần sau khi hết triệu chứng.
 - + Nhómazole
 - + Nhóm allylamines (naftifin, terbinafin).
 - + Nhóm hydroxypyridon (ciclopirox olamin)
- Thuốc điều trị hỗ trợ: mỡ salicylic giúp bạt sừng, bong vảy.

3.2.2. Điều trị toàn thân

Nhiễm nấm lan rộng, không đáp ứng thuốc bôi tại chỗ, nấm mặt kèm nấm râu.

Thuốc	Liều người lớn	Liều trẻ em
Terbinafin	250 mg/ngày x 2 tuần	Dùng với trẻ > 4 tuổi: < 25kg: 125 mg/ngày x 3-4 tuần; 25-35kg: 187,5 mg/ngày x 3-4 tuần; >35kg: 250mg/ngày x 3-4 tuần
Itraconazol	200mg x 2 lần/ngày x 1 tuần	3-5mg/kg/ngày x 1 tuần (tối đa 200mg/ngày)
Fluconazol	150-200mg x 1 lần/tuần x 2-4 tuần	6mg/kg x 1 lần/tuần x 2-4 tuần
Griseofulvin	500-1000mg/ngày x 2-4 tuần, hoặc 375-500mg/ngày x 2-4 tuần Kéo dài thời gian sử dụng lên 4-8 tuần trong trường hợp nấm bàn tay, bàn chân	15-20mg/kg/ngày x 2-4 tuần

- Phụ nữ có thai:
 - + Thuốc chống nấm tại chỗ được ưu tiên.
 - + Hạn chế dùng thuốc kháng nấm đường uống.

4. PHÒNG BỆNH

- Vệ sinh cá nhân, không mặc quần áo ẩm ướt, không dùng chung quần áo.

- Tránh tiếp xúc với các vật nuôi trong nhà như chó, mèo bị bệnh.
- Điều trị sớm khi mắc bệnh.
- Mặc quần rộng, làm khô sau khi tắm, là quần, áo hoặc ga giường, sử dụng bột làm khô tại chỗ; giảm cân đối với người béo phì.
- Phát hiện và điều trị nấm ở vị trí khác.

BỆNH DA VÀ NIÊM MẠC DO CANDIDA (Mucocutaneous candidiasis)

1. ĐẠI CƯƠNG

1.1. Khái niệm

Nhiễm nấm Candida là một bệnh nhiễm trùng do nấm *Candida* gây ra, thường là *Candida albicans*. *Candida* có thể gây bệnh ở niêm mạc, da và máu.

1.2. Dịch tễ

Nấm Candida có thể gây bệnh ở các lứa tuổi khác nhau và ở cả hai giới. Bệnh thường xuất hiện ở những người có yếu tố nguy cơ như đái tháo đường, chứng khô miệng, băng bột, tăng tiết mồ hôi, sử dụng corticosteroid, kháng sinh phổ rộng và suy giảm miễn dịch, bao gồm nhiễm HIV/AIDS.

1.3. Căn nguyên/Cơ chế bệnh sinh

Chủ yếu do *Candida albicans*. Candida bao gồm hơn 100 chủng khác, hầu hết không phát triển và gây bệnh trên người.

2. CHẨN ĐOÁN

2.1. Triệu chứng lâm sàng

- Nhiễm Candida da: vị trí hay gặp là kẽ ngón tay, ngón chân, nếp lằn dưới vú, mông, nách, khoeo. Các yếu tố thuận lợi mắc bệnh là ngâm nước nhiều, nóng, ẩm và béo phì. Nhiễm Candida da biểu hiện dát đỏ rõ rệt, đôi khi trợt thường đi kèm với mụn mủ vệ tinh. Candida có thể phát triển trên tổn thương vùng kẽ do viêm da dầu hoặc vảy nến.

- Nhiễm Candida da/niêm mạc mạn tính và u hạt: gặp ở người suy giảm miễn dịch, có bệnh lý nội tiết, tự miễn dịch, u ác tính. Tổn thương là mảng đỏ, dày sừng, dày da, niêm mạc và có thể tổn thương cả móng. Vị trí hay gặp là ở mặt, da đầu, tay, thân mình. Bệnh tiến triển mạn tính.

- Nhiễm Candida niêm mạc:

+ Viêm lưỡi giả mạc (tưa miệng): biểu hiện có thể cấp hoặc mạn tính. Cấp tính hay gặp ở trẻ em, phụ nữ cho con bú và người già với biểu hiện đám giả mạc màu hơi trắng, trên nền niêm mạc đỏ, phù nề ở lưỡi, vòm miệng, má, vùng hầu. Triệu chứng cơ năng là rát và bông nhẹ. Ở thể mạn tính, tổn thương ít đỏ và phù nề hơn nhưng lan rộng, có thể xuống thực quản. Giả mạc có thể dễ lấy bỏ để lại nền niêm mạc đỏ hoặc trợt.

+ Viêm teo: thượng bì miệng mỏng, cảm giác dát bông, phù. Có thể teo, đỏ và loét ở niêm mạc lưỡi, hay gặp ở người sử dụng răng giả.

+ Viêm góc miệng: vết nứt ở da góc miệng, vảy da trắng, cảm giác đau khi nhai và tổn thương có thể lan ra xung quanh miệng.

+ Viêm âm hộ/âm đạo: tham khảo bài viêm âm hộ/âm đạo do *Candida*.

+ Viêm quy đầu: tổn thương là sẩn đỏ, mụn mủ, vảy tiết, cảm giác kích ứng, đau ở quy đầu và bao da quy đầu. Bệnh hay tái phát.

- Nhiễm *Candida* quanh móng và móng: (tham khảo bài Nấm móng).

2.2. Cận lâm sàng

- Soi tươi trong dung dịch KOH, nước muối sinh lý hay trong tiêu bản nhuộm Gram, Giêm-sa thấy hình ảnh bào tử nấm men kèm giả sợi.

- Nuôi cấy trong môi trường Sabouraud mọc khuẩn lạc màu trắng hoặc vàng kem, bề mặt bóng, mịn.

- Xét nghiệm PCR: giúp phân loại các loài *Candida*.

- Sinh thiết được sử dụng trong chẩn đoán nhiễm *Candida* da/niêm mạc mạn tính. Biểu hiện chủ yếu là viêm dạng u hạt mạn tính.

- Kỹ thuật Maldi – Tof xác định tính chất sinh vật hóa học giúp định danh nấm *Candida*.

- Kháng nấm đồ.

2.3. Chẩn đoán xác định

- Lâm sàng

- Cận lâm sàng: soi tươi trực tiếp, nuôi cấy, phân lập nấm *Candida*

2.4. Chẩn đoán phân biệt

- Nhiễm *Candida* da: viêm kẽ do nguyên nhân khác.

- Nhiễm *Candida* niêm mạc

+ Viêm miệng: viêm niêm mạc do nguyên nhân khác, viêm lưỡi do nhiễm khuẩn.

+ Viêm âm hộ/âm đạo: viêm âm đạo do nguyên nhân khác.

+ Viêm quy đầu: viêm quy đầu do nhiễm khuẩn, do Herpes, vảy nến, hồng sản Queyrat.

+ Nhiễm *Candida* quanh móng và móng: viêm quanh móng do vi khuẩn, bệnh trắng móng, sang chấn móng, vảy nến, chàm đầu chi.

- Nhiễm *Candida* da/niêm mạc mạn tính và u hạt: vảy nến, dày sừng nang lông, bệnh lý đỏ da toàn thân.

3. ĐIỀU TRỊ

3.1. Nguyên tắc chung

- Vệ sinh cá nhân
- Điều trị thuốc kháng nấm tại chỗ
- Điều trị thuốc kháng nấm đường toàn thân
- Điều trị dự phòng, loại trừ các yếu tố nguy cơ

3.2. Điều trị cụ thể

3.2.1. Điều trị nhiễm Candida da

- Lựa chọn thứ nhất: sử dụng thuốc bôi kháng nấm gồm: imidazol (clotrimazol, isoconazol, ketoconazol, miconazol...), allylamine (terbinafin), ciclopirox olamine bôi 2 lần/ngày trong 4 tuần

Một số trường hợp có thể phối hợp corticosteroid bôi ngắn ngày để giảm viêm.

- Lựa chọn thứ 2: sử dụng thuốc toàn thân nếu tổn thương kéo dài, không đáp ứng với thuốc bôi, sử dụng một trong các thuốc dưới đây:

Thuốc	Liều lượng, cách dùng
Fluconazol	Uống 150 mg/tuần x 4 tuần
Itraconazol	Uống 200 mg x 2 lần/ngày, trong 4 tuần
Posaconazol	Uống 800 mg/ngày x 3 tuần
Voriconazol	Tiêm tĩnh mạch 4mg/kg/12 giờ hoặc uống 100-200mg/12 giờ
Echinocandin (caspofungin, micafungin)	Sử dụng cho các trường hợp <i>Candida</i> kháng thuốc

3.2.2. Điều trị nhiễm Candida niêm mạc

- Điều trị viêm lưỡi giả mạc (tưa miệng):

+ Điều trị tại chỗ: lựa chọn đầu tiên cho trẻ em có tổn thương niêm mạc miệng <50% và không có tổn thương sâu, loét; người lớn.

Thuốc	Liều lượng, cách dùng
Nystatin dạng hỗn dịch	Bôi 400.000-600.000 đơn vị 4 lần/ngày x 7-14 ngày
Nystatin dạng viên	Bôi 200.000-400.000 đơn vị (1-2 viên) 4 lần/ngày x 7-14 ngày
Clotrimazol dạng viên	Bôi 10mg 5 – 6 lần/ngày x 7 – 14 ngày

+ Điều trị toàn thân:

- Với người lớn: sử dụng khi không đáp ứng với thuốc tại chỗ hoặc những trường hợp nặng. Liều dùng tương tự như nhiễm Candida da.

- Với trẻ em: sử dụng khi không đáp ứng với thuốc tại chỗ hoặc với các trường hợp nặng trẻ có tổn thương niêm mạc miệng >50% và có tổn thương sâu, loét hoặc trẻ suy giảm miễn dịch, đau hầu họng nhiều (làm ảnh hưởng đến ăn uống)

Thuốc	Liều lượng, cách dùng	
	Tổn thương niêm mạc miệng >50% và có tổn thương sâu, loét	Trẻ suy giảm miễn dịch, đau hầu họng nhiều (ảnh hưởng đến ăn uống)
Fluconazol	6mg/kg uống 1 lần vào ngày đầu tiên (liều tối đa 200mg đối với trẻ không nhiễm HIV và 400mg cho trẻ nhiễm HIV). Ngày tiếp theo 3mg/kg mỗi ngày (liều tối đa 100mg cho trẻ không nhiễm HIV, 200mg cho trẻ nhiễm HIV và dương tính) trong vòng 7-14 ngày	Truyền tĩnh mạch 6mg/kg/ngày trong ngày đầu, ngày tiếp theo 3mg/kg/ngày trong 14 ngày
Amphotericin hoặc echinocandin	Sử dụng nếu kháng thuốc fluconazol	Sử dụng nếu kháng thuốc fluconazol

- Điều trị viêm âm hộ/âm đạo: tham khảo bài viêm âm hộ/âm đạo do *Candida*

4. PHÒNG BỆNH

- Vệ sinh da, niêm mạc thường xuyên.
- Giữ khô các nếp gấp, có thể sử dụng các bột talc làm khô.
- Quần, áo, tất, giày cần làm khô, phơi nắng, là trước khi sử dụng
- Hạn chế dùng các thuốc kháng sinh kéo dài.

NẤM MÓNG

(Onychomycosis)

1. ĐẠI CƯƠNG

1.1. Khái niệm

Nấm móng là tình trạng nhiễm nấm vùng móng, bao gồm nấm sợi dermatophyte (gồm 3 chủng nấm *Microsporum*, *Epidermophyton* và *Trichophyton*), nấm mốc và nấm men.

1.2. Dịch tễ

- Nấm móng là bệnh thường gặp.
- Bệnh xuất hiện ở người lớn nhiều hơn trẻ em.
- Bệnh thường gặp hơn ở người tiểu đường, suy giảm miễn dịch, có bệnh lý da nền (nấm da, tang tiết mồ hôi, vẩy nến...), công việc thường xuyên tiếp xúc với nước.

1.3. Căn nguyên/ Cơ chế bệnh sinh

- Do nấm sợi (Dermatophyte): hầu hết bệnh nấm móng gây ra bởi các loài *Trichophyton*. Một số căn nguyên khác có thể ít gặp là *Epidermophyton floccosum*, *Microsporum* sp và các loài *Arthroderma*.
- Nấm móng do nấm men: hầu hết do *Candida albicans* gây ra. Các loài *Candida* khác bao gồm *Candida tropicalis* và *Candida parapsilosis*. Ngoài ra, còn do *Malassezia spp.* như *M. furfur* nhưng hiếm gặp.
- Một số loài khác Có thể gây bệnh nấm móng nhưng ít gặp hơn bao gồm các loài *Aspergillus*, loài *Scopulariopsis*, loài *Fusarium*, loài *Acremonium*, loài *Syncephalastrum*, loài *Scytalidium*, loài *Paecilomyces*, loài *Neoscytalidium*, loài *Chaetomium*, loài *Onychocola* và loài *Alternaria*.

2. CHẨN ĐOÁN

2.1. Triệu chứng lâm sàng

- Biểu hiện nấm móng do nấm sợi bao gồm: dày sừng dưới móng, trắng móng, mụn móng. Xen kẽ với các những vùng sừng hóa là những vùng tách móng, là nơi cư trú của nấm sợi. Bề mặt móng có thể có đốm hoặc khía trắng.
- Biểu hiện chia làm 3 nhóm, phụ thuộc vào vị trí xâm nhập của nấm vào móng:
 - + Tổn thương ở phần bên và phần xa dưới móng.
 - + Tổn thương ở bề mặt móng.
 - + Tổn thương ở gốc móng.

2.2. Cận lâm sàng

- Soi tươi trực tiếp: hình ảnh tế bào nấm men, sợi nấm chia đốt, phân nhánh.
- Nuôi cấy và phân lập trên môi trường Sabouraud
- Mô bệnh học: ít được chỉ định. Hình ảnh sợi nấm và bào tử arthroconidia có thể gặp ở bản móng và giường móng khi nhuộm PAS, kèm theo ít hoặc không có hiện tượng viêm.
- Dermoscopy: hình ảnh dày sừng dưới móng, bờ tự do hình răng cưa, bản móng màu sắc thay đổi hình ảnh giống cực quang, khối cầu nấm móng

2.3. Chẩn đoán xác định

Dựa vào triệu chứng lâm sàng và xét nghiệm soi trực tiếp.

2.4. Chẩn đoán phân biệt

- Vẩy nến
- Lichen móng
- Loạn dưỡng móng
- Ung thư tế bào hắc tố.

3. ĐIỀU TRỊ

3.1. Nguyên tắc điều trị

- Thuốc bôi tại chỗ trường hợp nhẹ chỉ tổn thương bề mặt móng.
- Điều trị toàn thân khi tổn thương gốc móng, toàn bộ móng, phần bên và phần xa móng.
- Kết hợp bôi và thuốc uống nếu tổn thương nhiều móng hoặc viêm từ 3 móng trở lên.
- Phá hủy móng.

3.2. Điều trị cụ thể

3.2.1. Điều trị tại chỗ

Sử dụng các loại thuốc bôi móng như: efinaconazole 10%, amorolfine 5%, tavaborole 5%, ciclopirox 8%, 1 lần/ngày trong thời gian từ 6-12 tháng.

3.2.2. Điều trị toàn thân

- Lựa chọn hàng đầu với một trong các thuốc sau đây:

Thuốc	Liều người lớn	Liều trẻ em
Itraconazol	- Điều trị ngắt quãng: 200mg x 2 lần/ngày x 1 tuần mỗi tháng x 2 tháng liên tiếp với nấm móng tay hoặc 3-4 tháng liên tiếp với nấm móng chân. - Điều trị liên tục: 200mg/ngày x 6 tuần với nấm móng tay hoặc 12 tuần với nấm móng chân.	- Dùng với trẻ >12 tuổi: Dùng thuốc 1 tuần mỗi tháng trong 2 tháng liên tiếp với nấm móng tay hoặc 3 tháng liên tiếp với nấm móng chân. - Trẻ < 20kg: 5mg/kg/ngày - Trẻ 20 - 40kg: 100mg/ngày. - Trẻ 40 - 50kg: 200mg/ngày. - Trẻ > 50kg: 200mg x 2 lần/ngày.
Terbinafin	250mg/ngày x 6 tuần với nấm móng tay hoặc 12 tuần với nấm móng chân	- Dùng với trẻ > 4 tuổi: Dùng thuốc 6 tuần với nấm móng tay và 12 tuần với nấm móng chân. - Trẻ < 20 kg: 62,5mg/ngày. - Trẻ 20 – 40 kg: 125mg/ngày. - Trẻ > 40kg: 250mg/ngày.

- Lựa chọn thay thế với một trong các thuốc dưới đây:

Thuốc	Người lớn	Trẻ em
Fluconazol	150-450mg x 1 lần/tuần x 6 tháng với nấm móng tay hoặc 12 tháng với nấm móng chân.	6mg/kg x 1 lần/tuần x 3-4 tháng với nấm móng tay hoặc 5-7 tháng với nấm móng chân.
Griseofulvin	20 mg/kg/ ngày cho tới khi móng trở về bình thường	

Lưu ý: cần kiểm tra để phát hiện nấm da chân để điều trị phối hợp đồng thời vì thường cùng tồn tại với bệnh nấm móng. Vùng da xung quanh có thể như một ổ chứa nấm và khiến nấm gây bệnh ở móng có chu kỳ tái nhiễm và tái phát.

3.2.3. Các phương pháp điều trị khác

- Photodynamic therapy (PDT): Phương pháp quang động học gây tổn thương mô bằng cách cho mô tiếp xúc với một bước sóng ánh sáng cụ thể với sự có mặt của chất cảm quang và oxy. Nguồn ánh sáng thường dùng là đèn LED, IPL, Laser.

- Phá huỷ móng: ure, laser.

4. PHÒNG BỆNH

- Vệ sinh cá nhân: cắt tỉa gọn gàng móng tay, móng chân.
- Mang giày tất thoáng rộng, khô ráo. Rắc bột talc giày tất khi sử dụng trong quá trình điều trị.
- Điều trị sớm tổn thương nấm da, nấm tóc.

BỆNH ZONA

(Herpes zoster hay shingles)

1. ĐẠI CƯƠNG

1.1. Khái niệm

Bệnh zona là bệnh nhiễm trùng da gây nên do virus *Herpesvirus Varicellae*, còn gọi là *Varicella zoster virus* (VZV). Bệnh thường biểu hiện là các ban đỏ, mụn nước, bóng nước tập trung thành đám, thành chùm dọc theo đường phân bố của thần kinh ngoại biên. Bệnh do sự tái hoạt của VZV tiềm ẩn ở rễ thần kinh cảm giác cạnh cột sống.

1.2. Dịch tễ

Tỷ lệ mắc bệnh zona tăng lên theo tuổi có thể do sự suy giảm miễn dịch qua trung gian tế bào chống lại VZV.

1.3. Căn nguyên/ Cơ chế bệnh sinh

VZV là một herpesvirus, VZV có thể lây truyền qua nước bọt hoặc lây trực tiếp từ các tổn thương da.

Ở người đã mắc bệnh thủy đậu, sau khi khỏi, virus tồn tại trong các hạch thần kinh cảm giác cạnh cột sống dưới dạng tiềm tàng, im lặng. Khi gặp điều kiện thuận lợi như suy giảm miễn dịch (suy giảm về thần kinh và thể lực, người già yếu, dùng thuốc ức chế miễn dịch, các bệnh về máu, đái tháo đường), bệnh tự miễn, stress, điều trị tia xạ, ung thư, HIV/AIDS..., virus sẽ tái hoạt, nhân lên và lan truyền gây viêm lan toả và hoại tử thần kinh. Đồng thời, virus lan truyền ngược chiều đến da, niêm mạc và gây tổn thương.

2. CHẨN ĐOÁN

2.1. Triệu chứng lâm sàng

- Triệu chứng ban đầu: thường kéo dài 1-5 ngày với cảm giác bất thường trên một vùng da như bỏng, nóng rát, châm chích, tê, đau, dị cảm nhất là về đêm. Người bệnh có thể nhức đầu, sợ ánh sáng và khó chịu. Giai đoạn này được cho là virus lan truyền dọc dây thần kinh.

- Khởi phát: khoảng nửa ngày đến một ngày sau, tổn thương là mảng đỏ, hơi nề nhẹ, đường kính khoảng vài cm, gờ cao hơn mặt da, sắp xếp dọc theo đường phân bố thần kinh và dần dần nối với nhau thành dải, thành vệt.

- Toàn phát:

+ Triệu chứng da: Trên nền dát đỏ xuất hiện mụn nước, bóng nước hình tròn hoặc bầu dục, lõm giữa, tập trung thành đám giống như chùm nho. Mụn nước, bóng nước ban đầu chứa dịch trong, sau hóa mủ hoặc xuất huyết, đập vỡ để lại vết trợt đóng vảy

tiết, đôi khi có thể hoại tử. Thời gian trung bình từ khi phát tổn thương đến khi lành sẹo khoảng 2-4 tuần. Ở người cao tuổi, tổn thương nhiều, lan rộng. Ở trẻ nhỏ, tổn thương ít, tiến triển nhanh.

+ Vị trí thường gặp ở vùng lưng ngực, đầu mặt cổ và mông đùi hoặc khu trú ở vùng niêm mạc miệng, sinh dục, bàng quang. Tổn thương da thường chỉ ở một bên, không vượt quá đường giữa cơ thể và theo đường phân bố của một dây thần kinh ngoại biên. Các trường hợp suy giảm miễn dịch, tổn thương da lan tỏa như thủy đậu và có thể xuất huyết, đôi khi tiến triển nặng.

+ Triệu chứng hạch: Hạch bạch huyết vùng lân cận sưng to.

+ Các rối loạn khác: rối loạn bài tiết mồ hôi, vận mạch, phản xạ dựng lông nhưng hiếm gặp.

+ Viêm thần kinh cấp: đau là triệu chứng hay gặp nhất, đau bỏng rát, đau giật hoặc đau như dao đâm. Mức độ đau đa dạng từ nhẹ như cảm giác rát bỏng, âm ỉ tại chỗ hay nặng như kim châm, giật từng cơn. Triệu chứng đau thường phụ thuộc vào tuổi. Trẻ em, người trẻ đau ít. Người nhiều tuổi thường đau thành từng cơn, kéo dài. Cần phân biệt đau cấp với đau sau Zona.

+ Đau sau zona (post herpetic neuralgia-PHN) là hiện tượng đau dai dẳng trên 3 tháng, thậm chí hàng năm với biểu hiện đau nhạy cảm, rát bỏng, đau âm ỉ hay đau nhói như dao đâm ở vùng da tổn thương zona đã lành sẹo. Bệnh thường xuất hiện ở người già, người suy giảm miễn dịch, mắc bệnh ung thư. Nguyên nhân: do VZV gây viêm, hoại tử và xơ hóa các đầu mút thần kinh. Một số trường hợp có thể kèm đau cơ, đau khớp, mất ngủ do đau, ảnh hưởng chất lượng cuộc sống.

2.2. Cận lâm sàng

- Xét nghiệm tế bào Tzanck: thấy các tế bào gai lệch hình và tế bào đa nhân khổng lồ.

- PCR với bệnh phẩm lấy từ dịch mụn nước, bọt nước và hoặc các mô.

- Xét nghiệm khác với ca bệnh nặng có tổn thương lan tỏa và dai dẳng: xét nghiệm HIV, đường máu,...

2.3. Chẩn đoán xác định

- Chủ yếu dựa vào lâm sàng.

- Một số trường hợp không điển hình có thể phối hợp thêm xét nghiệm tế bào Tzanck và PCR để chẩn đoán xác định.

2.4. Chẩn đoán thể

- Các thể lâm sàng theo vị trí tổn thương:

+ Zona liên sườn và ngực bụng: hay gặp nhất, chiếm 50% trường hợp

+ Zona cổ (đám rối cổ nông) và cổ cánh tay

- + Zona gáy cổ: có tổn thương ở gáy, da đầu, vành tai
- + Zona hông, bụng, sinh dục, bẹn, xương cụt, ụ ngồi, đùi
- Theo hình thái tổn thương: những hình thái này thường gặp ở những người suy giảm miễn dịch như HIV/AIDS, ung thư, hoá trị liệu..., bao gồm:
 - + Zona lan toả
 - + Zona nhiều dây thần kinh
 - + Zona tái phát
- Các thể zona đặc biệt:
 - + Zona mắt: do chiếm 10-15% các thể zona. Do tổn thương thần kinh V hay thần kinh sinh ba chi phối cho mắt, hàm trên và hàm dưới. Trong đó tổn thương nhánh mắt thường gặp hơn gấp 5 lần các nhánh khác. Biểu chứng về mắt có thể gặp như viêm kết mạc, giác mạc, củng mạc, thậm chí nặng đe dọa thị lực như hoại tử võng mạc cấp tính, viêm dây thần kinh thị giác, hội chứng đình ỗ mắt, viêm hậu củng mạc, glaucome thứ phát.
 - + Zona hạch gối hay hội chứng Ramsay Hunt: do tổn thương hạch gối của dây thần kinh VII. Bệnh nhân liệt mặt một bên, ù tai, nghe kém hoặc mất khả năng nghe, buồn nôn, nôn, chóng mặt và giật nhãn cầu. Mắt không nhắm kín được (hở mí), có dấu hiệu Charlier Bell. Mất cảm giác vị giác một bên 2/3 trước lưỡi. Mụn nước mọc ở màng nhĩ, ống tai, vành tai. Có thể có viêm não, màng não.
 - + Zona vùng xương cụt (S2, S3, S4): do viêm dây thần kinh chi phối vùng bàng quang. Bệnh nhân khó tiểu, tiểu dắt, bí tiểu, có trường hợp tiểu máu và tiểu mủ. Đau bụng giống như các triệu chứng ngoại khoa, đau quặn bụng dưới, căng tức, bí trung đại tiện, hậu môn co thắt và cứng như đá không thể khám được, đau nhức vùng da một bên sinh dục kèm theo tổn thương da điển hình của zona.
 - + Zona tai: cảm giác rất bỏng, đau vùng tai, có thể lan ra thái dương và gáy. Đau xảy ra từng cơn kéo dài nhiều ngày làm bệnh nhân không ăn, không ngủ được, đặc biệt là zona tai kết hợp với zona họng gây đau họng không nuốt được. Rối loạn cảm giác vùng mặt, liệt mặt ngoại biên, nghe kém.
 - + Zona ở người nhiễm HIV/AIDS: bệnh zona ở người nhiễm HIV giai đoạn sớm tương tự như ở người bình thường không nhiễm HIV. Ở giai đoạn muộn (AIDS), zona có thể tái phát thường xuyên, tổn thương không điển hình mà thường lan rộng, mụn nước xuất huyết, hoại tử, nhiễm khuẩn, sẹo xấu, bệnh kéo dài dai dẳng.

2.5. Chẩn đoán phân biệt

- Giai đoạn khởi phát: phân biệt với các loại đau như đau đầu, viêm móng mắt, viêm màng phổi, viêm thần kinh cánh tay, đau do bệnh tim, viêm ruột thừa hoặc viêm túi mật, sỏi mật, đau quặn thận, thoát vị đĩa đệm, đau thần kinh tọa.

- Giai đoạn mụn nước, bông nước: phân biệt với herpes simplex, viêm da tiếp xúc dị ứng (với một số loại cây cỏ, côn trùng). Hiếm hơn là một số bệnh da bông nước tự miễn như pemphigus, pemphigoid, Dühring-Brocq, bệnh tăng IgA thành dải.

3. ĐIỀU TRỊ

3.1. Nguyên tắc điều trị

- Điều trị thuốc kháng virus càng sớm càng tốt.
- Điều trị tại chỗ
- Điều trị toàn thân
- Điều trị giảm đau: giảm đau cấp và giảm đau sau Zona.

3.2. Điều trị cụ thể

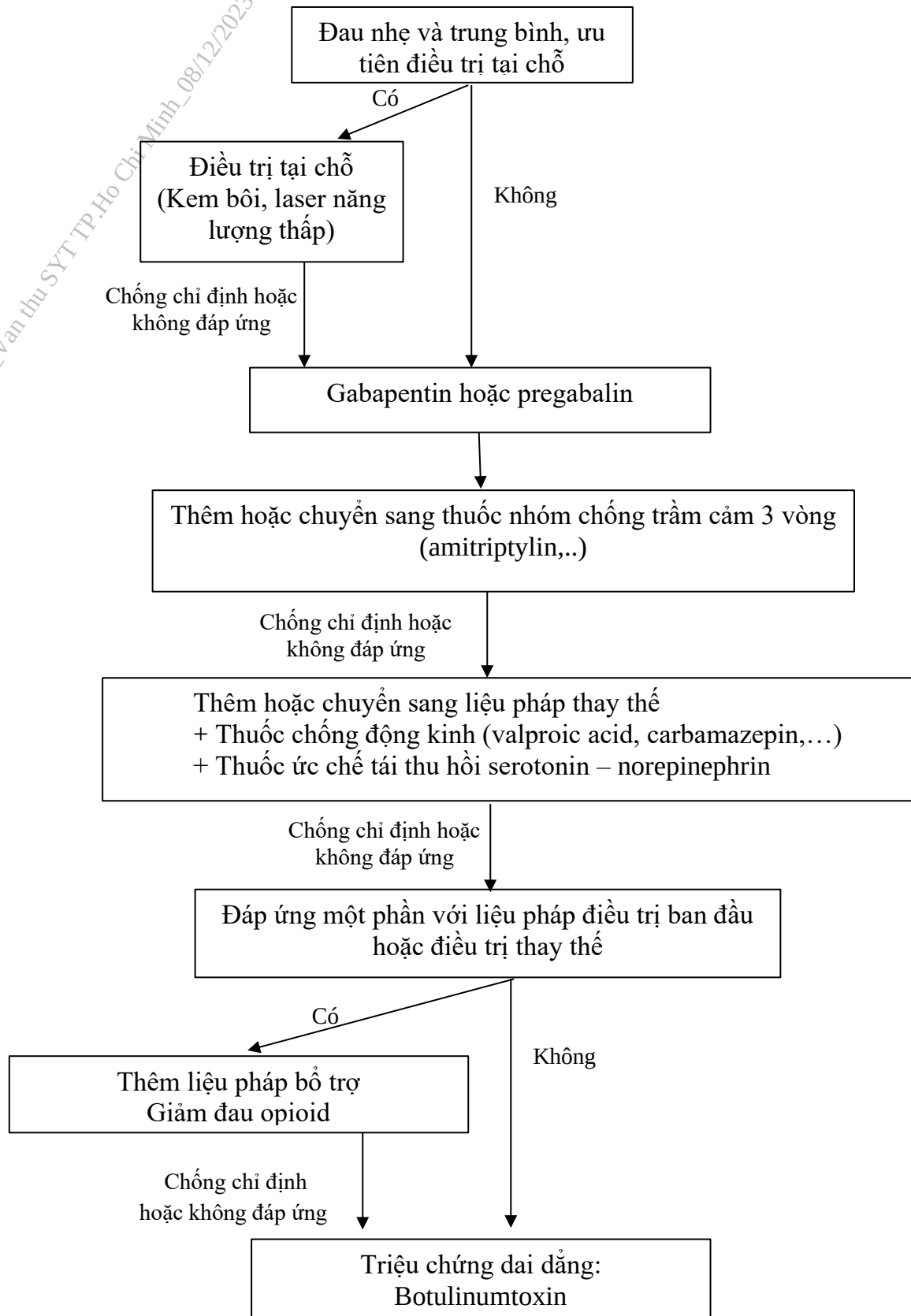
Trường hợp zona không biến chứng và ở người có miễn dịch bình thường:

3.2.1. Điều trị zona

- Điều trị tại chỗ: các dung dịch sát khuẩn, kháng sinh
- Điều trị toàn thân:
 - + Thuốc kháng virus: nên được dùng sớm, tốt nhất trong vòng 72 giờ đầu. Cần điều chỉnh liều ở bệnh nhân suy giảm chức năng thận. Có thể lựa chọn một trong các phác đồ sau:
 - Aciclovir 800mg x 5 lần/ngày x 7 ngày hoặc
 - Famciclovir 500mg x 3 lần/ngày x 7 ngày hoặc
 - Valaciclovir 1000mg x 3 lần/ngày x 7 ngày
 - + Phụ nữ có thai: aciclovir 800mg x 5 lần/ngày trong 7 ngày
 - + Trường hợp suy giảm miễn dịch hay tổn thương lan rộng: Tiêm tĩnh mạch aciclovir 30mg/kg/ngày, chia 3 lần trong 7 ngày hoặc cho đến khi tổn thương đóng vảy tiết
- Điều trị hỗ trợ:
 - + Kháng sinh chống bội nhiễm, (nếu có)
 - + Kháng viêm, an thần,
 - + Các vitamin nhóm B liều cao,
 - + Corticosteroid chỉ dùng trong một số trường hợp đặc biệt như hội chứng Ramsey Hunt...
- Điều trị đau cấp:
 - + Đau nhẹ có thể dùng NSAIDS hoặc các thuốc giảm đau không chứa opioid như acetaminophen
 - + Đau trung bình: nên kết hợp thêm với một loại opioid yếu đến trung bình tùy theo mức độ đáp ứng.
 - + Đau nhiều: phối hợp thêm giảm đau opioid mạnh và có thể thêm các uống thuốc chống động kinh, co giật (gabapentin, pregabalin) hoặc thuốc chống trầm cảm ba vòng (amitriptylin).

3.2.2. Điều trị đau sau zona

Sơ đồ tiếp cận điều trị đau sau zona



- Điều trị tại chỗ:

+ Kem chứa lidocain và prilocain, ngày 3-4 lần. Miếng dán lidocain 5% có thể giúp giảm nhẹ triệu chứng trong một thời gian ngắn, có thể dán tối đa 3 miếng lên vùng tổn thương trong 12h mỗi ngày.

+ Kem bôi hoặc miếng dán capsaicin bôi tại chỗ: giảm lượng canxi đi vào tiền synap (bằng cách bám vào protein TRPV1 - một kênh canxi, cư trú trên màng tế bào thần kinh cảm giác đau và cảm giác biến nhiệt) nên dây thần kinh không thể truyền cảm giác đau trong một khoảng thời gian, từ đó làm giảm cảm giác đau đớn và phong tỏa viêm thần kinh. Sau khi ngưng sử dụng, tế bào thần kinh sẽ phục hồi. Liều dùng: bôi ngày 3-4 lần, dùng điều trị nếu sau 7 ngày không có hiệu quả.

+ Điều trị bằng Botulinum toxin: một số thử nghiệm nhỏ đã đánh giá tiêm botulinum toxin tại chỗ có thể làm giảm đau sau 2 tuần, tác dụng kéo dài trung bình 16 tuần. Bệnh nhân cải thiện giấc ngủ và giảm sử dụng các thuốc giảm đau khác.

+ Laser năng lượng thấp: hỗ trợ làm giảm đau sớm.

- Điều trị toàn thân:

+ Thuốc chống co giật, động kinh:

- Gabapentin: liều 900-2000mg/ngày.
- ✓ Tác dụng phụ: buồn ngủ, ngủ gà, chóng mặt, buồn nôn, đi loạng choạng, run.
- ✓ Hạn chế tác dụng phụ bằng cách tăng dần liều. Dùng 300mg vào ngày 1, 300mg x 2 lần vào ngày thứ 2, 300mg x 3 lần vào ngày thứ 3, sau đó tăng thêm mỗi 300mg/ngày cho đến liều tối đa nếu cần thiết.
- Pregabalin: 150mg-300mg/ngày.
- ✓ Nên dùng tăng dần liều: 75mg x 2 lần mỗi ngày trong một tuần, sau đó 150mg x 2 lần mỗi ngày trong 1-3 tuần, sau đó 300mg x 2 lần mỗi ngày. Khi ngừng thuốc nên giảm liều pregabalin trong 1 tuần để giảm nguy cơ xuất hiện các triệu chứng cai. Tác dụng phụ có thể gặp như buồn ngủ, chóng mặt, khô miệng, tăng cân.

+ Nếu dùng thuốc chống co giật, động kinh không hiệu quả, có thể phối hợp thêm thuốc chống trầm cảm 3 vòng (amitriptylin). Amitriptylin bắt đầu với liều 10mg/ngày, liều tăng lên khi cần thiết và dung nạp được, tối đa 150mg/ngày. Tác dụng phụ: hạ huyết áp tư thế, ngủ gà, khô miệng, lú lẫn, táo bón, bí tiểu, tăng cân. Hạn chế tác dụng phụ bằng cách dùng liều tăng dần. Thận trọng trên bệnh nhân lớn tuổi, suy giảm nhận thức và sa sút trí tuệ, mắc bệnh tim, động kinh hoặc tăng nhãn áp.

+ Carbamazepin liều 400-1200mg/ngày. Tác dụng phụ: chóng mặt, buồn nôn lúc bắt đầu điều trị, hạn chế bằng tăng dần liều.

+ Nhóm thuốc giảm đau opioid (tramadol, fentanyl, morphin,...): có thể sử dụng đường uống hoặc đường truyền.

4. PHÒNG BỆNH

- Kiểm soát người cao tuổi có bệnh lý mạn tính, yếu tố nguy cơ cao.
- Sử dụng vắc xin: có 2 loại là vắc xin tái tổ hợp và vắc xin sống giảm độc lực.

+ Chỉ định:

- Đối tượng người lớn tuổi (từ 50 tuổi trở lên).
- Người trưởng thành từ 19 tuổi trở lên có nguy cơ cao mắc Zona do có tình trạng suy giảm miễn dịch (dùng thuốc ức chế miễn dịch hoặc mắc các bệnh lý gây suy giảm miễn dịch khác). Với đối tượng này chỉ dùng vắc xin tái tổ hợp và chống chỉ định dùng vắc xin sống giảm độc lực

+ Cách dùng:

- Vắc xin sống giảm độc lực: tiêm dưới da 1 mũi
- Vắc xin tái tổ hợp: tiêm bắp 2 mũi, mỗi mũi cách nhau 2-6 tháng.

BỆNH DO HERPES SIMPLEX

(Herpes simplex)

1. ĐẠI CƯƠNG

1.1. Khái niệm

Bệnh da do Herpes simplex là một bệnh gây ra do chủng virus Herpes thông qua hình thức tiếp xúc trực tiếp hoặc từ các chất bài tiết qua da, niêm mạc.

1.2. Dịch tễ

- Bệnh gặp ở mọi lứa tuổi, thường gặp nhất ở người trẻ tuổi. Tỷ lệ nhiễm cao ở những nơi đông dân, chật chội và điều kiện vệ sinh kém.
- Bệnh thường tái phát, có thể một vài lần/năm.
- Bệnh thường nặng hơn và hay tái phát hơn ở người suy giảm miễn dịch, có bệnh ác tính, ghép tạng, điều trị hóa chất, dùng corticosteroid hay thuốc ức chế miễn dịch toàn thân kéo dài.

1.3. Căn nguyên/ Cơ chế bệnh sinh

- Có 2 loại virus Herpes simplex chính là HSV1 và HSV2:
 - + HSV1: thường gây bệnh ở da, niêm mạc phần trên của cơ thể như mắt, mũi, miệng. Lây truyền bằng tiếp xúc trực tiếp với virus qua tổn thương trực tiếp hoặc qua nước bọt.
 - + HSV2: thường gây bệnh ở da, niêm mạc bộ phận sinh dục, hậu môn. Bệnh lây truyền qua quan hệ tình dục.
 - + Tuy nhiên hiện nay HSV1 cũng có thể gây bệnh ở bộ phận sinh dục, hậu môn và HSV2 cũng có thể gây bệnh ở phần trên của cơ thể (do quan hệ đường miệng - sinh dục).
- Ở trạng thái tiềm ẩn, virus cư trú ở các hạch thần kinh cảm giác. Khi tái hoạt động virus di chuyển dọc theo dây thần kinh đến da/niêm mạc gây hủy hoại các tế bào sừng.
- Virus có thể được đào thải ra bên ngoài theo nước bọt và chất bài tiết của bộ phận sinh dục ngay cả khi chưa có triệu chứng. Các bất thường về hệ miễn dịch và những bất thường tại da như viêm da cơ địa cũng là điều kiện thuận lợi để virus phát triển.

2. CHẨN ĐOÁN

2.1. Lâm sàng

- Vị trí tổn thương: da, bán niêm mạc, niêm mạc.
- HSV tiên phát:

- + Thời gian ủ bệnh: 3 - 5 ngày.
- + Tiền triệu: ngứa, dầm dết tại chỗ.
- + Toàn phát: tổn thương cơ bản là mụn nước trên nền dát đỏ, mụn nước bằng đầu đinh ghim căng tròn bên trong chứa dịch vàng hoặc trong suốt, thường đứng thành cụm từ 2 - 10 mụn nước. Có khi các mụn nước liên kết với nhau thành bọng nước nhỏ. Các mụn nước, bọng nước sắp xếp thành hình vòng cung, vỡ sau vài ngày để lại các vết trợt hình đa cung.
- + Triệu chứng toàn thân: có thể sốt, mệt mỏi, chán ăn, hạch lân cận sưng to, đau.
- HSV tái phát:
 - + Sau khi nhiễm tiên phát, các triệu chứng bệnh khỏi, bệnh nhân có thể không có biểu hiện lâm sàng nào trong suốt cuộc đời.
 - + Yếu tố nguy cơ có thể như sang chấn nhẹ, các bệnh nhiễm trùng khác, viêm đường hô hấp trên, tia tử ngoại, các phẫu thuật, một số phụ nữ tái phát liên quan đến chu kỳ kinh nguyệt, các stress
 - + Triệu chứng lâm sàng thường nhẹ hơn, khu trú hơn.
 - Biến chứng: viêm màng não, eczema herpeticum.

2.2. Cận lâm sàng

- Xét nghiệm tế bào Tzanck: thấy tế bào đa nhân khổng lồ, tế bào gai lệch hình.
- Xét nghiệm huyết thanh ELISA tìm kháng thể kháng HSV (IgG và IgM).
- Xét nghiệm tìm virus: PCR.

2.3. Chẩn đoán xác định

Dựa vào lâm sàng và cận lâm sàng.

2.4. Chẩn đoán phân biệt

- Zona
- Chốc bọng nước
- Duhring-Brocq
- Các loét sinh dục khác: hạ cam, giang mai, vết loét sang chấn vùng sinh dục, sưng ghè, pemphigus, Behcet..
- Viêm da tiếp xúc kích ứng do côn trùng

3. ĐIỀU TRỊ

3.1 Nguyên tắc điều trị

- Điều trị tại chỗ: sử dụng thuốc sát khuẩn tại chỗ làm giảm nguy cơ nhiễm khuẩn.
- Điều trị toàn thân: sử dụng thuốc kháng virus. Trường hợp nhẹ, tổn thương da ít, không có biến chứng có thể không cần điều trị toàn thân.

3.1. Điều trị cụ thể

3.1.1. Điều trị tại chỗ

- Dùng các dung dịch sát khuẩn tại chỗ
- Kháng sinh bôi tại chỗ chống nhiễm khuẩn như mupirocin, acid fusidic

3.1.2. Điều trị toàn thân

Lựa chọn một trong các phác đồ dưới đây, ưu tiên aciclovir do tương đương về hiệu quả và tối ưu chi phí điều trị.

Điều trị HSV tiên phát	Điều trị HSV tái phát	Điều trị dự phòng
- Trường hợp mắc mức độ nhẹ và vừa: + Aciclovir uống 400mg x 3 lần/ngày x 5 – 10 ngày + Aciclovir uống 200mg x 5 lần/ngày 5 – 10 ngày + Valaciclovir uống 500mg x 2 lần/ngày 5 – 10 ngày + Famciclovir uống 250mg x 3 lần/ngày 5 – 10 ngày + Trẻ em: 15mg/kg x 5 lần/ngày x 7 ngày. + Trẻ sơ sinh: aciclovir tĩnh mạch 60mg/kg/ngày chia 3 lần x 2 – 3 tuần. - Trường hợp nặng /nguy cơ biến chứng nghiêm trọng: aciclovir 5mg/kg đường tĩnh mạch mỗi 8 giờ trong ít nhất 5 ngày.	- Aciclovir uống 800mg 3 lần/ngày x 2 ngày hoặc 400mg x 3 lần/ngày trong 3 – 5 ngày. - Famciclovir 1g 2 lần/ngày x 1 ngày hoặc 125mg x 2 lần/ngày trong 3 – 5 ngày. - Valaciclovir 500mg x 2 lần/ngày trong 3 ngày.	- Phác đồ ưu tiên: + Aciclovir 400mg x 2 lần/ngày (cho tất cả bệnh nhân tái phát ≥ 6 đợt/năm) + Valaciclovir 500mg hàng ngày nếu tái phát ≤ 10 đợt/năm + Valaciclovir 1g hàng ngày nếu tái phát > 10 đợt/năm - Nếu thất bại với phác đồ ưu tiên: + Aciclovir 400mg x 3 lần/ngày + Aciclovir 200mg x 4 lần/ngày + Valaciclovir 500mg x 2 lần/ngày

- Điều trị biến chứng nếu có.

4. PHÒNG BỆNH

- Không tiếp xúc trực tiếp hoặc tiếp xúc với chất bài tiết qua da, niêm mạc của người mắc herpes simplex.
- Nâng cao thể trạng, dự phòng tái phát.

BỆNH THỦY ĐẬU

(Varicella)

1. ĐẠI CƯƠNG

1.1. Khái niệm

Thủy đậu là bệnh lý phát ban và mụn nước cấp tính, có thể lây truyền thành dịch. Bệnh thường lành tính, tuy nhiên cũng có thể gây biến chứng nguy hiểm như viêm phổi, viêm não...

1.2. Dịch tễ

Bệnh lây truyền trực tiếp từ người sang người, qua đường hô hấp, thường xảy ra ở trẻ em.

1.3. Căn nguyên/ Cơ chế bệnh sinh

Tác nhân gây thủy đậu là Varicella zoster virus-VZV, thuộc họ Herpeviridae. Đường lây chủ yếu qua hô hấp, virus được bài tiết qua niêm mạc mũi họng và truyền cho người khác. Virus cũng được bài xuất qua các tổn thương mụn nước và lây truyền cho trực tiếp cho người nhiễm. Bệnh nhân có thể lây bệnh cho người khác từ 1-2 ngày trước khi nổi ban đỏ cho đến khi mụn nước cuối cùng đóng vảy tiết.

2. CHẨN ĐOÁN

2.1. Triệu chứng lâm sàng

- Thời gian ủ bệnh khoảng 14 ngày (10 - 23 ngày). Trước khi xuất hiện các mụn nước thủy đậu có thể có triệu chứng toàn thân như: sốt, nhức đầu, mệt mỏi...
- Triệu chứng da xuất hiện sớm nhất là các ban đỏ, các sẩn sau đó nhanh chóng thành các mụn nước. Các mụn nước rất nhỏ như những giọt sương trên cánh hoa hồng, nông, xung quanh là quầng đỏ, ở giữa lõm. Kích thước mụn nước khoảng 2-3mm. Mụn nước nhanh chóng thành mụn mủ và đóng vảy tiết, có thể mọc ở niêm mạc mắt miệng, để lại vết trợt nông nhưng thường ít. Trên người bệnh cùng lúc các tổn thương là sẩn, mụn nước, mụn mủ và vảy tiết.
- Những biến chứng nghiêm trọng của thủy đậu có thể xảy ra trên những người có suy giảm miễn dịch như dùng corticosteroid, các thuốc ức chế miễn dịch khác, nhiễm HIV/AIDS... Các biến chứng khác có thể xảy ra là viêm phổi, viêm não - màng não, nhiễm khuẩn tại chỗ... Phụ nữ có thai mắc thủy đậu trong 3 tháng đầu thai kỳ có thể gây sảy thai, tử vong thai nhi hay bị dị tật như đầu nhỏ, bại não, sẹo trên da bẩm sinh do các nốt thủy đậu để lại...

2.2. Cận lâm sàng

- Xét nghiệm tế bào Tzanck: có tế bào đa nhân khổng lồ tại nền bọt nước của tổn

thương.

- Xét nghiệm tìm căn nguyên: PCR
- Xét nghiệm đánh giá tình trạng viêm: CRP, bạch cầu, máu lắng... có thể tăng
- Xquang ngực trong trường hợp nghi ngờ viêm phổi

2.3. Chẩn đoán xác định

Dựa vào lâm sàng và xét nghiệm tế bào học dịch tổn thương trong một số trường hợp không điển hình.

2.4. Chẩn đoán phân biệt.

- Bệnh tay chân miệng
- Chốc
- Herpes simplex
- Zona trên bệnh nhân suy giảm miễn dịch
- Eczema herpeticum

3. ĐIỀU TRỊ

3.1. Nguyên tắc điều trị

- Điều trị sớm, nâng cao thể trạng
- Sử dụng thuốc kháng vi rút
- Điều trị biến chứng

3.2. Điều trị cụ thể

3.2.1. Điều trị tại chỗ

- Chăm sóc các tổn thương da: dùng các dung dịch sát khuẩn, kháng sinh chống bội nhiễm
- Khi mắc bệnh vẫn cần vệ sinh hàng ngày để tránh nhiễm trùng.

3.2.2. Điều trị toàn thân

- Điều trị thuốc kháng virus:

+ Đối với những người có nguy cơ cao bị biến chứng như người lớn chưa tiêm phòng, phụ nữ có thai, người bị suy giảm miễn dịch, nên sử dụng thuốc kháng virus sớm trong vòng 24 giờ đầu sau khi phát ban:

- Người lớn và trẻ ≥ 12 tuổi: Aciclovir 800 mg, uống 5 viên/ ngày, chia 5 lần, cách 4h uống 1 viên, trong 1 tuần hoặc valaciclovir 1g, uống 3 lần/ ngày, cách nhau 8h, trong 1 tuần, hoặc famciclovir 500mg, uống 3 lần/ ngày, cách nhau 8h, trong 7-10 ngày.

- Trẻ <12 tuổi: aciclovir 20 mg/kg 6 giờ một lần hoặc valaciclovir 20mg/kg, cách nhau 8h uống 1 liều, trong 5-7 ngày.
 - Người bệnh suy giảm miễn dịch nặng, thủy đậu biến chứng viêm não: ưu tiên aciclovir tĩnh mạch, ít nhất trong giai đoạn đầu, liều 10 - 12,5 mg/kg, 8 giờ một lần, để làm giảm các biến chứng, thời gian điều trị là 7 ngày.
- Điều trị biến chứng viêm phổi, bội nhiễm tổn thương da nếu có.
- Điều trị hỗ trợ:
- + Hạ sốt bằng paracetamol, tránh dùng aspirin để ngăn ngừa hội chứng Reye
 - + Giảm ngứa bằng kháng histamin
 - + Tăng cường dinh dưỡng

4. PHÒNG BỆNH

- Tránh tiếp xúc với nguồn lây, người mắc bệnh nên cách ly với những người khác trong cộng đồng cho đến khi khỏi bệnh.
- Tiêm phòng vắc xin thủy đậu. Vaccin thủy đậu là vaccin sống giảm độc lực, tái tổ hợp được chỉ định cho tất cả trẻ em trên 1 tuổi chưa mắc thủy đậu và người lớn chưa có kháng thể. Vaccin thủy đậu có tính an toàn và hiệu quả cao.

BỆNH HẠT CƠM (Warts)

1. ĐẠI CƯƠNG

1.1. Định nghĩa

Bệnh hạt cơm (bệnh mụn cóc do virus) là tình trạng bệnh lý với sự tăng sinh lành tính của các tế bào biểu bì ở da và niêm mạc, do virus có tên *Human Papilloma Virus* (HPV) gây nên.

1.2. Dịch tễ

Hạt cơm là bệnh thường gặp, bệnh xuất hiện ở mọi lứa tuổi và mọi giới. Tuy nhiên, thường gặp nhất ở tuổi lao động, đặc biệt là học sinh và sinh viên. Tỷ lệ mắc bệnh cao hơn ở những người suy giảm miễn dịch, đặc biệt là suy giảm miễn dịch bẩm sinh hay mắc phải.

Sự lây nhiễm HPV có thể do tiếp xúc trực tiếp giữa người với người qua da bị xây sát hoặc qua các vật dụng trung gian như giày dép, dụng cụ thể thao...

1.3. Căn nguyên/ Cơ chế bệnh sinh

Có khoảng trên 100 tuýp HPV đã được xác định và được chia thành 3 nhóm: tuýp gây bệnh da: tuýp 1, 2, 3, 4; tuýp gây bệnh ở niêm mạc sinh dục: tuýp 6, 11, 16, 18 và type gây loạn sản biểu bì dạng hạt cơm là tuýp 5 và 8.

2. CHẨN ĐOÁN

2.1. Triệu chứng lâm sàng

– Hạt cơm thông thường (common warts)

+ Thường gặp nhất.

+ Tổn thương ban đầu là những sẩn nhỏ bằng hạt kê, màu da. Sau vài tuần hoặc vài tháng, thương tổn lớn dần, nổi cao, có hình bán cầu, bề mặt sần sùi thô ráp, dày sừng với nhiều kích thước khác nhau. Các thương tổn rải rác hoặc thành dải hoặc thành đám hay gặp ở mu bàn tay, mu bàn chân, ngón tay và ngón chân, quanh móng, da đầu.

– Hạt cơm bàn tay, bàn chân (palmo-plantar warts)

+ Hạt cơm ở bàn tay, bàn chân thường đa dạng. Diễn hình là các sẩn, kích thước từ 2-10mm, bề mặt xù xì làm mất những đường vân trên bề mặt, sắp xếp riêng rẽ hoặc tập trung thành đám ở những vùng tỳ đè, quanh móng được gọi là hạt cơm thể khảm. Đôi khi biểu hiện của hạt cơm chỉ là sẩn nhẵn, bằng phẳng với mặt da, màu vàng đục hoặc sẩn xù xì có gai nhỏ và lõm ở giữa. Bệnh nhân thường đau khi đi lại.

+ Khi dùng dao mổ gạt bỏ phần dày sừng thấy bên dưới là một mô màu trắng trên có các chấm đen do hiện tượng tắc các mạch máu nhỏ tạo nên. Đây là dấu hiệu có giá trị giúp chẩn đoán phân biệt giữa hạt com với những bệnh khác như chai chân hay dày sừng bàn tay bàn chân khu trú.

– Hạt com phẳng (flat warts): Tổn thương là các sẩn hơi nổi cao trên mặt da, bề mặt phẳng, kích thước nhỏ từ 1 đến 5 mm, hình tròn hay hình đa giác, màu da hay thâm vàng nâu, ranh giới rõ đứng riêng rẽ hay thành đám, đôi khi thành dải (dấu hiệu Koebner). Số lượng thương tổn thường ít nhưng ở những trường hợp lan tỏa có tới vài trăm thương tổn, hay gặp ở vùng da hở nhất là ở mặt, cánh tay và thân mình.

2.2. Cận lâm sàng

- PCR HPV: dương tính.

- Mô bệnh học: thường được sử dụng để chẩn đoán phân biệt với ung thư da hoặc các bệnh lý da khác. Hình ảnh tăng sinh thượng bì, các tế bào nhiễm virus là các koilocyte (nhân lớn, bắt màu kiềm, xung quanh là quang sáng halo, nguyên sinh chất ít).

- Dermoscopy: trường hợp điển hình có thể quan sát thấy các điểm đen trên nền tổn thương sùi.

2.3. Chẩn đoán xác định

Chủ yếu dựa vào triệu chứng lâm sàng và xét nghiệm HPV, mô bệnh học trong trường hợp cần thiết.

2.4. Chẩn đoán phân biệt

- Hạt com thông thường: cần phân biệt với dày sừng da đầu, dày sừng ánh nắng, ung thư tế bào gai.

- Hạt com lòng bàn tay, bàn chân: cần chẩn đoán phân biệt với mắt cá, chai chân, dày sừng lòng bàn tay, bàn chân mắc phải.

- Hạt com phẳng: cần phân biệt với các sẩn trong bệnh lichen phẳng, u mềm lây...

3. ĐIỀU TRỊ

3.1. Nguyên tắc điều trị

- Bệnh có thể tự khỏi trong trường hợp miễn dịch tốt.
- Loại bỏ tổn thương
- Dự phòng tái phát.

3.2. Điều trị cụ thể

3.2.1. Thuốc bôi tại chỗ

- Mỡ salicylic: mỡ salicylic với nồng độ khác nhau từ 10% đến 40%, có tác dụng bạt sừng mạnh, loại bỏ các tế bào chứa virus. Tùy từng loại thương tổn và tùy theo vị trí

mà có thể sử dụng thuốc với nồng độ khác nhau từ 10% đến 40%. Băng bột làm thuốc có thể ngấm sâu vào thương tổn có tác dụng điều trị tốt hơn.

- Acid trichloroacetic 33-100%: có tác dụng đông vón protein và gây hoại tử tế bào sừng. Ưu điểm là rẻ tiền, nhược điểm là có thể gây đau nhiều và gây loét do bôi thuốc quá nhiều

- Kem tretinoin 0,05%-0,1% có tác dụng bạt sừng, thường được dùng để điều trị hạt cơm phẳng, nhất là ở trẻ em.

- Sulfat kẽm dạng dung dịch bôi tại chỗ, ngày bôi 1 đến 2 lần. Phân tử kẽm gắn lên các phân tử glycoprotein trên bề mặt virus làm ngăn cản sự thâm nhập của virus vào tế bào. Thuốc ít gây kích ứng và cho kết quả tốt đối với những trường hợp nhiều thương tổn.

- Podophyllotoxin 25% là thuốc chống phân bào. Chấm thuốc ngày 2 lần, trong 3 ngày, sau đó ngừng 4 ngày. Nếu còn thương tổn lại tiếp tục điều trị với liệu trình như trên, tối đa có thể điều trị trong thời gian 5 tuần. Cần lưu ý bôi đúng thương tổn và phải rửa tay sau khi dùng thuốc vì thuốc có thể gây kích ứng ở da và niêm mạc. Cần thận trọng sử dụng thuốc đối với phụ nữ có thai vì có thể gây ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi.

- Imiquimod: Kem imiquimod 5% bôi ngày 2 lần trong 6 đến 12 tuần. Hiệu quả hạn chế với các tổn thương dày sừng, tốt hơn với các tổn thương ở niêm mạc.

3.2.2. Tiêm nội thương tổn

Leomycin có tác dụng gây độc tế bào, tiêm nồng độ 1 UI/ml nội tổn thương.

3.2.3. Liệu pháp lạnh

Sử dụng nitơ lạnh ở nhiệt độ -196°C gây bỏng lạnh làm bong thương tổn. Phương pháp xịt nitơ lỏng thường được sử dụng hơn chấm nitơ lỏng và áp nitơ vì dễ sử dụng và hiệu quả cao. Thời gian liền thương sau thủ thuật nhanh hơn so với laser. Nhược điểm của phương pháp này là có thể cần thực hiện nhiều lần.

3.2.4. Laser

- Loại laser thường được sử dụng nhất là laser CO₂ làm phá vỡ tế bào và làm bốc bay toàn bộ tổ chức. Phương pháp có ưu điểm làm sạch nhanh thương tổn trong 1 lần điều trị. Tuy nhiên, vết thương thường lâu, tỉ lệ tái phát cao với hạt cơm dưới móng và quanh móng.

- Laser màu: phá hủy các mạch máu làm giảm nguồn nuôi dưỡng các tế bào chứa virus từ đó có tác dụng điều trị bệnh. Thường áp dụng để điều trị hạt cơm phẳng với số lượng tổn thương nhiều, đặc biệt ở mặt vì ưu điểm ít đau, nguy cơ sẹo sau thủ thuật rất thấp. Khoảng cách giữa các lần điều trị là 1 tháng/lần. Nhược điểm của phương pháp là đắt tiền.

- Laser Nd:YAG xung dài cũng có thể sử dụng để điều trị hạt com, cho kết quả cao với số lần điều trị 1-3 lần, cách nhau 2-4 tuần/lần. Ưu điểm là vết thương nhanh liền, ít ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày của bệnh nhân. Nhược điểm là đau và đắt tiền.

- Điều trị bằng plasma: hiệu quả cao tương tự như điều trị bằng laser nhưng do nhiệt lan toả lớn hơn laser nên thời gian liền thương chậm hơn.

4. PHÒNG BỆNH

- Sát khuẩn làm vệ sinh thường xuyên các địa điểm công cộng như bể bơi, nhà tắm công cộng, phòng tập thể thao...

- Cần có bảo hộ lao động đối với một số nghề nghiệp có nguy cơ mắc bệnh cao như: thợ giết mổ gia súc, trồng hoa...

- Điều trị loại bỏ các tổn thương nếu có thể nhằm loại bỏ nguồn lây nhiễm.

U MỀM LÂY (Molluscum Contagiosum)

1. ĐẠI CƯƠNG

1.1. Khái niệm

U mềm lây là bệnh nhiễm trùng da do *Molluscum Contagiosum Virus* (MCV) gây nên, đặc trưng bởi các sẩn lõm giữa, sờ mềm, rải rác trên cơ thể.

1.2. Dịch tễ

- Bệnh có thể xảy ra ở bất kỳ lứa tuổi nào nhưng thường gặp nhất ở trẻ em.
- Phương thức lây truyền là tiếp xúc trực tiếp hay gián tiếp qua các dụng cụ, tắm cùng bể tắm, dùng khăn, dụng cụ thể thao chung hoặc ngồi cùng ghế.

1.3. Căn nguyên/ Cơ chế bệnh sinh

Virus MCV thuộc nhóm poxvirus, có 4 type virus là MCV 1, 2, 3 và 4. Hai type thường gặp là MCV 1 và MCV 2. Tuy nhiên, type 1 là nguyên nhân chủ yếu còn type 2 thường gây u mềm lây ở người lớn và được xếp vào nhóm các bệnh lây truyền qua đường tình dục.

2. CHẨN ĐOÁN

2.1. Triệu chứng lâm sàng

- Thời gian ủ bệnh: từ 2 tuần đến 6 tháng.
- Tổn thương cơ bản là các sẩn mềm màu hồng nhạt, trắng đục hoặc vàng hoặc màu da thường với kích thước từ 2-6mm đường kính, lõm giữa, đứng riêng rẽ hoặc thành từng đám, có thể sắp xếp thành dải, theo vết (dấu hiệu Koebner). Vị trí thường gặp ở trẻ em là vùng da hở như mặt, cổ, nếp gấp. Vị trí thường gặp ở người lớn là vùng bụng dưới, phía trong đùi, xương mu và sinh dục. Bệnh có thể xuất hiện ở một vài vị trí ít gặp như miệng, lưỡi, lòng bàn tay, bàn chân.
- Ở những bệnh nhân bị suy giảm miễn dịch như nhiễm HIV, mắc các bệnh mạn tính, bẩm sinh, hoặc điều trị bằng các thuốc ức chế miễn dịch, tổn thương u mềm lây thường có kích thước lớn hơn, lan tỏa toàn thân với số lượng nhiều và tồn tại dai dẳng.

2.2. Cận lâm sàng

- Xét nghiệm tế bào Tzanck: phát hiện các tế bào sừng có kích thước lớn, trong chứa nhiều thể vùi (tiểu thể mềm lây).
- Mô bệnh học: Ít khi chỉ định, thường làm để chẩn đoán phân biệt với các bệnh da khác.
- Dermoscopy: hình ảnh cấu trúc màu trắng ở trung tâm, giãn mạch máu ở rìa tổn thương tạo hình ảnh vương miện.

- PCR: ít khi sử dụng.

2.3. Chẩn đoán xác định

Chủ yếu dựa vào các đặc điểm lâm sàng và xét nghiệm tế bào học

2.4. Chẩn đoán phân biệt

- Milia.
- Hạt com phẳng.
- U ống tuyến mồ hôi.
- Tổn thương da do *Penicillium marneffe*.

3. ĐIỀU TRỊ

3.1. Nguyên tắc điều trị

- Loại bỏ tổn thương.
- Phòng tránh tái nhiễm.
- Điều trị các bệnh kèm theo: viêm da cơ địa, khô da.

3.2. Điều trị cụ thể

- Loại bỏ tổn thương bằng curett
- Điều trị bằng các thuốc bôi:
 - + Dung dịch KOH 5- 10%: chấm dung dịch lên đúng tổn thương bằng tăm nhọn, ngày một lần cho đến khi tổn thương đỏ, đóng vảy tránh vị trí sát mắt. Ưu điểm là phương pháp rẻ tiền. Thận trọng có thể gây loét hoặc sẹo xấu nếu chấm một lượng thuốc lớn.
 - + Salicylic 10-30%: bôi ngày 2-3 lần cho đến khi hết tổn thương.
 - + Imiquimod 5%: bôi thuốc vào buổi tối, rửa sạch sau 8-10 giờ. Một tuần bôi ba ngày liên tiếp, nghỉ 4 ngày, tuần tiếp theo điều trị với liều trình tương tự. Thời gian bôi tối đa có thể tới 16 tuần. Không dùng cho trẻ < 12 tuổi
- Một số phương pháp điều trị khác: bôi cantharidin, podophyllotoxin.

4. PHÒNG BỆNH

- Vệ sinh cá nhân.
- Tránh tiếp xúc với nguồn lây bệnh, nhất là ở những nơi có nhiều virus như bể bơi, nhà tắm công cộng.
- Cần theo dõi và điều trị sớm ở những người có nguy cơ mắc bệnh cao như trẻ em mắc viêm da cơ địa, khô da.

BỆNH LUPUS BAN ĐỎ HỆ THỐNG

(Systemic lupus erythematosus)

1. ĐẠI CƯƠNG

1.1. Khái niệm

Lupus ban đỏ hệ thống là bệnh lý tự miễn, do tự kháng thể và phức hợp miễn dịch lưu hành trong máu đến các cơ quan gây tổn thương nhiều cơ quan như da, niêm mạc, gan, thận, khớp, tim, phổi, hệ thần kinh.

1.2. Dịch tễ

Bệnh thường gặp ở phụ nữ trong độ tuổi 20-50 tuổi, nam giới ít gặp hơn.

1.3. Căn nguyên/Cơ chế bệnh sinh

- Căn sinh bệnh học của lupus ban đỏ hệ thống rất phức tạp, do nhiều yếu tố tham gia: di truyền, hormon, rối loạn miễn dịch, yếu tố môi trường. Trong đó hai yếu tố chính, quan trọng nhất được cho là có liên quan trực tiếp đến bệnh là di truyền và rối loạn miễn dịch.

+ Di truyền: đã xác định được một số gen có liên quan đến bệnh, đó là HLA-B8, HLA-DR 3, HLA-DRw52, HLA-DQw1.

+ Rối loạn miễn dịch: có hiện tượng mất cân bằng trong hệ thống miễn dịch. Tế bào lympho B không bị kiểm soát sẽ tăng sinh để sản xuất một lượng lớn các tự kháng thể chống lại các tự kháng nguyên. Tự kháng thể kết hợp với các tự kháng nguyên tạo thành phức hợp miễn dịch lắng đọng tại các mao mạch, cơ quan, tổ chức cùng với các bổ thể gây nên các hiện tượng bệnh lý ở nhiều tổ chức, cơ quan.

- Một số yếu tố liên quan khác

+ Nội tiết tố nữ: bệnh hay gặp ở nữ giới.

+ Thuốc: một số thuốc có khả năng gây bệnh giống như lupus đã được xác định: hydralazin, procainamid, isoniazid, sulfonamid, phenytoin, D-penicillamin, minocyclin... Thuốc tránh thai cũng có vai trò trong việc khởi động hay làm bệnh nặng thêm.

+ Nhiễm trùng: đặc biệt là các nhiễm trùng kinh điển.

+ Ánh nắng mặt trời: đóng vai trò quan trọng trong sinh bệnh học của bệnh.

2. CHẨN ĐOÁN

2.1. Triệu chứng lâm sàng

2.1.1. Triệu chứng toàn thân

Sốt, mệt mỏi, gầy sút là những biểu hiện hay gặp, đặc biệt trong giai đoạn bệnh tiến triển.

2.1.2. Tổn thương da, niêm mạc, tóc

- Tổn thương da

+ Tổn thương da đặc hiệu:

• Tổn thương cấp tính: ban đỏ khu trú hình cánh bướm ở hai má, mặt, hơi phù, có thể tồn tại trong nhiều tuần, nhiều tháng. Dát đỏ lan tỏa xuất hiện ở tay, chân

hay, thân mình ít gập hơn. Các dát nhạy cảm với ánh nắng mặt trời. Hiếm gặp ban cấp tính dạng hoại tử thượng bì.

- **Tổn thương bán cấp:** tổn thương dát sần bong vảy dạng “vảy nến” vùng ngực, lưng, cánh tay. Tổn thương mảng hình nhẫn, hình vòng, trung tâm không có vảy. Một số trường hợp hiếm gặp bong nước căng hoặc ban đỏ bán cấp dạng hoại tử thượng bì.

- **Tổn thương mạn tính:** lupus ban đỏ dạng đĩa khu trú hoặc lan tỏa: mảng đỏ, trên có vảy da, sần sùng nang lông, chậm lành, khi khỏi để lại tăng sắc tố, sẹo trắng, teo da trung tâm. Lupus thể phi đại, lupus profundus, viêm mô mỡ, lupus tumidus, lupus dạng cước là những tổn thương da mạn tính ít gặp.

- + **Tổn thương da không đặc hiệu:** sần phù, ban xuất huyết, viêm mạch/mao mạch gây xuất huyết, loét, hoại tử, viêm mạch dạng mạng lưới, lắng đọng canxi, hội chứng raynaud, tổn thương bong nước,... có thể gặp.

- **Tổn thương niêm mạc:** Môi, miệng, mũi, sinh dục trong đó thường gặp nhất ở niêm mạc khẩu cái cứng. Biểu hiện dát đỏ, xuất huyết, trợt, loét và thường không đau.

- **Rụng tóc**

- + **Rụng tóc không sẹo kiểu rụng thưa hay rụng lan tỏa toàn bộ có thể gặp.** Tóc có thể mọc lại khi lui bệnh.

- + **Rụng tóc có sẹo gây mất các nang tóc và không thể mọc lại.**

2.1.3. Tổn thương các cơ quan

- **Tổn thương khớp:** viêm sưng đau, cứng khớp nhỏ nhỏ (hay gặp khớp bàn ngón tay, ngón chân, cổ tay, khuỷu tay, đầu gối...) gây hạn chế vận động. Một số có thể gặp tràn dịch các khớp.

- **Viêm cơ:** viêm cơ, yếu cơ. Triệu chứng hồi phục nhanh sau điều trị bằng corticosteroid đường toàn thân.

- **Tổn thương thận:** viêm thận lupus với tổn thương tiểu cầu thận hoặc mô kẽ, ống thận.

- **Tim mạch:** tràn dịch ngoài màng tim, nhịp nhanh, có thể gặp tim to, suy tim. Viêm nội tâm mạc cấp và bán cấp do vi khuẩn có thể phối hợp với tổn thương van tim trong hội chứng Libman-Sacks. Tăng áp động mạch phổi ít gặp.

- **Phổi:** viêm màng phổi, tràn dịch màng phổi số lượng ít, viêm phổi kẽ, có thể gây triệu chứng đau ngực, khó thở.

- **Thần kinh, tâm thần:** rối loạn phương hướng, tri giác, trí nhớ. Đôi khi có đau đầu dữ dội, rối loạn tâm thần hoặc động kinh, co giật. Biểu hiện của rối loạn vận động như múa giật, múa vờn, bất thường thị lực, rối loạn dây thần kinh sọ cũng có thể gặp. Triệu chứng tâm thần có thể nặng thêm khi dùng corticosteroid liều cao kéo dài.

- **Tiêu hóa:** nôn, buồn nôn, chán ăn. Đau bụng ít gặp nhưng là một triệu chứng rất quan trọng. Có thể gặp viêm gan, xơ gan, tăng men gan.

- **Hạch bạch huyết:** hạch ngoại biên to, đặc biệt là giai đoạn bệnh nặng và thường

gặp hơn ở trẻ em. Có thể phối hợp với gan to, lách to.

- Huyết học: thiếu máu (mệt mỏi, da niêm mạc nhợt), xuất huyết dưới da.

2.2. Cận lâm sàng

2.2.1. Tự kháng thể

- Kháng thể kháng nhân (ANA) bằng kỹ thuật miễn dịch huỳnh quang trên tế bào hep-2 và/hoặc kỹ thuật elisa thường dương tính.
- Kháng thể đặc hiệu: kháng thể kháng DNA chuỗi kép (dsDNA), kháng thể kháng Smith, kháng thể kháng phospholipid.
- Một số kháng thể khác có thể gặp: kháng thể kháng Ro, kháng thể kháng La, kháng thể kháng U1RNP, kháng thể kháng histon,...

2.2.2. Xét nghiệm khác

- Xét nghiệm máu
 - + Công thức máu: giảm hồng cầu, bạch cầu lympho, tiểu cầu.
 - + Máu lắng, protein C phản ứng tăng.
 - + Bỏ thể: C4, C3, CH50 giảm, đặc biệt trong các đợt bệnh hoạt động.
 - + Sinh hóa máu: chức năng gan, thận, men cơ có thể biến đổi nếu có tổn thương cơ quan. Giảm albumin, protein và thay đổi mỡ máu trong hội chứng thận hư do lupus. Đường máu, điện giải đồ, acid uric cần thiết theo dõi điều trị.
- Xét nghiệm nước tiểu
 - + Tổng phân tích nước tiểu: protein niệu, hồng cầu niệu, trụ niệu...
 - + Protein niệu 24 giờ
- Xét nghiệm chẩn đoán hình ảnh
 - + Xquang ngực, cắt lớp vi tính ngực phát hiện tổn thương xơ phổi, tràn dịch màng phổi, màng tim
 - + Đo chức năng hô hấp.
 - + Siêu âm tim, điện tim.
 - + Siêu âm thận, chụp cắt lớp vi tính, chụp cộng hưởng từ (MRI) sọ não, điện não... khi có triệu chứng thần kinh.
 - + Soi mao mạch nền móng có thể thấy giãn mạch nền móng.
- Sinh thiết da: có vai trò quan trọng trong chẩn đoán tổn thương da đặc hiệu trong lupus.
- Sinh thiết thận: chẩn đoán xác định tổn thương thận lupus.

2.3. Chẩn đoán xác định

Có thể sử dụng 1 trong 3 tiêu chuẩn:

2.3.1. Tiêu chuẩn ACR 1997

Bệnh nhân được chẩn đoán SLE khi có $\geq 4/11$ tiêu chuẩn cả trong tiền sử bệnh và tại thời điểm thăm khám gồm:

1. Ban hình cánh bướm ở mặt: cố định, phẳng hoặc gồ lên mặt da, lan tỏa hai bên má.

2. Ban dạng đĩa: hình tròn gờ lên mặt da, lõm ở giữa có thể kèm theo sọc teo da.
3. Nhạy cảm ánh sáng: khi tiếp xúc với ánh sáng có thể gây ban đỏ xuất hiện.
4. Loét miệng: bao gồm loét miệng, mũi họng do thầy thuốc quan sát thấy.
5. Viêm khớp: một hoặc nhiều khớp ngoại biên với cứng khớp, sưng hoặc tràn dịch.
6. Viêm thanh mạc:
 - Viêm màng phổi.
 - Viêm màng ngoài tim.
7. Tổn thương thận: protein niệu thường xuyên cao hơn 0,5g/24h hoặc hơn (+++) nếu không định lượng hoặc cận tế bào.
8. Rối loạn về tâm, thần kinh: co giật hoặc rối loạn tâm thần trong điều kiện không do các nguyên nhân khác.
9. Rối loạn huyết học: thiếu máu tan máu; hoặc giảm bạch cầu dưới 4G/L; hoặc giảm lympho bào dưới 1.5G/L hoặc giảm tiểu cầu dưới 100G/L khi không có sai lầm trong dùng thuốc.
10. Rối loạn miễn dịch: xuất hiện kháng thể kháng dsDNA, kháng Sm và/hoặc kháng phospholipid.
11. Kháng thể kháng nhân (ANA) dương tính.

2.3.2. Tiêu chuẩn SLICC 2012

Chẩn đoán Lupus ban đỏ hệ thống khi có $\geq 4/17$ tiêu chuẩn trong đó có ít nhất 1 tiêu chuẩn lâm sàng và 1 tiêu chuẩn cận lâm sàng hoặc sinh thiết có tổn thương thận lupus cùng ANA dương tính hoặc dsDNA dương tính.

Tiêu chuẩn lâm sàng	Tiêu chuẩn cận lâm sàng
Tổn thương da lupus cấp tính	ANA dương tính
Tổn thương da lupus mạn tính	Anti dsDNA dương tính
Loét miệng hoặc mũi	Anti Sm dương tính
Rụng tóc không sọc	Antiphospholipid dương tính
Viêm khớp	Giảm bổ thể: C3, C4, CH50.
Viêm thanh mạc	Test Coomb trực tiếp dương tính (không tính nếu đã thiếu máu tan máu)
Tổn thương thận	
Tổn thương thần kinh	
Thiếu máu tan máu	
Giảm bạch cầu hoặc giảm lympho	
Giảm tiểu cầu (<100G/l)	

2.3.3. Tiêu chuẩn EULAR 2019



Tiêu chuẩn lâm sàng	Điểm
Sốt: khi > 38.5 độ	2
Huyết học	
• Bạch cầu < 4G/l	3
• Tiểu cầu < 100 G/l	4
• Tan máu tự miễn	4
Thần kinh	
• Mê sảng	2
• Rối loạn tâm thần: hoang tưởng, và hoặc ảo giác(không có mê sảng)	3
• Co giật: toàn thân hoặc khu trú	5
Tổn thương da – niêm mạc	
• Rụng tóc không sệt	2
• Loét miệng	2
• Tổn thương da bán cấp hoặc dạng đĩa	4
• Tổn thương da cấp tính	6
Thanh mạc	
• Tràn dịch màng tim, màng phổi	5
• Viêm màng ngoài tim	6
Xương khớp	6
• Viêm bao hoạt dịch liên quan đến > 2 khớp: sưng hoặc tràn dịch	
• Hoặc đau > nhiều khớp và cứng khớp ít nhất 30 phút buổi sáng	
Thận	
• Protein niệu > 0.5g/24h hoặc tỉ lệ pro/creatinin niệu tương đương	4
• Sinh thiết thận: loại 2 hoặc 5	8

• Sinh thiết thận: loại 3 hoặc 4	10
Tiêu chuẩn miễn dịch học	Điểm
Kháng phospholipid	2
• Kháng thể kháng Cardiolipin	
• Kháng thể kháng β 2GP1	
• KT kháng đông lupus	
Bồ thể	
• C3 thấp hoặc C4 thấp	3
• C3 thấp và C4 thấp	4
Kháng thể đặc hiệu SLE	
• Anti DsDNA	6
• Anti Sm	6

2.4. Chẩn đoán mức độ hoạt động bệnh

Chẩn đoán mức độ hoạt động của bệnh theo chỉ số SLEDAI (systemic lupus erythematosus disease activity index, Bombardier et al, 1992) và/ hoặc BILAG (British Isles Lupus Assessment Group 2004)

2.4.1 Chỉ số SLEDAI

Chỉ số SLEDAI			
Triệu chứng	Điểm	Triệu chứng	Điểm
Co giật	8	Protein niệu	4
Rối loạn tâm thần	8	Đái mù	4
Hội chứng não	8	Ban đỏ da mới	2
Bất thường thị lực	8	Rụng tóc	2
Rối loạn dây thần kinh sọ	8	Loét miệng	2
Đau đầu lupus	8	Viêm màng phổi	2
Tai biến mạch não	8	Viêm màng ngoài tim	2
Viêm mạch	8	Bồ thể thấp	2
Viêm khớp	4	Tăng DNA kết hợp	2
Viêm cơ	4	Sốt	1
Trụ niệu	4	Giảm tiểu cầu	1
Đái máu	4	Giảm bạch cầu	1

SLEDAI có 24 dấu hiệu của 5 cơ quan, các triệu chứng trên đánh giá trong vòng 10 ngày, tổng số điểm cho 24 dấu hiệu là 105 điểm.

- SLEDAI < 6 điểm: bệnh hoạt động mức độ nhẹ.

- SLEDAI từ 6 - 12 điểm: bệnh hoạt động mức độ trung bình.
- SLEDAI > 12: bệnh hoạt động mức độ nặng.

2.4.2 Chỉ số BILAG

Là thang ghi lại hoạt động của bệnh xảy ra trong 4 tuần với 4 tuần trước đó. Phân loại mức độ hoạt động của bệnh thành năm cấp độ khác nhau từ A đến E.

Mức độ A: hoạt động bệnh mức độ nặng

Mức độ B: hoạt động bệnh mức độ trung bình

Mức độ C: hoạt động nhẹ

Mức độ D: bệnh không hoạt động nhưng đã bị ảnh hưởng trước đó

Mức độ E: không có tổn thương hệ thống

TOÀN TRẠNG*	TIÊU HÓA*
1. Sốt - ghi nhận > 37,5°C	56. Viêm phúc mạc do lupus
2. Giảm cân - không chủ ý > 5%	57. Viêm huyết thanh bụng hoặc cổ chướng
3. Bệnh hạch bạch huyết/lách to	58. Viêm ruột/viêm đại tràng Lupus
4. Chán ăn	59. Kém hấp thu
DA NIÊM MẠC*	60. Bệnh lý ruột mất đạm
5. Phát ban da – nặng	61. Giả tắc ruột
6. Phát ban da - nhẹ	62. Viêm gan lupus
7. Phù mạch – nặng	63. Viêm túi mật lupus cấp tính
8. Phù mạch – nhẹ	64. Viêm tụy cấp do lupus
9. Loét niêm mạc – nặng	NHÃN KHOA*
10. Loét niêm mạc – nhẹ	65. Viêm hốc mắt/viêm cơ/lồi mắt
11. Viêm mô mỡ/Lupus bong nước - nặng	66. Viêm giác mạc - nặng
12. Viêm mô mỡ/Lupus bong nước - nhẹ	67. Viêm giác mạc - nhẹ
13. Viêm mạch/tắc mạch nặng	68. Viêm màng bồ đào trước
14. Nhồi máu ngón hoặc viêm mạch nốt	69. Viêm màng bồ đào sau/viêm mạch võng mạc - nặng
15. Rụng tóc – nặng	70. Viêm màng bồ đào sau/viêm mạch võng mạc - nhẹ
16. Rụng tóc – nhẹ	71. Viêm màng cứng
17. Ban đỏ quanh móng / dạng cước tay	72. Viêm củng mạc – nặng
18. Xuất huyết ở móng (Splinter haemorrhages)	73. Viêm củng mạc – nhẹ
TÂM THẦN KINH*	74. Bệnh tắc mạch võng mạc/màng mạch
19. Viêm màng não vô khuẩn	75. Đốm bông gòn biệt lập (thân tế bào)
20. Viêm mạch máu não	76. Viêm dây thần kinh thị giác
21. Hội chứng mất myelin	77. Bệnh thần kinh thị giác thiếu máu cục bộ phía trước
22. Bệnh lý tủy	THẬN **
23. Trạng thái lú lẫn cấp tính	78. Giá trị huyết áp tâm thu (mm Hg)
24. Rối loạn tâm thần	79. Giá trị huyết áp tâm trương (mm Hg)
25. Viêm hủy myelin cấp tính	80. Tăng huyết áp nhanh
bệnh đa rễ thần kinh	81. Protein nước tiểu (+=1, +=2, +++=3)
26. Bệnh đơn dây thần kinh (đơn/đa)	82. Tỷ lệ albumin-creatinine trong nước tiểu mg/mmol
27. Bệnh thần kinh sọ não	83. Tỷ lệ protein-creatinine trong nước tiểu mg/mmol
28. Bệnh rối loạn thần kinh	84. Giá trị protein nước tiểu 24 giờ
29. Bệnh đa dây thần kinh	85. Hội chứng thận hư
30. Rối loạn co giật	86. Creatinine (huyết tương/huyết thanh
31. Trạng thái động kinh	87. Mức lọc cầu thận GFR (được tính) ml/phút/1,73 m ²

32. Bệnh mạch máu não (không do viêm mạch) 33. Rối loạn chức năng nhận thức 34. Rối loạn vận động 35. Rối loạn tự động 36. Thất điều tiểu não (đơn độc) 37. Đau đầu do lupus – nặng không thuyên giảm 38. Đau đầu do tăng huyết áp IC CƠ XƯƠNG* 39. Viêm cơ - nặng 40. Viêm cơ - nhẹ 41. Viêm khớp (nặng) 42. Viêm khớp (trung bình)/Viêm gân/Viêm bao gân 43. Viêm khớp (nhẹ)/Đau khớp/Đau cơ TIM MẠCH HÔ HẤP* 44. Viêm cơ tim – nhẹ 45. Viêm cơ tim/Viêm nội tâm mạc + Suy tim 46. Rối loạn nhịp tim 47. Rối loạn chức năng van tim mới 48. Viêm màng phổi/viêm màng ngoài tim 49. Chèn ép tim 50. Tràn dịch màng phổi khó thở 51. Xuất huyết phổi/viêm mạch 52. Viêm phế nang kẽ/viêm phổi 53. Hội chứng phổi co lại 54. Viêm động mạch chủ 55. Viêm mạch vành	88. Cận niệu tiến triển 89. Viêm thận tiến triển HUYẾT HỌC** 90. Giá trị huyết sắc tố (g/dl) 91. Tổng số bạch cầu 92. Bạch cầu trung tính 93. Tế bào lympho 94. Tiểu cầu 95. TTP 96. Bảng chứng tan máu đang hoạt động 97. Xét nghiệm Coombs dương tính *Chấm điểm từ 0 - 4 0 Không có 1 Cải thiện 2 Không thay đổi 3 Tệ hơn 4 Xuất hiện mới ** Có/Không HOẶC ghi giá trị ** Có/Không xác nhận điều này là do hoạt động SLE
---	---

2.5. Chẩn đoán phân biệt

- Viêm da do ánh nắng
- Viêm da tiếp xúc dị ứng
- Viêm bì cơ
- Hội chứng trùng lấp hoặc bệnh tổ chức liên kết hỗn hợp
- Bệnh phong
- Dị ứng thuốc
- Bệnh máu biểu hiện ở da
- Viêm khớp dạng thấp
- Bệnh Behcet
- Các tổn thương niêm mạc miệng do bệnh khác.

3. ĐIỀU TRỊ

3.1. Nguyên tắc điều trị

- Kết hợp dùng thuốc với việc điều chỉnh chế độ sinh hoạt của người bệnh: chống nắng, luyện tập nghỉ ngơi hợp lý.
- Lựa chọn thuốc và phương pháp điều trị tùy thuộc vào mức độ hoạt động của bệnh (theo chỉ số SLEDAI và/hoặc BILAG).
- Điều trị tấn công kết hợp với điều trị duy trì.

3.2. Điều trị cụ thể

3.2.1. Điều trị lupus ban đỏ hệ thống không có tổn thương thận

ĐIỀU TRỊ LUPUS BAN ĐỎ HỆ THỐNG KHÔNG CÓ TỔN THƯƠNG THẬN						
Kết hợp - Chống nắng - Tiêm phòng vắc xin - Tập thể dục - Không hút thuốc - Kiểm soát: Cân nặng Huyết áp Đường máu Mỡ máu - Sử dụng thuốc chống ngưng tập tiểu cầu hoặc chống đông ở bệnh nhân có KT kháng phospholipid	NHẸ*		TRUNG BÌNH*		NẶNG*	
	Đầu tay	Kháng trị	Đầu tay	Kháng trị	Đầu tay	Kháng trị
	HCQ					
	GC uống/tiêm bắp		GC uống/ tĩnh mạch			
	MTX/AZA		BEL			
			CNI			
			MMF			
					CYC	
					RTX	
	Mục đích Đạt thuyên giảm: SLEDAI = 0 HCQ Không dùng GC Hoặc Bệnh hoạt động ít: SLEDAI ≤4 HCQ Pre ≤ 7.5mg/ngày ƯCMD (ở liều ổn định và đạt đáp ứng)					

<

3.2.2. Điều trị lupus ban đỏ hệ thống có tổn thương thận

Chẩn đoán xác định bằng sinh thiết thận, tuy nhiên ở các trường hợp không được làm sinh thiết, bệnh nhân có protein niệu $> 0,5\text{g}/24\text{h}$ có thể xác định điều trị như tổn thương thận lupus.

- Corticosteroid và các thuốc ức chế miễn dịch như mycophenolat mofetil, cyclophosphamid có thể được lựa chọn để điều trị khởi đầu.

- Mycophenolat mofetil, azathioprin, ức chế calcineurin (tacrolimus) có thể được sử dụng như liệu pháp duy trì kéo dài (trung bình 5 năm để giảm biến cố thận tái phát).

- Trong trường hợp bệnh dai dẳng hoặc tái phát, rituximab có thể được xem xét sử dụng.

- Nhóm ức chế men chuyển có thể được dùng làm giảm protein niệu, giảm biến cố tổn thương thận.

3.2.3. Điều trị một số tổn thương cơ quan khác

- Tổn thương da: chống nắng là biện pháp quan trọng. Thuốc bôi corticosteroid và ức chế calcineurin tại chỗ được chỉ định đầu tay cho các tổn thương da cấp, bán cấp và mạn tính. Điều trị toàn thân bằng corticosteroid và HCQ giúp ổn định nhanh tổn thương da. Một số trường hợp kháng trị: methotrexat, retinoids, dapsone và mycophenolat mofetil cũng cho thấy hiệu quả.

- Tổn thương huyết học: các biểu hiện huyết học thường cần điều trị corticosteroid hoặc ức chế miễn dịch bao gồm giảm tiểu cầu và thiếu máu tan máu tự miễn. Điều trị đầu tiên đối với mức độ giảm tiểu cầu nặng do lupus (số lượng tiểu cầu dưới 30 G/l) gồm corticosteroid toàn thân liều cao/trung bình kết hợp với thuốc ức chế miễn dịch khác. Globulin miễn dịch tiêm tĩnh mạch (IVIG) hoặc rituximab có thể được xem xét trong giai đoạn cấp tính, trong trường hợp không đáp ứng với corticosteroid liều cao hoặc để tránh các biến chứng nhiễm trùng liên quan đến corticosteroid kéo dài.

- Đau khớp: giảm đau các khớp bằng thuốc chống viêm không steroid: diclofenac, meloxicam, celecoxib...

3.3. Các nhóm thuốc

- Corticosteroid: được sử dụng với liều lượng và đường dùng phụ thuộc vào mức độ nặng của tổn thương cơ quan và cân nặng của bệnh nhân.

+ Trường hợp nặng, đe dọa tổn thương cơ quan nội tạng liều tải tương đương methyl prednisolon 250-1000mg/ngày trong 1-3 ngày sau đó chuyển sang dùng liều 0,5-1mg/kg.

+ Bệnh mức độ trung bình, liều tương đương methyl prednisolon 0,3-0,5 mg/kg cân nặng.

+ Trường hợp nhẹ, liều tương đương methyl prednisolon khởi đầu 7,5mg/ngày – 0,3mg/kg cân nặng.

+ Giảm liều corticosteroid chậm và phải luôn song song với tình trạng lâm sàng, cận lâm sàng. Nên giảm mỗi 2 tuần/lần đối với liều trên 0,5mg/kg cân nặng, sau đó có thể giảm mỗi 4 tuần/lần. Đối với điều trị duy trì kéo dài, nên giảm tối thiểu corticosteroid xuống dưới 7,5 mg/ngày (tính theo prednison) và sau đó có thể giảm liều chậm hơn mỗi 2-3 tháng/lần. Khi có thể, nên ngừng corticosteroid.

- Nhóm kháng sốt rét tổng hợp (thường dùng trên lâm sàng là HCQ): được khuyến cáo cho tất cả bệnh nhân lupus ban đỏ hệ thống, trừ các trường hợp có chống chỉ định với liều không vượt quá 5 mg/kg. Trong trường hợp không có các yếu tố nguy cơ gây tổn thương võng mạc, khám mắt (kiểm tra thị trường và/hoặc chụp cắt

lớp quang học mắt OCT) nên được thực hiện ngay từ đầu, sau 5 năm và hàng năm sau đó.

- Các thuốc ức chế miễn dịch: Ở những bệnh nhân không đáp ứng với nhóm kháng sốt rét tổng hợp (đơn độc hoặc kết hợp với corticosteroid) hoặc bệnh nhân không thể giảm corticosteroid xuống dưới liều tối thiểu, nên cân nhắc sử dụng các chất ức chế miễn dịch khác như methotrexat (MTX), azathioprin (AZA) hoặc mycophenolat mofetil (MMF). Các chất ức chế miễn dịch có thể được chỉ định sớm, đầu tay khi bệnh có biểu hiện đe dọa tổn thương cơ quan.

- + Azathioprin, methotrexat: nên được cân nhắc sử dụng ở những bệnh nhân đáp ứng kém với corticosteroid và HCQ hoặc HCQ đơn độc. Các tổn thương da và khớp cũng đáp ứng tốt với 2 thuốc này.

- + Mycophenolat mofetil: hiệu quả cho tổn thương thận và không do thận

- + Cyclophosphamid (CYC): đường uống hoặc truyền tĩnh mạch. Có thể sử dụng trong trường hợp tổn thương cơ quan nghiêm trọng dọa đe dọa tính mạng (đặc biệt là tim mạch, thận, phổi hoặc thần kinh) hoặc khi không đáp ứng với phương pháp điều trị khác.

- Thuốc sinh học: ở những bệnh nhân đáp ứng không hoàn toàn với điều trị HCQ, corticosteroid, các thuốc ức chế miễn dịch khác (kết hợp HCQ và corticosteroid có hoặc không có thuốc ức chế miễn dịch), được định nghĩa là các biểu hiện hoạt động của bệnh đang tồn tại không cho phép giảm liều corticosteroid và/hoặc tái phát thường xuyên, nên xem xét điều trị bổ sung bằng thuốc sinh học belimumab (BEL). Trong trường hợp bệnh kéo dài đe dọa tổn thương cơ quan hoặc không dung nạp/chống chỉ định với các thuốc ức chế miễn dịch, có thể cân nhắc sử dụng rituximab.

- Thuốc ức chế calcineurin (CNI): có thể được coi là lựa chọn hàng thứ hai trong điều trị khởi đầu hoặc duy trì chủ yếu ở tổn thương thận màng, bệnh lý tế bào chân giả hoặc bệnh viêm cầu thận tăng sinh với hội chứng thận hư kháng trị. CNI có thể được sử dụng một mình hoặc kết hợp với mycophenolat mofetil .

3.4. Điều trị hỗ trợ

- Giáo dục sức khỏe cho người bệnh để bệnh nhân có nhận thức về bệnh lý lupus ban đỏ hệ thống và các thuốc điều trị để đảm bảo tuân thủ điều trị bệnh.

- Điều trị dứt điểm các bệnh nhiễm trùng.

- Chống nắng, bổ sung calci, đặc biệt cho đối tượng trẻ em, sử dụng corticosteroid kéo dài.

- Hướng dẫn tập thể dục phù hợp với tình trạng sức khỏe. Dinh dưỡng hợp lý, bổ sung đầy đủ các nhóm thực phẩm. Chế độ ăn giảm muối, ít chất béo, đường giúp giảm tác dụng phụ của thuốc.

- Trường hợp có kháng thể kháng phospholipid: sử dụng các thuốc dự phòng như ức chế ngưng tập tiểu cầu, chống đông,...

3.5. Theo dõi điều trị

- Cần khám và đánh giá tổn thương các cơ quan và triệu chứng đợt hoạt động

bệnh bằng chỉ số SLEDAI, theo dõi tác dụng phụ của thuốc điều trị.

- Các xét nghiệm cần chỉ định mỗi 1 đến 3 tháng/lần khi tái khám:
- + Xét nghiệm tế bào máu ngoại vi, tốc độ máu lắng
- + Chức năng gan, thận, mỡ máu, protein, albumin máu (đặc biệt ở các trường hợp nghi ngờ tổn thương thận)
- + Tổng phân tích nước tiểu.
- + Chụp X-quang ngực, chụp cắt lớp vi tính phổi, siêu âm tim, điện tim, siêu âm ổ bụng, siêu âm hạch khi có nghi ngờ tổn thương tim, phổi, hạch bạch huyết,
- + Xét nghiệm miễn dịch kháng thể kháng chuỗi kép (dsDNA), kháng thể kháng nhân (ANA) làm lại mỗi 6 tháng hoặc khi bệnh hoạt động.
- + Xét nghiệm và theo dõi các tác dụng không mong muốn của corticosteroid và các thuốc ức chế miễn dịch: điện giải đồ, calci máu, glucose máu, mỡ máu, cortisol máu... phát hiện tình trạng nhiễm trùng, tăng huyết áp.

4. PHÒNG BỆNH

- Tránh dùng một số thuốc có thể gây lupus đỏ hệ thống: hydralazin, procainamid, D-penicillamin, minocyclin,... và một số thuốc gây nhạy cảm ánh sáng.
- Sử dụng các biện pháp chống nắng: kem chống nắng, mũ nón, quần áo chống nắng khi ra ngoài trời.
- Khi có thai, cần theo dõi chặt cả tình trạng bệnh lý và tình trạng thai kì ở các bác sĩ chuyên khoa. Nên có thai ở thời điểm bệnh đã ổn định (triệu chứng trên lâm sàng và xét nghiệm ổn định).
- Theo dõi lupus sơ sinh: xét nghiệm kháng thể kháng Ro, kháng thể kháng La cho mẹ, theo siêu âm tim thai, khám phát hiện các tổn thương da của trẻ sơ sinh.

BỆNH XƠ CỨNG BÌ HỆ THỐNG (Systemic sclerosis - Scleroderma)

1. ĐẠI CƯƠNG

1.1. Khái niệm

Xơ cứng bì hệ thống (XCBHT) là một bệnh mạn tính được đặc trưng bởi tổn thương chức năng mạch máu nhỏ, rối loạn tự miễn dịch, sự xơ hóa tiến triển của da và các cơ quan nội tạng. Bệnh biểu hiện bởi xơ cứng da và tổn thương nhiều cơ quan khác.

1.2. Dịch tễ

Bệnh thường gặp hơn ở nữ giới, tỷ lệ gặp nữ/nam là 3/1 đến 5/1 và thường khởi phát ở độ tuổi từ 30 đến 50 tuổi.

1.3. Căn nguyên/Cơ chế bệnh sinh

Căn nguyên của bệnh xơ cứng bì chưa được biết rõ nhưng đây là bệnh tự miễn với sự hiện diện của các tự kháng thể như kháng thể kháng nhân (ANA), kháng thể kháng Topoisomerase I (anti Scl-70) và một số tự kháng thể khác. Một số yếu tố về gen và kháng nguyên bạch cầu người (HLA) có liên quan đến cơ chế bệnh sinh của bệnh.

2. CHẨN ĐOÁN

2.1. Triệu chứng lâm sàng

2.1.1. Tổn thương da

– Thường bắt đầu từ các ngón tay với biểu hiện phù nề, sau đó xuất hiện hiện tượng dày da, cứng da tiến triển lan dần lên cẳng tay, cánh tay, mặt, phần trên của cổ, ngực, bụng... Tổn thương xơ cứng da ngày càng tiến triển nặng làm bệnh nhân khó cử động. Da mất nếp nhăn, rõ nhất ở mặt làm bệnh nhân giảm khả năng biểu hiện tình cảm trên nét mặt và khó há mồm. Hăm lưỡi xơ cứng ít hay nhiều tùy tiến triển của bệnh.

– Da bị mất sắc tố, hay gặp ở phía mu bàn tay, vùng cổ, ngực, lưng, có thể thấy hiện tượng loang lổ sắc tố.

– Lắng đọng canxi tại các mô mềm gây tình trạng ngứa, loét các vùng da lân cận.

– Thở giới hạn: xơ cứng da ở mặt và chi từ vùng khuỷu tay và đầu gối trở xuống, không có tổn thương vùng thân mình và gốc chi.

– Thở lan tỏa: xơ cứng da có xuất hiện đến vùng gốc chi, thân mình hoặc toàn bộ cơ thể.

2.1.2. Hiện tượng Raynaud

Tình trạng co thắt các tiểu động mạch hoặc động mạch tại các đầu chi như ngón tay, ngón chân xuất hiện khi tiếp xúc với nhiệt độ lạnh hoặc khi thay đổi cảm xúc với sự thay đổi màu da ở đầu chi theo ba giai đoạn: nhợt nhạt, xanh tái và đỏ tím.

Tổn thương loét, hoại tử tại các đầu chi, sẹo lõm đầu ngón do hội chứng Raynaud kéo dài.

2.1.3. Hội chứng CREST

Phối hợp các triệu chứng canxi hóa (Calcinosis), hiện tượng Raynaud (Raynaud), co thắt thực quản (Esophageal), xơ cứng da ngón, đầu chi (Sclerodactylic) và giãn mạch (Telangiectasia).

2.1.4. Tổn thương các cơ quan khác

- Cơ xương khớp: bệnh nhân có thể đau nhiều khớp chủ yếu là các khớp ở chi trên có thể viêm các khớp nhưng không có di chứng biến dạng khớp. Một số có đau mỗi cơ, tăng men cơ, viêm cơ, teo cơ.
- Phổi: tổn thương phổi hay gặp nhất là xơ phổi, bệnh nhân ho khan, khó thở khi gắng sức. Nghe phổi có ran rít hoặc ran ẩm khi có bội nhiễm phổi. Có thể có tràn dịch màng phổi với lượng dịch ít.
- Tim mạch: bệnh nhân có nhịp tim nhanh, hoặc rối loạn nhịp tim với nhiều mức độ khác nhau, có thể gặp suy tim.
- Tiêu hóa: tổn thương hay gặp nhất là tổn thương thực quản, cảm giác nóng rát phía sau xương ức, triệu chứng trào ngược, xơ cứng và co thắt thực quản làm bệnh nhân khó nuốt (nhất là với thức ăn đặc). Có thể kèm táo bón hoặc đi ngoài phân lỏng từng đợt.
- Tổn thương thận: suy thận, xơ hóa cầu thận,...
- Thần kinh: đau đầu, động kinh, đột quy,...

2.2. Cận lâm sàng

2.2.1. Tự kháng thể

- Kháng thể kháng nhân (ANA) bằng kỹ thuật miễn dịch huỳnh quang trên tế bào hep2 hoặc elisa thường dương tính.
- Kháng thể đặc hiệu:
 - + Kháng thể kháng – centromere (ACA): hay gặp nhất là CENP-A, CENP-B, CENP-C. Thường hay gặp trong thể da giới hạn, có tổn thương mạch máu, lắng đọng canxi và tiêu hóa.
 - + Kháng thể kháng – Topoisomerase I (kháng thể kháng Scl-70): thường gặp hơn ở thể da lan tỏa, tiến triển nhanh. Có mối liên quan đến bệnh phổi kẽ, bệnh lý cơ tim, biến chứng mạch máu ngoại vi.
 - + Kháng thể kháng – RNA polymerase III: thường gặp ở thể lan tỏa với tổn thương dày da tiến triển nhanh và tổn thương viêm cơ khớp.
 - Kháng thể khác: kháng thể kháng – U3 RNP (anti - fibrillarin), kháng thể kháng – Th/To, kháng thể kháng – U11/U12 RNP, kháng thể kháng – PM-Scl, kháng thể kháng Ku...có thể gặp trong xơ cứng bì hệ thống.

2.2.2. Xét nghiệm tổn thương các cơ quan

- Công thức máu: có thể gặp thiếu máu do quá trình viêm mạn tính và/ hoặc suy thận.

- Máu lắng, protein C phản ứng tăng.
- Sinh hóa máu: chức năng gan, thận, men cơ có thể biến đổi nếu có tổn thương cơ quan. Giảm albumin, protein trong trường hợp tổn thương thận hoặc suy kiệt. Đường máu, mỡ máu, điện giải đồ, acid uric cần thiết theo dõi điều trị.
- Tổng phân tích nước tiểu: protein niệu, hồng cầu niệu, trụ niệu...
- Xquang ngực, cắt lớp vi tính ngực độ phân giải cao phát hiện tổn thương xơ phổi, tràn dịch màng phổi, màng tim
- Đo chức năng hô hấp: hay gặp rối loạn thông khí hạn chế.
- Siêu âm tim: tràn dịch màng ngoài tim, bệnh cơ tim, suy tim sung huyết, tăng áp lực động mạch phổi (trên 25mmHg khi đo bằng thông tim).
- Điện tim: một số có rối loạn nhịp.
- Soi mao mạch đầu chi: giãn mao mạch nền móng, mao mạch khổng lồ, xuất huyết, mao mạch chia nhánh, giảm số lượng mao mạch.
- Sinh thiết da có giai đoạn viêm và giai đoạn xơ cứng.

2.3. Chẩn đoán xác định

- Chẩn đoán xơ cứng bì hệ thống theo Hội thập học Mỹ (ACR) và Liên đoàn chống thấp khớp châu Âu (EULAR) 2013.

Bảng 1.1. Tiêu chuẩn chẩn đoán XCBHT theo ACR/EULAR 2013.

Dày da các ngón tay ở 2 tay lan đến khớp bàn ngón		9 điểm
Dày da ngón tay (chỉ tính điểm cao nhất)	Phù nề ngón	2 điểm
	Xơ cứng da các ngón chưa đến khớp bàn ngón nhưng đến khớp gian ngón gần.	4 điểm
Tổn thương đầu ngón (chỉ tính điểm cao nhất)	Loét đầu ngón	2 điểm
	Sẹo lõm đầu ngón	3 điểm
Giãn mạch		2 điểm
Bất thường mao mạch nền móng		2 điểm
Tăng áp lực động mạch phổi và/hoặc bệnh phổi kẽ (điểm tối đa là 2)	Tăng áp lực động mạch phổi	2 điểm
	Bệnh phổi kẽ	2 điểm
Hiện tượng Raynaud		3 điểm
Các tự kháng thể liên quan (điểm tối đa là 3)	Kháng thể kháng centromere	1 điểm
	Kháng thể kháng topoisomerase I	1 điểm
	Kháng thể kháng RNA polymerase III	1 điểm
Chẩn đoán xác định khi tổng điểm từ 9 điểm trở lên.		

- Tiêu chuẩn này không sử dụng cho các bệnh nhân có tổn thương dày da không liên quan đến vùng ngón và những bệnh nhân có biểu hiện dày da có thể được giải thích phù hợp với các bệnh cảnh khác như xơ cứng da do rối loạn thần kinh, xơ cứng bì khu trú thể lan tỏa, viêm cân cơ tăng bạch cầu ái toan, phù cứng bì do đái tháo đường,

scleromyxedema...

2.4. Chẩn đoán thể lâm sàng

– XCBHT thể da giới hạn: xơ cứng da ở mặt và chi từ vùng khuỷu tay và đầu gối trở xuống, không có tổn thương vùng thân mình và gốc chi.

– XCBHT thể da lan tỏa: xơ cứng da có xuất hiện đến vùng gốc chi, thân mình hoặc toàn bộ cơ thể.

– Hội chứng CREST bao gồm các biểu hiện: canxi hóa tổ chức dưới da ở đầu chi, hội chứng Raynaud, tổn thương thực quản, xơ cứng da đầu ngón, và giãn mạch da.

– Xơ cứng bì hệ thống không có xơ cứng da: biểu hiện lâm sàng với bệnh lý xơ phổi hoặc thận, tim, ống tiêu hóa. Không có tổn thương da. Có thể có hội chứng raynaud và các kháng thể dương tính (anti Scl 70, ACA hoặc anti RNA polymerase I,II,III).

– Hội chứng trùng lấp của bệnh xơ cứng bì và các bệnh tự miễn khác như lupus ban đỏ hệ thống, viêm da cơ, viêm khớp dạng thấp, hội chứng Sjogren (hội chứng trùng lấp - overlap syndrome).

2.5. Chẩn đoán phân biệt

- Lupus ban đỏ hệ thống
- Viêm khớp dạng thấp
- Viêm da cơ
- Xơ cứng bì khu trú thể lan tỏa
- Phù cứng bì (scleromyxedema)
- Scleroderma liên quan đến đái tháo đường hoặc bệnh máu
- Phù niêm (myxedema)
- Hội chứng carcinoid do u nội tiết
- Bệnh ghép chống chủ
- Các bệnh da di truyền có xơ cứng da: hội chứng Werner, lão hóa sớm đầu cực, loạn sản xơ cốt hóa tiến triển...

3. ĐIỀU TRỊ

3.1. Nguyên tắc điều trị

- Hiện nay chưa có phương pháp hoặc thuốc điều trị khỏi bệnh nên chủ yếu là điều trị triệu chứng nhằm kiểm soát đợt tiến triển của bệnh.
- Điều trị dựa trên tổn thương cơ quan, kết hợp tấn công và duy trì.

3.2. Điều trị cụ thể

3.2.1. Điều trị theo cơ quan

Tùy từng tổn thương cơ quan mà lựa chọn điều trị khác nhau

Bảng 1.2: Điều trị các cơ quan bị tổn thương

Tổn thương	Điều trị
Bệnh phổi kẽ	- Điều trị tấn công: lựa chọn khởi đầu thường là mycophelonat mofetil hoặc cyclophosphamid, có hiệu quả trong cải thiện chức năng hô hấp (đặc biệt là chỉ số dung tích sống gắng sức - FVC). Tocilizumab hoặc azathioprin cũng được xem xét trong điều trị tấn công. + Mycophenolat mofetil (MMF): thường bắt đầu bằng liều thấp, sau đó tăng dần đến liều 1,5 – 3g/ ngày. MMF ít tác dụng phụ hơn cyclosporin. + Cyclophosphamid: thường ưu tiên dùng đường truyền tĩnh mạch mỗi tháng trong 6 tháng thay vì đường uống để giảm liều tích lũy. Liều tính theo diện tích da cơ thể. + Tocilizumab: được FDA chấp thuận sử dụng để làm chậm tiến triển của tổn thương phổi kẽ trong Xơ cứng bì hệ thống. Là sự lựa chọn thay thế cho MMF nếu bệnh nhân có chống chỉ định với MMF. - Điều trị duy trì: các thuốc ức chế miễn dịch hoặc nhóm thuốc khác cần được tiếp tục hàng tháng hoặc hàng năm (ít nhất từ 12 đến 24 tháng) + Mycophenolat mofetil hoặc azathioprin được khuyến cáo duy trì để sự cải thiện chức năng phổi. + Tocilizumab, nitedanib, rituximab: là một số thuốc đang được nghiên cứu để làm chậm tiến triển xơ phổi kẽ ở giai đoạn duy trì. - Ghép tế bào gốc tạo máu trong trường hợp bệnh tiến triển nhanh có nguy cơ suy nội tạng (không có chỉ định trong tổn thương phổi kẽ nặng). - Ghép phổi: một trong những sự lựa chọn cho bệnh nhân bị bệnh phổi kẽ mức độ nặng không đáp ứng với các thuốc điều trị.
Tăng áp lực động mạch phổi (TADMP)	Điều trị theo mức độ tổn thương (phân độ TADMP theo WHO). Các nhóm thuốc điều trị bao gồm: - Chất đối kháng thụ thể endothelin: ambrisentan, bosentan, macitentan. - Thuốc ức chế Phosphodiesterase-5 (PDE-5): sildenafil, tadalafil,... - Các chất tương tự prostacyclin: iloprost, treprostinil, epoprostenol, Epoprostenol tĩnh mạch được sử dụng trong trường hợp nặng (tăng áp lực động mạch phổi loại III và IV). - Chất kích thích guanylate cyclase hòa tan như riociguat - Trường hợp kháng trị: tạo shunt trái phải, ghép phổi
Cơn kịch phát thận	- Thuốc ức chế men chuyển giúp cải thiện tỷ lệ sống trong cơn kịch phát thận. - Các thuốc huyết áp khác có thể xem xét để kiểm soát tăng huyết áp kháng trị trong cơn kịch phát thận.

	- Corticosteroid liều cao có liên quan đến nguy cơ con kịch phát thận cao hơn nên phải theo dõi huyết áp và chức năng thận.
Da	- Methotrexat cải thiện tổn thương da trong xơ cứng bì hệ thống lan tỏa sớm. - Các lựa chọn khác bao gồm: mycophenolat mofetil, azathioprin, cyclophosphamid. - D-penicillamin hiện tại ít tác dụng nên không được khuyến cáo. - Giãn mạch: laser hoặc IPL (Intense Pulsed Light). - Tại chỗ: kem dưỡng ẩm da.
Khớp	- Thuốc chống viêm không steroid được sử dụng giảm đau các khớp - Corticosteroid đường toàn thân có thể giảm triệu chứng viêm đau các khớp, lưu ý liều dùng và tác dụng phụ khi dùng kéo dài.
Hiện tượng Raynaud	- Chẹn kênh canxi loại dihydropyridin, thường là nifedipin đường uống, được coi là liệu pháp đầu tay. - Thuốc ức chế PDE-5. - Iloprost truyền tĩnh mạch với các trường hợp Raynaud nặng, không đáp ứng với thuốc uống. - Thuốc ức chế tái hấp thu serotonin chọn lọc như fluoxetine. - Phẫu thuật cắt thần kinh giao cảm ở ngón tay (có hoặc không kết hợp với tiêm botulinum toxin) nên được xem xét ở những trường hợp nặng hoặc kháng trị
Loét ngón	- Iloprost truyền tĩnh mạch: loét ngón nặng đang hoạt động - Thuốc ức chế PDE-5 - Bosentan giúp giảm số lượng loét ngón mới, đặc biệt ở bệnh nhân không đáp ứng với thuốc chẹn kênh canxi, thuốc ức chế PDE-5 hoặc iloprost - Phẫu thuật cắt thần kinh giao cảm ở ngón tay (có hoặc không kết hợp với tiêm botulinum toxin) cũng được xem xét ở những trường hợp nặng hoặc kháng trị
Dạ dày-ruột	- Điều trị trào ngược dạ dày-thực quản và phòng ngừa loét, hẹp thực quản: thuốc ức chế bơm proton - Thuốc prokinetic để kiểm soát các rối loạn vận động có triệu chứng (chứng khó nuốt, GERD, no sớm, chướng bụng, giả tắc ruột,...) - Kháng sinh đường uống phổ rộng, ngắt quãng hoặc luân phiên để điều trị quá phát vi khuẩn đường ruột có triệu chứng. - Thuốc chống tiêu chảy (ví dụ như loperamid) hoặc thuốc nhuận tràng có thể sử dụng để kiểm soát triệu chứng.
Canxi hóa	- Biện chứng nhiễm trùng nên được phát hiện và điều trị sớm - Cân nhắc phẫu thuật với các trường hợp nặng, dai dẳng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng vận động và chất lượng cuộc sống.

3.2.2 Các nhóm thuốc chính

- **Các thuốc ức chế miễn dịch:** áp dụng điều trị cho các bệnh nhân xơ cứng bì có

tổn thương mạch nhiều, có nguy cơ hoại tử đầu chi hoặc tổn thương phổi kẽ... Có thể dùng một trong các thuốc sau:

+ Corticosteroid: thường dùng liều tương đương prednisolon 5-20mg/ngày. Trong một số trường hợp viêm cơ, tổn thương phổi kẽ, da xơ cứng tiến triển nhanh có thể dùng liều cao hơn ở giai đoạn đầu, tuy nhiên cần thận trọng khi sử dụng corticosteroid cho bệnh nhân xơ cứng bì vì nguy cơ có thể xuất hiện bệnh lý thận cấp, đặc biệt khi dùng liều cao kéo dài. Ở giai đoạn bệnh ổn định, triệu chứng da khớp đã cải thiện có thể sử dụng corticosteroid liều thấp 5mg - 10mg duy trì. Thường sử dụng kết hợp corticosteroid với nhóm ức chế miễn dịch khác trong điều trị để đem lại hiệu quả cao hơn.

+ Cyclophosphamid: thường truyền tĩnh mạch liều 500-750 mg/m² diện tích cơ thể mỗi 1 tháng/ lần trong 6 tháng liên tiếp), có thể điều chỉnh liều theo tuổi, chức năng thận và tình trạng cơ thể. Đường uống khởi đầu từ 50-150mg/ngày (tùy cân nặng) sau đó tăng dần liều lên khoảng 1.5-2.5mg/kg/ngày trong 12 tháng, sau đó có thể chuyển tiếp sang thuốc khác ít độc tính hơn.

+ Mycophenolat mofetil: liều phù hợp là 1,5 –3g/ngày. Thường bắt đầu bằng liều thấp để hạn chế tác dụng phụ với đường tiêu hóa sau đó tăng dần lên. Liều khởi đầu là 500mg x 2 lần/ngày sau tăng dần lên đến 1,5g x 2 lần/ngày. Tác dụng phụ thường gặp là ức chế tủy xương và rối loạn tiêu hóa. Do đó nên làm xét nghiệm công thức máu trong 1-2 tuần sau khi bắt đầu dùng thuốc và định kỳ khi sử dụng thuốc.

+ Azathioprin: 1-3mg/kg/ngày, chú ý tác dụng phụ gây ức chế tủy xương (hay gặp nhất là hạ bạch cầu). Nên bắt đầu bằng liều tấp 1mg/kg/ngày trong tháng đầu, sau đó tăng liều lên nếu không có tác dụng phụ ức chế tủy xương. Thường dùng kiểm soát tổn thương phổi kẽ sau truyền cyclophosphamid.

+ Methotrexat: được khuyến cáo trong điều trị tổn thương da trên bệnh nhân xơ cứng bì hệ thống. Thuốc còn được sử dụng trong trường hợp có viêm khớp và viêm cơ kèm theo. Liều dùng methotrexat từ 10-25mg/tuần. Thận trọng đối với những bệnh nhân có tổn thương phổi tiến triển.

+ Cyclosporin A: 50-100mg/ngày, ít được sử dụng trong điều trị xơ cứng bì hệ thống hơn các ức chế miễn dịch khác.

– Các thuốc điều trị tổn thương mạch máu:

+ Thuốc chẹn kênh canxi: thường dùng nifedipin liều tối đa 240mg/ngày, diltiazem liều tối đa 720 mg/ngày, amlodipin liều tối đa 20 mg/ngày, cải thiện tốt trường hợp tổn thương mạch máu ngoại vi, không có bằng chứng cải thiện tăng áp động mạch phổi.

+ Thuốc đối kháng thụ thể Endothelin-1 receptor: bosentan liều 125 - 250 mg/ngày, cải thiện tăng áp động mạch phổi và tình trạng loét ngón. Macitentan, ambrisentan là các thuốc cho thấy hiệu quả trên bệnh nhân xơ cứng bì hệ thống.

+ Thuốc ức chế phosphodiesterase type 5 (Phosphodiesterase type 5 inhibitors-PDE5i): Nhóm PDE5i có tác dụng ức chế quá trình chuyển hóa của cGMP, làm thúc

đẩy quá trình giãn mạch máu ở phổi dưới tác động của NO nội sinh. Cho đến nay có 2 thuốc thuộc nhóm này được chấp thuận để điều trị PAH là sildenafil và tadalafil. Sildenafil liều không quá 10-20mg x 3 lần/ ngày.

+ Chất chủ vận con đường prostacyclin: nhóm thuốc có khả năng giãn động mạch phổi như epoprostenol đường tiêm, treprostinil và iloprost đường tiêm hoặc hít và selexipag đường uống. Iloprost qua đường tĩnh mạch còn được lựa chọn trong điều trị loét, hoại tử ngón.

– **Nhóm thuốc sinh học:**

+ Tocilizumab: một kháng thể đơn dòng từ người kháng lại IL-6, được FDA chấp thuận sử dụng để điều trị bệnh phổi kẽ trong xơ cứng bì. Liều 162mg mỗi tuần 1 lần, tiêm dưới da.

+ Nitedanib: là thuốc ức chế nhiều loại tyrosine kinase, đã được chứng minh làm chậm tiến triển của bệnh xơ phổi vô căn. Trong điều trị Xơ cứng bì hệ thống đang cho thấy bước đầu làm chậm quá trình giảm chức năng hô hấp của bệnh nhân phổi kẽ.

+ Rituximab: kháng thể đơn dòng chống lại CD20 trên tế bào lympho B. Kết quả bước đầu từ một vài thử nghiệm lâm sàng nhỏ cho thấy rituximab có thể là một loại thuốc điều trị cho bệnh phổi kẽ trong xơ cứng bì.

– **Các thuốc điều trị hỗ trợ khác:**

+ Thuốc ức chế bơm proton: liều tiêu chuẩn esomeprazol 40mg/ngày, lansoprazol 30mg/ngày, pantoprazol 40mg/ngày, omeprazol 20mg/ngày, rabeprazol 20mg/ngày. Liều tối đa được sử dụng có thể gấp đôi liều tiêu chuẩn.

+ Thuốc chống viêm không steroid: diclofenac 50-100mg/ngày, meloxicam 7,5-15mg/ngày, celecoxib 200mg/ngày. Cần lưu ý các tác dụng phụ của thuốc trên hệ tiêu hóa dạ dày, ruột.

+ Colchicin : dùng trong điều trị giảm canxi hóa ở da, đau khớp..., liều 1mg/ngày, lưu ý tác dụng phụ trên đường tiêu hóa.

– **Liệu pháp oxy:** chưa có bằng chứng về lợi ích của liệu pháp oxy dài hạn. Có thể chỉ định thở oxy khi phân áp O₂ động mạch <8 kPa (60 mmHg) hoặc SpO₂ <91%). Có thể xem xét liệu pháp oxy cấp cứu (ambulatory oxygen therapy) trong trường hợp cần thiết.

– **Phương pháp lọc huyết tương:** để loại bỏ các phức hợp miễn dịch trong các trường hợp tiến triển nặng.

3.3. Theo dõi điều trị

Cần khám và đánh giá tổn thương các cơ quan và triệu chứng theo dõi tác dụng phụ của thuốc điều trị. Các xét nghiệm cần chỉ định mỗi 1 đến 3 tháng /lần khi tái khám:

- Xét nghiệm tế bào máu ngoại vi, tốc độ máu lắng
- Chức năng gan, thận, men cơ, mỡ máu, protein, albumin máu

- Tổng phân tích nước tiểu.
- Chụp Xquang ngực, chụp cắt lớp vi tính phân giải cao phổi, siêu âm tim, điện tim, siêu âm ổ bụng, siêu âm hạch khi có nghi ngờ tổn thương,...
- Xét nghiệm miễn dịch kháng thể kháng nhân (ANA), kháng thể kháng Topoisomerase I (anti Scl 70) có thể làm lại mỗi 6 tháng hoặc khi bệnh hoạt động.
- Xét nghiệm và theo dõi các tác dụng không mong muốn của corticosteroid và các thuốc ức chế miễn dịch: điện giải đồ, calci máu, glucose máu, mỡ máu, cortisol máu... phát hiện tình trạng nhiễm trùng, tăng huyết áp.

4. PHÒNG BỆNH

- Tránh các yếu tố làm nặng tổn thương mạch máu: không hút thuốc lá, giữ ấm tay, tránh kích thích lạnh đột ngột.
- Kiểm soát tình trạng trào ngược dạ dày - thực quản: bệnh nhân nên ăn thành nhiều bữa nhỏ, không ăn quá no, nên nằm đầu cao, không nằm ngay sau khi ăn, tránh lạm dụng cà phê, thuốc lá và các chất kích thích khác.
- Dinh dưỡng hợp lý, đầy đủ các nhóm thực phẩm, tránh vận động gắng sức.
- Dùng các loại xà phòng ít gây khô da, xoa kem làm mềm da, xoa bóp da thường xuyên.
- Hướng dẫn tập thể dục, bài tập vật lý trị liệu phù hợp với tình trạng sức khỏe, tập thở và xoa bóp toàn thân thường xuyên.
- Tái khám và dùng thuốc thường xuyên ngăn chặn đợt tiến triển của bệnh.

BỆNH PEMPHIGUS (Pemphigus)

1. ĐẠI CƯƠNG

1.1. Khái niệm

- Pemphigus thuộc nhóm bệnh bong nước tự miễn do tự kháng thể kháng lại cầu nối liên gai gây hiện tượng ly gai ở thượng bì. Bệnh đặc trưng trên lâm sàng bởi tổn thương bong nước nông, dễ vỡ để lại vết trợt da, tùy thể lâm sàng có thể có hoặc không kèm theo tổn thương niêm mạc.

- Hiện nay bệnh được chia thành 2 nhóm chính là pemphigus sâu gồm pemphigus thông thường và pemphigus sùi; pemphigus nông gồm pemphigus vảy lá và pemphigus đỏ da. Các thể khác ít gặp hơn: pemphigus á u, pemphigus IgA.

1.2. Dịch tễ

- Bệnh xảy ra khắp nơi trên thế giới. Tỷ lệ mắc bệnh từ 0,5 - 4/100.000 dân.
- Bệnh có thể gặp ở mọi lứa tuổi nhưng hay gặp nhất ở lứa tuổi trung niên từ 45 – 65 tuổi.
- Tỷ lệ nữ/nam là 1-2/1.

1.3. Căn nguyên/Cơ chế bệnh sinh

- Căn nguyên gây bệnh chưa được biết chính xác.
- Cơ chế bệnh sinh của bệnh: tổn thương cầu nối gian bào các tế bào gai.
- Nhóm pemphigus nông và sâu: do tự kháng thể IgG tuần hoàn chống lại kháng nguyên desmoglein 1 và 3.

- Pemphigus á u: liên quan đến khối u. Các khối u tạo ra các protein bất thường và là đích của hệ miễn dịch của cơ thể, tạo miễn dịch chéo với các protein của da. Bản chất là kháng thể IgG kháng plakine, với các kháng nguyên đích là: desmoplakin I&II, envoplakin, periplakin, BP230.

- Pemphigus IgA: tự kháng thể IgA chống lại các kháng nguyên desmoglein-1, desmoglein-3 và desmocollin-1.

2. CHẨN ĐOÁN

2.1. Triệu chứng lâm sàng

2.1.1. Pemphigus thể sâu

a. Pemphigus thông thường (*Pemphigus vulgaris* = P.V)

- Tổn thương niêm mạc:
 - + Tổn thương niêm mạc hay gặp nhất, bong nước vỡ nhanh tạo thành vết trợt giới hạn rõ, hình tròn hoặc đa cung. Vị trí: lợi, môi, vòm khẩu cái, lan tới vòm hầu, rất đau và lâu lành.
 - + Tổn thương vùng niêm mạc khác: kết mạc, thực quản, âm đạo, cổ tử cung, dương vật, niệu đạo, hậu môn.
- Tổn thương da:

+ Bọng nước trong, kích thước lớn, mềm, nhẵn nheo, nằm rời rạc trên nền da bình thường không viêm, rất dễ vỡ, để lại những vết trợt da hình tròn hoặc bầu dục khu trú hoặc lan tỏa. Tổn thương da có thể xuất hiện sau tổn thương niêm mạc vài tuần hoặc vài tháng.

+ Trường hợp bội nhiễm, có thể gặp bọng nước hóa mủ trên nền da viêm đỏ đóng vảy tiết vàng nâu dày.

+ Dấu hiệu Nikolsky dương tính.

- Tổn thương móng: dày sừng, loạn dưỡng móng, viêm quanh móng.

- Toàn thân: có thể sốt, suy kiệt cơ thể nếu đi kèm với tình trạng nhiễm khuẩn, rối loạn điện giải và dinh dưỡng kém.

b. Pemphigus sùi (*Pemphigus vegetans* = P.Veg)

Là biến thể khu trú của pemphigus thông thường. Vị trí thường ở niêm mạc, nếp gấp; tổn thương là các mảng u sùi, có vảy, mủ, hôi thối, hiếm gặp hơn thể thông thường.

2.1.2. Pemphigus thể nông

a. Pemphigus vảy lá (*Pemphigus foliaceus* = P.F)

Biểu hiện lâm sàng gồm 2 giai đoạn:

- Giai đoạn bọng nước: khởi đầu bọng nước nhỏ, mềm nhẵn nheo, nhanh chóng dập vỡ, vị trí ở mặt, lưng, ngực. Tổn thương có thể xuất hiện trên da lành hay mảng đỏ da. Niêm mạc không bị tổn thương. Đây là tiêu chuẩn lâm sàng quan trọng để chẩn đoán phân biệt Pemphigus thể thông thường và Pemphigus vảy lá.

- Giai đoạn đỏ da: bọng nước biến mất nhanh, để lại những mảng ban đỏ tróc vảy, rỉ dịch nhiều, chiếm toàn bộ cơ thể hình thành bệnh cảnh đỏ da toàn thân.

b. Pemphigus thể đỏ da hay da mỡ (*Pemphigus erythematosus*, *Pemphigus seborrheic*, hội chứng Senear - Ushear = P.S)

Đây là một thể khu trú của Pemphigus vảy lá.

- Tổn thương cơ bản là bọng nước, nhanh chóng dập vỡ để lại những mảng hồng ban đóng vảy tiết. Vảy tròn, dày, màu vàng khu trú ở các vùng tiết bã: mặt, vùng xương trước ức, rãnh lưng, thắt lưng.

- Niêm mạc không bị tổn thương.

- Toàn trạng bệnh nhân tương đối tốt.

2.1.3. Pemphigus á u

- Khoảng 2/3 trường hợp bệnh xuất hiện đồng thời với khối u và 1/3 trường hợp còn lại, u được phát hiện sau tổn thương da và niêm mạc.

- Tổn thương da:

Tổn thương da của pemphigus á u rất đa dạng, bệnh có thể biểu hiện giống 5 bệnh sau:

+ Pemphigus: các bọng nước nhẵn, nông.

+ Pemphigoid: bọng nước căng, nổi trên nền ban đỏ.

- + Hồng ban đa dạng: tổn thương da nặng, nhiều hình thái; có/không kèm tổn thương niêm mạc.
- + Hội chứng mảnh ghép chống vật chủ (graft-vs-host disease): tổn thương dạng lichen lan tỏa kèm tổn thương niêm mạc nặng.
- + Lichen phẳng: các sẩn bóng, tím, có vảy, hình đa giác.
- Tổn thương niêm mạc:
- + Tổn thương sớm nhất và thường gặp nhất: các vết loét miệng đau, lâu lành.
- + Ngoài ra, bệnh có thể ảnh hưởng đến các vùng niêm mạc khác như kết mạc, niêm mạc sinh dục như âm đạo, môi lớn, môi bé, dương vật.
- Các tổn thương khác:
- + Tổn thương của niêm mạc đường tiêu hóa và hô hấp và là nguyên nhân đáng kể gây tử vong.
- + Tổn thương của phổi bao gồm: bệnh phổi tắc nghẽn và viêm tiểu phế quản tắc nghẽn, có thể gây tử vong. Trên lâm sàng, bệnh nhân thấy khó thở nhưng trên phim chụp X - quang có thể bình thường.

2.1.4. IgA pemphigus

- Tổn thương cơ bản: mụn mủ trên nền da đỏ nhanh chóng vỡ ra tạo thành các lớp vảy hình vòng trên nền da đỏ.
- Vị trí: các vùng nếp gấp như nách và bẹn. Tuy nhiên, trường hợp tổn thương lan tỏa toàn thân và thân mình không phải là hiếm.
- Không có tổn thương ở niêm mạc.
- Cơ năng: thường có đau và ngứa tại tổn thương.
- Triệu chứng toàn thân như sốt, khó chịu, đau đầu và sụt cân có thể gặp.

2.2. Cận lâm sàng

2.2.1. Xét nghiệm tế bào Tzanck

Hình ảnh tế bào gai đứt cầu nối và lệch hình, ngoài ra còn gặp các tế bào viêm như bạch cầu đa nhân trung tính, đa nhân ái toan.

2.2.2. Mô bệnh học

- Pemphigus thể sâu (pemphigus thông thường, pemphigus sùi): bong nước trong thượng bì kèm hiện tượng tiêu gai ở sâu ngay trên lớp đáy. Trong dịch bong nước chứa bạch cầu đa nhân trung tính, lympho bào. Ngoài ra với pemphigus sùi còn tăng sản thượng bì với các áp xe chứa bạch cầu đa nhân trung tính và ái toan.
- Pemphigus thể nông (pemphigus vảy lá, pemphigus da mỡ): hiện tượng tiêu gai rất nông, xảy ra ở phần cao của lớp gai hay trong lớp hạt.
- Pemphigus á u: thường có hoại tử thượng bì, ly gai trên lớp đáy, dị sừng của các tế bào biểu mô (dyskeratotic). Hiện tượng dị sừng là một dấu hiệu đặc trưng mô học của pemphigus á u, được thấy trong tất cả các lớp của thượng bì, đặc biệt rõ ở vùng có hiện tượng ly gai.
- Pemphigus IgA: mụn nước dưới lớp sừng thâm nhiễm nhiều bạch cầu đa nhân trung tính và mất liên kết nhẹ giữa các tế bào sừng.

2.2.3. Miễn dịch huỳnh quang

- Miễn dịch huỳnh quang gián tiếp:
 - + Với pemphigus thể sâu: kháng thể tuần hoàn IgG kháng màng bào tương của các tế bào thuộc toàn bộ các lớp của thượng bì trong 80-90% trường hợp.
 - + Với pemphigus thể nông: kháng thể kháng gian bào thượng bì tuần hoàn chỉ ở phần trên của thượng bì nông.
 - + Pemphigus á u: thấy lắng đọng IgG có/không kèm bổ thể cả gian bào và màng đáy.
 - + Pemphigus IgA: lắng đọng kháng thể IgA ở khoảng gian bào các tế bào thượng bì.
- Miễn dịch huỳnh quang trực tiếp
 - + Với pemphigus thể sâu: lắng đọng kháng thể IgG hình mạng lưới ở gian tế bào các tế bào biểu mô của thượng bì.
 - + Với pemphigus thể nông: kháng thể IgG kháng gian bào thượng bì tuần hoàn chỉ ở phần trên của thượng bì nông
 - + Pemphigus á u: tự kháng thể IgG chống lại cả gian bào và màng đáy.
 - + Pemphigus IgA: tự kháng thể IgA gian bào các tế bào gai.

2.2.4. ELISA

Tự kháng thể IgG kháng Desmoglein dương tính trên 95% trường hợp khi xét nghiệm ELISA.

Giá trị trên ELISA tương quan với độ nặng và mức độ hoạt động của bệnh.

2.2.5. Xét nghiệm máu

Tổng phân tích thể bào máu ngoại vi.

Sinh hóa máu: đánh giá tình trạng nhiễm trùng (CRP, procalcitonin...), đánh giá rối loạn nước điện giải (điện giải đồ), đánh giá các chức năng khác nhằm theo dõi điều trị (chức năng gan, thận, mỡ máu...).

Sàng lọc nhiễm viêm gan virus B,C, HIV....

2.3. Chẩn đoán xác định:

Dựa vào lâm sàng và miễn dịch huỳnh quang trực tiếp.

2.4. Chẩn đoán mức độ

Mức độ nhẹ	Mức độ vừa	Mức độ nặng
- Diện tích tổn thương < 5% - Tổn thương niêm mạc miệng giới hạn, không ảnh hưởng ăn uống, không cần dùng thuốc giảm đau	- Tổn thương từ 2 vị trí niêm mạc trở nên - Tổn thương niêm mạc miệng nặng hoặc khó nuốt dẫn tới sụt cân - Đau nhiều - Và/hoặc diện tích tổn thương > 5%	

2.5. Chẩn đoán phân biệt

- Bệnh Pemphigoid bóng nước
- Bệnh Duhring – Brocq
- Dị ứng thuốc
- Hồng ban đa dạng
- Chốc
- Bệnh Zona
- Ly thượng bì bóng nước bẩm sinh
- Bệnh Herpes
- Các bệnh da có tổn thương niêm mạc miệng: lichen phẳng,

3. ĐIỀU TRỊ

3.1. Nguyên tắc điều trị

- Điều trị theo mức độ và giai đoạn bệnh.
- Chống nhiễm khuẩn, bôi phụ nước điện giải.

3.2. Điều trị cụ thể

3.2.1. Điều trị tại chỗ

Cần điều trị trong môi trường vô khuẩn, bệnh nhân cần được chăm sóc da ở phòng chăm sóc đặc biệt như điều trị bỏng

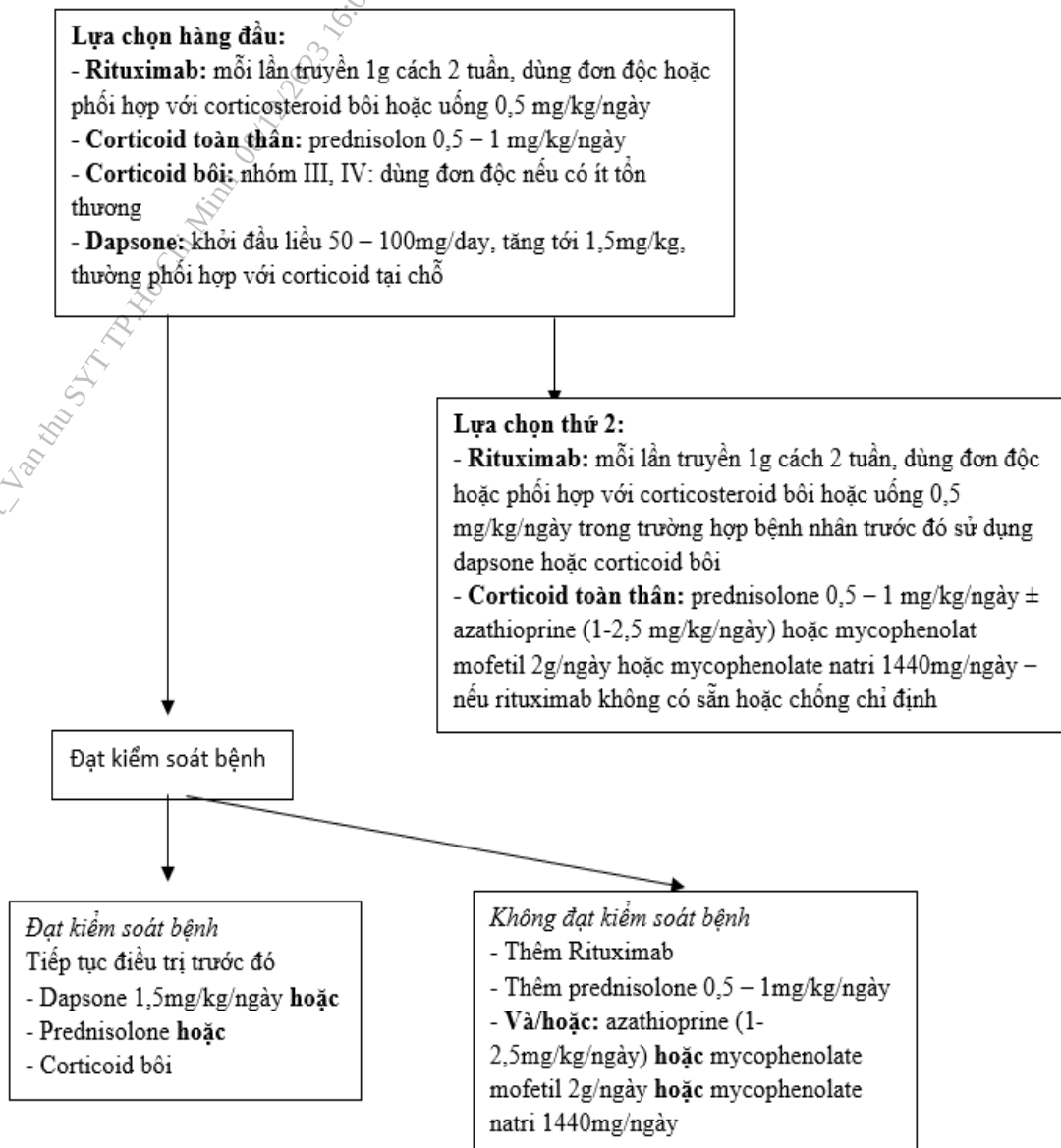
- Tổn thương bóng nước: dùng kim vô khuẩn chọc thấm dịch bóng nước.
- Các tổn thương trợt ướt, bóng nước vỡ đắp tổn thương bằng dung dịch Jarish
- Thuốc bôi tại chỗ: corticosteroid bôi tại chỗ, dùng mỡ kháng sinh nếu có bội nhiễm
- Tắm gạc vaselin băng tổn thương đối với những tổn thương trợt rộng, tổn thương có vảy tiết dày.
- Tắm bằng dung dịch thuốc tím pha loãng. Tổn thương trợt, nhiễm khuẩn nhiều có thể cho bệnh nhân ngâm tắm trong thời gian 15- 30 phút.

3.2.2. Toàn thân

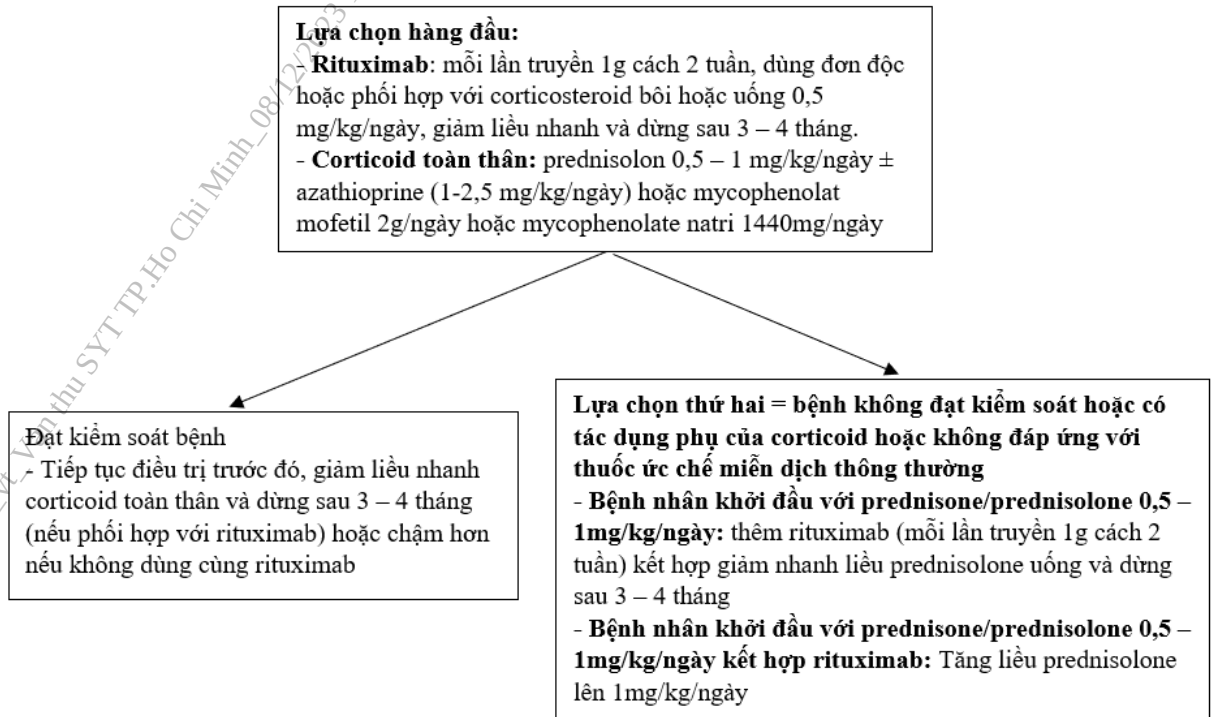
a. Pemphigus thể nông và sâu

- Mức độ nhẹ

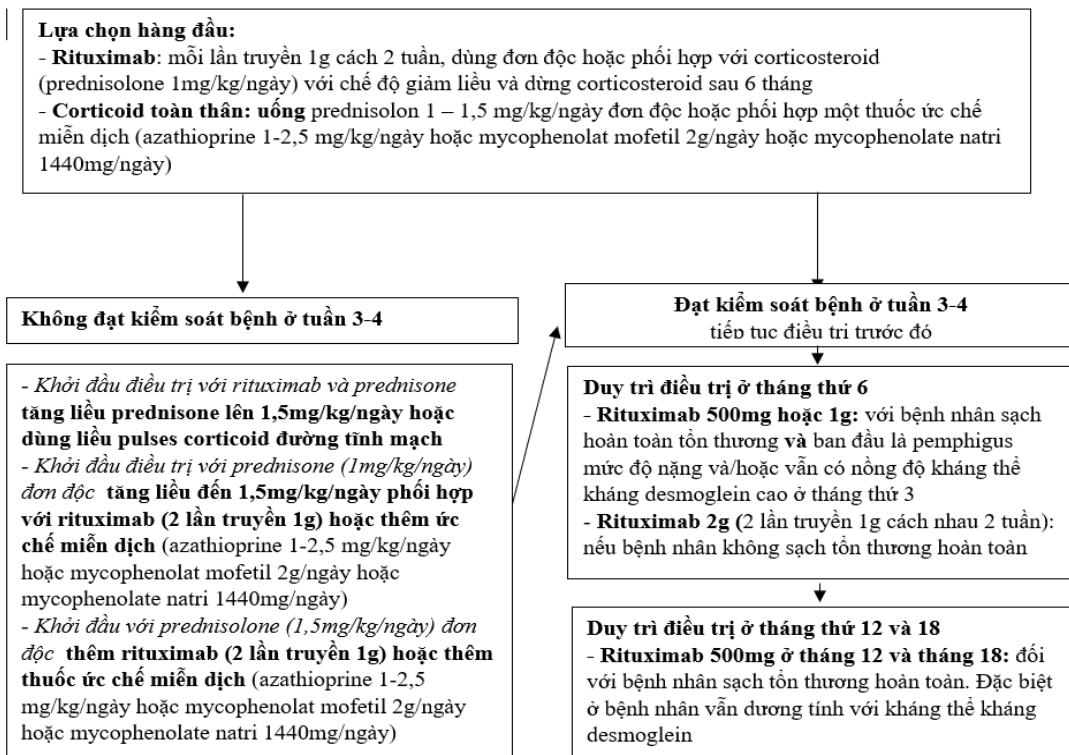
+ Pemphigus thể nông:



+ Pemphigus thể sâu



- Mức độ trung bình và nặng



b. Pemphigus á u

- Do khối u ác tính: việc điều trị khối u không ngăn chặn được sự tiến triển của bệnh.
- Do khối u lành tính: việc loại bỏ khối u sẽ giúp cải thiện bệnh đáng kể do giảm sản

xuất tự kháng thể.

- Đáp ứng điều trị trong pemphigus á u thấp, đặc biệt các tổn thương ở niêm mạc; tổn thương da đáp ứng tốt hơn:
 - + Thuốc điều trị đầu tay là corticosteroid với liều tương đương prednisolon 1-2 mg/kg/ngày, sau đó giảm liều tùy đáp ứng.
 - + Ngoài ra, có thể phối hợp các thuốc ức chế miễn dịch khác như: azathioprin, cyclosporin và mycophenolat mofetil . Tuy nhiên, sự phối hợp thuốc cũng khó tác động lên tổn thương niêm mạc.
 - + Các chọn lựa khác bao gồm: tách huyết tương, gammaglobulin tĩnh mạch.
 - + Thuốc sinh học: rituximab có tác dụng tốt trên bệnh nhân pemphigus á u kết hợp với u lympho B.

c. IgA pemphigus

- Điều trị đầu tay: liều tương đương prednisolon 0,5-1mg/kg phối hợp dapson. Giảm liều tùy theo đáp ứng.
- Một số loại thuốc khác có tác dụng điều trị: colchicin, retinoids, mycophenolat mofetil và adalimumab.

3.2.3. Điều trị hỗ trợ:

- Bù nước điện giải.
- Chống nhiễm khuẩn.

3.2.4. Theo dõi điều trị

- Giai đoạn bệnh hoạt động: theo dõi tình trạng nhiễm khuẩn (tổng phân tích tế bào máu ngoại vi, máu lắng, CRP, procalcitonin), tình trạng rối loạn nước điện giải (điện giải đồ), chức năng gan, thận: với tình trạng bệnh nhẹ 7-10 ngày/lần, với tình trạng bệnh nặng 3 ngày/lần hoặc tùy theo diễn biến lâm sàng.
- Giai đoạn bệnh ổn định:
 - + Đo hiệu giá kháng thể sau 3 tháng điều trị và sau mỗi 3 – 6 tháng tùy theo tiến triển bệnh.
 - + Đánh giá các dụng phụ của điều trị (tùy theo phác đồ sử dụng thuốc).

4. Phòng bệnh

- Phát hiện bệnh sớm.
- Điều trị tích cực ở giai đoạn bệnh hoạt động.
- Khám lại theo hẹn kể cả khi bệnh ổn định.
- Tránh sang chấn làm nặng tổn thương da.

PEMPHIGOID BỌNG NƯỚC

(Bullous pemphigoid)

1. ĐẠI CƯƠNG

1.1. Khái niệm

Bệnh Pemphigoid bong nước (*Bullous pemphigoid*-BP) là bệnh da bong nước tự miễn dưới thượng bì, lành tính, tiến triển mạn tính, tồn tại dai dẳng với nhiều đợt tự phát và thuyên giảm. Bệnh biểu hiện ở da, ít gặp ở niêm mạc.

1.2. Dịch tễ

Là bệnh da bong nước chiếm tỷ lệ cao nhất trong số các bệnh bong nước tự miễn dưới thượng bì. Tại Việt Nam, tỷ lệ mắc Pemphigoid trong tổng số các bệnh bong nước tự miễn là 9,9%. Bệnh thường gặp ở lứa tuổi 60-80 tuổi, hiếm gặp ở trẻ em.

Bệnh có thể khởi phát sau dùng một số loại thuốc chống viêm không steroid, kháng sinh, sau một số bệnh da mạn tính, sau đột quỵ, Parkinson. BP có thể đồng mắc với một số bệnh như đái tháo đường, tăng huyết áp.

1.3. Căn nguyên/Cơ chế bệnh sinh

Pemphigoid bong nước là bệnh lý tự miễn dịch. Cơ chế bệnh sinh phức tạp, liên quan đến nhiều yếu tố.

Kháng nguyên của bệnh BP (Bullous Pemphigoid Antigen - BPAg) có 2 loại chính nằm chủ yếu ở màng đáy của da là BPAg 1 và BPAg 2 (còn gọi là BP 230 và BP 180). Tự kháng thể trong BP chủ yếu thuộc lớp IgG. Bỏ thể trong BP có 2 thành phần chính là C3a và C5a. Các men tiêu đạm protease cũng đóng vai trò quan trọng trong bước cuối cùng hình thành bong nước.

Tất cả các yếu tố trên cùng kết hợp tạo nên cơ chế bệnh sinh của bệnh BP. Tế bào B và tương bào bị kích thích sản xuất kháng thể IgG chống lại kháng nguyên BP ở vùng lá trong của màng đáy. Sự kết hợp kháng nguyên kháng thể hoạt hóa bỏ thể giải phóng ra các chất trung gian hóa học như các men ly giải, histamin, các yếu tố lôi kéo bạch cầu ái toan, bạch cầu đa nhân trung tính đến tập trung ở trung bì, thậm chí kết dính vào màng đáy. Tại đó các bạch cầu đa nhân sẽ giải phóng ra các men phá hủy tổ chức gây ra sự phân tách thượng bì-trung bì và hình thành bong nước.

2. CHẨN ĐOÁN

2.1. Triệu chứng lâm sàng

2.1.1. Tổn thương da

Bệnh thường khởi phát bằng tổn thương dạng sẩn ngứa, mào đay kéo dài một đến vài tháng trước khi xuất hiện tổn thương bong nước điển hình.

- Tổn thương da điển hình là các bọt nước có kích thước lớn thường từ 1-4 cm trên nền da đỏ, hình tròn hoặc bầu dục, rải rác hoặc tập trung thành hình đa cung. Bọt nước căng, chứa đầy dịch trong, có thể gặp bọt nước xuất huyết, khó vỡ, khi vỡ tạo thành đám vảy tiết. Tổn thương khi lành không để lại sẹo nhưng thường để lại dát tăng hoặc giảm sắc tố, có thể có hạt milia. Dấu hiệu Nikolsky (-).

- Các tổn thương khác: dát đỏ, tổn thương dạng mày đay, sẩn ngứa, vết trợt do cào gãi.

- Vị trí tổn thương: thường gặp ở bụng dưới, mặt trong đùi, bẹn, nách, mặt gấp cẳng tay, phần dưới cẳng chân (thường là dấu hiệu đầu tiên). Một số trường hợp bọt nước khu trú một vùng cơ thể, thường ở chi dưới.

2.1.2. Tổn thương niêm mạc

Tổn thương niêm mạc ít gặp, nếu có thường ở niêm mạc miệng, bọt nước nhỏ, khó vỡ, khi vỡ lành nhanh không để lại sẹo. Hiếm gặp ở môi, thực quản, sinh dục, hậu môn.

2.1.3. Triệu chứng cơ năng và toàn thân

- Cơ năng: bệnh nhân thường ngứa, mức độ thay đổi có thể ít ngứa hoặc ngứa rất nhiều. Một số trường hợp ngứa kéo dài hoặc ngứa xuất hiện trước tổn thương da.

- Triệu chứng toàn thân: sốt, mệt mỏi khi tổn thương da lan rộng, bệnh nặng hoặc có nhiễm khuẩn kèm theo.

2.2. Cận lâm sàng

- Xét nghiệm tế bào Tzanck: không có tế bào gai lệch hình, xâm nhập viêm chủ yếu bạch cầu ái toan.

- Mô bệnh học: nhuộm HE bọt nước dưới thượng bì, xâm nhập tế bào bạch cầu đa nhân ái toan, trung tính, lympho trong bọt nước.

- Miễn dịch huỳnh quang trực tiếp (MDHQ trực tiếp): kháng thể IgG có thể kèm theo bổ thể C3 lắng đọng thành dải dọc màng đáy.

- Miễn dịch huỳnh quang gián tiếp (MDHQ gián tiếp): huyết thanh bệnh nhân có kháng thể IgG chống lại màng đáy.

- MDHQ tách muối: lắng đọng IgG ở đỉnh bọt nước.

- Xét nghiệm ELISA: phát hiện và định lượng tự kháng thể kháng BP180, kháng thể kháng BP230 lưu hành trong máu.

2.3. Chẩn đoán xác định: dựa vào lâm sàng và xét nghiệm MDHQ trực tiếp.

2.4. Chẩn đoán mức độ bệnh

- Mức độ bệnh nhẹ: xuất hiện < 10 bọt nước mới/ngày và tổn thương khu trú ở một vùng cơ thể.

- Mức độ bệnh nặng: xuất hiện ≥ 10 bọng nước mới/ngày hoặc số lượng bọng nước mới/ngày < 10 nhưng nhiều tổn thương viêm phân bố lan rộng trên cơ thể.

2.5. Chẩn đoán phân biệt

- Pemphigus thông thường
- Bệnh Dühring-Brocq
- Ly thượng bì bọng nước mắc phải
- Hồng ban đa dạng
- Chốc

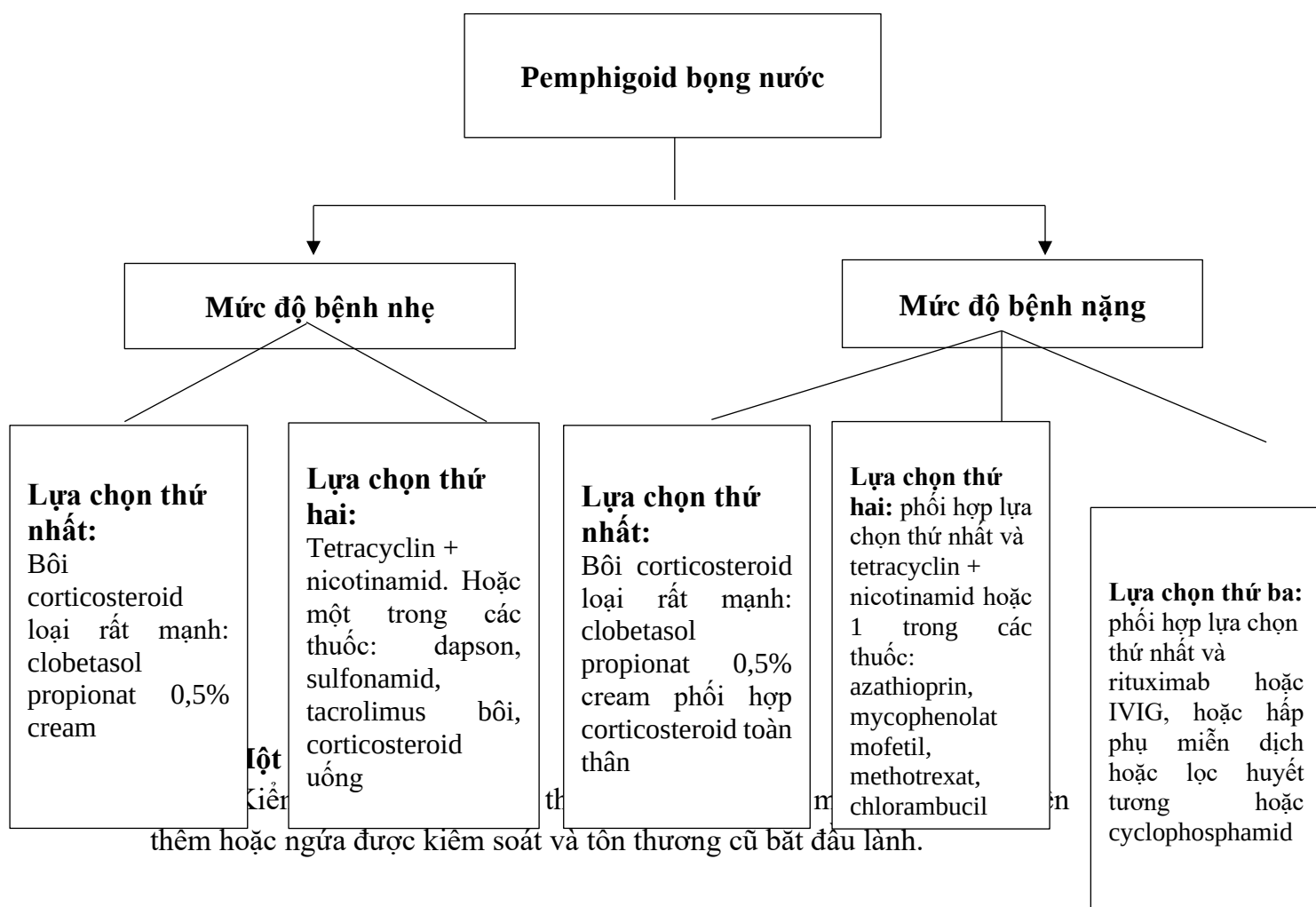
3. ĐIỀU TRỊ

3.1. Nguyên tắc điều trị

- Lựa chọn thuốc điều trị tùy theo mức độ bệnh.
- Chống bội nhiễm, kiểm soát ngứa, nâng cao thể trạng.

3.2. Điều trị cụ thể: lựa chọn thuốc điều trị tùy theo mức độ bệnh

Sơ đồ điều trị bệnh Pemphigoid bọng nước



- Tái phát: khi xuất hiện ≥ 3 tổn thương mới (bọng nước hoặc nốt) trong 1 tháng, các tổn thương này không lành trong 1 tuần hoặc ở những bệnh nhân đã kiểm soát được bệnh tổn thương cũ lan rộng.

- Điều trị tối thiểu: prednisolon $\leq 0,1$ mg/kg/ngày hoặc clobetasol propionat $0,05\% \leq 20$ g/ngày hoặc minocyclin, doxycyclin ≤ 100 mg/ngày, azathioprin ≤ 1 mg/kg/ngày hoặc methotrexat (MTX) ≤ 5 mg/tuần hoặc mycophenolat mofetil ≤ 500 mg/ngày hoặc cyclosporin ≤ 1 mg/kg/ngày hoặc nicotinamid ≤ 500 mg/ngày.

3.2.2. Điều trị tại chỗ

- Thuốc bôi clobetasol propionate 0,5% cream
- + Mức độ bệnh nặng: 30 - 40g/ngày, bôi lên toàn bộ cơ thể trừ mặt (sử dụng 20g/ngày nếu cân nặng < 45 kg).
- + Mức độ bệnh nhẹ: bôi 1 lần/ngày toàn cơ thể trừ mặt, 20g/ngày (hoặc 10g/ngày nếu cân nặng < 45 kg).
- Nếu sau 1 - 3 tuần không kiểm soát được bệnh tăng liều lên tối đa 40g/ngày. Khi đạt kiểm soát được bệnh thì giảm liều bôi.
- Chăm sóc tổn thương da, thuốc kháng sinh bôi, thuốc sát khuẩn tại chỗ nếu có bội nhiễm, kem dưỡng ẩm làm dịu da, giảm ngứa.

3.2.3. Điều trị toàn thân

- Corticosteroid toàn thân:
- + Liều trung bình, khởi đầu tương đương prednisolon 0,5 mg/kg/ngày đến khi đạt kiểm soát bệnh, dùng tiếp 15 ngày, sau đó giảm liều chậm đến liều tối thiểu có tác dụng (0,1 mg/kg/ngày) hoặc cắt thuốc sau 6 tháng dùng. Nếu trong quá trình giảm liều mà tái phát, cần quay trở về liều trước đó và cân nhắc thêm các thuốc toàn thân khác.
- + Nếu sau 1 - 3 tuần dùng liều khởi đầu không kiểm soát được bệnh thì tăng liều lên 0,75 mg/kg/ngày, có thể phối hợp thêm các thuốc toàn thân khác.
- Các thuốc toàn thân khác:
- + Tetracyclin (tetracyclin 500 - 2000mg/ngày, doxycyclin 200mg/ngày, minocyclin 100 - 200mg/ngày) dùng đơn độc từng loại hoặc phối hợp với nicotinamid 2 g/ngày.
- + Azathioprin 1-3mg/kg/ngày, mycophenolat mofetil 2g/ngày, methotrexat 15 mg/tuần, chlorambucil 2 - 4mg/ngày, cyclosporin 3 - 5mg/kg/ngày, dapsone 50 - 200mg/ngày.
- + Nếu kháng trị xét lựa chọn tiếp theo như rituximab, IVIG, hấp thụ miễn dịch, lọc huyết tương, cyclophosphamid.
- Dừng điều trị: thời gian điều trị trung bình của bệnh là 6 - 12 tháng.
- Các tiêu chuẩn dừng thuốc:
 - + Ổn định bệnh ít nhất 3 - 6 tháng dưới điều trị tối thiểu.
 - + Xét nghiệm: miễn dịch huỳnh quang trực tiếp âm tính và hoặc anti-BP180 ELISA âm tính (hoặc < 27 U/ml).

3.2.4. Điều trị hỗ trợ

- Kháng sinh toàn thân chống bội nhiễm.
- Bù dịch, điện giải.
- Kháng histamin giảm triệu chứng ngứa.

4. PHÒNG BỆNH

- Tránh dùng các thuốc nghi ngờ gây khởi phát bệnh.
- Phát hiện và điều trị bệnh sớm, tránh cào gãi, vệ sinh sạch sẽ vùng da bị bệnh để tránh nhiễm khuẩn toàn thân do bội nhiễm vi khuẩn, virus.

- Tiến triển: Bệnh tiến triển mạn tính, thành từng đợt, lúc tăng lúc giảm, lúc tạm ổn định. Một phần ba trường hợp có thể tự khỏi. Bệnh có thể tái phát nhưng có thể không chế được nhờ uống sulfon (dapson) hoặc chế độ ăn không có gluten. Có trường hợp bệnh kéo dài suốt đời nhưng bệnh nhân vẫn sinh hoạt, lao động như bình thường, trừ vài trường hợp ở người cao tuổi, lâu ngày có thể bị suy kiệt.

2.2. Cận lâm sàng

- Xét nghiệm tế bào Tzanck : không có tế bào gai lệch hình, xâm nhập viêm chủ yếu bạch cầu đa nhân trung tính.

- Mô bệnh học: bong nước dưới thượng bì. Thượng bì hoàn toàn bình thường và bị đẩy lên cùng màng đáy, không có hiện tượng tiêu gai. Đỉnh nhú bì thâm nhiễm chủ yếu là bạch cầu đa nhân trung tính, đôi khi có bạch cầu đa nhân ái toan. Ở trung bì nông có thâm nhiễm tế bào lympho, bạch cầu trung tính, bạch cầu ái toan xung quanh mạch máu.

- Miễn dịch huỳnh quang:

+ Miễn dịch huỳnh quang trực tiếp: là tiêu chuẩn vàng trong chẩn đoán bệnh DH. Có sự lắng đọng dạng hạt của IgA ở đỉnh nhú bì hay ranh giới trung bì-thượng bì. Ngoài ra, có thể thấy sự lắng đọng của bổ thể C3 và fibrinogen. Sự lắng đọng IgA có thể trong vùng tổn thương và ngoài vùng tổn thương.

+ Miễn dịch huỳnh quang gián tiếp: kháng thể IgA tuần hoàn có thể tìm thấy trên khoảng 70% bệnh nhân và hiệu giá kháng thể có liên quan đến mức độ trầm trọng của tổn thương theo các sợi lông nhưng vùng hồng tràng.

- Xét nghiệm máu: nói chung không đặc hiệu, có thể thấy số lượng bạch cầu ái toan tăng trên 10%.

2.3. Chẩn đoán xác định:

Chẩn đoán xác định dựa vào lâm sàng và xét nghiệm miễn dịch huỳnh quang trực tiếp.

2.4. Chẩn đoán phân biệt

- Hồng ban đa dạng
- Chốc
- Pemphigus
- Bệnh zona
- Bệnh herpes
- Bệnh ly thượng bì bong nước bẩm sinh
- Bệnh porphyria da
- Ly thượng bì bong nước mắc phải
- Pemphigoid bong nước

3. ĐIỀU TRỊ

3.1. Nguyên tắc điều trị

- Chế độ ăn không có gluten
- Điều trị bằng các thuốc chống viêm như dapson, sulfapyridin.
- Kết hợp điều trị tại chỗ và điều trị toàn thân
- Corticosteroid toàn thân ít có tác dụng

3.2. Điều trị cụ thể

3.2.1. Tại chỗ

- Tổn thương ướt, bong nước: Có thể đắp các tổn thương trợt ướt, bong nước vỡ bằng dung dịch Jarish, tắm bằng dung dịch thuốc tím pha loãng.
- Tổn thương khô: bôi mỡ kháng sinh và/hoặc bôi mỡ corticosteroid.

3.2.2. Toàn thân

- Chế độ ăn không có gluten đơn thuần đã có thể kiểm soát được bệnh hoặc có tác dụng giảm được thuốc dùng toàn thân. Tuy nhiên, điều này khó thực hiện trong thực đơn.
- Thuốc được dùng chủ yếu là dapson 100-300mg/ngày hoặc 0,5mg/kg/ngày đối với trẻ em. Triệu chứng có thể giảm đi trong vòng 3 giờ hoặc vài ngày. Bệnh nhân được khuyến cáo nên duy trì liều thấp để không chế các triệu chứng.
- Sulfapyridin 1-1,5g/ngày có hiệu quả trên một số bệnh nhân, nhất là những bệnh nhân không đáp ứng với dapson.
- Có thể dùng tetracyclin 500mg từ 1 đến 4 lần/ngày hoặc minocyclin 100mg 2 lần/ngày và nicotinamid 500mg 2-3 lần/ngày hoặc phối hợp tetracyclin với nicotinamid. Thuốc nhóm cyclin không dùng cho trẻ em

4. PHÒNG BỆNH

Để tránh bệnh tái phát, cần thực hiện chế độ ăn không có gluten.

BỆNH IGA THÀNH DẢI (Linear IgA dermatosis)

1. ĐẠI CƯƠNG

1.1. Khái niệm

- Bệnh IgA thành dải (linear IgA bullous dermatosis-LAD) là bệnh da bong nước tự miễn dưới thượng bì hiếm gặp, gây ra do tự phát hay do thuốc, đặc trưng bởi sự lắng đọng IgA thành dải ở màng đáy.

- Bệnh da bong nước IgA thành dải có thể xuất hiện ở cả người lớn và trẻ em với các tên gọi khác nhau. Ở trẻ em, bệnh được gọi là bệnh da bong nước mạn tính ở trẻ em (chronic bullous disease of childhood-CBDC), trong khi ở người lớn bệnh được gọi là bệnh IgA thành dải (LAD).

1.2. Dịch tễ

- Bệnh gặp ở tất cả các chủng tộc với tỷ lệ khác nhau.
- Bệnh có 2 đỉnh tuổi phát bệnh. Ở trẻ em, bệnh gặp chủ yếu ở trẻ dưới 5 tuổi, bắt đầu ở độ tuổi từ 6 tháng đến 10 tuổi, trung bình 3,3-4,5 tuổi. Trong khi ở người lớn, bệnh gặp từ 14-80 tuổi, trung bình 50 tuổi và thường phát sau khi sử dụng một số thuốc, đặc biệt là vancomycin.
- Bệnh hay gặp ở nữ nhiều hơn nam, tỉ lệ nữ/nam là 1,6/1.

1.3. Căn nguyên/Cơ chế bệnh sinh

- Căn nguyên gây LAD chưa rõ ràng, đa số là vô căn, phát sinh một cách tự nhiên. Tuy nhiên, LAD có thể gây nên do một số căn nguyên khác. Đôi khi bệnh xảy ra sau một nhiễm trùng, hiếm hơn là do dị ứng thuốc. Vancomycin là thuốc thường được đề cập nhiều nhất liên quan đến khởi phát LAD. Ngoài ra, một số thuốc khác cũng được đề cập đến như diclofenac, captopril, cotrimoxazol, sodium hypochlorit và somatostatin...

- Bệnh IgA thành dải đi kèm với bệnh ác tính gặp khoảng 5%. Các bệnh ác tính thường là u lympho, đặc biệt là bệnh Hodgkin, không Hodgkin, bệnh bạch cầu dòng lympho mạn tính, ung thư bàng quang, ung thư biểu mô tế bào vảy thực quản, ung thư vú, ung thư tử cung, ung thư biểu mô tuyến mồ hôi... Tuy nhiên, mối liên quan giữa IgA thành dải với bệnh ác tính vẫn còn chưa được chứng minh.

- Kháng nguyên đích: phân 97 kDa của BPAG2 (kháng nguyên pemphigoid 2 hay còn gọi là BP180) nằm trong lá sáng. Tiểu đơn vị này nằm trong miền NC16A. Trong bệnh pemphigoid bong nước, các kháng thể IgG lưu hành liên kết với vùng MCW-1 của miền NC16A gần đầu amino hơn, trong khi tiểu đơn vị 97kDa nằm ở đầu carboxy.

2. CHẨN ĐOÁN

2.1. Triệu chứng lâm sàng

2.1.1. Tổn thương da

- Tổn thương cơ bản là các đám mụn nước, bóng nước chứa dịch trong và/hoặc xuất huyết sắp xếp thành hình tròn hoặc bầu dục trên nền da bình thường hay nền da đỏ/mảng da đỏ phù dạng mây đay. Các tổn thương này sắp xếp thành đám, thành cụm giống bệnh herpes nên còn gọi là hình thái herpes (herpetiform) hay tập trung ở rìa bờ dát đỏ theo hình nhẫn hoặc hình đa cung, hay gặp ở mặt dưới của đầu gối và khuỷu tay.

- Các loại tổn thương khác là mảng đỏ, dát, sẩn giống hồng ban đa dạng hay các tổn thương thứ phát như vảy tiết, vết trợt, vết loét, có thể đối xứng hoặc không, khi lành không để lại sẹo.

- Sự phân bố của các tổn thương khác nhau giữa người lớn và trẻ em

+ Ở trẻ em, tổn thương điển hình thường xuất hiện trước tuổi dậy thì với một khởi phát đột ngột là bóng nước ở bộ phận sinh dục, sau đó lan đến tay, chân và mặt. Thời kỳ toàn phát, tổn thương chủ yếu ở vùng bụng dưới, sinh dục ngoài và vùng đáy chậu. Ngoài ra còn thấy các tổn thương ở tay, chân, mặt, đặc biệt là vùng quanh miệng.

+ Ở người lớn, vị trí đầu tiên thường ở các chi, sau đó có thể xuất hiện ở bất cứ vị trí nào trên cơ thể. Vùng đáy chậu và quanh miệng ít gặp hơn. Hình ảnh các tổn thương tương tự như viêm da dạng herpes (DH), pemphigoid bóng nước (BP) hay hồng ban đa dạng (erythema multiforme-EM).

- Bệnh có thể làm tăng nguy cơ bị u lympho.

- Cơ năng có thể có ngứa.

2.1.2. Tổn thương niêm mạc

- Khoảng 50% các trường hợp LAD ở cả người lớn và trẻ em có tổn thương trong miệng. Triệu chứng bao gồm các mụn nước trợt loét, dát đỏ, viêm lợi, viêm môi trợt... Các biểu hiện này có thể xuất hiện trước khi có tổn thương da.

- Có thể thấy tổn thương ở mắt như kích ứng, khô, nhạy cảm ánh sáng, nhìn mờ, sẹo giác mạc và thậm chí mù lòa.

- Nếu bệnh kéo dài, tổn thương niêm mạc khi lành thường để lại sẹo và có thể gây nên hậu quả nặng nề. Viêm lợi thứ phát có thể làm hỏng răng. Tổn thương ở mắt rất khó phân biệt được với pemphigoid sẹo (pemphigoid cicatricial) và có thể dẫn đến mù lòa. Ngoài ra, có thể thấy tổn thương ở hầu họng, thanh quản, mũi, trực tràng và thực quản.

2.1.3. Tiến triển

- Bệnh LAD ở trẻ em thường lành tính, tự thuyên giảm, có thể tồn tại một vài tháng đến vài năm, nhưng hiếm khi đến tuổi dậy thì.
- Ở người lớn bệnh thường kéo dài hơn, trung bình 5-6 năm, kéo dài trong khoảng 1-15 năm.
- Các trường hợp bệnh gây nên do thuốc thường mất đi nhanh chóng nếu xác định được thuốc gây bệnh và ngừng sử dụng.

2.2. Cận lâm sàng

- Xét nghiệm tế bào Tzanck: không có tế bào gai lệch hình.
- Mô bệnh học: bong nước dưới thượng bì. Thượng bì hoàn toàn bình thường và bị đẩy lên cùng màng đáy, không có hiện tượng tiêu gai. Trung bì có xâm nhập chủ yếu là bạch cầu đa nhân trung tính, ngoài ra còn có bạch cầu đơn nhân và bạch cầu ái toan.
- Miễn dịch huỳnh quang:
 - + Miễn dịch huỳnh quang trực tiếp: lắng đọng IgA thành dải ở màng đáy.
 - + Miễn dịch huỳnh quang gián tiếp: kháng thể tuần hoàn IgA có thể thấy ở trẻ em (80%), thường xuyên hơn người lớn (30%). Miễn dịch huỳnh quang gián tiếp tách muối cho tỉ lệ IgA dương tính cao hơn và chủ yếu là dương tính ở đỉnh bong nước.
 - Đặc điểm miễn dịch huỳnh quang theo căn nguyên:
 - + Nếu LAD tự phát: khoảng 50% cho thấy có lắng đọng cả IgA và IgG ở màng đáy.
 - + Nếu LAD do thuốc: chủ yếu lắng đọng IgA (89%) ở màng đáy, không có IgG.

2.3. Chẩn đoán xác định:

Dựa vào lâm sàng và xét nghiệm miễn dịch huỳnh quang trực tiếp

2.4. Chẩn đoán phân biệt

- Hồng ban đa dạng
- Pemphigoid bong nước
- Viêm da dạng herpes
- Ly thượng bì bong nước mắc phải
- Chốc
- Lupus bong nước

3. ĐIỀU TRỊ

3.1. Nguyên tắc điều trị

- Ngừng thuốc nghi ngờ gây bệnh.
- Điều trị bằng các thuốc chống viêm như dapson, sulfapyridin và/hoặc corticosteroid toàn thân.
- Kết hợp điều trị tại chỗ và điều trị toàn thân

3.2. Điều trị cụ thể

3.2.1. Tại chỗ

- Dung dịch sát khuẩn (nếu tổn thương còn bọt nước nên dùng kim vô khuẩn chọc thấm dịch trước khi bôi).
- Khi tổn thương khô có thể bôi mỡ kháng sinh và/hoặc mỡ corticosteroid.
- Có thể đắp các tổn thương ướt, bọt nước vỡ bằng dung dịch Jarish, tắm bằng dung dịch thuốc tím pha loãng.

3.2.2. Toàn thân

- Lựa chọn thứ nhất: dapson 0,5 - 2 mg/kg/ngày (hoặc 50 - 200 mg/ngày) do cơ chế ức chế hóa ứng động bạch cầu, đáp ứng nhanh sau 1 - 2 ngày. Sử dụng từ liều thấp, tăng dần liều để đạt đáp ứng. Nên làm các xét nghiệm loại trừ thiếu hụt G6PD, theo dõi công thức máu để hạn chế tác dụng phụ của dapson.
- Lựa chọn thứ 2:
 - + Sulfasalazin 1 - 1,5mg/ ngày đơn trị hoặc kết hợp, sulfamethoxypyridazin 0,25 - 1,5 g/ngày mang lại tác dụng trong một số báo cáo lâm sàng.
 - + Colchicin 0,6 - 1 mg/kg/2 lần/ngày.
- Lựa chọn thứ 3: corticosteroid liều tương đương prednisolon đơn trị 0,5 - 1 mg/kg/ngày. Sau đó giảm liều theo phác đồ đến liều thấp nhất có đáp ứng lâm sàng.
- Lựa chọn khác: methotrexat, mycophenolat mofetil, azathioprin, cyclosporin, dicloxacillin, erythromycin, interferon, IVIG, thalidomid, infliximab cân nhắc trong trường hợp không đáp ứng với lựa chọn đầu tiên và lựa chọn số hai.

4. PHÒNG BỆNH

- Tránh sử dụng các thuốc có nguy cơ cao gây bệnh.
- Sử dụng kháng sinh khác thay thế vancomycin nếu nguyên nhân do vancomycin.

syt_hochiminh_vt_Van thu SYT TP.Ho Chi Minh_08/12/2023 16:01:22

Chương 5

BỆNH DA DỊ ỨNG – MIỄN DỊCH VÀ BỆNH DA VIÊM

VIÊM DA TIẾP XÚC

(Contact Dermatitis)

1. ĐẠI CƯƠNG

1.1. Khái niệm

- Viêm da tiếp xúc là phản ứng viêm cấp tính hoặc mạn tính của da với một số yếu tố trong môi trường khi tiếp xúc với da.
- Viêm da tiếp xúc dị ứng (VDTXDU) là phản ứng tăng nhạy cảm của da đối với các dị nguyên. Tổn thương là dát đỏ, mụn nước, có khi loét trợt hoại tử, ngứa. Bệnh tiến triển dai dẳng, hay tái phát nếu không phát hiện và loại trừ được dị nguyên.
- Viêm da tiếp xúc kích ứng (VDTXKU) là biểu hiện của phản ứng trên da đối với các tác nhân hóa học, lý học và sinh học bên ngoài. Biểu hiện của VDTXKU khá đa dạng bao gồm dát đỏ, mụn nước, trợt da, loét, kèm cảm giác châm chích, rát bỏng.

1.2. Dịch tễ

- Viêm da tiếp xúc dị ứng chiếm khoảng 20% trong số các viêm da tiếp xúc. Là bệnh thường gặp, chiếm 1,5-5,4% dân số thế giới. Mọi lứa tuổi, mọi giới và mọi nghề khác nhau đều có thể bị VDTXDU.
- Viêm da tiếp xúc kích ứng chiếm 80% trong số các trường hợp viêm da tiếp xúc, xảy ra ở hầu hết những người tiếp xúc với chất gây kích ứng. Nghiên cứu cộng đồng ở châu Âu về chàm (eczema) do tất cả các loại nguyên nhân cho thấy tỷ lệ VDTXKU từ 0,7-40%. Nghiên cứu tại Mỹ ở đối tượng lao động cho thấy viêm da tiếp xúc chiếm 90-95% bệnh da nghề nghiệp.

1.3. Căn nguyên/Cơ chế bệnh sinh

- Viêm da tiếp xúc dị ứng là biểu hiện của phản ứng quá mẫn chậm qua trung gian tế bào (typ IV). Lúc đầu kháng nguyên là hapten có trọng lượng phân tử thấp, tiếp xúc trên da, kết hợp với protein tạo phức hợp protein-hapten là kháng nguyên hoàn chỉnh, tác động đến hệ miễn dịch. Quá trình mẫn cảm này xảy ra trong 5-21 ngày. Sự tái tiếp xúc với kháng nguyên đặc hiệu gây tăng sinh rất nhanh các tế bào T đã hoạt hóa, giải phóng chất trung gian hóa học, di chuyển các tế bào T độc, gây phản ứng chàm trên da vùng tiếp xúc. Giai đoạn này xảy ra 48-72 giờ sau khi tiếp xúc và chỉ cần một liều nhỏ dị nguyên cũng đủ kích thích phản ứng viêm. Có trên 3700 dị nguyên được cho là có thể gây VDTXDU ở người. Một số dị nguyên chính là kim loại (nickel, cobalt, chromates đồng), thuốc bôi (chất màu, kháng sinh), dung dịch dầu, một số băng dính, chất dẻo, cao su, thực vật, ánh sáng.
- Có bốn cơ chế có liên quan đến VDTXKU gồm mất lớp lipid bề mặt và các

chất giữ nước, màng tế bào bị phá hủy, sự biến tính của keratin thượng bì và tác động độc tế bào trực tiếp. Có trên 2800 chất kích ứng. Tiếp xúc với các chất kích ứng mạnh gây triệu chứng lâm sàng ở hầu hết bệnh nhân, với các chất kích ứng nhẹ thì chỉ có biểu hiện cơ năng. Khi tiếp xúc nhiều lần với chất kích ứng gây ra hiện tượng tích lũy, phá hủy dần lớp sừng do phá hủy enzym hoặc làm tan màng tế bào gây viêm mạn tính.

2. CHẨN ĐOÁN

2.1. Viêm da tiếp xúc dị ứng

2.1.1. Triệu chứng lâm sàng

Tổn thương cơ bản: phụ thuộc vào mức độ nặng, vị trí và thời gian bị bệnh, VDTXDU có thể cấp tính, bán cấp và mạn tính.

- Viêm da tiếp xúc dị ứng cấp tính

Biểu hiện là dát đỏ, ranh giới rõ, phù nề, trên bề mặt có mụn nước, sẩn. Trường hợp phản ứng mạnh có bọt nước kết hợp lại với nhau thành mảng. Bọt nước vỡ để lại vết trợt tiết dịch và đóng vảy tiết. Cơ năng có ngứa.

- Viêm da tiếp xúc dị ứng bán cấp

Biểu hiện là những mảng, dát đỏ nhẹ, kích thước nhỏ, trên có vảy da khô, đôi khi kèm theo những đám màu đỏ nhỏ hoặc những sẩn chắc, hình tròn.

- Viêm da tiếp xúc dị ứng mạn tính:

Biểu hiện là da dày, lichen hóa, nếp da sâu thành những đường kẻ song song hoặc hình thoi, bong vảy da cùng các sẩn vệ tinh, nhỏ, chắc, hình tròn, phẳng, những vết xước, dát đỏ và nhiễm sắc tố.

Bệnh thường gặp ở người đã mẫn cảm với dị nguyên gây viêm da tiếp xúc. Khởi đầu, tại vị trí da tiếp xúc lại với dị nguyên (48 giờ trở lên) xuất hiện tổn thương. Về sau, mỗi khi tiếp xúc với dị nguyên thì tổn thương xuất hiện nhanh hơn. Đa số trường hợp tổn thương vượt qua giới hạn vùng da tiếp tiếp xúc với dị nguyên, có thể rải rác ở những nơi khác. Cơ năng ngứa nhiều, có thể có cảm giác nhức nhối và đau nếu bệnh nặng. Tổn thương có thể cấp tính hoặc mạn tính phụ thuộc vào hoàn cảnh tiếp xúc, đậm độ của dị nguyên, tần suất tiếp xúc, đa số các trường hợp có tính chất đối xứng.

2.1.2. Cận lâm sàng

- Patch test (test áp): Dùng để chẩn đoán xác định dị nguyên gây VDTXDU và phân biệt với VDTXKU.

- Test kích thích (provocative test): Để xác định cá thể nhạy cảm với chất tiếp xúc bằng cách bôi chất đó vào da ở mặt trong cẳng tay hay các vùng da khác ngày vài lần trong 7 ngày.

- Mô bệnh học: Ở thể cấp tính có xốp bào rất mạnh, phù gian bào, xâm nhập các lympho bào và bạch cầu ái toan vào thượng bì, bạch cầu đơn nhân và mô bào ở trung bì. Ở thể mạn tính, cùng với xốp bào là hiện tượng tăng gai làm mào liên nhú kéo dài xuống. Các nhú bì nhô cao và mở rộng, có hiện tượng dày sừng và thâm nhiễm lympho bào. Xét nghiệm này có thể giúp chẩn đoán phân biệt với các bệnh viêm da khác.

2.1.3. Chẩn đoán xác định

Dựa vào lâm sàng, yếu tố tiếp xúc. Test áp giúp xác định dị nguyên gây dị ứng.

2.1.4. Chẩn đoán phân biệt

- Viêm da tiếp xúc do ánh sáng
- Viêm da cơ địa
- Viêm da dầu
- Bệnh vẩy nến (ở lòng bàn tay, bàn chân)
- Nấm da
- Nếu có bọt nước: bệnh zona, pemphigoid bọt nước

2.2. Viêm da tiếp xúc kích ứng

2.2.1. Triệu chứng lâm sàng

Biểu hiện lâm sàng của VDTXKU tương đối đa dạng, có thể được xếp thành ba thể chính như dưới đây.

- Phản ứng kích ứng

Là biểu hiện nhẹ gồm đỏ da nhẹ, bong vảy, mụn nước hoặc vết trợt, thường gặp ở mặt mu bàn tay và ngón tay. Bệnh hay xảy ra ở người làm các công việc có tiếp xúc với nước, có thể tự khỏi hoặc tiến triển thành VDTXKU.

- Viêm da tiếp xúc kích ứng

Xảy ra do tiếp xúc với hoá chất mạnh như acid và kiềm. Biểu hiện nhẹ gồm châm chích, rát bỏng, da khô căng hoặc sần phù thoáng qua. Biểu hiện nặng gồm đỏ, phù nề, đau, mụn nước, bọt nước, mụn mủ, lột da, hoại tử. Thương tổn giới hạn rất rõ với da lành, khu trú ở vùng tiếp xúc, xuất hiện nhanh trong vài phút đến vài giờ sau khi tiếp xúc với chất kích ứng. Có thể có trường hợp xuất hiện muộn, sau khi tiếp xúc với chất kích ứng 8-24 giờ hoặc thậm chí 2 tuần. Biểu hiện lâm sàng giống VDTXDU và đôi khi rất khó phân biệt, nhưng tiên lượng tốt hơn. Tổn thương lành nhanh sau vài ngày hoặc vài tuần ngừng tiếp xúc với chất kích ứng.

- Viêm da tiếp xúc kích ứng mạn tính

Đây là một bệnh hay gặp, xuất hiện khi tiếp xúc nhiều lần với chất có nồng độ thấp như xà phòng, dầu gội đầu. Các yếu tố thuận lợi gồm cọ xát, sang chấn, độ ẩm thấp. Bệnh xảy ra vài tuần, vài tháng, có thể vài năm sau khi tiếp xúc với chất kích

ứng. Biểu hiện gồm da đỏ, bóc vảy, nứt nẻ, lichen hóa, giới hạn không rõ với da lành, ngứa. Viêm da bàn tay hay gặp ở phụ nữ hơn nam giới do tiếp xúc với các chất kích ứng khi làm công việc nội trợ.

2.2.2. Cận lâm sàng

- Patch test (test áp): Dùng để chẩn đoán phân biệt với VDTXDU.
- Mô bệnh học: Không phải là xét nghiệm thường quy để chẩn đoán nhưng có thể giúp chẩn đoán phân biệt với bệnh vảy nến hoặc các bệnh da viêm khác.

2.2.3. Chẩn đoán xác định

Dựa vào lâm sàng, yếu tố tiếp xúc.

2.2.4. Chẩn đoán phân biệt

- Viêm da tiếp xúc dị ứng
- Viêm da cơ địa
- Viêm da dầu
- Bệnh vảy nến (ở lòng bàn tay, bàn chân)
- Tổ đũa
- Bệnh nấm da
- Bệnh ghẻ

3. ĐIỀU TRỊ

3.1. Nguyên tắc điều trị

- Tìm và loại bỏ được căn nguyên gây bệnh.
- Điều trị phụ thuộc vào giai đoạn của bệnh, mức độ bệnh.
- Hồi phục hàng rào bảo vệ da.

3.2. Điều trị cụ thể

3.2.1. Viêm da tiếp xúc dị ứng

- *Trường hợp cấp tính, khu trú*
 - + Corticosteroid tại chỗ.
 - Các vùng da mặt dưới, bàn tay, bàn chân: Dùng corticosteroid tại chỗ loại mạnh. Thuốc được bôi 1-2 lần/ngày trong 2-4 tuần hoặc cho tới khi lành thương tổn. Chú ý các tác dụng phụ của thuốc như teo da, giãn mạch.

- Mặt và các vùng da mặt gấp: Dùng corticosteroid tại chỗ loại trung bình tới nhẹ. Thuốc được dùng 1-2 lần/ngày trong 1-2 tuần. Sau đó có thể dùng 2 ngày 1 lần trong 2 tuần tiếp theo.

- + Chẹn calcineurin tại chỗ (tacrolimus, pimecrolimus) là một lựa chọn thay

thể cho corticosteroid ở những người bệnh cần được tiếp tục điều trị lâu dài (trên 2 tuần). Thuốc được dùng 2 lần/ngày cho tới khi cải thiện thương tổn, sau đó giảm dần số lần bôi. Tác dụng phụ hay gặp là nóng, rát, châm chích tại chỗ nhưng không gây teo da.

+ Các điều trị khác: kem dưỡng ẩm có thể được dùng nhiều lần trong ngày; dung dịch Jarish dùng để đắp vùng thương tổn ướt, rỉ dịch, nhiều vảy tiết; kháng histamin uống để giảm ngứa; kháng sinh tại chỗ và/hoặc toàn thân được sử dụng nếu có bội nhiễm.

- *Trường hợp lan tỏa, nặng hoặc không ổn định*

Khi có trên 20% diện tích cơ thể bị ảnh hưởng hoặc liên quan tới vùng mặt, bàn tay, bàn chân hoặc vùng sinh dục, corticosteroid toàn thân được dùng như là lựa chọn thứ nhất. Sử dụng prednisolon, hoặc hoạt chất corticosteroid tương đương, liều 0,5-1 mg/kg/ngày (tối đa 60 mg/ngày) trong 7 ngày. Sau đó, liều thuốc được giảm 50% trong mỗi 5-7 ngày tiếp theo rồi dừng sau 2 tuần.

- *Trường hợp mạn tính*

+ Hàng rào bảo vệ da bị hỏng, teo da do tác dụng phụ của corticosteroid tại chỗ là một biến chứng hay gặp. Điều trị trường hợp mạn tính nhằm tối thiểu hóa việc sử dụng thuốc kéo dài trên 2-4 tuần. Các loại kem dưỡng ẩm không có dị nguyên được sử dụng tích cực bên cạnh việc dùng thuốc.

+ Sử dụng ngắt quãng corticosteroid tại chỗ: Dùng loại mạnh trong kiểm soát VDTXDƯ mạn tính ở bàn tay, bàn chân và các mặt duỗi. Thuốc được dùng ngày 1 lần trong 7-10 ngày đầu tiên, sau đó cách ngày, không nên dùng thuốc kéo dài quá 4 tuần. Trong trường hợp tái phát, có thể dùng nhắc lại.

+ Tacrolimus tại chỗ: Nên sử dụng trong trường hợp VDTXDƯ mạn tính ở mặt và các nếp kẽ, hoặc trường hợp không đáp ứng với corticosteroid tại chỗ. Tacrolimus 0,1% hoặc 0,03% được dùng 1-2 lần/ngày cho tới khi lành và nhắc lại nếu tái phát.

+ Có thể dùng thuốc kháng histamin để giảm ngứa. Sử dụng kháng sinh tại chỗ và/hoặc toàn thân nếu có bội nhiễm.

+ Lựa chọn cho VDTXDƯ mạn tính không đáp ứng với các phương pháp trên gồm:

- Liệu pháp ánh sáng: tia cực tím (ultra violet-UV) B dải hẹp, UVA phối hợp với psoralen (PUVA)
- Các thuốc ức chế miễn dịch toàn thân khác: methotrexat, azathioprin, mycophenolat mofetil, và cyclosporin.

3.2.2. Viêm da tiếp xúc kích ứng

- Chất dưỡng ẩm: Chất giữ ẩm, chất làm mềm da, chất tạo độ ẩm cho da được sử dụng như liệu pháp đầu tay.

+ Chất giữ ẩm như axit lactic, urê, glycerin hoặc axit sorbic giúp hút nước, hydrat hóa lớp sừng.

+ Chất làm mềm da (petrolatum, lanolin, dầu khoáng) hoạt động bằng cách làm chậm quá trình mất nước qua da, đồng thời dưỡng ẩm cho da.

+ Các chất tạo độ ẩm cho da: Kem dưỡng ẩm, chất làm mềm, chất tạo độ ẩm cho da có thể được sử dụng nhiều lần trong ngày trên vùng da bị ảnh hưởng hoặc các khu vực tiếp xúc

- Corticosteroid tại chỗ: Chế phẩm dạng mỡ được sử dụng nhiều hơn dạng kem.

+ Trường hợp nặng, ở các vùng da ngoài mặt và không phải mặt gấp: Sử dụng corticosteroid cực mạnh, ngày 1-2 lần trong 2-4 tuần.

+ Trường hợp nhẹ, ở các vùng da ngoài mặt và không phải mặt gấp: Sử dụng corticosteroid loại mạnh, ngày 1-2 lần trong 2-4 tuần.

+ Trường hợp ở mặt và các mặt gấp: Sử dụng corticosteroid loại trung bình tới nhẹ, ngày 1-2 lần trong 1-2 tuần.

4. PHÒNG BỆNH

- Tránh tiếp xúc với các chất gây dị ứng, kích ứng; dùng đồ bảo hộ phù hợp khi làm việc trong môi trường có chất kích ứng hoặc dị nguyên nghi ngờ; tư vấn nghề nghiệp phù hợp cho người bệnh.

- Xác định cơ địa nhạy cảm bằng cách đo độ đỏ của da, độ mất nước qua da hoặc dùng test áp để sàng lọc sự kích ứng của sản phẩm định dùng, đồng thời thăm dò phản ứng dị ứng của cơ thể.

- Dùng kem bảo vệ, sản phẩm làm sạch thích hợp, tránh tắm rửa quá nhiều.

- Thường xuyên bôi kem làm ẩm, nhất là sau khi làm việc, để chống nứt, khô da, tránh sự xâm nhập của các chất kích ứng, dị ứng.

VIÊM DA CƠ ĐỊA

(Atopic Dermatitis)

1. ĐẠI CƯƠNG

1.1. Khái niệm

Viêm da cơ địa (trước đây được gọi là chàm thể tạng) là bệnh da viêm mạn tính, ngứa, hay tái phát, có tăng IgE, thường gặp ở người có tiền sử gia đình hen, viêm mũi dị ứng, viêm da cơ địa. Bệnh thường xuất hiện ở trẻ em và có thể tồn tại suốt đời.

1.2. Dịch tễ

Tỉ lệ bệnh viêm da cơ địa rất cao và khác nhau ở từng quốc gia. Bệnh thường khởi phát sớm ở trẻ nhỏ. Trên thế giới có khoảng 5 – 20% trẻ em bị bệnh này. Bệnh gặp ở cả hai giới. Trong những năm gần đây tỉ lệ viêm da cơ địa tăng cả ở những nước phát triển và đang phát triển.

1.3. Căn nguyên/Cơ chế bệnh sinh

- Yếu tố môi trường đóng vai trò khởi phát:
 - + Ô nhiễm môi trường
 - + Các dị nguyên có trong bụi nhà, lông súc vật, quần áo, đồ dùng gia đình...
 - + Nhiễm khuẩn, đặc biệt là tụ cầu vàng
- Yếu tố di truyền: khoảng 60% người lớn bị viêm da cơ địa có con bị bệnh này, nếu cả bố và mẹ cùng bị bệnh thì con đẻ ra có đến 80% cũng bị bệnh. Đã xác định được một số gen liên quan đến bệnh viêm da cơ địa, trong đó quan trọng nhất là đột biến gen filaggrin – gen mã hóa cho protein có vai trò liên kết các sợi keratin thượng bì cấu trúc thượng bì dẫn đến tổn thương hàng rào bảo vệ da.
 - Rối loạn cân bằng đáp ứng miễn dịch, vì vậy mất cân bằng đáp ứng miễn dịch Th1 và Th2.

2. CHẨN ĐOÁN

2.1. Triệu chứng lâm sàng

Bệnh viêm da cơ địa có các biểu hiện khác nhau tùy theo lứa tuổi.

- *Viêm da cơ địa ở trẻ nhũ nhi*
 - + Bệnh phát sớm khoảng 2-3 tháng sau sinh, thường cấp tính với các đám đỏ da, ngứa, sau đó xuất hiện nhiều mụn nước nông nhỏ như đầu đinh ghim tập trung thành từng đám, dễ vỡ, xuất tiết và đóng vảy tiết, có thể bội nhiễm, hạch lân cận sưng to.
 - + Vị trí hay gặp nhất là 2 má, có thể ở da đầu, trán, cổ, thân mình, mặt dưới các chi. Khi trẻ biết bò có thể xuất hiện tổn thương ở đầu gối. Không thấy tổn thương ở vùng tả lót.
 - + Trẻ có thể dị ứng với một số thức ăn như sữa, hải sản, thịt bò, thịt gà... Khi không ăn các thức ăn gây dị ứng thì bệnh viêm da cơ địa giảm rõ rệt.

- + Bệnh hay tái phát, mạn tính và rất nhạy cảm với các yếu tố như nhiễm trùng, mọc răng, tiêm chủng, thay đổi khí hậu hay môi trường sống.
- + Hầu hết bệnh sẽ tự khỏi khi trẻ được 18-24 tháng.
- *Viêm da cơ địa ở trẻ em*
- + Thường từ viêm da cơ địa nhũ nhi chuyển sang.
- + Tổn thương là các sẩn đỏ, vết trợt, da dày, mụn nước khu trú hay lan toả cấp tính kèm theo nhiễm khuẩn thứ phát.
- + Vị trí hay gặp nhất là ở khoeo, nếp gấp khuỷu tay, mi mắt, hai bên cổ, cẳng tay, ở cổ cổ sạm da mạng lưới, ít khi ở mặt dưới các chi.
- + Bệnh thường trở nên cấp tính khi trẻ tiếp xúc với lông súc vật, gia cầm, mặc đồ len, dạ...
- + Nếu tổn thương trên 50% diện tích da, trẻ thường suy dinh dưỡng.
- + Khoảng 50% sẽ khỏi khi trẻ được 10 tuổi.
- *Viêm da cơ địa ở thanh thiếu niên và người lớn*
- + Biểu hiện là mụn nước, sẩn đỏ dẹt, có vùng da mỏng trên mảng da dày, lichen hoá, ngứa. Vị trí hay gặp: nếp gấp khuỷu, khoeo, cổ, rốn, vùng da quanh mắt. Khi bệnh lan toả thì vùng nặng nhất là các nếp gấp.
- + Viêm da lòng bàn tay, chân: gặp ở 20-80% người bệnh, có thể là dấu hiệu đầu tiên của viêm da cơ địa ở người lớn.
- + Viêm da quanh mi mắt, chàm ở vú.
- + Tiến triển mạn tính, ảnh hưởng nhiều bởi các dị nguyên, môi trường, tâm sinh lý người bệnh.
- *Các biểu hiện khác của viêm da cơ địa*
- + Khô da: do tăng mất nước qua biểu bì.
- + Da cá, dày da lòng bàn tay, bàn chân, dày sừng nang lông, lông mi thưa.
- + Viêm môi bong vảy.
- + Dấu hiệu ở mắt, quanh mắt: mi mắt dưới có thể có 2 nếp gấp, tăng sắc tố quanh mắt, viêm kết mạc tái diễn có thể gây lộn mi.
- + Chứng da vẽ nổi.
- *Tiến triển và biến chứng:*
- + Khoảng 70% trẻ bị viêm da cơ địa sẽ khỏi khi lớn lên. Còn lại 30% kéo dài dai dẳng.
- + Khoảng 30-50% người bệnh viêm da cơ địa sẽ xuất hiện thêm các bệnh dị ứng khác như viêm mũi dị ứng, hen phế quản.

2.2. Cận lâm sàng

- IgE trong huyết thanh thường tăng
- Mô bệnh học: thượng bì có xốp bào xen kẽ với hiện tượng á sừng; trung bì có sự xâm nhập của bạch cầu lympho, mono, dưỡng bào, có hoặc không có các tế bào ái kiềm. Trường hợp lichen hoá có hiện tượng tăng sản thượng bì.

- Test xác định dị nguyên.
- Các xét nghiệm khác giúp đánh giá biến chứng và theo dõi điều trị, chẩn đoán phân biệt nếu cần: soi tươi tìm nấm, công thức máu, sinh hóa máu,

2.3. Chẩn đoán xác định

Có thể chẩn đoán xác định dựa vào một trong hai bộ tiêu chuẩn sau:

2.3.1. Tiêu chuẩn của Hanifin và Rajka

- *Tiêu chuẩn chính (4 tiêu chuẩn)*
 - + Ngứa
 - + Hình thái và vị trí tổn thương điển hình:
 - Lichen hoá ở các nếp gấp trẻ em hoặc thành dải ở người lớn
 - Mụn nước tập trung thành đám ở mặt và mặt dưới các chi ở trẻ em và trẻ sơ sinh
 - + Tổn thương viêm da mạn tính hoặc tái phát.
 - + Tiền sử cá nhân hay gia đình có mắc các bệnh dị ứng.
- *Tiêu chuẩn phụ (23 tiêu chuẩn)*
 - + Khô da.
 - + Vảy cá thông thường.
 - + Phản ứng da tức thì.
 - + Tuổi phát bệnh sớm.
 - + Dễ nhiễm trùng da.
 - + Viêm da bàn tay, bàn chân không đặc hiệu.
 - + Chàm núm vú.
 - + Viêm môi.
 - + Viêm kết mạc tái phát.
 - + Nếp dưới mi mắt của Dennie Morgan.
 - + Ngứa khi bài tiết mồ hôi.
 - + Tăng IgE huyết thanh.
 - + Tăng sắc tố quanh mắt.
 - + Vảy phấn Alba.
 - + Nếp lằn cổ trước.
 - + Ban đỏ, ban xanh ở mặt.
 - + Không chịu được len và chất hòa tan mỡ.
 - + Dày sừng quanh nang lông.
 - + Dị ứng thức ăn.
 - + Viêm kết mạc.
 - + Giác mạc hình chớp.
 - + Đục thủy tinh thể dưới màng bọc trước.
 - + Tiến triển bệnh có ảnh hưởng bởi yếu tố môi trường và tinh thần

Để chẩn đoán xác định cần phải có ≥ 3 tiêu chuẩn chính kết hợp với ≥ 3 tiêu chuẩn phụ.

2.3.2. Tiêu chuẩn của Anh

Ngứa da (bắt buộc)	
Ít nhất 3/5 triệu chứng	Hiện tại có tổn thương dạng chàm ở nếp gấp (nếp gấp khuỷu, hố khoeo, mặt trước cổ chân, cổ tay- trên 18 tháng; ở má, mặt dưới chi- dưới 18 tháng).
	Tiền sử cá nhân có tổn thương dạng chàm ở các vị trí như trên.
	Tiền sử cá nhân có khô da trong ít nhất 12 tháng.
	Tiền sử cá nhân bị hen hoặc viêm mũi xoang dị ứng (hoặc tiền sử gia đình có bố mẹ/anh chị em bị hen/viêm mũi xoang dị ứng nếu là trẻ dưới 4 tuổi).
	Khởi phát sớm, dưới 2 tuổi (tiêu chí này không áp dụng cho trẻ dưới 4 tuổi).

2.4. Chẩn đoán phân biệt

- Chàm vi trùng
- Viêm da dầu
- Viêm da tiếp xúc
- Ghẻ
- Rôm sảy
- Nấm da

3. ĐIỀU TRỊ

3.1. Nguyên tắc điều trị

- Điều trị tùy theo giai đoạn, mức độ bệnh.
- Dùng các sản phẩm chăm sóc da, dưỡng ẩm thường xuyên, duy trì.
- Tư vấn cho người bệnh và gia đình biết cách điều trị và phòng bệnh.

3.2. Điều trị cụ thể

3.2.1. Điều trị tại chỗ

- Lựa chọn dạng bào chế thuốc phù hợp với giai đoạn bệnh
- + Giai đoạn cấp tính: Đắp liên tục vào tổn thương bằng các loại dung dịch như Jarish, nước muối sinh lý 0.9%.
- + Giai đoạn bán cấp: dùng các loại hồ.
- + Giai đoạn mạn tính: dùng các loại thuốc dạng kem hoặc dạng mỡ.
- Các thuốc bôi tại chỗ:
 - + Corticosteroid được dùng nhiều trong điều trị viêm da cơ địa.
 - Trẻ dưới 3 tháng tuổi dùng loại hoạt tính yếu.
 - Trẻ từ 3 tháng tuổi: có thể dùng các loại có hoạt tính yếu đến trung bình.
 - Trẻ trên 2 tuổi và người lớn có thể dùng các loại corticosteroid có hoạt tính mạnh hơn tùy tình trạng bệnh.
 - Lưu ý: với tổn thương vùng da mỏng, nhạy cảm như mặt dùng mỡ

corticosteroid nhẹ hơn, ít ngày, còn vùng da dày, lichen hoá thì dùng loại mạnh hơn để giảm ngứa, giảm viêm.

- Corticosteroid bôi 1 lần/ngày và cần giảm liều một cách từ từ, tránh tái phát. Với vùng da mỏng như mặt, các nếp gấp thời gian bôi thuốc thường không quá 10 ngày liên tục. Với các vùng da dày có thể bôi kéo dài đến khi tổn thương ổn định thì giảm liều dần.

- Khi dùng corticosteroid bôi tại chỗ cần chú ý các tác dụng phụ trên da như mỏng da, teo da, viêm nang lông, trứng cá, giãn mạch, xuất huyết, bội nhiễm nấm-virus...

- + Thuốc bạt sừng bong vảy như mỡ salicylic 5%, 10%, mỡ goudron, ichthyol, crysophanic trong trường hợp vảy dày, lichen hóa nặng.

- + Thuốc chẹn calcineurin: rất hiệu quả đối với viêm da cơ địa và hạn chế được các tác dụng phụ của corticosteroid trên da, tuy nhiên thuốc đắt tiền và hay gặp kích ứng da trong thời gian đầu sử dụng, thường sử dụng sau đợt điều trị corticosteroid tại chỗ. Tacrolimus 0,03% chỉ định cho trẻ từ 2 đến 16 tuổi. Tacrolimus 0,1% chỉ định cho bệnh nhân từ 16 tuổi trở lên. Tacrolimus bôi 2 lần/ngày đến khi tổn thương ổn định hoàn toàn thì duy trì bôi thêm ít nhất 4 đến 8 tuần để tránh tái phát.

3.2.2. Điều trị toàn thân

- Kháng histamin H1: dùng khi bệnh nhân có biểu hiện ngứa.
- Kháng sinh trong trường hợp có nhiễm khuẩn đặc biệt là tụ cầu vàng, liên cầu. Cho kháng sinh thuộc nhóm cephalosporin thế hệ 1 hoặc amoxicillin kết hợp acid clavulanic là tốt nhất, cho một đợt từ 10-14 ngày.

- Corticosteroid: có thể được chỉ định trong thời gian ngắn khi bệnh bùng phát nặng, lưu ý không dùng thuốc kéo dài. Thường cho liều tương đương 0,5-1mg prednisolon/kg cân nặng trong 3 đến 7 ngày đầu khi cần khống chế nhanh tình trạng bệnh, sau đó cắt corticosteroid toàn thân chỉ dùng thuốc tại chỗ hoặc chuyển sang các thuốc toàn thân khác.

- Liệu pháp ánh sáng: NB-UVB hoặc UVA1
- Các thuốc khác được chỉ định trong trường hợp bệnh dai dẳng, tái phát nhiều, không đáp ứng với các điều trị trên:

- + Cyclosporin A liều 3-5mg/kg/ngày dùng 4 đến 8 tuần hoặc lâu hơn cho đến khi bệnh ổn định.

- + Methotrexat 10-25 mg/tuần, dùng 2-4 tháng hoặc lâu hơn tùy theo đáp ứng của từng bệnh nhân.

- + Thuốc sinh học dupilumab (thuốc ức chế I4 và IL13)

- Người lớn dùng liều 300mg- 600mg mỗi 2 tuần

- Trẻ em trên 6 tuổi liều tính theo cân nặng

- ✓ Cân nặng từ 60kg trở lên: liều khởi đầu 600mg sau đó duy trì 300mg mỗi 2 tuần.

- ✓ Cân nặng từ 30 đến 59kg: liều khởi đầu 400mg sau đó duy trì 200mg

mỗi 2 tuần.

- ✓ Cân nặng từ 15 đến 29kg: liều khởi đầu 600mg sau đó duy trì 300mg mỗi 4 tuần
- Trẻ em từ 6 tháng tuổi đến 5 tuổi liều tính theo cân nặng
 - ✓ Cân nặng từ 5 đến 15kg dùng liều 200mg mỗi 4 tuần
 - ✓ Cân nặng từ 15 đến 30kg dùng liều 300mg mỗi 4 tuần
- + Thuốc sinh học tralokinumab (thuốc ức chế IL13) 300mg- 600mg mỗi 2 tuần (chỉ dùng cho người lớn).
- + Thuốc ức chế JAK: baricitinib 4mg/ngày (chỉ dùng cho người lớn) hoặc upadacitinib 15mg- 30mg/ ngày (trẻ từ 12 tuổi trở lên).

3.2.3. Các phương pháp điều trị hỗ trợ

- Sữa tắm: Tắm hàng ngày bằng nước ấm với các sản phẩm làm sạch dịu nhẹ.
- Dưỡng ẩm: sử dụng kem dưỡng ẩm phù hợp lứa tuổi, tình trạng bệnh thường xuyên, duy trì.

4. PHÒNG BỆNH

- Duy trì sữa tắm dưỡng ẩm, kem dưỡng ẩm, tăng cường bôi kem dưỡng ẩm khi thời tiết hanh khô, ít nhất 2-3 lần mỗi ngày.
- Tắm nước ấm, không quá nóng, không quá lạnh, nhiệt độ < 36°C, ngay sau khi tắm xong bôi thuốc ẩm da, dưỡng da.
- Giảm các yếu tố khởi phát: giữ phòng ngủ thoáng mát, tránh tiếp xúc lông gia súc, gia cầm, len, dạ, giảm bụi nhà, giảm stress, nên mặc đồ vải cotton.
- Ăn kiêng chỉ áp dụng cho trường hợp bệnh nặng, trẻ nhỏ, khi đã xác định rõ loại thức ăn gây kích thích.
- Giáo dục người bệnh, người nhà người bệnh kiến thức về bệnh, yếu tố khởi động, quan điểm điều trị, lợi ích và nguy cơ.
- Tư vấn cho những người có yếu tố gia đình các biện pháp phòng bệnh.

VIÊM DA TIẾP XÚC DO ÁNH SÁNG

(Photocontact Dermatitis)

1. ĐẠI CƯƠNG

1.1. Khái niệm

Viêm da tiếp xúc do ánh sáng là bệnh da xảy ra do sự tương tác giữa ánh sáng với một loại hóa chất nào đó sử dụng trong da. Hóa chất có thể là thuốc, mỹ phẩm, sản phẩm nông nghiệp hoặc công nghiệp. Viêm da tiếp xúc do ánh sáng bao gồm: viêm da tiếp xúc kích ứng do ánh sáng (phản ứng nhiễm độc ánh sáng) và viêm da tiếp xúc dị ứng do ánh sáng (phản ứng dị ứng ánh sáng).

1.2. Dịch tễ

Viêm da tiếp xúc do ánh sáng thường gặp ở người lớn, gặp ở tất cả các chủng tộc, màu da. Tỷ lệ gặp ở nam nữ như nhau. Bệnh thường xuất hiện ở những người thường xuyên tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, thường nặng vào mùa xuân hè, thuyên giảm vào mùa thu đông. Viêm da tiếp xúc kích ứng do ánh sáng thường gặp hơn viêm da tiếp xúc dị ứng do ánh sáng.

1.3. Căn nguyên/Cơ chế bệnh sinh

- Viêm da tiếp xúc kích ứng do ánh sáng xảy ra do sự tương tác giữa ánh sáng với một loại hóa chất nào đó trong da tạo ra các sản phẩm như các gốc tự do, chất oxy hóa mạnh gây phá hủy trực tiếp tế bào. Viêm da tiếp xúc dị ứng do ánh sáng xảy ra khi hóa chất tương tác với ánh sáng hình thành kháng nguyên, kích hoạt phản ứng dị ứng type IV.

- Nguyên nhân thường gặp:

+ Thực vật có chứa psoralen như trái cây họ cam quýt (chanh), cần tây (celery), cải dại (wild parsnip), mùi tây (parsley). Bệnh thường gặp ở đầu bếp, công nhân ngành thực phẩm, người nội trợ, người làm vườn, người tiếp xúc với cỏ dại,....

+ Thành phần chống nắng (benzophenones, cinnamat, avobenzon, ...).

+ Hương liệu (6-methylcoumarin, xạ hương, dầu gỗ đàn hương, ...).

+ Chất kháng khuẩn (chlorhexidin, hexachlorophen, triclosan, fenticlor...).

+ Thuốc: nhóm cyclin (tetracyclines (doxycyclin), fluoroquinolones, sulfonamid, griseofulvin, voriconazol, NSAIDs, quinidin, quinin, amiodaron, hydrochlorothiazid, chlorpromazin, phenothiazines (promethazin...), metformin, retinoids, hợp chất nhựa đường, vemurafenib, ...

2. CHẨN ĐOÁN

2.1. Triệu chứng lâm sàng

2.1.1. Viêm da tiếp xúc kích ứng do ánh sáng

- Triệu chứng xuất hiện vài phút đến vài giờ sau khi tiếp xúc với ánh sáng.
- Biểu hiện giống bỏng nắng như đỏ da, phù nề, mụn nước, bong nước ở vùng tiếp xúc với tác nhân và ánh sáng.
- Viêm da tiếp xúc ánh sáng do thực vật (phytophotodermatitis): các tổn thương xuất hiện thành vệt, thành hình theo vị trí tiếp xúc với thực vật, sau đó để lại dát tăng sắc tố kéo dài.
- Cơ năng: bỏng rát, châm chích tại tổn thương.
- Triệu chứng thường nặng nhất sau tiếp xúc ánh sáng 24-48 giờ. Tổn thương có thể để lại dát tăng sắc tố kéo dài hàng tháng, hàng năm.

2.1.2. Viêm da tiếp xúc dị ứng do ánh sáng

- Triệu chứng xuất hiện 24 - 48 giờ sau khi tiếp xúc với ánh sáng.
- Biểu hiện giống tổn thương dạng chàm cấp tính như đỏ da, phù nề, sản mụn nước, chảy nước, bong vảy da, vảy tiết. Vị trí chủ yếu ở vùng da tiếp xúc với ánh sáng, nhưng có thể xuất hiện ở vùng da cạnh đó dù không tiếp xúc với ánh sáng.
- Cơ năng: rất ngứa.
- Bệnh có thể tồn tại dai dẳng nhiều tháng, nhiều năm, tiến triển thành viêm da ánh sáng mạn tính.

2.2. Cận lâm sàng

- Test ánh sáng (phototesting): liều đỏ da tối thiểu ở bệnh nhân viêm da tiếp xúc do ánh sáng thấp hơn so với những người bình thường có cùng type da.
- Test áp ánh sáng (photopatch test): dương tính ở bệnh nhân viêm da tiếp xúc dị ứng do ánh sáng.
- Mô bệnh học:
 - + Viêm da tiếp xúc kích ứng do ánh sáng: tế bào sừng chết theo chương trình ở thượng bì, hoại tử thượng bì, xâm nhập rải rác lympho, đại thực bào, bạch cầu trung tính ở trung bì.
 - + Viêm da tiếp xúc dị ứng do ánh sáng: xốp bào ở thượng bì, xâm nhập dày đặc lympho, mô bào ở trung bì.

2.3. Chẩn đoán xác định

Dựa vào tiền sử tiếp xúc với ánh sáng, các tác nhân, tiền sử dùng thuốc, triệu chứng lâm sàng và cận lâm sàng.

2.4. Chẩn đoán phân biệt

- Viêm da tiếp xúc kích ứng, dị ứng không liên quan đến ánh sáng
- Ban đa dạng do ánh sáng
- Sẩn ngứa do ánh sáng
- Mày đay ánh sáng
- Bệnh mụn nước dạng đậu mùa
- Viêm da mạn tính do ánh sáng
- Porphyria
- Pellagra
- Khô da sắc tố
- Lupus ban đỏ
- Viêm da cơ

3. ĐIỀU TRỊ

3.1. Nguyên tắc điều trị

- Tránh tiếp xúc với ánh sáng
 - + Đội mũ rộng vành, đeo kính, mặc quần áo dài chống tia UV
 - + Bôi kem chống nắng phổ rộng với chỉ số bảo vệ cao trước khi ra ngoài nắng 30 phút và kể cả khi trời râm
 - + Không phơi nắng
- Tránh tiếp xúc, sử dụng hóa chất gây nhạy cảm ánh sáng có trong một số thực vật, thuốc, mỹ phẩm, thức ăn, đồ uống.
- Điều trị triệu chứng là chủ yếu

3.2. Điều trị cụ thể

3.2.1. Viêm da tiếp xúc kích ứng do ánh sáng

- Tại chỗ
 - + Bọng nước: chọc thoát dịch, giữ nguyên phần da phía trên bọng nước.
 - + Trợt da, rỉ dịch: làm sạch với sản phẩm làm sạch dịu nhẹ và nước, đắp gạc tẩm dung dịch Jarish hoặc nước muối sinh lý, có thể bôi kháng sinh/kháng khuẩn, băng lại với gạc vô khuẩn.

- + Dưỡng ẩm.
- + Điều trị viêm da tiếp xúc ánh sáng do thực vật: thuốc bôi điều trị tăng sắc tố như retinoids, acid azelaic, lột da hóa chất.
- Toàn thân
 - + Giảm đau: thuốc giảm đau chống viêm không steroid (NSAIDs).
 - + Đảm bảo cân bằng nước, điện giải.
 - + Kháng sinh (nếu có bội nhiễm).

3.2.2. Viêm da tiếp xúc dị ứng do ánh sáng

Tại chỗ

- + Bọng nước: chọc thoát dịch, giữ nguyên phần da phía trên bọng nước.
- + Trợt da, rỉ dịch: làm sạch với sản phẩm làm sạch dịu nhẹ và nước, đắp gạc tẩm dung dịch Jarish hoặc nước muối sinh lý, có thể bôi kháng sinh/kháng khuẩn, băng lại với gạc vô khuẩn.
- + Dưỡng ẩm.
- + Corticosteroid bôi tổn thương.
- Toàn thân
 - + Kháng Histamin H1.
 - + Trường hợp nặng: corticosteroid toàn thân.
 - + Trường hợp nặng, kéo dài: thuốc ức chế miễn dịch như mycophenolat mofetil, azathioprin hoặc cyclosporin.
 - + Kháng sinh (nếu có bội nhiễm)

4. PHÒNG BỆNH

- Hạn chế tiếp xúc với ánh sáng
 - + Đội mũ rộng vành, đeo kính, mặc quần áo dài chống tia UV.
 - + Bôi kem chống nắng phổ rộng với chỉ số bảo vệ cao trước khi ra ngoài nắng 30 phút và kể cả khi trời râm.
 - + Không phơi nắng.
- Tránh tiếp xúc, sử dụng hóa chất gây nhạy cảm ánh sáng có trong một số thực vật, thuốc, mỹ phẩm, thức ăn, đồ uống.

PHẢN ỨNG THUỐC CÓ TĂNG BẠCH CẦU ÁI TOAN VÀ TRIỆU CHỨNG TOÀN THÂN

(Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms)

1. ĐẠI CƯƠNG

1.1. Khái niệm

DRESS (Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms) là một phản ứng quá mẫn do thuốc hiếm gặp, phức tạp, có khả năng đe dọa tính mạng. Đặc trưng của bệnh là tổn thương da, bất thường về huyết học (tăng bạch cầu ái toan, tế bào lympho không điển hình), hạch bạch huyết to và tổn thương cơ quan nội tạng. Các biểu hiện bệnh thường khởi đầu chậm 2-6 tuần sau khi bắt đầu điều trị thuốc và có thể tái phát nhiều lần, rất lâu sau khi ngừng thuốc.

1.2. Dịch tễ

- DRESS là phản ứng do thuốc hiếm gặp.
- DRESS có thể xảy ra ở trẻ em, nhưng hầu hết các trường hợp xảy ra ở người lớn và không bị ảnh hưởng bởi giới tính.

1.3. Căn nguyên/Cơ chế bệnh sinh

- Nguyên nhân gây DRESS chủ yếu là allopurinol, các thuốc chống động kinh (carbamazepin, phenobarbital, oxcarbazepin, phenytoin...), sulfonamid (dapson, sulfamethoxazol/trimethoprim), minocyclin, vancomycin, piperacillin/tazobactam,
- Yếu tố HLA-B5801 có liên quan chặt chẽ với hội chứng DRESS do allopurinol, đặc biệt ở người châu Á.
- Virus *Herpes* (đặc biệt là HHV6, HHV7, EBV) là yếu tố kích hoạt quan trọng của DRESS trên cơ địa phản ứng thuốc.

2. CHẨN ĐOÁN

2.1. Triệu chứng lâm sàng

DRESS đặc trưng bởi các tổn thương đa dạng, thay đổi theo thời gian và diễn biến bệnh. Biểu hiện lâm sàng thường xuất hiện sau 2-8 tuần dùng thuốc, và có thể xuất hiện nhanh hơn sau vài giờ đến vài ngày nếu dùng lại thuốc đó. Các bất thường về mặt xét nghiệm có thể xuất hiện trước khi có biểu hiện lâm sàng.

2.1.1. Tổn thương da

- Tổn thương da khởi phát thường là ban mẩn dạng sởi, ngứa nhẹ, bắt đầu ở mặt, cổ, chi trên rồi lan tỏa toàn thân. Các dạng thường gặp là: phát ban dạng sẩn phù, phát ban dạng sởi, đỏ da bong vảy toàn thân và phát ban dạng hồng ban đa dạng. Trong đó, phát ban dạng hồng ban đa dạng thường tiên lượng kém, hay kết hợp với tổn thương gan nặng. Tổn thương mụn mủ, mụn nước hoặc bong nước, xuất huyết gặp trong một vài trường hợp. Có thể gặp phù nề vùng giữa mặt, đối xứng và dai dẳng.

- Diện tích tổn thương da thường trên 50%.
- Tổn thương da phân bố đối xứng ở thân mình, các chi.

2.1.2. Tổn thương niêm mạc

- Khoảng 50% bệnh nhân DRESS có tổn thương niêm mạc mức độ nhẹ, thường chỉ ở 1 vị trí niêm mạc, hay gặp nhất là niêm mạc miệng hoặc hầu họng.

- 15% bệnh nhân DRESS có tổn thương từ 2 niêm mạc trở lên.

2.1.3. Triệu chứng toàn thân:

- Sốt gặp ở trên 90% trường hợp DRESS và thường xuất hiện trước tổn thương da, với nhiệt độ cao $>38^{\circ}\text{C}$ và tăng nhanh.
- Tổn thương cơ quan nội tạng:
 - + 85-96% trường hợp DRESS có tổn thương nội tạng, là tiêu chí đánh giá mức độ nặng của bệnh.
 - + 50-60% bệnh nhân có tổn thương từ 2 cơ quan trở lên,
 - + Các tổn thương thường gặp: bất thường hệ bạch huyết (30-60%), hệ máu, gan (75%), sau đó là thận (10-30%), tim và phổi (5-25%). Các trường hợp rất nặng có thể có tổn thương hệ thần kinh, tiêu hóa và nội tiết.

2.2. Cận lâm sàng

2.2.1. Xét nghiệm chẩn đoán xác định bệnh và đánh giá mức độ nặng:

- Công thức máu: thường có thay đổi công thức bạch cầu như tăng bạch cầu, tăng bạch cầu ái toan, tế bào lympho bất thường.
- Sinh hóa máu: ure, creatinin, AST, ALT, Bilirubin toàn phần/trực tiếp, ALP...
- Tổng phân tích nước tiểu.
- Các xét nghiệm đánh giá sự tái hoạt virus như PCR hoặc huyết thanh với HHV-6, HHV-7, CMV, EBV.
- Mô bệnh học da không đặc hiệu cho DRESS nhưng giúp phân biệt với các bệnh lý khác, có thể thấy hình ảnh viêm da dạng lichen, viêm da không đặc hiệu, tổn thương dạng hồng ban đa dạng. Sự xâm nhập viêm của bạch cầu ái toan vùng trung bì có thể có hoặc không.
- Chẩn đoán hình ảnh: siêu âm hạch ngoại vi, chụp Xquang ngực thẳng,

2.2.2. Xét nghiệm tìm nguyên nhân

Xét nghiệm chẩn đoán thuốc gây bệnh in vitro như chuyển dạng lympho bào có giá trị hơn các xét nghiệm in vivo như test áp, test lấy da, tiêm nội bì,

2.2.3. Các xét nghiệm khác

- Các xét nghiệm giúp chẩn đoán phân biệt với bệnh lý khác như kháng thể kháng nhân, cấy máu.
- Các xét nghiệm chẩn đoán loại trừ tổn thương nội tạng do các nguyên nhân khác: viêm gan A, B, C; *Chlamydia/ Mycoplasma*.

2.3. Chẩn đoán xác định

Có thể áp dụng một trong hai bộ tiêu chuẩn sau.

- *Tiêu chuẩn của Nhật Bản:*
 - + Các dát, sẩn xuất hiện sau khi dùng một số loại thuốc trên 3 tuần.
 - + Các triệu chứng kéo dài ngay cả khi đã ngừng thuốc.
 - + Sốt trên 38°C .
 - + Rối loạn men gan ($\text{ALT} > 100\text{UI/l}$) hoặc có thể thay bằng tổn thương các cơ quan khác như thận.
 - + Bất thường về công thức bạch cầu: có ít nhất 1 trong các dấu hiệu sau: tăng bạch cầu ($>11\text{G/l}$), tăng tế bào lympho không điển hình ($>5\%$), tăng bạch cầu ái toan ($>1.5\text{G/l}$).
 - + Hạch ngoại biên to.
 - + Tái hoạt HHV-6.

Chẩn đoán xác định DRESS điển hình khi có đủ 7/7 tiêu chuẩn trên, DRESS

không điển hình khi có 5/7 tiêu chuẩn trên.

- *Thang điểm RegiSCAR*

Triệu chứng		Điểm			
		-1	0	1	2
Sốt $\geq 38,5$ độ C (thân nhiệt lõi) hoặc > 38 độ C (thân nhiệt đo ở nách)		(-)	(+)		
Hạch to (>1 cm ở ít nhất 2 vị trí giải phẫu)			(-) hoặc không rõ	(+)	
Tăng bạch cầu ái toan trong máu			(-) hoặc không rõ	700-1499 hoặc chiếm 10-19,9% nếu có giảm bạch cầu <4000	≥ 1500 hoặc chiếm $\geq 20\%$ nếu có giảm bạch cầu <4000
Tế bào lympho không điển hình			(-) hoặc không rõ	(+)	
Tổn thương da	Diện tích tổn thương da		(-) hoặc không rõ	$>50\%$	
	Tổn thương da gợi ý DRESS: ≥ 2 đặc điểm sau phù nề mặt, xuất huyết, thâm nhiễm, bong vảy	(-)	Không rõ	(+)	
	Sinh thiết da gợi ý DRESS	(-)	Không rõ hoặc (+)		
Tổn thương nội tạng như gan, thận, phổi, cơ/ tim, tụy hoặc các cơ quan khác.			(-) hoặc không biết	Nếu có 1 nội tạng (+)	Nếu có ≥ 2 nội tạng (+)
Tiến triển ≥ 15 ngày		(-)	(+)		
Các xét nghiệm loại trừ bệnh lý khác: ANA Cấy máu Huyết thanh virus viêm gan A, B, C; <i>Chlamydia/ Mycoplasma</i>				(+) (ít nhất 3 xét nghiệm đều âm tính)	

Tiêu chuẩn chẩn đoán theo thang điểm RegiSCAR:

<2 điểm: loại trừ hội chứng DRESS

2-3 điểm: có thể

4-5 điểm: rất có khả năng

>5 điểm: chẩn đoán xác định hội chứng DRESS

2.4. Chẩn đoán mức độ bệnh

- DRESS không nghiêm trọng (bệnh nhân không có tổn thương cơ quan nội tạng hoặc tổn thương gan dưới ngưỡng DILI hoặc DILI mức độ nhẹ hoặc tổn thương thận mức độ 1).
- DRESS nghiêm trọng (tổn thương gan DILI từ mức độ vừa trở lên hoặc tổn thương thận từ giai đoạn 2 trở lên hoặc tổn thương tim phổi hoặc cơ quan khác).
- Đánh giá mức độ tổn thương thận: theo tiêu chuẩn sau:

Mức độ tổn thương thận	Nồng độ Creatinin máu	Lượng nước tiểu
Độ 1	Tăng 1,5-1,9 lần mức nền hoặc tăng $\geq 26,5 \mu\text{mol/l}$	$<0,5\text{ml/kg/h}$ trong 6-12h
Độ 2	Tăng 2-2,9 lần mức nền	$<0,5\text{ml/kg/h}$ trong $\geq 12\text{h}$
Độ 3	Tăng ≥ 3 lần mức nền hoặc tăng $\geq 353,6 \mu\text{mol/l}$	$<0,3\text{ml/kg/h}$ trong $\geq 24\text{h}$ hoặc vô niệu trong $\geq 12\text{h}$.

- Đánh giá mức độ tổn thương gan theo DILI (drug-induced liver injury)
 - + DILI: Có 1 trong các tiêu chuẩn sau: ALT ≥ 5 giới hạn trên hoặc ALP ≥ 2 giới hạn trên (đặc biệt là đi kèm với sự gia tăng nồng độ 5'-nucleotidase hoặc γ -glutamyl transpeptidase trong trường hợp không có bệnh lý xương đã biết dẫn đến sự gia tăng mức độ ALP)
 - + Mức độ nhẹ: tăng ALT/ALP đạt tiêu chuẩn DILI nhưng Bilirubin toàn phần dưới 2 lần giới hạn trên.
 - + Mức độ trung bình: tăng ALT/ALP đạt tiêu chuẩn DILI và Bilirubin toàn phần tăng ≥ 2 lần giới hạn trên hoặc có biểu hiện lâm sàng của viêm gan.
 - + Mức độ nặng: tăng ALT/ALP đạt tiêu chuẩn DILI và Bilirubin toàn phần tăng ≥ 2 lần giới hạn trên kèm theo 1 trong các đặc điểm như INR $\geq 1,5$; cổ chướng hoặc bệnh não gan mà không có xơ gan từ trước, hoặc tổn thương cơ quan khác do tổn thương gan gây ra
 - + Mức độ rất nặng bắt buộc phải ghép gan.

2.5. Chẩn đoán phân biệt

- Hội chứng Stevens-Johnson/Lyell.
- Dị ứng thuốc thể dát đỏ mụn mủ cấp tính (acute generalized exanthematous pustulosis-AGEP).
- Nhiễm khuẩn, nhiễm virus: CMV, EBV, viêm gan virus...
- Hội chứng tăng bạch cầu ái toan.
- U lympho T ở da, hội chứng Sezary.
- Bệnh tổ chức liên kết.

3. ĐIỀU TRỊ

3.1. Nguyên tắc điều trị

- Ngừng ngay thuốc nghi ngờ và hạn chế dùng nhiều loại thuốc. Trong DRESS, phản ứng chéo xảy ra thường xuyên hơn các thể dị ứng thuốc khác, đặc biệt là trong nhóm thuốc chống động kinh.

- Đánh giá tổn thương da và cơ quan nội tạng, điều trị theo cơ quan tổn thương.
- Điều trị hỗ trợ như hạ sốt, giảm ngứa, kem dịu da dưỡng ẩm, ...

3.2. Điều trị cụ thể

- DRESS không nghiêm trọng:
 - + Dùng corticosteroid tại chỗ nhóm mạnh hoặc vừa (clobetasol, betamethason).
 - + Theo dõi sát diễn biến lâm sàng (mỗi 24h) và xét nghiệm (mỗi 48-72h) để đánh giá lại mức độ nặng.
- DRESS nghiêm trọng: sử dụng corticosteroid đường toàn thân và hội chẩn với các bác sĩ chuyên khoa.
 - + Corticosteroid: liều trung bình đến cao, tương đương 0,5-2 mg prednisolon/kg/ngày cho đến khi cải thiện lâm sàng và xét nghiệm. Sau đó, nên hạ dần liều thuốc trong 6-12 tuần để tránh tái phát.
 - + Nếu các triệu chứng của DRESS tái phát trong khi giảm liều corticosteroid thì quay lại liều corticosteroid gần nhất để kiểm soát bệnh và giảm liều chậm hơn.
 - + Bệnh nhân có chống chỉ định dùng corticosteroid toàn thân hoặc không đáp ứng với corticosteroid toàn thân, sử dụng các thuốc khác như cyclosporin 4-5mg/kg/ngày trong 5-7 ngày, giảm liều 50mg/tuần cho đến khi lâm sàng cải thiện, thường dùng trong khoảng 6 tuần. Hoặc IVIG 2g/kg/ngày trong 5 ngày.
 - + Các trường hợp có bằng chứng sự tái hoạt của virus gây biến chứng nghiêm trọng của bệnh như viêm não, viêm trợt đại tràng mức độ nặng... nên dùng thêm thuốc kháng virus (ganciclovir, valganciclovir...) tối thiểu trong 1 tuần, đánh giá tải lượng virus hàng tuần cho đến khi âm tính 2 lần liên tiếp mới ngừng thuốc kháng virus.
 - + Điều trị hỗ trợ: hạ sốt, bù nước điện giải, giảm ngứa, chống nhiễm khuẩn, chăm sóc da, niêm mạc...

4. PHÒNG BỆNH

- Tránh sử dụng thuốc không cần thiết.
- Một số nhóm thuốc cần tránh liên quan đến HLA như allopurinol với HLA B58:01, carbamazepin với HLA 31:01, phenytoin và lamotrigin với HLA-A 24:02,

HỒNG BAN ĐA DẠNG (Erythema multiforme)

1. ĐẠI CƯƠNG

1.1. Khái niệm

Hồng ban đa dạng (Erythema multiforme-EM) là một bệnh da, niêm mạc cấp tính theo cơ chế miễn dịch do nhiều căn nguyên khác nhau gây nên. Đặc trưng của bệnh là tổn thương da hình bia bắn, có thể kèm theo tổn thương ở niêm mạc.

1.2. Dịch tễ

Hiện chưa rõ tỉ lệ mắc mới của EM. Bệnh thường xảy ra ở người trẻ tuổi, ưu thế nhẹ hơn ở nữ giới và không bị ảnh hưởng bởi chủng tộc.

1.3. Căn nguyên/Cơ chế bệnh sinh

Nhiều yếu tố được xác định có liên quan đến EM.

- Nhiễm trùng: chiếm đến 90% các trường hợp, chủ yếu là *Herpes simplex virus* (HSV). HSV1 phổ biến hơn HSV2. Với trẻ nhỏ, vai trò của *Mycoplasma pneumoniae* cũng là một nguyên nhân quan trọng gây EM.
- Thuốc: chiếm tỷ lệ dưới 10%. Hay gặp nhất là nhóm kháng viêm không steroid (NSAIDs), nhóm sulfonamides, thuốc chống động kinh và kháng sinh.
- Các căn nguyên khác: bệnh ác tính, bệnh tự miễn, phóng xạ, tiêm chủng,

2. CHẨN ĐOÁN

2.1. Triệu chứng lâm sàng

2.1.1. Tổn thương da

- Tổn thương đặc trưng của hồng ban đa dạng là hình bia bắn điển hình. Đó là những tổn thương hình tròn, đường kính dưới 3cm, ranh giới rõ với da lành, được tạo nên bởi ít nhất 3 vòng tròn đồng tâm, hai vòng ngoài có màu sắc khác nhau bao quanh một tâm ở giữa sẫm màu (là nơi có sự phá hủy của thượng bì để hình thành nên một mụn nước hoặc vảy tiết).

- Ngoài ra, trên da bệnh nhân còn có các tổn thương khác như dát đỏ, sẩn phù, mụn nước, bong nước.

- Phân bố tổn thương: thường xuất hiện ở các chi và vùng mặt, đặc biệt ở chi trên (mặt dưới của cánh tay, cẳng tay, lòng bàn tay). Ở một số vị trí như khuỷu tay, đầu gối, tổn thương có xu hướng tập trung thành nhóm.

- Có thể gặp hiện tượng Koebner: tổn thương hình bia bắn xuất hiện ở vùng da bị sang chấn.

2.1.2. Tổn thương niêm mạc

- Tổn thương niêm mạc thường gặp và thường xuất hiện đồng thời với tổn thương da. Hiếm gặp trường hợp chỉ có tổn thương niêm mạc mà không có tổn thương da.

- Thường gặp nhất là tổn thương trượt ở miệng bao gồm vùng niêm mạc môi, niêm mạc má, niêm mạc lợi. Các vị trí khác có thể gặp như niêm mạc sinh dục và niêm mạc mắt.

2.1.3. Biểu hiện toàn thân

Biểu hiện toàn thân thường gặp ở hồng ban đa dạng thể nặng. Triệu chứng toàn thân có thể biểu hiện trước khi có tổn thương da, bao gồm các triệu chứng như sốt, mệt mỏi, sưng đau các khớp, viêm phổi không điển hình.

2.1.4. Tiến triển

- Hồng ban đa dạng thể điển hình là bệnh da tự giới hạn. Đa số các tổn thương xuất hiện trong 3-5 ngày và thường khỏi sau 1-2 tuần. Thời gian từ khi khởi phát đến khi khỏi thường dưới 4 tuần. Một số trường hợp có tổn thương niêm mạc thì bệnh có thể kéo dài đến 6 tuần.

- Tổn thương da khỏi không để lại sẹo, có thể để lại dát tăng sắc tố dai dẳng. Tổn thương niêm mạc có thể để lại di chứng nếu chăm sóc và điều trị không kịp thời như viêm giác mạc, sẹo kết mạc, viêm màng bồ đào, sẹo thực quản,

2.2. Cận lâm sàng

- Xét nghiệm cơ bản như công thức máu, sinh hóa máu, tổng phân tích nước tiểu để sơ bộ tìm nguyên nhân và đánh giá các rối loạn nếu có.

- Mô bệnh học: Hình ảnh mô bệnh học của hồng ban đa dạng không đặc hiệu để phục vụ cho chẩn đoán xác định, nhưng có giá trị để chẩn đoán phân biệt. Biểu hiện sớm nhất trên hình ảnh giải phẫu bệnh là sự hoại tử của tế bào sừng. Tiếp theo là hiện tượng phù nề lớp gai và hiện tượng thoái hóa từng điểm của các tế bào đáy, xâm nhập viêm dạng lichen từ nhẹ đến vừa của tế bào lympho và mô bào tại vị trí giữa thượng bì và trung bì.

- Miễn dịch huỳnh quang trực tiếp của EM không đặc hiệu, có thể thấy sự lắng đọng của IgM và C3 tại vị trí giữa thượng bì và trung bì hoặc quanh các tế bào thượng bì bị hoại tử.

- Xét nghiệm tìm căn nguyên liên quan đến vi sinh vật

+ HSV: xét nghiệm tế bào học dịch bong nước, PCR hoặc nuôi cấy virus. DNA HSV có thể tìm thấy trên mẫu sinh thiết da bằng PCR. Các xét nghiệm huyết thanh IgM và IgG đối với HSV không có giá trị đối với EM tái phát.

+ *M.pneumoniae*: chụp Xquang ngực, PCR bệnh phẩm dịch hầu họng và xét nghiệm huyết thanh với sự có mặt của IgM hoặc hiệu giá kháng thể IgG tăng gấp 2 lần.

+ Các xét nghiệm virus khác.

2.3. Chẩn đoán xác định

Chẩn đoán xác định hồng ban đa dạng chủ yếu là dựa vào hình ảnh lâm sàng, có thể làm thêm mô bệnh học đối với trường hợp không điển hình

2.4. Chẩn đoán mức độ nặng

Dựa vào vị trí và số lượng tổn thương của niêm mạc, EM được chia thành hai mức độ:

- Mức độ nhẹ: chỉ bị ở một vị trí niêm mạc (miệng hoặc sinh dục hoặc mắt). Số lượng từ 1-5 mụn nước, có thể vỡ ra tạo thành vết trợt nông, đáy sạch.

- Mức độ nặng: từ 2 vị trí niêm mạc trở lên hoặc 1 vị trí với số lượng mụn nước nhiều hơn 5, lan tỏa, hoặc tạo thành vết trợt rộng, loét.

2.5. Chẩn đoán phân biệt

- Mày đay
- Hội chứng Steven-Johnson
- Hồng ban cố định nhiễm sắc
- Bệnh pemphigoid bong nước
- Pemphigus á u
- Hội chứng Sweet
- Hội chứng Rowell
- Phát ban đa dạng do ánh sáng
- Các bệnh lý có tổn thương niêm mạc khác

3. ĐIỀU TRỊ

3.1. Nguyên tắc điều trị

- Phát hiện, loại bỏ và điều trị theo căn nguyên nếu phát hiện được.
- Điều trị tùy thuộc vào giai đoạn bệnh, mức độ bệnh và nguyên nhân gây bệnh.

3.2. Điều trị cụ thể

- Điều trị tại chỗ:
 - + Tổn thương da: corticosteroid bôi, kem dưỡng ẩm.
 - + Tổn thương niêm mạc: corticosteroid bôi dạng gel hoặc paste, dung dịch sát khuẩn.
 - + Tổn thương mắt: khám chuyên khoa mắt để xử trí kịp thời, tránh di chứng.

- Điều trị toàn thân:
 - + Corticosteroid: với thể nặng, liều tương đương 40-60mg prednisolon/ngày, giảm liều dần trong 2-4 tuần.
 - + Bồi phụ nước, điện giải.
 - + Kháng histamin nếu có ngứa.
- Điều trị theo nguyên nhân:
 - + Hồng ban đa dạng do thuốc: ngừng ngay thuốc nghi ngờ.
 - + Hồng ban đa dạng do virus HSV: nếu tái phát < 6 lần/ năm, chỉ điều trị triệu chứng. Nếu tái phát > 6 lần/ năm, điều trị dự phòng bằng thuốc kháng virus như aciclovir 400mg x 2 lần/ ngày hoặc valaciclovir 500mg x 2 lần/ ngày hoặc famciclovir 250mg x 2 lần/ngày trong 6 tháng.
 - + Hồng ban đa dạng do *M.pneumonia* (bệnh nhân có viêm phổi trước đó hoặc xét nghiệm huyết thanh dương tính): điều trị bằng kháng sinh như Rovamycin.

4. PHÒNG BỆNH

- Tránh sử dụng thuốc có tiền sử dị ứng.
- Nâng cao thể trạng, tránh nhiễm các loại virus, vi khuẩn.

HỘI CHỨNG STEVENS – JOHNSON VÀ HOẠI TỬ THƯƠNG BÌ NHIỄM ĐỘC (Steven Johnson syndrome and Toxic Epidermal Necrolysis)

1. ĐẠI CƯƠNG

1.1. Khái niệm

- Hội chứng Stevens-Johnson (Steven Johnson syndrome - SJS) và hoại tử biểu bì nhiễm độc (Toxic Epidermal Necrolysis - TEN) là những phản ứng bất lợi nghiêm trọng trên da được đặc trưng bởi hoại tử lan rộng và bong tróc lớp thượng bì.
- Những nghiên cứu gần đây cho rằng SJS và TEN thuộc cùng một loại bệnh, chỉ khác nhau về mức độ nặng và được phân loại như sau:
 - + Hội chứng Stevens-Johnson: là một thể nhẹ của TEN với tổn thương da dưới 10% diện tích cơ thể
 - + Hội chứng ranh giới SJS-TEN: tổn thương da chiếm 10-30% diện tích cơ thể.
 - + TEN: tổn thương da trên 30% diện tích cơ thể.

1.2. Dịch tễ

Gặp ở mọi lứa tuổi, chủng tộc, nam gặp nhiều hơn nữ, tỷ lệ 2:1, tuổi hay gặp khoảng 25-47, có khi rất sớm từ 3 tháng tuổi, tuổi càng cao, nguy cơ mắc bệnh càng lớn.

1.3. Căn nguyên/Cơ chế bệnh sinh

Phần lớn là do thuốc, một số do nhiễm khuẩn hoặc không rõ nguyên nhân.

- Do thuốc: Các thuốc hay gặp gồm
 - + Allopurinol
 - + Thuốc an thần: carbamazepin, phenytoin, phenobarbital
 - + Thuốc kháng viêm không steroid
 - + Sulfamid, nhất là sulfamid chậm
 - + Thuốc kháng sinh: nhóm beta lactam, cyclin, quinolon.
 - + Các thuốc khác (kháng virus, haloperidol, hydantoin, thuốc kháng lao...)
 - + Thuốc Đông y: ngày càng gặp nhiều bệnh nhân dị ứng với các thuốc này.
- Do nhiễm trùng: nhiễm *Mycoplasma pneumoniae* hoặc một số loại vi khuẩn/virus khác.

- Các nguyên nhân khác:
 - + Do tiêm vắc xin, huyết thanh.
 - + Nhiễm trùng kèm theo bệnh dị ứng
 - + Do thái bỏ mảnh ghép.
 - + Người bệnh đang điều trị ánh sáng liệu pháp
 - + Một số trường hợp không rõ nguyên nhân.
- Cơ chế bệnh sinh của TEN đến nay vẫn chưa rõ ràng, chủ yếu là phản ứng qua trung gian tế bào T dẫn đến giải phóng các protein gây độc tế bào gây hoại tử thượng bì. Theo một số nghiên cứu những người mang HLA- B1502* và HLA-B5801* dễ có nguy cơ mắc TEN, HLA-B12 hay gặp SJS.

2. CHẨN ĐOÁN

2.1. Triệu chứng lâm sàng

- Tổn thương da:
 - + Là các dát đỏ sẫm màu, sau nổi mụn nước, bóng nước nông, nhăn nheo, trợt hoại tử, xen kẽ các mảng sần phù, tổn thương hình bia bắn không điển hình, không ngứa. Da bong trợt từng mảng lớn để lại nền da màu đỏ, tím.
 - + Dấu hiệu Nikolsky thường dương tính.
 - + Trường hợp nặng, tổn thương tiết dịch rất nhiều hoặc chảy máu.
 - + Vị trí tổn thương ban đầu thường ở mặt, ngực, sau nhanh chóng lan ra khắp người kể cả lòng bàn tay chân.
- Tổn thương niêm mạc:
 - + Gặp trên 90% trường hợp. Với hội chứng SJS, tổn thương từ 2 hốc tự nhiên trở lên.
 - + Tổn thương niêm mạc miệng, sinh dục: thường gặp nhất. Biểu hiện chủ yếu là các bóng nước nông dễ vỡ, để lại vết trợt, loét, tiết dịch, chảy máu, đóng vảy tiết nâu đen, người bệnh ăn uống khó, đau rất nhiều.
 - + Tổn thương ở niêm mạc họng, hầu, thanh quản: gây chít hẹp thanh quản, xuất huyết đường tiêu hóa.
 - + Tổn thương ở mắt: gây viêm kết mạc làm mắt viêm đỏ, phù nề, không mở được mắt, có thể bị viêm dính kết mạc, loét giác mạc, nặng hơn có thể gây mù lòa.
 - + Tổn thương mũi: viêm mũi, xung huyết, chảy máu mũi.
- Toàn thân:
 - + Sốt, mệt mỏi, ho, viêm họng, đau khớp, đau đầu, nôn, tiêu chảy.

+ Trường hợp nặng, người bệnh sốt cao liên tục 39-40°C, nhiễm trùng da, tổn thương nội tạng, rối loạn nước điện giải, có thể li bì, hôn mê.

- Tiến triển:

+ Nếu được chẩn đoán sớm, tiên lượng tốt, thường tiến triển 2-4 tuần. Sau khi tổn thương khỏi, có thể để lại các sẹo, dát tăng hoặc mất sắc tố.

+ Tỷ lệ tử vong khoảng 5%

+ Nếu không được điều trị sớm có thể có các biến chứng: viêm màng não, nhiễm khuẩn da thứ phát, nhiễm khuẩn huyết, viêm loét kết mạc, giác mạc, mù lòa, xuất huyết tiêu hóa, chít hẹp thực quản, viêm phổi, viêm cơ tim, có thể tử vong do suy đa tạng.

2.2. Cận lâm sàng

- Công thức máu: số lượng bạch cầu thường tăng.
- CRP (C- reactive protein): thường tăng.
- Sinh hóa: có thể phát hiện được rối loạn điện giải, chức năng gan, thận, thường có tăng đường máu, ure, creatinin, men gan.
- Sinh thiết da: có hiện tượng bong tách thượng bì, xâm nhập tế bào viêm.
- Cấy máu: theo dõi tình trạng nhiễm khuẩn huyết.
- Cấy vi khuẩn tại tổn thương da.
- Khí máu: đánh giá chỉ số bicarbonate huyết thanh.
- Định type HLA trong một số trường hợp cần thiết.

2.3. Chẩn đoán xác định

Dựa vào tiền sử sử dụng thuốc nghi ngờ và triệu chứng lâm sàng điển hình, dấu hiệu Nikolsky dương tính.

2.4. Chẩn đoán mức độ

- Tiên lượng mức độ nặng của bệnh để đánh giá nguy cơ tử vong bằng chỉ số SCORTEN được áp dụng cho cả TEN và SJS gồm 7 tiêu chuẩn, mỗi tiêu chuẩn là 1 điểm, bao gồm:

- + Tuổi > 40
- + Nhịp tim > 120 lần/phút
- + Có bệnh lý ác tính
- + Bong tách thượng bì > 10% diện tích cơ thể
- + Chỉ số BUN (Blood Urea Nitrogen – nồng độ urea nitrogen trong máu) > 28 mg/dl (ure > 10mmol/l)

- + Glucose huyết thanh > 252 mg/dl (14mmol/l)
- + Bicarbonat huyết thanh < 20mEq/l
- Theo nghiên cứu của Bastuji, những người bệnh có chỉ số SCORTEN: 0-1 điểm thì tỉ lệ tử vong là 3,2%; 2 điểm $\geq$ 12,1%; 3 điểm $\geq$ 35,3%; 4 điểm $\geq$ 58,3%; trên 5 điểm tỉ lệ tử vong là 90%.

2.5. Chẩn đoán phân biệt:

- Hội chứng bong vảy da do tụ cầu.
- Hồng ban đa dạng.
- Pemphigus thông thường.
- Hội chứng DRESS.
- Đỏ da toàn thân.

3. ĐIỀU TRỊ

3.1. Nguyên tắc điều trị

- Điều trị nội trú, nên sử dụng phòng vô khuẩn có đầy đủ các phương tiện hồi sức, cấp cứu.
- Dừng ngay thuốc xác định là dị ứng hoặc nghi ngờ gây dị ứng.
- Hạn chế tối đa dùng thuốc.
- Đánh giá người bệnh một cách toàn diện để có kế hoạch điều trị cụ thể.
- Điều trị hỗ trợ: bồi phụ nước điện giải, dinh dưỡng, chống nhiễm khuẩn.

3.2. Điều trị cụ thể

- Điều trị hỗ trợ:
 - + Chế độ ăn: lỏng, đủ dinh dưỡng, nhiều đạm, tốt nhất là sữa, cháo dinh dưỡng, ăn nhiều bữa, có thể ăn qua sonde nếu cần.
 - + Truyền đạm, plasma tươi.
 - + Bồi phụ nước, điện giải.
 - + Kháng sinh: chỉ định trong trường hợp nghi ngờ nhiễm khuẩn phối hợp.
- Điều trị tại chỗ:
 - + Rửa các vùng da tổn thương hàng ngày bằng nước muối sinh lý, dung dịch thuốc tím loãng, đắp gạc ẩm. Nên đắp hoặc quấn băng gạc có tẩm thuốc kháng sinh hoặc vaselin.
 - + Niêm mạc: vệ sinh bằng nước muối sinh lý
 - + Các tổn thương mắt cần sớm được đánh giá và điều trị theo mức độ, tra

thuốc mỡ kháng sinh, dầu vitamin A, bóc tách mi mắt tránh hiện tượng viêm, loét kết mạc, dính mi mắt, mù lòa.

- Điều trị toàn thân: Điều trị toàn thân cho TEN chưa có thống nhất, có thể sử dụng một trong các thuốc sau trong giai đoạn bệnh cấp tính

+ Cyclosporin 3-5 mg/kg/ngày trong vòng 24 đến 48 giờ kể từ khi khởi phát triệu chứng, kéo dài 10-14 ngày.

+ Corticosteroid: liều tương đương prednisolon 1-2 mg/kg cân nặng, có khi tới 4mg/kg cân nặng, hoặc có thể dùng liều 100-250 mg truyền tĩnh mạch trong khoảng 3-4 ngày đầu, khi tổn thương da và toàn thân tiến triển tốt, có thể giảm nhanh liều để tránh các tai biến do thuốc.

+ Globulin miễn dịch liều cao truyền tĩnh mạch: IVIG liều 2 đến 4 g/kg trong 2-5 ngày

+ Các điều trị khác: thuốc ức chế miễn dịch và các thuốc khác (infliximab, etanercept...), lọc huyết tương.

4. PHÒNG BỆNH

- Giáo dục cho người bệnh hiểu biết các triệu chứng của bệnh, không tái sử dụng các thuốc đã xác định là dị ứng hoặc nghi ngờ gây dị ứng, có thể chứng nhận người bệnh dị ứng thuốc.

- Thận trọng khi sử dụng thuốc: tránh lạm dụng thuốc, khi cần dùng thuốc, phải thông báo cho bác sĩ tiền sử dị ứng, nếu có bất kì những biểu hiện bất thường nào sau khi sử dụng, phải dừng thuốc ngay và đến các cơ sở y tế khám càng sớm càng tốt.

- Tránh sử dụng một số loại thuốc đối với bệnh nhân có HLA đặc hiệu.

SẼN NGỨA (Prurigo)

1. ĐẠI CƯƠNG

1.1. Khái niệm

Sẩn ngứa biểu hiện bằng tổn thương nốt nhỏ hoặc sẩn kèm theo cảm giác ngứa. Sẩn ngứa là phản ứng viêm xuất tiết, xuất hiện ở lớp trung bì nông, có sự tăng thâm nhiễm của tế bào lympho và bạch cầu đa nhân trung tính.

1.2. Dịch tễ

Bệnh gặp ở cả nam và nữ với tỉ lệ tương đương nhau. Hay gặp ở người trung tuổi và người già. Người da đen có khả năng mắc sẩn ngứa cao gấp 3,4 lần so với người da trắng.

1.3. Căn nguyên/Cơ chế bệnh sinh

Côn trùng đốt, kích thích về cơ học, vật lý, ánh sáng, dị ứng thức ăn, hóa chất gây giải phóng histamin được cho là yếu tố gây bệnh. Sẩn ngứa cũng có thể là biểu hiện của viêm da cơ địa. Ngoài ra, sẩn ngứa cũng xuất hiện kèm theo một số bệnh như khối u, rối loạn nội tiết, bệnh tuyến giáp, bệnh tuyến cận giáp, chuyển hóa, bệnh lý gan mật, suy thận mạn, bệnh máu, ung thư, bệnh ký sinh trùng, thuốc, thần kinh, tâm thần, khô da, thức ăn, thai kỳ...

2. CHẨN ĐOÁN

2.1. Triệu chứng lâm sàng

- Sẩn huyết thanh: sẩn có mụn nước ở trung tâm, mụn nước có thể vỡ gây tiết dịch và đóng vảy tiết.
- Sẩn cục: tổn thương sẩn chắc, màu đỏ nâu hoặc xám. Kích thước từ 1 đến 2 cm.
- Tổn thương rải rác chủ yếu vùng da hở.
- Cơ năng: ngứa ở các mức độ khác nhau.

2.2. Cận lâm sàng

- Xét nghiệm công thức máu: thường có tăng nhẹ bạch cầu ưa acid.
- Nồng độ IgE huyết thanh bình thường hoặc tăng nhẹ.
- Sinh thiết da: ít được sử dụng do không đặc hiệu, có tăng sinh lớp gai và xâm nhập tế bào viêm ở phần nông của trung bì.
- Xét nghiệm khác tìm nguyên nhân tùy từng trường hợp như sẩn ngứa nhiều, lan tỏa, không đáp ứng điều trị,

2.3. Chẩn đoán

2.3.1. Chẩn đoán xác định

Chẩn đoán dựa chủ yếu vào biểu hiện lâm sàng.

2.3.2. Chẩn đoán thể

- Phân loại sẩn ngứa theo hình thái lâm sàng
- + Sẩn ngứa: sẩn huyết thanh nổi cao, bề mặt có mụn nước, hoặc vết trợt, vảy tiết do chà xát kèm ngứa nhiều.

+ Sẩn cục: sẩn cục lớn, phân bố riêng lẻ, rải rác. Có thể có tổn thương vết trợt, vảy tiết đen trên bề mặt sẩn do bệnh nhân ngứa nhiều, chà xát. Vị trí hay gặp ở chi, tổn thương tiến triển kéo dài.

+ Sẩn ngứa mạn tính đa dạng: sẩn mạn tính xuất hiện quanh tổn thương ban đầu, lichen hóa, tạo mảng thâm nhiễm, có thể có vết xước, trợt trên bề mặt mảng lichen hóa. Hay gặp ở người lớn tuổi, tiến triển dai dẳng.

- Phân loại theo căn nguyên:

+ Côn trùng đốt

+ Sẩn ngứa liên quan tới bệnh lý: suy thận, suy gan, đái tháo đường, bệnh máu ác tính, u ác tính nội tạng, viêm da cơ địa, sau tổn thương da dạng chàm, HIV

+ Sẩn ngứa ở người bệnh tâm thần

+ Sẩn ngứa thai kỳ

+ Sẩn ngứa ở người dị ứng thuốc

+ Sẩn ngứa ở người dị ứng kim loại

+ Sẩn ngứa tự phát

2.3.3. Chẩn đoán phân biệt

- Viêm da cơ địa.

- Viêm da tiếp xúc dị ứng.

- Bệnh ghẻ

- Herpes simplex

- Hồng ban đa dạng

3. ĐIỀU TRỊ

3.1. Nguyên tắc điều trị

- Tìm nguyên nhân để loại bỏ.

- Điều trị tùy từng giai đoạn.

- Hạn chế gãi, chà xát.

3.2. Điều trị cụ thể

3.2.1. Điều trị tại chỗ

- Corticosteroid bôi tại chỗ: Tùy vào vị trí và mức độ tổn thương có thể sử dụng các thuốc sau

+ Corticosteroid nhẹ (hydrocortison, desonid): bôi cho vùng da mỏng mặt, kẽ, và cho trẻ em.

+ Corticosteroid trung bình (betamethason, triamcinolon): bôi vùng da tay chân, thân mình.

+ Corticosteroid mạnh (Clobetasol propionat): bôi vùng da dày ở tay, chân thân mình.

Bôi thuốc 1-2 lần/ ngày. Có thể sử dụng biện pháp băng bột để tăng khả năng hấp thu của thuốc.

- Tiêm nội tổn thương corticosteroid: sử dụng kết hợp khi bôi corticosteroid đơn thuần không hiệu quả

- Các thuốc bôi kết hợp khác: tacrolimus, calcipotriol, mỡ capsaicin. Sử dụng sau đợt bôi corticosteroid, tổn thương đã giảm.

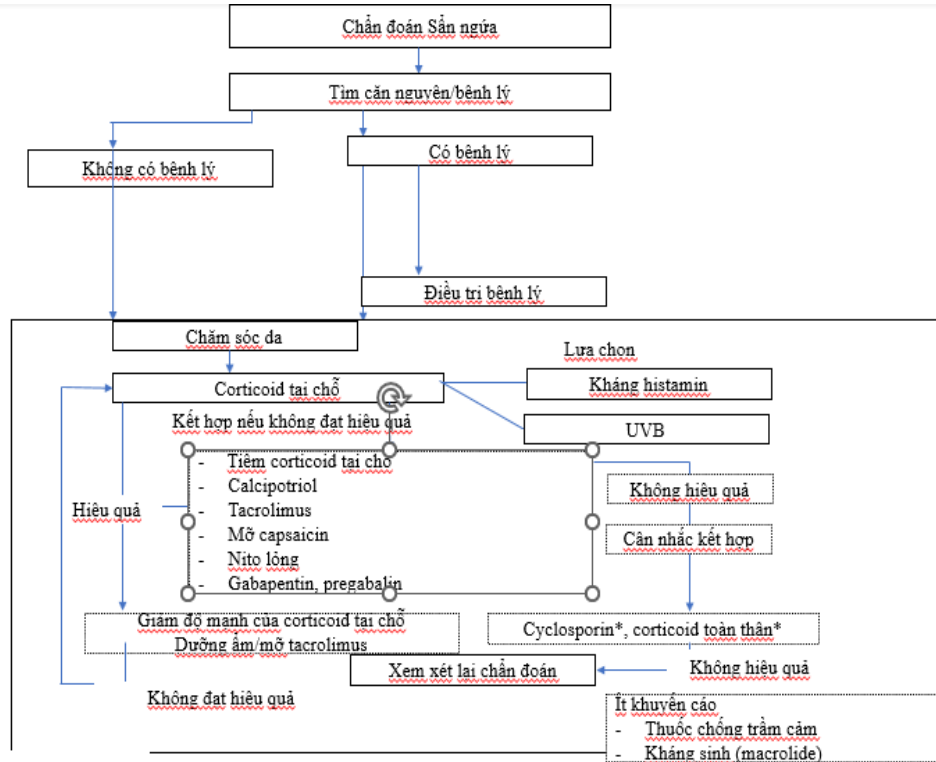
- Chăm sóc da: sử dụng các sản phẩm làm sạch dịu nhẹ, kem dưỡng ẩm, dịu da.

3.2.2. Điều trị toàn thân

- Kháng histamin uống
- + Thế hệ 1: promethazin, chlorpheniramin, hydroxyzin, mequitazin .
- + Thế hệ 2: loratadin, cetirizin, levocetirizin, fexofenadin, desloratadin, rupatadin, bilastin, ...
- Quang trị liệu và quang hóa trị liệu: UVA, PUVA, UVB, NB-UVB, laser excimer,
- Một số thuốc khác có tác dụng giảm ngứa: pregabalin, gabapentin.
- Thuốc ức chế miễn dịch: corticosteroid đường toàn thân, cyclosporin khi điều trị tại chỗ không hiệu quả.

Phác đồ điều trị Sẩn ngứa

(tham khảo theo Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị Sẩn ngứa - Hội Da liễu Nhật Bản)



* Chú ý đánh giá tác dụng không mong muốn

4. PHÒNG BỆNH

- Giáo dục y tế: tư vấn cho bệnh nhân biết các dấu hiệu bệnh lý, tránh các yếu tố kích thích, dị nguyên để tránh tái phát bệnh.
- Dùng các sản phẩm làm sạch thích hợp, các sản phẩm để giữ độ ẩm cho da.

BỆNH MÀY ĐAY

(Urticaria)

1. ĐẠI CƯƠNG

1.1. Khái niệm

- Mày đay có biểu hiện lâm sàng là các dát đỏ và/hoặc sẩn phù, có thể kèm theo phù mạch hoặc không; tổn thương ở lớp trung bì hoặc hạ bì.
- Mày đay được phân loại thành mày đay cấp và mày đay mạn:
 - + Mày đay cấp: thời gian diễn biến bệnh dưới 6 tuần.
 - + Mày đay mạn: trong vòng ít nhất 6 tuần liên tiếp, xuất hiện triệu chứng của mày đay ít nhất 2 ngày/tuần.

1.2. Dịch tễ

Mày đay là bệnh phổ biến, bệnh có thể gặp ở mọi lứa tuổi nhưng độ tuổi thường gặp nhất là từ sơ sinh tới 9 tuổi và từ 30-40 tuổi.

1.3. Căn nguyên/Cơ chế bệnh sinh

- Nhiễm khuẩn: các tế bào viêm tham gia vào phản ứng trong mày đay bao gồm tế bào lympho T CD4+, tế bào đơn nhân, bạch cầu đa nhân trung tính và bạch cầu ái toan với mức độ khác nhau.
- Tác nhân vật lý: nhiệt độ, áp lực, ánh nắng, rung động,...
- Một số tác nhân khác: nước, tiếp xúc, cholinergic...
- Nhóm mày đay tự phát (vô căn) là hay gặp nhất.
- Cơ chế bệnh sinh: tế bào mast đóng vai trò chính, giải phóng histamin, leukotriene, chemokine, cytokine sau khi khử hạt. Vai trò bradykinin gây hoạt hóa tế bào nội mô mạch máu, dẫn tới giãn mạch, tăng tính thấm thành mạch gây biểu hiện phù mạch trên lâm sàng.

2. CHẨN ĐOÁN

2.1. Triệu chứng lâm sàng

- Sẩn phù: các sẩn phù màu trắng, đỏ ranh giới rõ và/hoặc quầng đỏ, kích thước 1 - 8 cm hình tròn, ovan, đa cung, mảng lớn, thường xuất hiện và biến mất trong vòng 24 giờ mà không để lại dát thâm.
- Phù mạch: biểu hiện đau, sưng nề bàn tay, chân, môi, mắt, lưỡi, sinh dục, sưng nề thanh gây khó thở. Phù mạch có thể kéo dài đến 72 giờ.
- Cơ năng: ngứa, đôi khi nóng rát tại tổn thương.
- Toàn thân:

+ Các triệu chứng cấp tính như khó thở, suy hô hấp, tiếng rít thanh quản xuất hiện khi có phù mạch gây chít hẹp đường hô hấp, bệnh nhân cần phải xử trí cấp cứu.

+ Các triệu chứng khác tùy thuộc nguyên nhân: sốt, viêm long đường hô hấp, viêm đường hô hấp trên trong mày đay do nhiễm khuẩn.

2.2. Cận lâm sàng

- Xét nghiệm cơ bản:
 - + Công thức máu, sinh hóa máu, máu lắng
 - + Định lượng IgE, test dị nguyên
 - + Xét nghiệm nội soi dạ dày, test *Helicobacter pylori* đối với bệnh nhân có viêm loét dạ dày - tá tràng
 - + Tìm ký sinh trùng
 - + Hormon tuyến giáp
 - + Tự kháng thể
- Xét nghiệm tìm nguyên nhân đặc hiệu:
 - + Mày đay do lạnh: Thử nghiệm kích thích lạnh – test ice cube (nước lạnh, đá).
 - + Mày đay do áp lực: Thử nghiệm áp suất (que có trọng lượng 0,2 - 1,5 kg/cm² đặt ở đùi hoặc lưng trong 10 - 20 phút hoặc đeo 6,8kg túi cát ở vai trong 15 phút ở tư thế ngồi).
 - + Mày đay do nhiệt: dùng bồn tắm nóng.
 - + Mày đay do ánh sáng: cho tiếp xúc ánh sáng cực tím và ánh sáng nhìn thấy với bước sóng khác nhau.
 - + Chứng vẽ nổi: vạch lên da tạo thành tổn thương mày đay (mất đi sau 30 phút).
 - + Phù mạch rung động : kích thích rung trong 1 - 5 phút.
 - + Mày đay do nước: kích thích bằng áo ướt ở cẳng tay 15 - 20 phút.
 - + Mày đay cholinergic: kích thích bằng tập thể dục hoặc tắm nước nóng 15 - 20 phút.
 - + Mày đay tiếp xúc: test lấy da, test áp.

2.3. Chẩn đoán xác định

- Dựa vào triệu chứng lâm sàng với tổn thương cơ bản điển hình: dát đỏ, sẩn phù kèm ngứa thường xuất hiện và biến mất trong vòng 24 giờ, có hoặc không kèm phù mạch.

- Chẩn đoán nguyên nhân dựa vào các xét nghiệm đặc hiệu.

2.4. Chẩn đoán phân loại

2.4.1. Dựa trên thời gian diễn biến bệnh

Dựa trên thời gian diễn biến bệnh, mày đay được phân loại thành mày đay cấp tính và mày đay mạn tính.

- Mày đay cấp tính được định nghĩa là sự xuất hiện tự phát của sẩn phù, phù mạch hoặc cả hai trong thời gian nhỏ hơn hoặc bằng 6 tuần.

- Mày đay mạn tính là mày đay mà triệu chứng sẩn phù hoặc phù mạch hoặc cả hai xuất hiện hàng ngày hoặc gần như hàng ngày trong thời gian trên 6 tuần.

2.4.2. Dựa trên yếu tố khởi phát đặc hiệu

Dựa trên yếu tố gây khởi phát đặc hiệu, mày đay mạn tính được chia thành mày đay mạn tính tự phát (chronic spontaneous urticaria) và mày đay mạn tính cảm ứng (chronic inducible urticaria).

- Mày đay mạn tính tự phát: được định nghĩa là sự xuất hiện một cách tự phát của sẩn phù, phù mạch hoặc cả hai trong thời gian lớn hơn 6 tuần do các nguyên nhân đã biết hoặc chưa biết (nguyên nhân đã biết có thể là tự kháng thể hoạt hóa tế bào mast). Mày đay mạn tính tự phát được chia ra thành: mày đay mạn tính tự miễn và mày đay mạn tính tự phát khác.

- Mày đay mạn tính cảm ứng: đặc trưng bởi sự xuất hiện sẩn phù hoặc phù mạch sau kích thích của các tác nhân đặc hiệu bên ngoài như chà xát, cào gãi, áp lực, ánh sáng, nhiệt độ, nước... Mày đay mạn tính cảm ứng được chia ra thành 2 nhóm chính:

- + Mày đay vật lý:

- Mày đay do lạnh: gây ra bởi vật liệu lạnh, không khí, chất lỏng, gió. Ngưỡng nhiệt độ gây khởi phát triệu chứng tùy thuộc từng người. Mày đay do lạnh có thể liên quan đau đầu, hạ huyết áp, ngất, khó thở, rối loạn tiêu hóa khi cơ thể tiếp xúc trực tiếp với môi trường lạnh.

- Mày đay do áp lực: do áp suất tác động lên da tạo sẩn phù trong vòng 3 - 12 giờ.

- Mày đay do nhiệt: tác động nhiệt cục bộ gây nên tổn thương da tại chỗ. Thường gặp mày đay nhiệt liên quan nghề nghiệp (công nhân lò than, lò gạch).

- Mày đay do ánh nắng: do bức xạ từ tia cực tím và hoặc ánh sáng nhìn thấy. Vị trí xuất hiện tổn thương ở vùng da tiếp xúc trực tiếp.

- Chứng vẽ nổi: xuất hiện sẩn phù khi vạch lên da (trong vòng 5 - 15 phút), có liên quan đến mày đay áp lực, gặp ở 2 - 4% dân số.

- Mày đay do rung động: thường xuất hiện khi chịu tác động của lực rung (liên quan nghề nghiệp: công nhân làm đường, lái xe, thợ khoan). Tính chất di truyền cũng đường mô tả đi kèm với triệu chứng đỏ mặt.

- + Mày đay không do tác nhân vật lý:

- Mày đay do nước: hiếm gặp, triệu chứng ngứa và/hoặc kèm tổn thương da xuất hiện khi tiếp xúc với nước ở bất kì nhiệt độ nào. Các dát đỏ, sẩn phù nhỏ thường nhỏ, đồng đều giống trong mày đay cholinergic. Bệnh thường vô căn, tuy nhiên có liên quan đến chứng da khô ở người cao tuổi, bệnh đa hồng cầu, bệnh Hodgkin, hội chứng tăng bạch cầu ái toan.

- Mày đay cholinergic: xuất hiện tổn thương khi gia tăng nhiệt độ cơ thể (sau khi tập thể dục, tắm nước ấm, trong cơn sốt). Thường gặp ở người trẻ (10 - 20 tuổi). Tổn thương da của mày đay mạn thường là sẩn, dát đỏ nhỏ 1 - 2mm, kèm theo ngứa.

- Mày đay tiếp xúc: Xảy ra khi tiếp xúc với các chất khác nhau. Cơ chế qua trung gian IgE hoặc không. Các chất nhựa latex thường gặp gây mày đay tiếp xúc.

2.5. Chẩn đoán phân biệt

- Bệnh tế bào mast.
- Viêm da cơ địa.
- Pemphigoid giai đoạn sẩn ngứa.
- Sẩn ngứa ở phụ nữ có thai.
- Phát ban do thuốc.
- Hồng ban đa dạng.
- Lupus ban đỏ hệ thống.
- Mày đay viêm mạch

3. ĐIỀU TRỊ

3.1. Nguyên tắc điều trị

- Tìm nguyên nhân và loại trừ nguyên nhân (nếu có).
- Điều trị theo thể bệnh.

3.2. Điều trị cụ thể

3.2.1. Điều trị mày đay cấp tính

- Chỉ định nhập viện:
 - + Phù mạch ở lưỡi
 - + Đau bụng
- Mày đay cấp nặng: số sẩn phù ≥ 50 nốt/24 giờ và/hoặc phù mạch:
 - + Kháng Histamin: 2 – 4 liều tiêu chuẩn trong 10 ngày.
 - + Corticosteroid: liều tương đương methylprednisolon người lớn: 16-32mg/ngày, trẻ em ≤ 12 tuổi: 0,5 – 1 mg/kg/ngày trong 5 ngày.
- Mày đay cấp thông thường: kháng histamin liều tiêu chuẩn trong vòng 10 ngày.

3.2.2. Điều trị mày đay mạn tính

- Lựa chọn thứ nhất: Thuốc kháng histamin H1 thế hệ 2: fexofenadin, desloratadin, loratadin, cetirizin, bilastin, rupatadin...

+ Điều trị khởi đầu bằng liều chuẩn của thuốc, và theo dõi đáp ứng điều trị. Sau 2 - 4 tuần không có đáp ứng, cân nhắc tăng liều kháng histamin (theo nghiên cứu có thể tăng liều gấp 4 lần bình thường mà không gây tác dụng phụ).

+ Kháng histamin được cho thấy có hiệu quả nếu sử dụng hàng ngày (khác với việc sử dụng khi cần) và nếu đạt được kiểm soát bệnh, nên duy trì liều kháng histamin hiệu quả trong vài tuần đến 1 tháng. Đối với mày đay mạn cần duy trì kéo dài hơn tùy theo ý kiến bác sĩ chuyên khoa.

+ Việc kết hợp 2 loại kháng histamin H1 được cho là không có lợi ích so với sử dụng 1 loại đơn độc.

- Lựa chọn thứ hai: omalizumab được FDA cho phép sử dụng điều trị mày đay mạn tính với liều 150 – 300mg tiêm dưới da mỗi 4 tuần cho trường hợp bệnh nhân không đáp ứng với kháng histamin liều gấp 4 lần liều tiêu chuẩn sau 2 - 4 tuần.

- Lựa chọn thứ ba: cyclosporin được lựa chọn cho mày đay mạn với liều 3 - 5mg/kg/ngày khi bệnh nhân không đáp ứng với liệu pháp kháng histamin H1 thế hệ 2 và omalizumab (trong 6 tháng). Cần theo dõi và cân nhắc tác dụng phụ của cyclosporin khi dùng thuốc.

- Các lựa chọn khác:

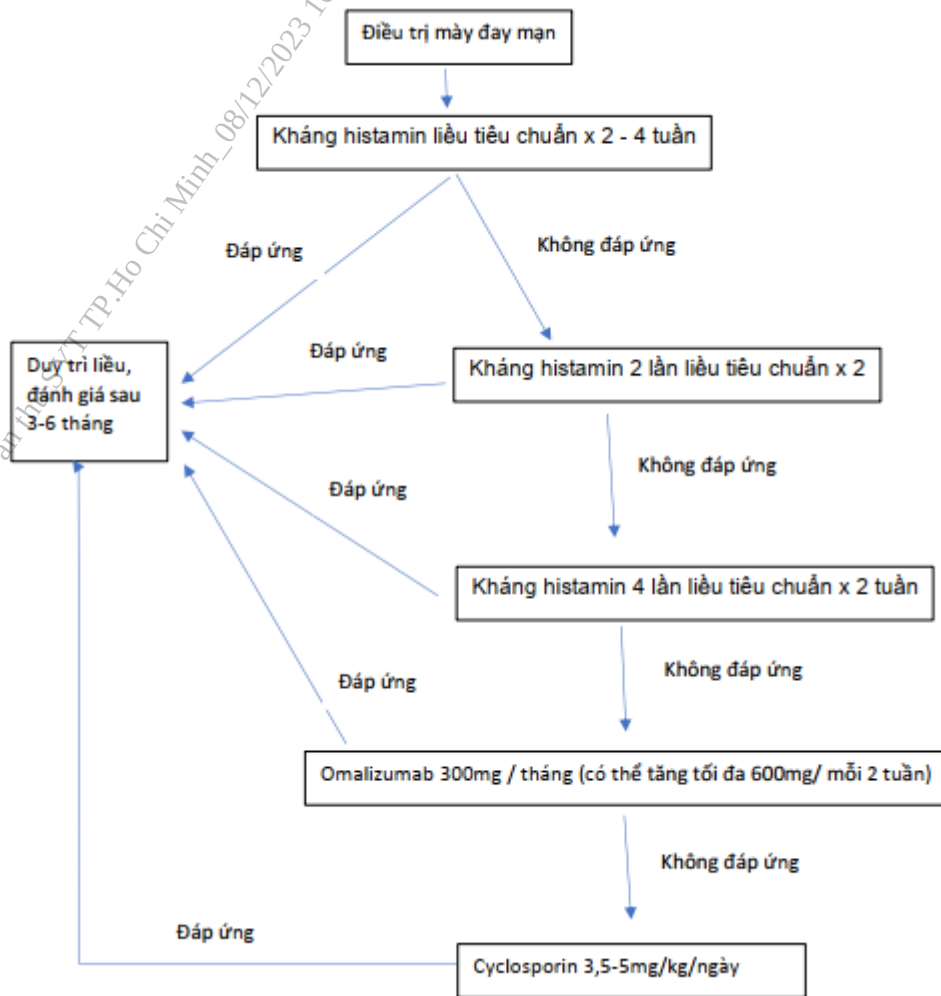
+ Kháng leukotrien: như montelukast, đồng thuận mới nhất 2017 chứng minh thuốc ít có tác dụng trong điều trị mày đay mạn tính.

+ Corticosteroid ngắn ngày: được chỉ định trong trường hợp mày đay nặng, mày đay cấp tính có nguy hiểm đến tính mạng. Liều khuyến cáo 0,3 - 0,5 mg/kg trong 10 - 14 ngày. Sử dụng kéo dài corticosteroid không được khuyến cáo do nhiều tác dụng phụ.

- Điều trị trên đối tượng phụ nữ có thai và cho con bú: cetirizin là kháng histamin được lựa chọn hàng đầu.

- Điều trị hỗ trợ: dưỡng ẩm, làm dịu da tránh yếu tố kích thích. Bột talc xoa da giảm ngứa, giảm cào gãi.

- Hạ sốt, kháng sinh điều trị nhiễm khuẩn trong trường hợp mày đay nhiễm khuẩn.

Hình 1. Phác đồ điều trị mày đay mạn tính**4. PHÒNG BỆNH**

- Tránh các tác nhân nghi ngờ gây bệnh hoặc làm khởi phát mày đay.
- Tránh cào gãi
- Dùng thuốc theo đơn, không tự ý ngừng thuốc.

HỒNG BAN NÚT **(Erythema nodosum)**

1. ĐẠI CƯƠNG

1.1. Khái niệm

Hồng ban nút là tổn thương viêm ở vách mô mỡ, lâm sàng đặc trưng bởi các tổn thương dạng cục màu đỏ, đau, thường gặp ở mặt trước hai cẳng chân. Tình trạng này có thể tự phát hoặc sau một số các nguyên nhân như nhiễm khuẩn, virus hoặc sau khi sử dụng thuốc.

1.2. Dịch tễ

Bệnh có thể gặp ở mọi tuổi, giới, chủng tộc nhưng thường gặp ở nữ giới, 20-40 tuổi.

1.3. Căn nguyên/Cơ chế bệnh sinh

- Hồng ban nút được cho là phản ứng quá mẫn của cơ thể đối với nhiều tác nhân khác nhau, tuy nhiên, cơ chế vẫn chưa được hiểu một cách đầy đủ. Các giả thuyết về cơ chế bệnh sinh của hồng ban nút như sau:

+ Hồng ban nút là kết quả của sự lắng đọng phức hợp miễn dịch ở vách của mô mỡ gây nên tình trạng viêm mô mỡ tăng bạch cầu đa nhân trung tính

+ Liên quan tới gen: trong một nghiên cứu cho thấy ở những bệnh nhân hồng ban nút có hiện tượng tăng sản xuất TNF alpha.

- Nguyên nhân có thể gây hồng ban nút

+ Nhiễm khuẩn: vi khuẩn, virus, nấm và protozoa, Nhiễm liên cầu đường hô hấp trên là nguyên nhân phổ biến nhất của hồng ban nút ở trẻ nhỏ. Trước đây, nhiễm lao, phong là nguyên nhân phổ biến, tuy nhiên ngày nay tỉ lệ này đã giảm đi đáng kể.

+ Thuốc: penicillin và sulfonamid là 2 loại thường gây hồng ban nút.

+ Các bệnh ác tính: thường gặp nhất là leukemia hoặc lymphoma.

+ Bệnh tự miễn và các rối loạn viêm khác: sarcoidosis và bệnh viêm ruột mạn

+ Hồng ban nút tự phát: thường tiến triển kéo dài trên 6 tháng.

2. CHẨN ĐOÁN

2.1. Triệu chứng lâm sàng

- Triệu chứng da:

+ Các cục hoặc các mảng nóng, đỏ, đau, ranh giới không rõ, kích thước từ 1

– 6 cm. Tổn thương có thể tồn tại vài ngày hoặc vài tuần sau đó liên kết với nhau tạo thành mảng đỏ hoặc mảng thâm tím nếu có xuất huyết trong mô mỡ, không có loét và khi khỏi không để lại teo da hay sẹo.

+ Vị trí: thường gặp ở mặt duỗi hai cẳng chân, đối xứng nhau. Các vị trí khác có thể xuất hiện tổn thương bao gồm: cánh tay, đùi, hiếm khi xuất hiện ở thân mình và mặt.

+ Tiến triển: Tổn thương thường kéo dài 3 - 6 tuần, tuy nhiên thời gian có thể dài hơn hoặc tái phát nhiều lần.

- Triệu chứng toàn thân: tùy thuộc vào nguyên nhân, hay gặp nhất thường là sốt, mệt mỏi.

- Các triệu chứng khác: đau khớp, viêm khớp, đau đầu, đau bụng, nôn, tiêu chảy và ho. Viêm họng, viêm amidan, viêm đường hô hấp trên thường xuất hiện trước khi có tổn thương da khoảng 20 - 30% các trường hợp và có thể xuất hiện trước khi xuất hiện tổn thương da 1- 3 tuần.

2.2. Cận lâm sàng

- Mô bệnh học: hồng ban nút được phân loại vào viêm vách mô mỡ (septal panniculitis), mặc dù viêm thùy mỡ có thể kèm theo trong một vài trường hợp. Thành phần của các tế bào viêm khác nhau tùy thuộc vào độ tuổi của tổn thương. U hạt Miescher là tiêu chuẩn vàng của hồng ban nút – là những u hạt ranh giới rõ có các mô bào (histiocyte) bao xung quanh, ở trung tâm rải rác có các khe hình sao.

- Tốc độ máu lắng tăng cao hoặc CRP tăng.

- Các xét nghiệm tìm nguyên nhân:

+ Công thức máu có thể tăng số lượng bạch cầu hoặc bất thường dòng tế bào trong các bệnh lý ác tính.

+ Nếu nguyên nhân do nhiễm liên cầu thì ASLO tăng cao.

+ Test mantoux hoặc xét nghiệm lao tiềm ẩn (interferon-gamma release assay) để loại trừ hồng ban nút do lao

+ Xquang ngực thẳng: loại trừ hồng ban nút do nhiễm khuẩn, do lao và hồng ban nút do sarcoidosis.

2.3. Chẩn đoán xác định

Chẩn đoán xác định hồng ban nút chủ yếu dựa vào lâm sàng, mô bệnh học có vai trò trong một số trường hợp khó.

2.4. Chẩn đoán nguyên nhân

Xác định các nguyên nhân có thể gây hồng ban nút, đặc biệt là nhiễm liên cầu

khuẩn, sarcoidosis và bệnh lao. Ngoài ra cũng có thể gặp ở bệnh tự miễn, Behcet ác tính hoặc do thuốc, vaccin, có thai,

2.5. Chẩn đoán phân biệt

- Viêm mô bào,
- Viêm đa động mạch hình nút.
- Viêm mô mỡ dưới da khác: hồng ban cứng bazin, xơ da và mô mỡ cấp tính (acute lipodermatosclerosis), viêm mô mỡ do bệnh lý tụy (pancreatic panniculitis).

3. ĐIỀU TRỊ

3.1. Nguyên tắc điều trị

- Điều trị triệu chứng.
- Điều trị nguyên nhân nếu xác định được.

3.2. Điều trị cụ thể

3.2.1. Điều trị triệu chứng

- Lựa chọn thứ nhất
 - + Các thuốc giảm đau chống viêm không steroid (NSAID): ibuprofen hoặc naproxen hoặc indomethacin.
 - + Kali iodid: cơ chế của thuốc chưa rõ ràng nhưng có giả thuyết là thuốc tập trung ở tổn thương, giải phóng heparin cũng như ức chế hóa hướng động bạch cầu trung tính. Thuốc giúp làm giảm đau và hết hồng ban nút nhanh. Nếu sau 2-3 tuần không thấy cải thiện thì nên ngừng điều trị.
- Lựa chọn thứ hai: Nếu đáp ứng kém với NSAID hoặc kali iodid thì có thể sử dụng:
 - + Corticosteroid (thận trọng khi sử dụng, đặc biệt là phải loại trừ nguyên nhân do nhiễm khuẩn, đặc biệt là lao): trong trường hợp cấp tính, tổn thương nhiều có thể cho corticosteroid đường toàn thân trong thời gian ngắn tương đương liều prednisolon 0,5mg/kg trong 1- 2 tuần.
 - + Tiêm corticosteroid nội tổn thương cho những trường hợp số lượng tổn thương ít, không thể sử dụng corticosteroid toàn thân.
 - + Colchicin: đặc biệt tốt đối với bệnh nhân hồng ban nút do Behcet.
 - + Một số thuốc khác: dapsone, hydroxychloroquine, methotrexat, ức chế TNF alpha, thalidomide...
- Nếu bệnh mạn tính, tái phát: Không nên sử dụng corticosteroid lâu dài cho những trường hợp này vì có thể gây nhiều tác dụng phụ. Có thể lựa chọn dapsone, colchicin và hydroxychloroquine dựa trên tình trạng cụ thể của bệnh nhân.

3.2.2. Điều trị nguyên nhân

Tùy từng nguyên nhân gây hồng ban nút như nhiễm khuẩn liên cầu: dùng kháng sinh, nhiễm lao: điều trị theo phác đồ lao, do thuốc: ngừng thuốc nghi ngờ.

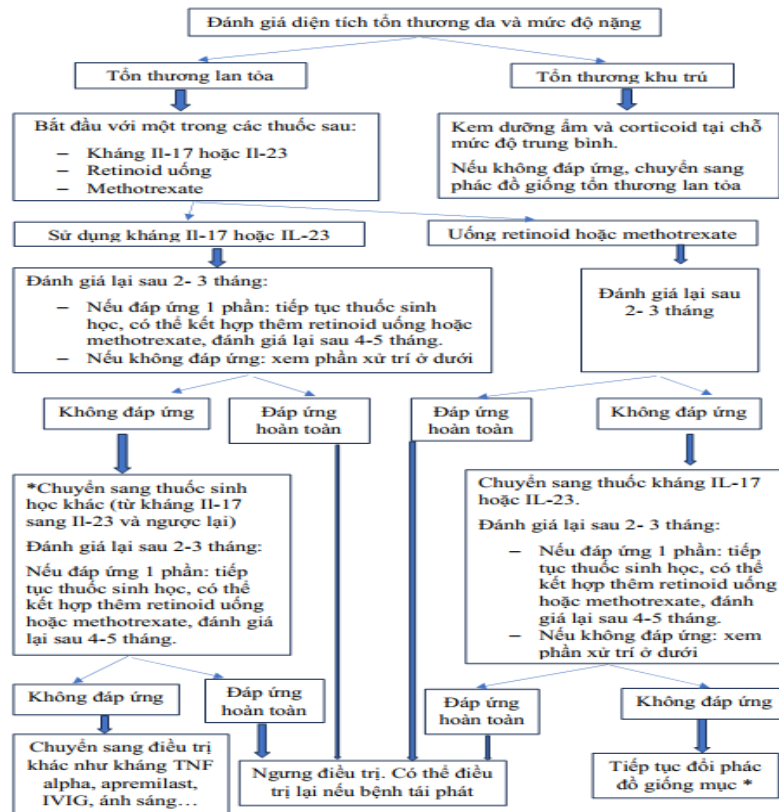
4. PHÒNG BỆNH

- Tránh các nguyên nhân có thể gây ra hồng ban nút.
- Khi có tổn thương: nghỉ ngơi, nâng cao chân, băng ép hoặc sử dụng tất áp lực.

+ Tác dụng phụ thường gặp nhất của retinoid là khô da và niêm mạc, tăng lipid máu, tăng men gan và giảm thị giác.

+ Tránh thai trong và sau dùng thuốc 3 năm khi điều trị acitretin và trong 1 tháng sau khi điều trị isotretinoin.

- Methotrexat: 15-25 mg/tuần.
- Liệu pháp ánh sáng: UVA, UVB - NB hoặc PUVA có hiệu quả trong một số trường hợp.



Lưu ý: sơ đồ này dùng tiếp cận điều trị RPR ở người lớn, không áp dụng với týp VI (liên quan HIV) và những trường hợp đột biến gen CARD14.

4. PHÒNG BỆNH

Chủ yếu là các chăm sóc khi bị bệnh:

- Tránh chà xát, cào gãi tổn thương.
- Sử dụng các sản phẩm tắm gội dịu nhẹ, kem dưỡng ẩm.

VẢY NÉN THỂ THÔNG THƯỜNG (Psoriasis vulgaris)

1. ĐẠI CƯƠNG

1.1. Khái niệm

Vẩy nến là bệnh viêm mạn tính, tiến triển từng đợt, dai dẳng. Bệnh đặc trưng bởi dát, sẩn đỏ ranh giới rõ, trên có nhiều vảy da trắng, dày, dễ bong, có thể gây tổn thương ở móng, khớp và các cơ quan khác.

1.2. Dịch tễ

Tỷ lệ bệnh vẩy nến chiếm khoảng 2-3% dân số tùy theo từng khu vực. Bệnh có thể gặp ở hai giới và mọi lứa tuổi nhưng thường gặp nhiều ở người lớn hơn trẻ em.

1.3. Căn nguyên/Cơ chế bệnh sinh

Căn nguyên của bệnh vẩy nến chưa rõ. Người ta cho rằng bệnh vẩy nến có liên quan đến rối loạn miễn dịch, yếu tố di truyền, yếu tố môi trường.

- Yếu tố di truyền: nhiều gen đã được phát hiện ở những người có HLA - B13, B17, BW57 và CW6. Đặc biệt gen HLA - CW6 gặp ở 87% bệnh nhân vẩy nến.
- Cơ chế miễn dịch: bệnh vẩy nến có liên quan đến tế bào lympho T ở da đặc biệt là tế bào Th1, Th17 và Th22. Hiện tại trục TNF- α - IL-23 – IL-17A được coi là đóng vai trò chủ đạo trong cơ chế bệnh sinh của bệnh vẩy nến.
- Các yếu tố môi trường: stress, chấn thương, nhiễm khuẩn hoặc sử dụng thuốc,

2. CHẨN ĐOÁN

2.1. Triệu chứng lâm sàng

- Tổn thương da: điển hình là những sẩn, mảng màu đỏ tươi, giới hạn rõ với da lành, trên có vảy da trắng, dày, dễ bong. Vị trí thường ở chỗ tỳ đè, vùng hay bị cọ xát như khuỷu tay, đầu gối, mấu chuyển, mặt duỗi các chi. Tổn thương có khuynh hướng đối xứng.
- Tổn thương móng: rỗ móng, rãnh ngang móng, móng xù xì, vạch trắng ngang móng, dấu hiệu giọt dầu, tách móng, dày sừng dưới móng, xuất huyết.
- Tổn thương khớp: sưng nóng đỏ đau các khớp, viêm một/nhiều khớp, hình ảnh lâm sàng giống viêm đa khớp dạng thấp, viêm khớp cột sống, viêm điểm bám gân và phần mềm quanh khớp tạo hình ảnh ngón tay, ngón chân hình khúc dồi.
- Tổn thương niêm mạc: thường gặp ở niêm mạc quy đầu, âm hộ. Đó là dát màu hồng, không thâm nhiễm, giới hạn rõ, ít hoặc không có vảy, tiến triển mạn tính. Ở lưỡi tổn thương giống viêm lưỡi hình bản đồ hoặc viêm lưỡi phì đại tróc vảy.

- Các triệu chứng của bệnh phối hợp: tim mạch, rối loạn chuyển hóa, tâm thần, ruột,....

2.2. Cận lâm sàng

- Mô bệnh học: hình ảnh đặc trưng là á sừng, mất lớp hạt, lớp gai quá sản đều hình dùi trống, mào liên nhú dài ra, có vi áp xe của Munro trong lớp gai, lớp đáy tăng sinh, bình thường chỉ có một hàng tế bào, bệnh vẩy nến có thể đến 3 hàng.

- Dermoscopy: mạch máu dạng chấm sắp xếp đều đặn trên nền da đỏ với vẩy da trắng.

- Xét nghiệm ASLO hay nuôi cấy vi khuẩn (ngoaý hợ) đối với bệnh nhân mắc vẩy nến thể giọt.

- Xét nghiệm máu: công thức máu, sinh hoá: glucose, ure, creatinin, AST, ALT, mỡ máu, ... để tầm soát các rối loạn chuyển hoá trong bệnh vẩy nến và theo dõi điều trị.

- Các xét nghiệm trước khi sử dụng thuốc sinh học:

+ Tầm soát lao và lao tiềm ẩn: chụp X quang ngực thẳng kết hợp Quantiferon hoặc test Mantoux.

+ Xét nghiệm tầm soát viêm gan B, C, HIV,

2.3. Chẩn đoán xác định

Chủ yếu dựa vào lâm sàng, mô bệnh học có vai trò trong một số trường hợp khó, lâm sàng không điển hình.

2.4. Chẩn đoán thể bệnh

- Thể thông thường: theo kích thước tổn thương có vẩy nến thể giọt (dưới 1 cm) và thể mảng.

- Theo vị trí giải phẫu: vẩy nến ở các nếp gấp (vẩy nến đảo ngược); vẩy nến ở da đầu và ở mặt; vẩy nến lòng bàn tay, lòng bàn chân; vẩy nến thể móng.

- Vẩy nến đỏ da toàn thân: thường là biến chứng của vẩy nến thể thông thường hoặc do dùng corticosteroid toàn thân, đôi khi là biểu hiện đầu tiên của bệnh vẩy nến.

2.5. Chẩn đoán mức độ

- Theo PASI (psoriasis area and severity index): dựa vào mức độ đỏ da, dày da, vẩy da và diện tích của tổn thương theo từng vùng cơ thể; PASI < 10: mức độ nhẹ, PASI ≥ 10: bệnh mức độ vừa - nặng.

- DLQI (dermatology life quality index): gồm bộ 10 câu hỏi đánh giá mức độ ảnh hưởng của bệnh đến cuộc sống bệnh nhân: 0 - 1, 2 - 5, 6 - 10, 11 - 20, 21 - 30 điểm lần lượt: không ảnh hưởng, ảnh hưởng nhỏ, ảnh hưởng trung bình, ảnh hưởng lớn, ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng cuộc sống.

- BSA (body surface areas): theo diện tích cơ thể tổn thương; $BSA \leq 10\%$: vảy nền thể mảng mức độ nhẹ, $BSA > 10\%$: vảy nền thể mảng mức độ vừa, nặng.

2.6. Chẩn đoán phân biệt

- Giang mai thời kỳ thứ II
- Lupus ban đỏ dạng đĩa
- Vảy phấn dạng lichen mạn tính
- Vảy phấn hồng Gibert
- Vảy phấn đỏ nang lông
- Nấm da
- Viêm da dầu
- U lympho T
- Dị ứng thuốc
- Đỏ da toàn thân do nguyên nhân khác.

3. ĐIỀU TRỊ

3.1. Nguyên tắc điều trị

- Điều trị theo mức độ bệnh: Điều trị xoay vòng và phối hợp các phương pháp với nhau.
- Điều trị phối hợp các chuyên khoa: tầm soát các bệnh lý chuyển hoá và khám các chuyên khoa khi cần.
- Quản lý bệnh thường xuyên: Điều trị nhằm kiểm soát và duy trì bệnh ở mức thấp nhất, giảm đỏ da và bong vảy, nâng cao chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân.

3.2. Điều trị cụ thể

3.2.1. Điều trị tại chỗ

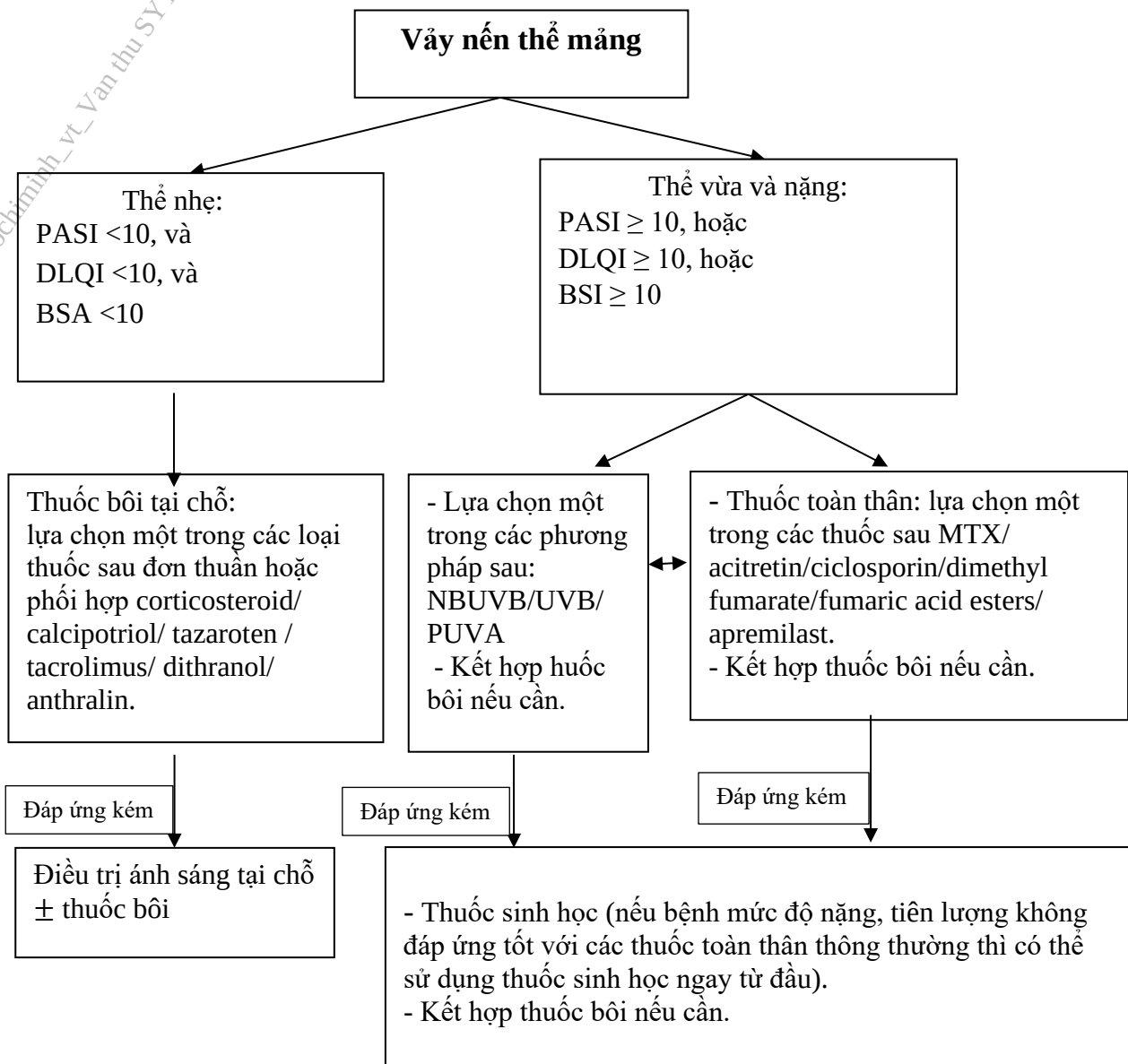
- Corticosteroid tại chỗ: bôi ngày 1 đến 2 lần, lựa chọn loại thuốc phù hợp với độ tuổi, vị trí tổn thương. Khi dùng kéo dài có thể gặp các tác dụng không mong muốn nên cần sử dụng ở mức thấp nhất có thể kiểm soát bệnh, phối hợp các thuốc điều trị khác.
- Calcipotriol là một dẫn chất của vitamin D3, liều tối đa không quá 100mg/tuần. Calcipotriol kết hợp với corticosteroid bôi ngày 1 lần, dùng điều trị tấn công, dạng gel dùng điều trị vảy nền da đầu, dạng mỡ dùng điều trị vảy nền ở thân mình
- Vitamin A acid: thuốc hay dùng nhất là tazaroten. Thuốc có tác dụng chậm sau vài tuần nhưng lại duy trì được tác dụng lâu dài hơn corticosteroid bôi. Nhược điểm đó là hay gặp tác dụng phụ kích ứng da.
- Dithranol, anthralin: hiệu quả tuy nhiên có thể kích ứng da.

- Salicylic axit đơn thuần hay được sử dụng ở Việt Nam, thuốc có tác dụng bạt sừng, bong vảy. Salicylic axit kết hợp với corticosteroid vừa có tác dụng bạt sừng vừa chống viêm

- Chẹn calcineurin: thuốc chống viêm tác dụng chậm hơn nhưng giúp hạn chế các tác dụng phụ của corticosteroid, có thể sử dụng các thuốc như tacrolimus, pimecrolimus nếu tổn thương ở mặt hoặc sau đợt bôi corticosteroid.

- Dưỡng ẩm: dưỡng ẩm giúp vùng da tổn thương giảm ngứa/đau, ngăn ngừa kích ứng, do đó ngăn ngừa hiện tượng Koebner. Có thể bôi dưỡng ẩm ngày nhiều

Sơ đồ điều trị vẩy nến thông thường



3.2.2. Điều trị ánh sáng (phototherapy).

- Quang trị liệu áp dụng khi vẩy nến ở mức độ trung bình, nặng.

- Thường sử dụng UVB dải hẹp do có hiệu quả và hạn chế được tác dụng không mong muốn. Chiếu liều khởi đầu dựa trên liều da tối thiểu hoặc tuýp da bệnh nhân, tăng mỗi lần 50 mJ/cm².

- PUVA (Psoralen phối hợp UVA) áp dụng khi tổn thương dày, không đáp ứng với UVB dải hẹp: meladinin 0,6 mg/kg uống 2 giờ trước khi chiếu UVA, liều UVA khởi đầu dựa trên liều đồ da tối thiểu hoặc tuýp da bệnh nhân, tăng mỗi lần 0,5 J/cm². Sau uống thuốc cần đeo kính chống tia UV trong suốt 24 giờ sau đó.

- Liều trình: 2 - 3 lần/tuần x 20 - 30 lần chiếu tấn công, sau đó chiếu duy trì. Hiệu quả: đạt tỷ lệ PASI 75 từ 50 - 90%. Phương pháp này giúp ổn định bệnh lâu dài. UVB dải hẹp có thể điều trị được cho trẻ em, phụ nữ có thai, người mắc các bệnh mạn tính.

- Tác dụng phụ: hay gặp nhất là đỏ da, ngứa, thâm da. Với PUVA có thể gặp nôn, buồn nôn do thuốc. UVB dải hẹp ít tăng nguy cơ ung thư da hắc tố và không hắc tố trong khi PUVA có tăng nguy cơ này vì vậy nên theo dõi chặt chẽ, tổng số lần chiếu.

3.2.3. Điều trị toàn thân

- Methotrexat: Liều khởi đầu thường 7,5- 10mg/tuần, uống hoặc tiêm bắp cố định vào 1 ngày trong tuần. Bổ sung acid folic khác ngày uống MTX. Nếu bệnh nhân đáp ứng kém có thể tăng liều (tùy thuộc cân nặng), nếu đáp ứng tốt có thể giảm liều dần. Tổng liều tích lũy khoảng 3,5g hoặc 1,5g đối với bệnh nhân nguy cơ (uống nhiều rượu, đái tháo đường, ...). Khi đạt tổng liều tích lũy, cần sàng lọc tình trạng xơ gan cho bệnh nhân.

- Acitretin, dẫn chất của vitamin A axit, tác dụng điều hòa quá trình sừng hóa, điều trị các thể vảy nến vừa và nặng. Người lớn dùng liều khởi đầu 25 mg/ngày, sau 1-2 tuần, tùy theo kết quả và dung nạp thuốc sẽ điều chỉnh (tăng hoặc giảm liều) cho phù hợp. Tác dụng phụ rất hay gặp trên da và niêm mạc: khô da, khô môi, rụng tóc, chảy máu cam, bong tróc bàn tay, chân. Phụ nữ nên tránh thai trong và sau ngừng thuốc ít nhất 3 năm do thuốc có nguy cơ gây quái thai.

- Cyclosporin: tác dụng ức chế miễn dịch, điều trị những thể vảy nến nặng, liều khởi đầu 2,5-5 mg/kg/ngày chia làm 2 lần. Sau 1 tháng có thể tăng liều nhưng không quá 5mg/kg/ngày. Sau 6 tuần dùng liều cao mà không thấy hiệu quả thì ngừng thuốc. Khi đạt hiệu quả có thể dùng liều thấp duy trì nhưng không nên dùng thuốc quá 2 năm.

- Apremilast: một chất ức chế phosphodiesterase 4, là một loại thuốc uống khác để điều trị bệnh vảy nến mảng bám. Sự ức chế phosphodiesterase 4 làm giảm sản xuất nhiều cytokine liên quan đến sinh bệnh học của bệnh vảy nến

- Dimethyl fumarat/fumaric acid esters: thường được sử dụng ở Bắc Âu, hiệu quả tương đương MTX.

- Deucravacitinib là một chất ức chế chọn lọc qua đường uống của tyrosine kinase 2 (TKY2), một kinase làm trung gian truyền tín hiệu của các cytokine liên

quan đến sinh bệnh học của bệnh vẩy nến, như IL-23. Vào năm 2022, FDA đã phê duyệt deucravacitinib để điều trị bệnh vẩy nến thể mảng từ trung bình đến nặng ở những người trưởng thành phù hợp với liệu pháp toàn thân hoặc liệu pháp quang học.

- Thuốc sinh học (biotherapy): Trước đây thuốc sinh học sử dụng khi thất bại với các phương pháp toàn thân cổ điển. Tuy nhiên, hiện nay quan điểm đã thay đổi, nhóm thuốc này có thể được chỉ định ngay từ đầu. Một số thuốc sinh học đã được cấp phép sử dụng cho trẻ em mắc vẩy nến như: Adalimumab, etanercept cho trẻ ≥ 4 tuổi, ustekinumab, secukinumab, ixekinumab cho trẻ ≥ 6 tuổi.

+ Nhóm ức chế TNF- α : etanercept, infliximab, adalimumab, certolizumab pegol.

+ Nhóm ức chế IL17: secukinumab, ixekizumab, brodalumab, bimekizumab.

+ Nhóm ức chế IL 23: ustekinumab, guselkumab, tildrakizumab, risankizumab.

+ Phác đồ một số thuốc sinh học hiện có ở Việt Nam cho người trưởng thành

Thuốc	Cơ chế	Đường dùng	Phác đồ
Infliximab	ức chế TNF- α	truyền tĩnh mạch	3 - 5 mg/kg tuần 0, 2, 6 $\rightarrow$ mỗi 8 tuần
Adalimumab	ức chế TNF- α	Tiêm dưới da	80mg tuần 0, 40mg tuần 1 sau đó 40mg mỗi 2 tuần.
Ustekinumab	ức chế IL-12, IL-23	Tiêm dưới da	45 hoặc 90mg tuần 0 và 4; sau đó mỗi 12 tuần
Secukinumab	ức chế IL-17	Tiêm dưới da	300mg tuần 0, 1, 2, 3, 4 sau đó mỗi 4 tuần 1 lần.
Guselkumab	ức chế IL-23	Tiêm dưới da	100mg tuần 0 và 4, sau đó mỗi 8 tuần

+ Phác đồ điều trị ở trẻ em

Thuốc	Đối tượng	Đường dùng	Phác đồ
Etanercept	≥ 4 tuổi	tiêm dưới da	0,8 mg/kg/tuần (tối đa: 50mg/lần)
Adalimumab	≥ 4 tuổi	Tiêm dưới da	0,8 mg/kg ở tuần 0,1 sau đó cách tuần (tối đa: 40mg/lần)
Ustekinumab	≥ 6 tuổi	Tiêm dưới da	≤ 60 kg: 0,75mg/kg, 60-100kg: 45 mg; >100kg: 90 mg (tuần 0, 4 và mỗi 12 tuần)
Secukinumab	≥ 6 tuổi	Tiêm dưới da	< 50kg: 75mg, ≥ 50 kg: 150 mg với phác đồ 0,1,2,3,4 và mỗi 4 tuần
Ixekizumab	≥ 6 tuổi	Tiêm dưới da	< 25kg: 40mg tuần 0, → 20mg mỗi 4 tuần 25-50kg: 80mg ở tuần 0 -> 40mg mỗi 2 tuần >50kg: 160 tuần 0 -> 80 mg mỗi 2 tuần

4. PHÒNG BỆNH

- Tránh các yếu tố kích thích: nhiễm khuẩn, chấn thương, stress, ...
- Thăm khám định kì theo hẹn.
- Không tự ý sử dụng các thuốc điều trị.

BỆNH LICHEN PHẪNG (Lichen planus)

1. ĐẠI CƯƠNG

1.1. Khái niệm

Lichen phẳng là tình trạng viêm da với các tổn thương đặc trưng là sẩn phẳng, hình đa giác, màu đỏ tím và ngứa, ngoài ra còn có tổn thương ở niêm mạc và móng.

1.2. Dịch tễ

Lichen phẳng chiếm khoảng 0,5-1% dân số với tỉ lệ mắc bệnh giữa nam và nữ ngang nhau. Lứa tuổi hay gặp từ 30-60 tuổi và ít gặp ở trẻ em.

1.3. Căn nguyên/Cơ chế bệnh sinh

Cơ chế bệnh sinh của lichen phẳng chưa được sáng tỏ, liên quan đến phản ứng miễn dịch liên quan đến hoạt hóa tế bào lympho T, đặc biệt là tế bào TCD8.

Các yếu tố liên quan đến khởi phát bệnh bao gồm:

- Thuốc: thuốc ức chế ACE, thuốc chẹn beta, methyldopa, quinidine, cloroquin, hydroxychloroquine, thuốc lợi tiểu thiazide, muối vàng.
- Virus: đặc biệt là viêm gan C, HSV.
- + Các bệnh phối hợp: pemphigoid, lupus,
- + Nhiều trường hợp không rõ nguyên nhân.

2. CHẨN ĐOÁN

2.1. Triệu chứng lâm sàng

- Tổn thương da:
 - + Sẩn nhẵn, bóng, dẹt, hình đa giác, màu tím hoa cà, kích thước 1-10mm, bề mặt thường có những khía ngang dọc gọi là mạng lưới Wickham. Sẩn có thể liên kết thành mảng, khi khò để lại vết thâm. Tổn thương ở da đầu có thể gây rụng tóc vĩnh viễn.
 - + Vị trí thường gặp: cổ tay, thắt lưng, cẳng chân, đầu, dương vật.
 - + Có thể gặp hiện tượng Koebner: người bệnh gãi, dọc theo vết gãi xuất hiện tổn thương mới.
- Tổn thương niêm mạc:
 - + Tổn thương đặc trưng là những dải hoặc mạng lưới màu trắng như sứ hoặc màu xám.
 - + Vị trí thường gặp: lưỡi và niêm mạc má, ngoài ra còn có thể gặp ở thanh

quản, amidan, quy đầu, âm đạo, niêm mạc dạ dày-ruột, quanh hậu môn.

- Tổn thương móng gặp ở 10% người bệnh với các biểu hiện là những khía dọc, dày móng, tách móng hoặc teo móng.

- Cơ năng: ngứa ít hoặc nhiều tùy từng trường hợp.

2.2. Cận lâm sàng

- Mô bệnh học: Thương bì: dày sừng, dày lớp hạt, thoái hóa lỏng lớp đáy. Phần trung bì nông các tế bào thâm nhiễm làm biến dạng nhú bì tạo thành vòm, giới hạn rõ. Tế bào thâm nhiễm chủ yếu là lympho T như CD4+, CD8+ và tương bào.

- Dermoscopy: góp phần chẩn đoán sớm bệnh lichen phẳng. Các dấu hiệu trên da của lichen phẳng bao gồm mạng lưới Wickham, mao mạch hướng tâm, tăng sắc tố dạng chấm lan tỏa màu nâu.

- Xét nghiệm soi nấm: âm tính.

- Miễn dịch huỳnh quang trực tiếp: lắng đọng phức hợp miễn dịch mà chủ yếu là IgM ở thượng bì và trung bì, một phần nhỏ IgA và C3. Lắng đọng sợi fibrin ở vùng tiếp giáp trung bì thượng bì cũng là một đặc trưng của lichen phẳng.

- Các xét nghiệm khác: xét nghiệm viêm gan virus B và C, nhất là viêm gan C. Ngoài ra nên xét nghiệm đánh giá chức năng gan do bệnh lichen phẳng liên quan đến xơ gan.

2.3. Chẩn đoán xác định:

Chẩn đoán xác định dựa vào lâm sàng và mô bệnh học.

2.4. Chẩn đoán thể bệnh:

- Thể thông thường

- + Hay gặp nhất.

- + Biểu hiện lâm sàng và mô bệnh học như trên

- Thể teo

- + Các sản thoái triển để lại sẹo teo, xơ cứng, màu sáng, hơi lõm, khu trú ở cổ, cổ tay, ngực, bụng.

- + Ở da đầu có thể gây rụng tóc mảng nhỏ, rụng lông nách, lông mu,...

- + Trên hình ảnh giải phẫu bệnh thấy có thượng bì teo, ít tế bào viêm, di chuyển sắc tố xuống trung bì, ít thể Civatte.

- Thể phì đại

- + Sẩn sùi màu tím hoặc đỏ nâu, trên phủ một lớp vảy sừng.

- + Vị trí: hay gặp mặt trước cẳng chân, bàn chân, quanh mắt cá.

- + Trên hình ảnh giải phẫu bệnh thấy có thêm lớp gai quá sản dạng vảy nền

không đều, lớp sừng dày, nén chặt. Có thể nhìn thấy bạch cầu ái toan trong thể này.

- Thể vòng
 - + Đặc trưng bởi sự phát triển của các mảng màu tím, lành ở vùng trung tâm, có thể có teo trung tâm.
 - + Vị trí thường gặp là dương vật, bìu và các vùng kẽ, có thể gặp ở các vị trí khác.
- Thể có mụn nước, bọt nước
 - + Ngoài các sản điển hình của lichen phẳng, còn có thể thấy mụn nước, bọt nước chứa huyết tương trên nền da bình thường.
 - + Miễn dịch huỳnh quang trực tiếp: hình ảnh thấy nhiều tế bào chết theo chương trình tại vùng tiếp giáp thượng bì và trung bì, sự lắng đọng của IgM, IgG và IgA.
- Thể quanh nang lông
 - Sẩn xung quanh nang lông hình nón nhọn, riêng rẽ hoặc liên kết thành mảng đỏ xung quanh nang lông. Tổn thương ở da đầu gây sẹo teo da, rụng tóc vĩnh viễn.
- Thể đảo ngược:
 - Đặc trưng bởi các sẩn, mảng từ đỏ đến tím ở các vị trí nếp kẽ, chẳng hạn như nách, bẹn, vùng dưới vú hoặc các nếp gấp tay chân.
- Thể tăng sắc tố:
 - Biểu hiện là các mảng màu nâu xám hoặc nâu sẫm, thường gặp ở các vùng tiếp xúc với ánh nắng hoặc mặt gấp.

2.5. Chẩn đoán phân biệt:

- Phản ứng thuốc dạng lichen
- Hội chứng mảnh ghép chống vật chủ
- Các bệnh đỏ da bong vảy: vảy nến, lichen đơn dạng mạn tính, giang mai II...
- Viêm miệng do Candida
- Loạn dưỡng móng

3. ĐIỀU TRỊ

3.1. Nguyên tắc điều trị

- Phát hiện và kiểm soát căn nguyên.
- Điều trị theo vị trí, mức độ tổn thương.

3.2. Điều trị cụ thể

3.2.1. Điều trị tại chỗ

- Điều trị tổn thương da:
 - + Bôi corticosteroid: dạng kem, mỡ, có thể băng bột.

+ Tiêm corticosteroid tại chỗ khi tổn thương dày, nhiều. Thường dùng trimcinolone acetonide, cần theo dõi các biến chứng teo da, giảm sắc tố.

+ Acid salicylic: dạng mỡ có các nồng độ 3%, 5% và 10%, tác dụng làm tiêu sừng, bong vảy. Nên bôi mỗi ngày 2-3 lần.

– Điều trị tổn thương niêm mạc:

+ Bôi hoặc tiêm corticosteroid tại chỗ.

+ Tacrolimus 0,1% dạng bôi trong miệng chỉ định đối với những trường hợp có tổn thương niêm mạc miệng, nhất là tổn thương có loét, trợt.

+ Gel lidocain khi bệnh nhân đau nhiều.

3.2.2. Điều trị toàn thân:

– Lựa chọn thứ nhất: corticosteroid uống. Có thể dùng riêng rẽ hoặc kết hợp với liệu pháp corticosteroid tại chỗ, liều tương đương 30-60 mg prednisolon/ngày trong 4-6 tuần, sau đó giảm dần liều và dùng trong 4-6 tuần tiếp.

– Lựa chọn thứ hai: acitretin 0,5-1 mg/kg/ngày trong 2-3 tháng, cần lưu ý ở phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ phải dùng thuốc 3 năm mới được có thai.

– Các điều trị khác

+ Ánh sáng: PUVA hoặc UVB, điều trị 3 lần/tuần trong 6 tuần cho hiệu quả tốt, tỷ lệ tái phát của UVB thấp hơn PUVA.

+ Chống ngứa: kháng histamin H1 thế hệ 1, thế hệ 2.

+ Cyclosporin: Chỉ định trong trường hợp lan tỏa, không đáp ứng với các trị liệu khác. Liều 1-6mg/kg trong thời gian vài tháng.

+ Trong những trường hợp nặng, tổn thương lan tỏa: có thể sử dụng các thuốc ức chế miễn dịch khác như: azathioprin, cyclophosphamid, mycophenolat mofetil, methotrexat.

– Phối hợp điều trị các bệnh khác nếu có như viêm gan, xơ gan.

4. Phòng bệnh:

– Tránh sử dụng các thuốc có nguy cơ gây bệnh

– Hạn chế gãi, chà xát.

– Tránh các chất kích thích như rượu bia, thuốc lá.

NHIỄM HERPES SIMPLEX SINH DỤC (Genital herpes simplex)

1. ĐẠI CƯƠNG

Nhiễm herpes simplex sinh dục là một trong những bệnh lây truyền qua đường tình dục phổ biến, diễn biến mạn tính, có các đợt tái phát tại vị trí nhiễm trùng. Người nhiễm vi rút có thể có triệu chứng hoặc không và ngay cả khi không có triệu chứng vẫn có thể lây cho bạn tình. Bệnh lây truyền qua quan hệ tình dục đường âm đạo, hậu môn hoặc miệng, có thể lây cho trẻ sơ sinh khi mẹ bị bệnh.

Nguyên nhân gây bệnh do vi rút Herpes simplex (Herpes simplex virus - HSV) gây ra. HSV có 2 type là HSV-1 và HSV-2. Herpes sinh dục chủ yếu do HSV-2. Tuy nhiên, HSV-1 hiện nay đang có xu hướng tăng do quan hệ miệng -sinh dục. Nhiễm HSV là tình trạng mạn tính suốt đời, có thể có các đợt tái phát. Hầu hết các trường hợp nhiễm HSV không có triệu chứng hoặc triệu chứng không điển hình, do đó phần lớn người nhiễm HSV-2 không được chẩn đoán.

Bệnh thường gặp ở người trẻ, trong độ tuổi hoạt động tình dục, đặc biệt các đối tượng có hành vi tình dục nguy cơ cao. Theo ước tính của Tổ chức Y tế thế giới năm 2016, có khoảng 491,5 triệu người nhiễm HSV-2 trong độ tuổi từ 15 đến 49 trên toàn cầu, trong đó nữ giới mắc nhiều hơn nam giới.

Herpes simplex sinh dục có thể gây ra các biến chứng ngoài sinh dục như viêm rễ thần kinh, viêm màng não vô khuẩn, bí tiểu, viêm niêm mạc trực tràng (đặc biệt ở đối tượng nam quan hệ đồng giới).

Trẻ sơ sinh bị nhiễm HSV, mặc dù hiếm gặp nhưng vẫn có tỷ lệ tàn tật nặng và tử vong.

Người nhiễm HSV-2 có nguy cơ mắc HIV cao gấp 3 lần. Người đồng nhiễm HIV và HSV-2 có thể tăng nguy cơ lây HIV cho người khác. Nhiễm HSV-2 trên người HIV có thể gây các biến chứng nghiêm trọng như nhiễm trùng mắt, não, phổi.

2. CHẨN ĐOÁN

2.1. Triệu chứng lâm sàng

Người bệnh mắc bệnh lần đầu tiên được gọi là nhiễm HSV sinh dục tiên phát. Tuy cách lây truyền HSV-1, HSV-2 khác nhau và gây bệnh ở những vị trí khác nhau nhưng biểu hiện lâm sàng của nhiễm HSV-1 và HSV-2 sinh dục thường khó phân biệt về mặt lâm sàng mà chỉ có thể phân biệt bằng xét nghiệm.

Hầu hết bệnh nhân nhiễm HSV-2 sinh dục tiên phát có triệu chứng sau đó sẽ bị những đợt tái phát. Nhiễm HSV-1 sinh dục thường ít tái phát hơn. Triệu chứng của các đợt tái phát thường nhẹ hơn đợt tiên phát.

Sau đợt nhiễm HSV-2 tiên phát, thường xuất hiện những đợt tái phát vì rút từ các tổn thương sinh dục mặc dù không có triệu chứng lâm sàng. Vì vậy HSV-2 thường lây truyền từ những người không biết mình bị nhiễm hoặc những người không có triệu chứng ở thời điểm quan hệ tình dục.

2.1.1. Nhiễm HSV sinh dục tiên phát

- Thời gian ủ bệnh khoảng 4-7 ngày.
- Tổn thương là các mụn nước trên nền dát đỏ, tập trung thành đám ở bộ phận sinh dục ngoài, quanh hậu môn, mông. Các mụn nước tiến triển thành mụn mủ, vết loét bờ đa cung, đóng vảy tiết và lành không để lại sẹo trong vòng 2-3 tuần. Tổn thương tại niêm mạc có thể loét, loét mà không có biểu hiện mụn nước trước đó.
- Tổn thương không điển hình của nhiễm HSV-2 sinh dục có thể gặp như vết loét, vết nứt nhỏ, khó tiểu, viêm niệu đạo mà không có tổn thương.
- Triệu chứng tại chỗ: đau, ngứa bộ phận sinh dục hoặc bí tiểu.
- Triệu chứng toàn thân: có thể sốt, nhức đầu, đau cơ, hạch bẹn sưng đau, viêm cổ tử cung.

2.1.2. Nhiễm HSV sinh dục tái phát

- Tiền triệu: đau, bỏng rát, dị cảm trước khi xuất hiện mụn nước.
- Lâm sàng: các tổn thương tái phát thường ít hơn, ở một bên và không đau nhiều như nhiễm HSV tiên phát, thường tự lành sau 5-10 ngày.
- Hầu như không có triệu chứng toàn thân.
- Ở những bệnh nhân suy giảm miễn dịch, bệnh nhân HIV, các đợt tái phát diễn ra thường xuyên hơn và có triệu chứng rầm rộ, ảnh hưởng nhiều đến thể chất và tinh thần.

2.2. Cận lâm sàng

Các phương pháp xét nghiệm chẩn đoán HSV-2 gồm phát hiện trực tiếp từ tổn thương và gián tiếp qua huyết thanh:

- Xét nghiệm huyết thanh: có thể áp dụng sàng lọc HSV-2 để phát hiện kháng thể đặc hiệu. Kháng thể đặc hiệu xuất hiện sau khi nhiễm vi rút vài tuần và tồn tại vĩnh viễn.
- Nuôi cấy vi rút: trước đây được coi là tiêu chuẩn vàng chẩn đoán HSV-2, nhưng độ nhạy không cao, đặc biệt ở các tổn thương bắt đầu lành và các đợt tái phát.
- Xét nghiệm khuếch đại axit nucleic (Nucleic Acid Amplification Test – NAATs, trong đó có xét nghiệm PCR với HSV-1 và HSV-2): so với nuôi cấy vi rút, xét nghiệm NAATs có độ nhạy cao hơn, bệnh phẩm dễ thu thập và vận chuyển, cho kết quả nhanh hơn nên ngày càng được ưu tiên hơn.

- Trong trường hợp không có các xét nghiệm trên, có thể làm xét nghiệm chẩn đoán tế bào Tzanck: nhuộm Giemsa hoặc Wright dịch mụn nước thấy tế bào gai lệch hình và tế bào đa nhân khổng lồ. Tuy nhiên, xét nghiệm này không đặc hiệu để chẩn đoán nhiễm herpes simplex sinh dục.

2.3. Chẩn đoán xác định

- Chẩn đoán chủ yếu dựa vào lâm sàng: mụn nước tập trung thành đám trên nền dát đỏ, sau vài ngày vỡ để lại các vết trợt hình đa cung; ở niêm mạc, bán niêm mạc, da vùng sinh dục.

- Xét nghiệm: trong điều kiện không thực hiện được nuôi cấy vi rút, xét nghiệm khuếch đại gen (trong đó có PCR) được xem xét là xét nghiệm có giá trị cao trong chẩn đoán herpes simplex sinh dục.

- Trong trường hợp không làm được các xét nghiệm trên, có thể làm xét nghiệm tế bào Tzanck để hỗ trợ chẩn đoán.

2.4. Chẩn đoán phân biệt

- Săng giang mai
- Hạ cam mềm
- Bệnh áp tơ
- Bệnh Behcet
- Nấm Candida
- Dị ứng thuốc...

3. ĐIỀU TRỊ

3.1. Nguyên tắc điều trị

Điều trị càng sớm càng tốt trong vòng 72 giờ sau khi xuất hiện tổn thương đối với nhiễm HSV tiên phát mà không cần chờ kết quả xét nghiệm. Thuốc kháng vi rút đường uống làm giảm thời gian và mức độ nặng của bệnh, giảm triệu chứng và khả năng phát tán vi rút. Tuy nhiên, sau 72 giờ vẫn nên

- Sử dụng thuốc kháng vi rút đường uống nếu bệnh nhân vẫn xuất hiện tổn thương mới và/hoặc triệu chứng đau đáng kể.
- Chủ yếu điều trị ngoại trú, chỉ điều trị nội trú trong trường hợp bệnh nặng (viêm loét sinh dục nặng, sưng đau nhiều...) hoặc có biến chứng (viêm rãnh thần kinh, viêm màng não vô khuẩn, bí tiểu, viêm niêm mạc trực tràng...).
- Tư vấn điều trị cho bạn tình và phòng tránh nhiễm các bệnh lây truyền qua đường tình dục khác, trong đó có nhiễm HIV.
- Nếu có bội nhiễm, dùng kháng sinh phổ rộng.
- Nâng cao thể trạng.

3.2. Điều trị cụ thể

Lựa chọn một trong các phác đồ dưới đây, ưu tiên aciclovir do tương đương về hiệu quả và tối ưu chi phí điều trị.

	Vị thành niên, người trưởng thành và phụ nữ có thai	Người nhiễm HIV và suy giảm miễn dịch
Herpes sinh dục tiên phát	• aciclovir 400 mg uống 3 lần/ngày trong 10 ngày (liều chuẩn) • aciclovir 200 mg uống 5 lần/ngày trong 10 ngày • valaciclovir 500 mg uống 2 lần/ngày trong 10 ngày • famciclovir 250 mg uống 3 lần/ngày trong 10 ngày	
Herpes sinh dục tái phát Điều trị nên được bắt đầu trong vòng 24h kể từ khi có triệu chứng	• aciclovir 400 mg uống 3 lần/ngày trong 5 ngày, hoặc 800 mg uống 2 lần/ngày trong 5 ngày, hoặc 800 mg uống 3 lần/ngày trong 2 ngày • valaciclovir 500 mg uống 2 lần/ngày trong 3 ngày • famciclovir 250 mg uống 2 lần/ngày trong 5 ngày	• aciclovir 400 mg uống 3 lần/ngày trong 5 ngày • valaciclovir 500 mg uống 2 lần/ngày trong 5 ngày • famciclovir 500 mg uống 2 lần/ngày trong 5 ngày
Điều trị dự phòng Cho bệnh nhân tái phát 4-6 đợt/năm hoặc hơn.	• aciclovir 400 mg uống 2 lần/ngày hàng ngày, trong 6-12 tháng • valaciclovir 500 mg uống 1 lần/ngày hàng ngày, trong 6-12 tháng • famciclovir 250 mg uống 2 lần/ngày hàng ngày, trong 6-12 tháng	• aciclovir 400 mg uống 2 lần/ngày hàng ngày, trong 6-12 tháng • valaciclovir 500 mg uống 2 lần/ngày hàng ngày, trong 6-12 tháng • famciclovir 500 mg uống 2 lần/ngày hàng ngày, trong 6-12 tháng

Phối hợp điều trị tại chỗ: rửa nước muối sinh lý, bôi tê tại chỗ như lidocain. Thuốc bôi aciclovir hiệu quả kém.

4. PHÒNG BỆNH

- Đây là bệnh lây truyền qua đường tình dục, phải thực hiện các biện pháp phòng tránh như các bệnh lây truyền qua đường tình dục khác.
- Bao cao su có hiệu quả phòng tránh lây truyền bệnh nhưng không đạt được

hiệu quả 100%.

- Người nhiễm HSV có nguy cơ rất cao lây truyền HIV nên bệnh herpes simplex sinh dục cần được quan tâm trong phòng chống bệnh lây truyền qua đường tình dục và HIV/AIDS.

BỆNH DO CHLAMYDIA TRACHOMATIS

(*Chlamydia trachomatis*)

1. ĐẠI CƯƠNG

Nhiễm Chlamydia sinh dục – tiết niệu là một trong những nhiễm khuẩn lây truyền qua đường tình dục hay gặp nhất. Theo ước tính của Tổ chức y tế thế giới, trong năm 2020, thế giới có khoảng 128,5 triệu người mắc bệnh.

Chlamydia trachomatis có 3 biến thể sinh học khác nhau, mỗi biến thể bao gồm nhiều kiểu gen, gây nên nhiễm khuẩn đường sinh dục – tiết niệu, bệnh hạch xoài (lymphogranuloma venereum – LGV) và bệnh mắt hạch.

Nhiễm Chlamydia sinh dục – tiết niệu nếu không được điều trị có thể gây ra một số biến chứng như viêm phần phụ ở nữ giới, viêm mào tinh hoàn ở nam giới và vô sinh ở cả hai giới. Nhiễm Chlamydia ở phụ nữ có thai có thể dẫn đến sinh non và/hoặc trẻ sinh ra thiếu cân. Trẻ sơ sinh có thể bị nhiễm Chlamydia từ mẹ trong quá trình chuyển dạ dẫn đến viêm kết mạc, viêm mũi họng, viêm phổi. Nguy cơ biến chứng tăng lên khi tái nhiễm nhiều lần.

2. CHẨN ĐOÁN

2.1. Triệu chứng lâm sàng

2.1.1. Nhiễm Chlamydia không biến chứng

- Nhiễm Chlamydia sinh dục – tiết niệu: 70% ở nữ và 50% ở nam giới nhiễm Chlamydia sinh dục – tiết niệu không có biểu hiện lâm sàng. Các trường hợp có triệu chứng lâm sàng bao gồm:

+ Ở nữ giới: tiết dịch âm đạo bất thường; tiểu khó; chảy máu khi quan hệ tình dục; viêm, tiết dịch cổ tử cung.

+ Ở nam giới: tiết dịch niệu đạo, tiểu khó, đau tinh hoàn

- Nhiễm Chlamydia ngoài sinh dục:

+ Trực tràng: phần lớn không có biểu hiện lâm sàng, một số trường hợp có tiết dịch, đau và có máu trong phân.

+ Hạch bạch huyết: hiếm khi có triệu chứng, có thể viêm hạch, đau hạch nhẹ.

2.1.2. Nhiễm Chlamydia có biến chứng

- Ở nam giới: viêm mào tinh hoàn, viêm ống dẫn tinh, túi tinh và có thể dẫn đến vô sinh.

- Ở nữ giới: viêm tiểu khung, chửa ngoài tử cung, viêm vòi trứng, ống dẫn trứng và có thể dẫn đến vô sinh.

- Ở phụ nữ có thai: sinh non và/hoặc trẻ sinh ra thiếu cân.
- Ở trẻ sơ sinh: có thể bị nhiễm Chlamydia từ mẹ trong quá trình chuyển dạ dẫn đến viêm kết mạc (tiết dịch, sưng mí mắt), viêm mũi họng, viêm phổi.

2.1.3. Biểu hiện lâm sàng của bệnh hạt xoài (lymphogranuloma venereum)

- Do các biến thể L1-3 của *C. trachomatis* xâm nhập sâu hơn đến tổ chức dưới niêm mạc và hạch lân cận.
- Tổn thương thường gặp ở hạch bẹn hoặc hạch đùi một bên, hạch mềm và vết loét hoặc sẩn ở bộ phận sinh dục.
- Tổn thương ở hậu môn trực tràng có thể biểu hiện viêm hậu môn trực tràng, tiết dịch, đau, táo bón hoặc mót rặn. Nếu không được điều trị, có thể dẫn đến chít hẹp hoặc rò hậu môn.

2.2. Cận lâm sàng

- Nuôi cấy: là phương pháp có thể dùng để chẩn đoán nhiễm Chlamydia nhưng tính ứng dụng không cao vì đắt tiền và đòi hỏi kỹ thuật cao.
- Xét nghiệm khuếch đại axit nucleic (Nucleic acid amplification tests - NAATs)
 - + Độ nhạy, độ đặc hiệu cao và có thể áp dụng với nhiều loại bệnh phẩm đường sinh dục - tiết niệu như âm hộ, âm đạo, cổ tử cung, niệu đạo và nước tiểu.
 - + So với các phương pháp khác như nuôi cấy và phát hiện kháng nguyên, độ nhạy của xét nghiệm khuếch đại gen cao hơn, thu thập mẫu bệnh phẩm không xâm lấn và có thể áp dụng ở các tuyến cơ sở.
 - + Một số xét nghiệm có thể thực hiện tại phòng xét nghiệm hoặc tại điểm khám bệnh (POC) như xét nghiệm kép Chlamydia – Lậu (*C. trachomatis*/N. gonorrhoeae: CT/NG) dựa trên nguyên lý NAATs cho kết quả nhanh trong vòng 90 phút, được FDA chấp thuận cho mẫu bệnh phẩm ở cổ tử cung, âm đạo, nước tiểu.
- Xét nghiệm phát hiện kháng nguyên: Xét nghiệm miễn dịch huỳnh quang trực tiếp (Direct immunofluorescence assays – DFAs); xét nghiệm miễn dịch gắn men (Enzyme linked immunosorbent assay – ELISA) tại phòng xét nghiệm hoặc tại điểm khám bệnh.
- Xét nghiệm khuếch đại gen và xét nghiệm phát hiện kháng nguyên được khuyến cáo do tính thuận tiện và có giá trị chẩn đoán cao.

2.3. Chẩn đoán xác định

- Chẩn đoán xác định nhiễm Chlamydia dựa vào xét nghiệm khuếch đại gen hoặc xét nghiệm phát hiện kháng nguyên.
- Trong trường hợp hạn chế về nguồn lực có thể chẩn đoán dựa vào xét nghiệm tại điểm (POC) như xét nghiệm kép Chlamydia – Lậu.

Lưu ý: Nếu không có điều kiện xét nghiệm, hướng tới chẩn đoán nhiễm

Chlamydia sinh dục – tiết niệu dựa vào các triệu chứng lâm sàng và các yếu tố dịch tễ (người trẻ tuổi, đối tượng nguy cơ cao...).

2.4. Chẩn đoán phân biệt

- Viêm đường sinh dục – tiết niệu do các tác nhân gây bệnh lây truyền qua đường tình dục khác, bao gồm *N. gonorrhoeae*, *Trichomonas vaginalis*, *Mycoplasma genitalium*; và các căn nguyên không lây truyền qua đường tình dục.

- Viêm cổ tử cung do các tác nhân khác: lậu, Herpes simplex, *Trichomonas vaginalis*, trực khuẩn lao, Mycoplasma, Ureaplasma, Cytomegalovirus và liên cầu khuẩn tan huyết beta nhóm B... Các tác nhân trên có thể gây bệnh độc lập hoặc phối hợp với nhau.

- Viêm hậu môn – trực tràng do các tác nhân lây truyền qua đường tình dục khác như lậu, Herpes simplex, giang mai; và các căn nguyên không lây truyền qua đường tình dục.

Đồng nhiễm lậu và *C. trachomatis* thường gặp trên lâm sàng, vì vậy nên tiến hành xét nghiệm lậu cho tất cả các bệnh nhân nhiễm Chlamydia.

3. ĐIỀU TRỊ

3.1. Nguyên tắc điều trị

- Nhiễm Chlamydia có thể điều trị khỏi dễ dàng bằng kháng sinh. Nên điều trị sớm, đúng phác đồ, đủ liều để tránh biến chứng.
- Điều trị bạn tình để ngăn ngừa tái nhiễm và lây nhiễm cho người khác.
- Tránh quan hệ tình dục trong vòng 7 ngày sau khi bắt đầu điều trị, để tránh lây nhiễm cho bạn tình.
- Nếu các triệu chứng còn tiếp tục sau khi hoàn thành phác đồ điều trị, bệnh nhân nên tái khám để đánh giá lại.

3.2. Điều trị cụ thể

Hướng dẫn này bao gồm các phác đồ điều trị nhiễm Chlamydia không biến chứng cho người lớn, vị thành niên (10-19 tuổi), người nhiễm HIV, các quần thể đích (người mại dâm, nam có quan hệ đồng giới, người chuyển giới); điều trị và dự phòng viêm kết mạc do Chlamydia ở trẻ sơ sinh.

3.2.1. Nhiễm Chlamydia sinh dục - tiết niệu không biến chứng

- Có thể lựa chọn một trong những phác đồ ưu tiên sau:
 - + Azithromycin 1g, uống liều duy nhất.
 - + Doxycyclin 100mg, uống 2 lần/ngày trong 7 ngày.
- Hoặc một trong các phác đồ thay thế sau:
 - + Tetracyclin 500mg, uống 4 lần/ngày trong 7 ngày.
 - + Erythromycin 500mg, uống 4 lần/ngày trong 7 ngày.

- + Ofloxacin 200-400mg, uống 2 lần/ngày trong 7 ngày.

Lưu ý: Không sử dụng doxycyclin, tetracyclin, ofloxacin cho phụ nữ mang thai.

3.2.2. Nhiễm Chlamydia hậu môn - trực tràng

- Lựa chọn phác đồ theo thứ tự ưu tiên:

- + Doxycyclin 100mg, uống 2 lần/ngày trong 7 ngày.
- + Azithromycin 1g, uống liều duy nhất.

- Áp dụng cho các trường hợp đã được chẩn đoán xác định nhiễm Chlamydia hậu môn – trực tràng và cả những trường hợp nghi ngờ nhiễm sinh dục và hậu môn - trực tràng (theo khai thác tiền sử quan hệ tình dục đường hậu môn).

3.2.3. Nhiễm Chlamydia ở phụ nữ có thai

Các thuốc được lựa chọn ưu tiên theo thứ tự: azithromycin, amoxicillin, erythromycin.

- + Azithromycin 1g, uống liều duy nhất.
- + Amoxicillin 500mg, uống 3 lần/ngày trong 7 ngày.
- + Erythromycin 500mg, uống 4 lần/ngày trong 7 ngày.

3.2.4. Bệnh hạch xoài (LGV)

- Ở bệnh nhân vị thành niên và người trưởng thành mắc bệnh hạch xoài, ưu tiên lựa chọn phác đồ theo thứ tự:

+ Doxycyclin 100mg uống 2 lần/ngày trong 21 ngày. Doxycyclin không dùng ở phụ nữ mang thai.

- + Azithromycin 1g uống 1 lần/tuần trong 3 tuần.

- Khi cả 2 loại trên đều không thể sử dụng thì thay thế bằng erythromycin 500mg, uống 4 lần/ngày trong 7 ngày.

3.2.5. Viêm kết mạc ở trẻ sơ sinh

- Lựa chọn phác đồ điều trị theo thứ tự ưu tiên:

- + Azithromycin uống 20mg/kg/ngày, 1 lần/ngày trong 3 ngày
- + Erythromycin uống 50mg/kg/ngày chia 4 lần/ngày trong 14 ngày.

Lưu ý: Erythromycin có nguy cơ gây hẹp môn vị ở trẻ sơ sinh. Tuy nhiên ở một số cơ sở không có azithromycin dạng hỗn dịch, erythromycin có thể được cân nhắc sử dụng và cần phải theo dõi chặt chẽ.

- Dự phòng viêm kết mạc mắt do Chlamydia và lậu cho tất cả trẻ sơ sinh. Lựa chọn một trong các phác đồ sau (cho cả 2 mắt, ngay sau khi sinh):

- + Mỡ tra mắt tetracyclin hydrochloride 1%
- + Mỡ tra mắt erythromycin 0.5%

- + Dung dịch povidon iodine 2.5% (dung môi nước)
- + Dung dịch bạc nitrate 1%
- + Mỡ chloramphenicol 1%

Lưu ý: Lựa chọn thuốc tra mắt phụ thuộc vào giá thành và tình hình kháng thuốc erythromycin, tetracyclin và chloramphenicol tại địa phương. Cần tránh chạm vào mắt trong khi tra thuốc. Dung dịch povidon iod dung môi cồn không được khuyến cáo sử dụng.

3.3. Theo dõi

Nên khám lại sau 3 tháng cho tất cả các trường hợp, bất kể bệnh tình của họ đã được điều trị hay không. Nếu không thể khám lại sau 3 tháng, có thể kiểm tra lại bất kỳ thời điểm nào trong khoảng thời gian 3-12 tháng sau điều trị ban đầu.

4. PHÒNG BỆNH

- Truyền thông, giáo dục cho cộng đồng về nguyên nhân, đường lây, biến chứng và cách phòng bệnh.
- Tập huấn chuyên môn cho các bác sĩ đa khoa, chuyên khoa da liễu và sản phụ khoa để hạn chế tối đa nhiễm Chlamydia có biến chứng.
- Thực hành tình dục an toàn.
- Khám sàng lọc định kỳ các nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục cho quần thể đích.

BỆNH SÙI MÀO GÀ (Genital warts)

1. ĐẠI CƯƠNG

- Sùi mào gà, hay còn gọi là bệnh mụn cơm ở hậu môn sinh dục, do vi rút Human papilloma (HPV) gây nên. Đây là bệnh lây truyền qua đường tình dục thường gặp với đặc trưng là các tổn thương dạng nhú lành tính ở cơ quan sinh dục, bẹn, mu, hậu môn, quanh hậu môn.

- Theo ước tính của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), trong năm 2016, thế giới có khoảng 300 triệu phụ nữ nhiễm HPV. Tại Việt Nam, chưa có con số thống kê cụ thể.

- Sùi mào gà gây ra bởi nhiều tuýp HPV, trong đó thường gặp nhất là tuýp 6 và 11 (chiếm 90% số trường hợp). Một số tuýp HPV có nguy cơ gây loạn sản tế bào và ung thư như tuýp 16, 18, 31, 33, 35...

- HPV lây truyền chủ yếu qua quan hệ tình dục đường âm đạo, đường hậu môn hoặc đường miệng. Vi rút xâm nhập vào niêm mạc sinh dục qua các tổn thương nhỏ ở thượng bì và nằm ở lớp tế bào đáy. Tuy thời gian tồn tại ngoài môi trường ngắn nhưng HPV có thể lây truyền qua các vật dụng, dụng cụ y tế. HPV rất ít khi lây truyền từ mẹ sang con trong quá trình chuyển dạ, mặc dù hiếm gặp nó có thể gây ra u nhú đường hô hấp tái phát ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.

- Hầu hết người nhiễm HPV không có biểu hiện lâm sàng, tỉ lệ có triệu chứng chỉ khoảng 1-2%. Thời kì ủ bệnh thay đổi, trung bình là 2,9 tháng ở nữ và 11 tháng ở nam giới. Khả năng lây truyền HPV cho bạn tình cao và có thể xảy ra ngay cả khi không có tổn thương sùi mào gà. Các yếu tố thuận lợi cho nhiễm HPV là nhiều bạn tình và mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục khác.

2. CHẨN ĐOÁN

2.1. Lâm sàng

2.2.1. Tổn thương cơ bản

- Tổn thương điển hình là các sẩn nông, kích thước từ 1-10mm, có thể đơn độc hoặc nhiều. Các loại tổn thương khác có thể gặp là sẩn mịn hình vòm, màu da; sẩn giống súp lơ màu hồng hoặc màu da; sẩn tăng sừng có lớp vảy dày, giống như mụn cóc ở da hay dày sừng da dầu; sẩn dẹt hơi nhô lên trên vùng da xung quanh, màu hồng, phẳng, bề mặt nhẵn.

- Vị trí tổn thương: ở nam giới thường gặp ở dương vật, rãnh quy đầu, dây hãm dương vật, mặt trong bao qui đầu, bìu; ở nữ giới thường gặp ở âm hộ, môi bé, môi lớn, âm vật, lỗ niệu đạo, âm đạo và cổ tử cung. Ngoài ra, tổn thương sùi mào gà có thể thấy ở bẹn, vùng đáy chậu và hậu môn. Tổn thương ở hậu môn có thể gặp ở cả hai giới và ngay cả khi không có tiền sử quan hệ đường hậu môn. Tổn thương sùi

mào gà ống hậu môn hay gặp hơn ở nam có quan hệ đồng giới. Sùi mào gà còn có thể thấy ở môi, họng, vòm họng kèm theo các tổn thương vùng sinh dục-hậu môn trên người có tiền sử quan hệ tình dục đường miệng.

- Ở phụ nữ có thai và người có suy giảm miễn dịch, tổn thương thường phát triển nhanh, kích thước lớn và số lượng nhiều.

- Theo diễn biến tự nhiên, sùi mào gà có thể thoái triển, không thay đổi hoặc tăng dần kích thước và số lượng.

2.2.2. Triệu chứng khác

- Thường không có triệu chứng cơ năng, hiếm khi ngứa, bỏng rát, đau.

- Nữ giới bị sùi mào gà xuất hiện triệu chứng ra khí hư có thể viêm âm đạo kèm theo. Nam giới có sùi ở miệng sáo, niệu đạo có thể tiểu ra máu tươi cuối dòng và có bất thường dòng nước tiểu.

- Có thể kèm theo triệu chứng của các bệnh lây truyền qua đường tình dục khác.

2.1.3. Các lưu ý khi khám lâm sàng

- Sùi mào gà có thể có nhiều tổn thương và ở nhiều vị trí khác nhau nên khi khám phải rất cẩn thận và tỉ mỉ, khám toàn bộ vùng sinh dục, hậu môn.

- Đối với cả hai giới cần kiểm tra cẩn thận sinh dục ngoài bằng nguồn sáng mạnh, sử dụng kính lúp để phát hiện các tổn thương nhỏ.

- Đối với nữ đã quan hệ tình dục đường âm đạo, cần khám bằng mỏ vịt để phát hiện tổn thương sùi trong âm đạo, cổ tử cung. Soi cổ tử cung được chỉ định khi có tổn thương sùi ở cổ tử cung, để phát hiện các tổn thương dạng sẩn dẹt.

- Đối với nam giới, để khám miệng sáo chỉ cần dùng tăm bông mở hai mép miệng sáo ra nhưng muốn khám kỹ hố thuyên cần sử dụng panh nhỏ hoặc soi niệu đạo. Thông thường, niệu đạo không bị tổn thương nếu không thấy có sùi mào gà ở miệng sáo.

- Chỉ định soi hậu môn đối với người có tiền sử quan hệ tình dục qua đường hậu môn hoặc người có sùi mào gà vùng quanh hậu môn tái phát nhiều lần.

- Đối với các trường hợp nghi ngờ, có thể sử dụng test axit axetic 5% bôi vào tổn thương, sau vài phút tổn thương có màu xám trắng. Kết quả của test này không đặc hiệu mà chỉ hỗ trợ cho việc chọn tổn thương khi sinh thiết hoặc loại bỏ tổn thương.

2.1.4. Biến chứng

- Ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần: mệt mỏi, lo lắng, sợ hãi, mất tự tin.

- Tiền ung thư và ung thư: sùi mào gà là những tổn thương lành tính. Tuy nhiên, các tổn thương tiền ung thư hoặc ung thư có thể cùng tồn tại hoặc phát triển cùng các tổn thương sùi mào gà và có thể chẩn đoán nhầm là sùi mào gà. Các dấu

hiệu của tổn thương ác tính gồm có dễ chảy máu, loét, xâm lấn. Trong những trường hợp này, cần sinh thiết để khẳng định chẩn đoán.

- Sản dạng Bowen là một tổn thương tân sản biểu mô ở hậu môn sinh dục, do các tuýp HPV nguy cơ cao gây ra.

- Sùi mào gà khổng lồ (u Buschke-Lowenstein) rất hiếm gặp và được xem là một dạng của ung thư biểu mô tế bào vảy dạng nhú do HPV 6 và 11 gây nên. Bệnh có đặc điểm là xâm lấn xuống dưới trung bì. Tổ chức bệnh học có những vùng tổ chức dạng nhú lành tính xen kẽ với các ổ tế bào thượng bì bất thường hoặc các tế bào biệt hoá ung thư tế bào vảy (SCC). Chẩn đoán u Buschke-Lowenstein cần phải sinh thiết nhiều vị trí, chụp cắt lớp vi tính hoặc cộng hưởng từ.

2.2. Cận lâm sàng

- Mô bệnh học: Cần sinh thiết khi tổn thương không điển hình hoặc nghi ngờ ung thư; tổn thương không đáp ứng hoặc nặng lên sau điều trị. Hình ảnh trên mô bệnh học đặc trưng của sùi mào gà là tăng sinh nhú, tăng sinh sừng; thoái hóa dạng hốc sáng koilocytosis (tế bào không bào nhân lớn, không đều).

- Xét nghiệm HPV PCR: không được khuyến cáo để chẩn đoán xác định, theo dõi hay thay đổi phác đồ điều trị. Xét nghiệm nhằm mục đích xác định tình trạng nhiễm các tuýp HPV nguy cơ cao để theo dõi nguy cơ ung thư.

- Xét nghiệm các bệnh lây truyền qua đường tình dục khác, bao gồm cả HIV.

2.3. Chẩn đoán xác định

Chẩn đoán sùi mào gà chủ yếu dựa vào lâm sàng và tiền sử quan hệ tình dục. Đối với những tổn thương không điển hình (tăng sắc tố, xâm lấn, loét, dễ chảy máu) có thể cần các xét nghiệm cận lâm sàng khác để chẩn đoán.

2.4. Chẩn đoán phân biệt

- Các tổn thương cần phân biệt với u mềm treo, sản ngọc quy đầu, các u tuyến bã (tuyến Tyson), nốt ruồi, u mềm lây, bệnh Crohn, dày sừng da đầu, lichen phẳng, lichen dạng chấm (lichen nitidus), sản sùi giang mai (condylomata lata).

- Các tổn thương cần phân biệt với vẩy nến, viêm da đầu, hội chứng Reiter, bệnh Bowen, hồng sản Queyrat ở qui đầu và ung thư tế bào vảy.

3. ĐIỀU TRỊ

3.1. Mục đích và nguyên tắc điều trị

- Mục đích điều trị là loại bỏ tổn thương, không phải là tiêu diệt vi rút.
- Lựa chọn phương pháp điều trị dựa vào tuổi bệnh nhân, vị trí, số lượng, kích thước tổn thương, chi phí và khả năng chuyên môn cũng như trang thiết bị của cơ sở điều trị (Bảng 1).

- Không có phương pháp nào được coi là vượt trội và phù hợp cho tất cả các bệnh nhân cũng như tất cả các tổn thương. Các phương pháp điều trị không diệt được vi rút HPV. Thời gian đào thải vi rút ra khỏi cơ thể chưa được biết rõ. Tái phát có thể

xảy ra ở tất cả các phương pháp.

- Đa số bệnh nhân điều trị ngoại trú, chỉ điều trị nội trú khi cần theo dõi trước và sau điều trị đối với bệnh nhân có nguy cơ biến chứng, phụ nữ có thai, tổn thương lớn hoặc số lượng nhiều.

Bảng 1. Lựa chọn điều trị theo vị trí tổn thương

Vị trí tổn thương		Lựa chọn điều trị
Sinh dục ngoài, hậu môn		Imiquimod cream 3.75% hoặc 5% ¹
		Podofilox 0.5% dung dịch hoặc gel ¹
		Sinecatechins mỡ 15% ¹
		Liệu pháp lạnh
		Các phương pháp phá hủy, loại bỏ tổn thương ²
		Dung dịch TCA hoặc BCA ³ 80%-90%
Đường sinh dục trong, ống hậu môn	Niệu đạo	Liệu pháp lạnh
		Các phương pháp phá hủy, loại bỏ tổn thương ²
	Âm đạo	Liệu pháp lạnh
		Các phương pháp phá hủy, loại bỏ tổn thương ²
		Dung dịch TCA hoặc BCA ³ 80%-90%
	Cổ tử cung	Liệu pháp lạnh
		Các phương pháp phá hủy, loại bỏ tổn thương ²
		Dung dịch TCA hoặc BCA ³ 80%-90%
	Ống hậu môn	Liệu pháp lạnh
		Các phương pháp phá hủy, loại bỏ tổn thương ²
		Dung dịch TCA hoặc BCA ³ 80%-90%
	Niêm mạc miệng, lưỡi, hầu họng	Liệu pháp lạnh
		Các phương pháp phá hủy, loại bỏ tổn thương ²
		Dung dịch TCA hoặc BCA ³ 80%-90%

¹: Bệnh nhân tự bôi ở nhà

²: Bằng dao, kéo, nạo, laser, đốt điện

³: Trichloroacetic hoặc bichloroacetic

3.2. Các điều trị cụ thể

3.2.1. Thuốc gây độc tế bào: Podophyllotoxin (podofilox)

- Podophyllotoxin có tác dụng làm ngừng phân chia các tế bào bị nhiễm vi rút gây hoại tử mô.

- Có hai chế phẩm: podophyllotoxin 0,5% dạng dung dịch dùng cho sùi mào gà ở dương vật và podophyllotoxin 0,15% dạng kem dùng cho sùi mào gà ở hậu môn, âm hộ.

- Cách sử dụng: bôi ngày 2 lần bằng tăm bông, bôi 3 ngày liên tiếp rồi nghỉ 4 ngày, điều trị một đợt 4-5 tuần. Diện tích bôi không quá 10cm² và bôi dưới 0,5ml podophyllotoxin/ngày.

- Tác dụng không mong muốn: kích ứng và đau rát, trợt tại chỗ.

- Chống chỉ định cho các vết thương hở, phụ nữ có thai.

- Tỷ lệ sạch tổn thương của podophyllotoxin dung dịch là 36-83%, của dạng kem là 43-74%. Tỷ lệ tái phát thay đổi từ 6-100% thường sau 8-12 tuần sạch tổn thương.

- Ngày nay không còn khuyến cáo sử dụng podophyllin dạng nhựa thô do hiệu quả thấp và nhiều độc tính.

3.2.2. Các phương pháp phá hủy tổn thương

3.2.2.1. Liệu pháp lạnh

- Dùng ni tơ lỏng (-196⁰C) gây đóng băng tế bào nhiễm bệnh, gây ra tổn thương không hồi phục màng tế bào.

- Xịt hoặc dùng tăm bông chấm tổn thương cho đến khi xuất hiện quần mô đông lạnh 1mm quanh tổn thương, thời gian quang đông từ 5-20 giây, mỗi lần 1-2 chu kỳ đông lạnh và lặp lại 1-3 lần/tuần tối đa 12 tuần.

- Tác dụng phụ: đau, hoại tử, bong nước, sẹo. Có thể cần gây tê vùng nếu nhiều vị trí hoặc tổn thương rộng.

- Tỷ lệ sạch tổn thương là 44-87%, tái phát 12-42% sau 1-3 tháng và có thể lên đến 59% sau sạch tổn thương 12 tháng. Các nghiên cứu gần đây cho thấy tác dụng của liệu pháp lạnh kém hơn đốt điện tuy nhiên không khác biệt so với TCA, podophyllotoxin và imiquimod.

- Phương pháp này cần trang thiết bị khá đơn giản, rẻ tiền, an toàn cho phụ nữ có thai. Nhược điểm của phương pháp này là người bệnh cần đến cơ sở y tế nhiều lần và các bác sĩ điều trị phải được đào tạo về cách sử dụng liệu pháp này.

3.2.2.2. Các phương pháp vật lý loại bỏ, phá hủy tổn thương

- Bao gồm: laser CO₂, cắt, nạo, đốt điện.

- Chỉ định ưu tiên cho các tổn thương sùi lớn, lan rộng, sùi ở niệu đạo, âm đạo, cổ tử cung và các tổn thương không đáp ứng điều trị khác. Laser CO₂ được lựa chọn nhiều hơn vì duy trì được giải phẫu, kiểm soát được độ sâu và dễ thực hiện hơn so với phẫu thuật cắt bỏ; ít chảy máu hơn và ít gây khó chịu hơn so với đốt điện. Chống chỉ định đốt điện cho người bệnh mang máy tạo nhịp tim, tổn thương ở gần hậu môn.

- Gây tê tại chỗ trước khi tiến hành; trường hợp tổn thương lớn, trong ống hậu môn hoặc ở trẻ em có thể gây mê toàn thân.

- Những phương pháp này có tác dụng loại bỏ hầu hết (89-100%) tổn thương trong một lần, tuy nhiên nguy cơ tái phát từ 19-29%.

- Nhược điểm: có thể để lại sẹo, thay đổi sắc tố, nứt hậu môn, tổn thương cơ thắt hậu môn.

3.2.2.3. *Trichloroacetic (TCA) hoặc bichloroacetic (BCA) 80-90%*

- Chỉ định bôi cho các tổn thương nhỏ, dạng sần; do nhân viên y tế thực hiện.

- Chăm gọn thuốc lên bề mặt tổn thương sùi, để khô xuất hiện sương trắng. Thực hiện 1 lần/tuần trong tối đa 8-10 tuần. Nếu đau nhiều hoặc lượng thuốc bôi nhiều, có thể trung hòa bằng bột Na_2CO_3 , bột talc hoặc rửa bằng xà phòng. Cần phải cẩn thận khi bôi để tránh tổn hại vùng da, niêm mạc bằng cách dùng bicarbonate hay vaselin bôi xung quanh tổn thương.

- Có thể dùng cho phụ nữ có thai do không ảnh hưởng đến thai và không hấp thu toàn thân.

- Các báo cáo cho thấy tỉ lệ sạch tổn thương là 56-94%, tỉ lệ tái phát là 36%.

- Nhược điểm: có thể gây bỏng, phá hủy mô xung quanh, để lại sẹo.

3.2.3. Các thuốc điều hòa miễn dịch

3.2.3.1. *Imiquimod*

- Đây là một thuốc bôi tại chỗ kích thích hệ miễn dịch thông qua tăng sản xuất interferon và các cytokin.

- Có hai chế phẩm chủ yếu: imiquimod 5% cream: bôi 3 lần/tuần đến khi sạch tổn thương trong tối đa 16 tuần và imiquimod 3,75% cream: bôi hàng ngày trong tối đa 8 tuần.

- Sau khi bôi 6-10 giờ phải rửa bằng nước và xà phòng nhẹ. Hướng dẫn người bệnh xác định đúng tổn thương và bôi đúng cách trong lần đầu và yêu cầu khám định kỳ để theo dõi và đánh giá hiệu quả điều trị.

- Tác dụng phụ: đỏ, kích ứng, loét, trợt, mụn nước.

- Tỉ lệ sạch tổn thương từ 35-75%, cao hơn ở phụ nữ. Tỉ lệ tái phát thấp từ 6-26%. Imiquimod không gây quái thai ở chuột và thỏ. Không có dữ liệu về sự an toàn đối với phụ nữ có thai và trẻ em dưới 12 tuổi.

3.2.3.2. *Sinecatechin*

- Chiết xuất từ trà xanh với chất có hoạt tính chủ yếu là catechin với cơ chế là chống tăng sinh, điều hòa gen liên quan đến phản ứng viêm do nhiễm HPV.

- Mỡ sinecatechin 15% bôi 3 lần/ngày cho đến khi sạch tổn thương nhưng không nên dùng kéo dài trên 16 tuần. Không cần rửa sau khi dùng.

- Tác dụng phụ: đỏ, ngứa, nóng rát, đau, xuất hiện mụn nước, loét, trợt.
- Không nên dùng cho người nhiễm HIV hoặc các tình trạng suy giảm miễn dịch cũng như phụ nữ có thai.
- Tỷ lệ sạch tổn thương là 47 - 59% và tỷ lệ tái phát tương đối thấp (7-11%).

3.2.3.3. Interferon

- Interferon bôi/tiêm nội tổn thương: interferon là một nhóm các protein tự nhiên được sản xuất bởi các tế bào hệ miễn dịch ở người và động vật nhằm chống lại các tác nhân ngoại lai.
- Dữ liệu về điều trị sùi mào gà bằng interferon còn hạn chế tuy nhiên một số cho thấy kết quả khả quan.
- Khuyến cáo xem xét dùng interferon trong các trường hợp kháng trị.

3.2.4 Kết hợp các phương pháp

Kết hợp một thuốc bôi và một phương pháp phá hủy tổn thương (ví dụ: podophyllotoxin và liệu pháp lạnh) có thể dùng trên lâm sàng, tuy nhiên cho đến thời điểm này, còn thiếu dữ kiện lâm sàng về hiệu quả sạch tổn thương và tỷ lệ tái phát.

3.3. Đối tượng đặc biệt

3.3.1. Phụ nữ có thai

- Các phương pháp điều trị ưu tiên ở phụ nữ có thai là: liệu pháp lạnh, TCA và các phương pháp cắt bỏ tổn thương. Chống chỉ định với podophyllotoxin, podophyllin. Sinecatechine, imiquimod có nguy cơ thấp nhưng nên tránh do chưa đủ bằng chứng.
- Không có khuyến cáo về đẻ mổ ở phụ nữ mang thai mắc sùi mào gà. Chỉ định đẻ mổ khi sùi mào gà làm cản trở đường ra của thai hoặc nguy cơ chảy máu cao. Tổn thương có thể thoái triển sau sinh. Nhiều tác giả khuyến cáo nên trì hoãn điều trị trong thời kỳ mang thai.
- U nhú đường hô hấp là một biến chứng hiếm gặp, ở 4/100.000 trẻ sinh ra sống. Không có bằng chứng chứng minh việc điều trị ở mẹ sẽ làm giảm nguy cơ này.

3.3.2. Bệnh nhân nhiễm HIV và các đối tượng suy giảm miễn dịch khác

Điều trị như thông thường tuy nhiên đáp ứng với điều trị thường kém hơn và có nguy cơ tiến triển thành ung thư biểu mô vảy cao hơn.

3.4. Theo dõi và quản lý

- Hầu hết tổn thương đáp ứng trong 3 tháng điều trị. Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả gồm có: tình trạng suy giảm miễn dịch và biến chứng điều trị. Tùy theo điều kiện của từng địa phương, có thể đánh giá lại bệnh nhân mỗi 2-4 tuần về hiệu quả, tác dụng phụ, biến chứng của điều trị.
- Bệnh nhân mắc sùi mào gà có thể nhiễm HPV mặc dù không nhìn thấy tổn thương, do vậy xét nghiệm PCR HPV là không cần thiết đối với bệnh nhân. Cần khám lâm sàng để phát hiện sớm tổn thương sùi mào gà và các bệnh lây

truyền qua đường tình dục khác. Thời gian tồn tại vi rút sau khi hết tổn thương chưa được biết rõ nên không có khuyến cáo rõ ràng về thời gian kiêng quan hệ tình dục. Trên thực hành lâm sàng, thường khuyến cáo bệnh nhân hạn chế quan hệ tình dục khi đang có tổn thương và trong thời gian điều trị.

4. PHÒNG BỆNH

- Biện pháp phòng ngừa hữu hiệu nhất hiện nay vẫn là sử dụng bao cao su đúng cách, tuy nhiên chỉ có tác dụng một phần.

- Nếu người bệnh được điều trị bằng đốt điện thì nên sử dụng kim đốt dùng một lần nhằm hạn chế lan truyền sùi mào gà và các bệnh do vi rút khác như HIV.

- Tiêm vắc xin phòng nhiễm HPV. Hiện nay có 3 loại vắc xin HPV đã được FDA chấp thuận: vắc xin nhị giá (Cervarix phòng được HPV type 16 và 18), vaccin tứ giá (Gadasil phòng được HPV type 6, 11, 16, 18) và vắc xin 9 giá (Gardasil 9 phòng được HPV type 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58). Trong đó vắc xin Gadasil và Gardasil 9 có thể phòng HPV type 6 và 11. Cả 3 loại vắc xin đều được tiêm bắp 3 mũi vào tháng 0, tháng 1-2 và tháng 6.

+ Đối với nữ, tuổi tiêm được khuyến cáo là 11-12 tuổi, có thể bắt đầu từ 9 tuổi, và có thể tiêm cho những người từ 13-26 tuổi mà chưa tiêm trước đó.

+ Đối với nam, vắc xin tứ giá hoặc 9 giá được khuyến cáo tiêm thường quy trong độ tuổi từ 11-12 tuổi, có thể tiêm từ 9 tuổi và từ 13-21 tuổi chưa được tiêm trước đó.

+ Đối với người suy giảm miễn dịch và quan hệ đồng giới, vắc xin được khuyến cáo tiêm ngay cả trên 26 tuổi. Không dùng cho phụ nữ mang thai.

UNG THƯ BIỂU MÔ TẾ BÀO ĐÁY

(Basal cell carcinoma - BCC)

1. ĐẠI CƯƠNG

1.1. Khái niệm

Ung thư biểu mô tế bào đáy là loại ung thư da không hắc tố thường gặp nhất, chiếm khoảng 75% trong các loại ung thư da. Bệnh thường gặp ở người trên 50 tuổi. Nguồn gốc thực sự của ung thư biểu mô tế bào đáy còn chưa rõ ràng.

1.2. Dịch tễ

Trên thế giới, ung thư biểu mô tế bào đáy gặp nhiều nhất là ở Úc (trên 1.000/100.000 dân/năm), người châu Âu và châu Á thấp hơn, thấp nhất là các nước châu Phi (dưới 1/100.000 dân/năm).

1.3. Căn nguyên/ Cơ chế bệnh sinh

- Tia cực tím được cho là nguyên nhân chủ yếu gây ung thư biểu mô tế bào đáy. Chùm tia cực tím có thể tác động trực tiếp hay gián tiếp lên quá trình phân bào.
- Gen p53 mã hóa cho protein p53 có tác dụng ức chế sự phát triển của các tế bào u. Người có gen p53 không hoạt động, khả năng bị ung thư da sẽ cao hơn.
- Gen BRAF thuộc họ raf/mil có vai trò điều hòa sự dẫn truyền thông tin trong tế bào theo hệ thống MAP kinase/ERKs trong quá trình phân chia và biệt hóa tế bào.
- Gen "patched" nằm trên nhiễm sắc thể 9, có tác dụng trực tiếp làm tăng cường quá trình chết theo chương trình (apoptosis) của các tế bào u.

2. CHẨN ĐOÁN

2.1. Triệu chứng lâm sàng

- Ung thư biểu mô tế bào đáy thường gặp ở người lớn tuổi, vị trí thường gặp là ở vùng mặt, nơi tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời, tiến triển chậm, tổn thương có thể lan rộng, xâm lấn tổ chức xung quanh gây biến dạng và làm rối loạn chức năng của một số cơ quan bộ phận như mũi, miệng và mắt. Nếu được phát hiện sớm và điều trị kịp thời, cắt bỏ tổn thương, tiên lượng bệnh rất tốt.
- Ung thư biểu mô tế bào đáy có nhiều thể lâm sàng. Các triệu chứng lâm sàng thay đổi tùy thuộc vào thể lâm sàng:
 - + Thể u: thường gặp ở vùng đầu, cổ và nửa trên thân mình. Tổn thương ban đầu là khối u nhỏ, mật độ chắc, trên có giãn mạch, không ngứa, không đau, tiến triển chậm, tăng dần về kích thước, lan ra xung quanh, thâm nhiễm, xâm lấn đến các tổ chức dưới da. Tổn thương có thể loét, dễ chảy máu, đóng vảy tiết đen, bờ nổi cao với các sẩn bóng, chắc được gọi là "hạt ngọc ung thư".
 - + Thể nông: thường gặp ở vùng thân và ít có xu hướng xâm lấn. Tổn thương là những dát, sẩn màu hồng hoặc đỏ nâu, có vảy da, trung tâm tổn thương thường lành, bờ nổi cao giống như sợi chỉ.
 - + Thể xơ: thường gặp ở vùng mũi hoặc trán. Tổn thương bằng phẳng với mặt da, đôi khi lõm nhẹ, thâm nhiễm, trên có các mạch máu giãn, giới hạn không rõ ràng với da lành.

- + Thẻ hỗn hợp: Ung thư biểu mô tế bào vảy – đáy (BSCC)
- + Thẻ tăng sắc tố.
- Ung thư biểu mô tế bào đáy nhiều tổn thương:
 - + Hội chứng Gorlin là hội chứng thường gặp nhất, biểu hiện nhiều tổn thương BCC, kèm theo nang xương hàm dưới, dày sừng điểm lòng bàn tay, bàn chân...
 - + Những bệnh nhân bị bệnh khô da sắc tố, hội chứng Muir-Torre có nguy cơ cao xuất hiện nhiều tổn thương BCC và các loại ung thư da khác.

2.2. Cận lâm sàng

2.2.1. Dermoscopy

Có thể thấy các hình ảnh: giãn mạch hình cành cây, tăng sắc tố dạng ổ, cấu trúc giống nan hoa bánh xe, vùng giống hình lá, chất nền hồng sữa, loét. Tuy nhiên, dermoscopy chỉ có vai trò định hướng, không dùng để chẩn đoán xác định.

2.2.2. Xét nghiệm mô bệnh học

- Mô bệnh học là tiêu chuẩn vàng, có vai trò quyết định chẩn đoán BCC.
- Trên tiêu bản mô bệnh học là các tế bào ác tính: bào tương kiềm, nhân quái, nhân chia, tập trung thành đám, bao quanh bởi tổ chức xơ, phá vỡ cấu trúc của thượng bì và màng đáy; đôi khi có loét.
- Mô bệnh học còn xác định thể bệnh; mức độ biệt hóa, xâm lấn và nguy cơ

2.2.3. Hóa mô miễn dịch

- Vai trò: xác định nguồn gốc tế bào.
 - BerEP4 dương tính có giá trị cao trong chẩn đoán (độ nhạy và đặc hiệu cao).
- Ngoài ra, các marker EMA, p63... âm tính, giúp phân biệt với SCC; S100, HMB-45 âm tính... giúp phân biệt với các ung thư tế bào hắc tố.

2.2.4. Các xét nghiệm phát hiện di căn

Trong một số trường hợp cần thiết, các xét nghiệm: X-quang, CT-scan, MRI, PET-CT... có thể phát hiện di căn.

2.3. Chẩn đoán xác định

Dựa vào:

- Triệu chứng lâm sàng
- Xét nghiệm mô bệnh học nhuộm HE
- Hóa mô miễn dịch: trong 1 số trường hợp để xác định nguồn gốc tế bào

2.4. Chẩn đoán thể lâm sàng

- Ung thư biểu mô tế bào đáy thể u
- Ung thư biểu mô tế bào đáy thể nông
- Ung thư biểu mô tế bào đáy thể xơ
- Ung thư biểu mô tế bào đáy thể hỗn hợp
- Ung thư biểu mô tế bào đáy thể tăng sắc tố

2.5. Chẩn đoán phân biệt

- Lupus lao
- Lupus ban đỏ kinh điển
- Ung thư tế bào hắc tố
- Bệnh Paget ngoài vú

2.5. Chẩn đoán giai đoạn bệnh

Chẩn đoán TNM theo AJCC (American Joint Committee on Cancer):

T (Tumour - khối u): Xâm lấn tại chỗ (pT tương tự cT)	
Tx	Khối u nguyên phát không đánh giá được
T0	Không có bằng chứng của khối u nguyên phát
Tis	Ung thư biểu mô tại chỗ
T1	Khối u có kích thước $\leq 20\text{mm}$
T2	Khối u có kích thước > 20 đến $\leq 40\text{mm}$
T3	Khối u có kích thước $> 40\text{mm}$, hoặc T1/T2 nguy cơ cao: xâm lấn quanh thần kinh, xâm lấn sâu (độ dày $> 6\text{mm}$ hoặc đến lớp hạ bì)
T4	Xâm lấn xương, sụn
N (Node - hạch)	
pNx	Không đánh giá được xâm lấn hạch vùng
pN0	Không phát hiện di căn hạch vùng
Đối với thân mình (Hạch đối bên được coi là di căn xa)	
pN1	Di căn 1 hạch vùng cùng bên $\leq 30\text{mm}$
pN2	Di căn 1 hạch vùng cùng bên > 30 đến $\leq 60\text{mm}$, hoặc nhiều hạch $\leq 60\text{mm}$
pN3	Di căn 1 hạch $> 60\text{mm}$
Đối với vùng đầu cổ (trừ vị trí môi)	
pN1	Di căn 1 hạch cùng bên $\leq 30\text{mm}$, không xâm lấn ngoài hạch
pN2a	Di căn 1 hạch cùng bên > 30 đến $\leq 60\text{mm}$, không xâm lấn ngoài hạch
pN2b	Di căn nhiều hạch cùng bên $\leq 60\text{mm}$, không xâm lấn ngoài hạch
pN2c	Di căn hạch đối bên hoặc hai bên $\leq 60\text{mm}$, không xâm lấn ngoài hạch
pN3a	Di căn 1 hạch $> 60\text{mm}$, không xâm lấn ngoài hạch
pN3b	Di căn 1 hạch kích thước bất kỳ, xâm lấn ngoài hạch
Di căn xa	
M0	Không có di căn xa
M1	Phát hiện di căn xa

Chẩn đoán giai đoạn

- Giai đoạn 0: T0N0M0
- Giai đoạn I: T1N0M0
- Giai đoạn II: T bất kỳ, N1-3, M0
- Giai đoạn III: T bất kỳ, N bất kỳ, M1

2.6. Chẩn đoán mức độ nguy cơ

Đặc điểm	Nguy cơ thấp	Nguy cơ cao
Lâm sàng		
- Vị trí/Kích thước	Vùng L: < 20mm Vùng M: < 10mm	Vùng L: > 20mm Vùng M: > 10mm Vùng H: kích thước bất kì
- Ranh giới	Bờ rõ	Bờ không rõ
- Tái phát	U nguyên phát	U tái phát
- Yếu tố ức chế miễn dịch	Không	Có
- Vùng da bị xạ trị	Không	Có
Mô bệnh học		
Thể bệnh	Thể u, thể nông	Thể xơ, thể BSCC
Xâm lấn quanh thần kinh	Không	Có
- Vùng L: thân mình, chi thể (trừ sinh dục, bàn tay, bàn chân). - Vùng M: má, trán, da đầu, cổ, mặt trước xương chày. - Vùng H: mặt (trừ má, trán), sinh dục, bàn tay, bàn chân.		

3. ĐIỀU TRỊ

3.1. Nguyên tắc điều trị

- Loại bỏ triệt để tổ chức ung thư.
- Điều trị phủ tổn khuyết, đảm bảo chức năng và thẩm mỹ
- Các phương pháp điều trị khác

3.2. Điều trị cụ thể

3.2.1. Loại bỏ tổ chức ung thư

- Phẫu thuật cắt rộng tiêu chuẩn:
 - + Chỉ định cho BCC nguy cơ thấp. BCC nguy cơ cao, chỉ định cho trường hợp đặc biệt hoặc không có điều kiện phẫu thuật Mohs.
 - + Cách thức: cắt bỏ khối u cách bờ tổn thương ít nhất 4mm.
- Phẫu thuật Mohs: Khuyến cáo mức độ cao với BCC nguy cơ cao. BCC nguy cơ thấp, chỉ định trong những trường hợp cần tiết kiệm da hoặc nếu có điều kiện.
- Nạo và đốt điện: Chỉ định cho bệnh nhân lớn tuổi, thể trạng kém, mắc bệnh mạn tính không có chỉ định phẫu thuật hoặc tổn thương nhỏ, giới hạn rõ.
- Áp lạnh: Phương pháp này chủ yếu áp dụng cho thể nông. Có thể kết hợp nạo bỏ tổn thương và áp lạnh để cho kết quả tốt hơn.
- Laser CO2: Áp dụng cho bệnh nhân không có chỉ định phẫu thuật, hoặc ung thư biểu mô tế bào đáy thể nông.

3.2.2. Che phủ tổn khuyết

Phẫu thuật che phủ tổn khuyết sau cắt bỏ tổn thương theo bậc thang tạo hình, đảm bảo chức năng và thẩm mỹ.

3.2.3. Các biện pháp điều trị khác

- Quang động lực (PDT): áp dụng cho trường hợp nhiều tổn thương như hội chứng Gorlin... Phương pháp này sử dụng 5-méthylaminolévunilate (MAL) kết hợp

với chiếu laser màu 635nm.

- Xạ trị: Áp dụng cho những bệnh nhân không có chỉ định phẫu thuật hoặc có tình trạng da không thể phẫu thuật, hoặc tổn thương không cắt bỏ được hoàn toàn, ung thư thâm nhiễm thần kinh trên mô bệnh học.

- + Tia xạ chiếu ngoài: Sử dụng tia X hoặc tia Gamma (télécobalt. Liều chiếu không quá 2 Gy/lần. Số lần chiếu 10-30 lần/3-6 tuần. Tổng liều không quá 60Gy. Chiếu cách bờ tổn thương 1-1,5cm.

- + Tia xạ bên trong: Cấy vào khối u sợi Iridium 192.

- Thuốc bôi tại chỗ: chỉ định cho thể nông, nhiều tổn thương, người già yếu không có khả năng phẫu thuật. Kết quả điều trị có thể đạt hiệu quả 60-100%.

- + Fluouracin (5FU) 5%: bôi 1-2 lần/ngày trong thời gian 3-4 tuần.

- + Imiquimod 5%: bôi mỗi ngày một lần, mỗi tuần 3 ngày, tối đa là 16 tuần.

3.3. Theo dõi sau điều trị

- Mục đích: phát hiện tái phát, tổn thương ung thư da mới (BCC, SCC, MM)

- Thời gian theo dõi:

- + 2 năm đầu tái khám 6-12 tháng/lần.

- + Sau đó tái khám hàng năm.

4. PHÒNG BỆNH

- Tránh ánh nắng mặt trời: mặc quần áo dài tay, mang mũ rộng vành, sử dụng các sản phẩm chống nắng đúng quy cách.

- Một số thuốc uống: retinoid, selenium, beta-carotene, celecoxib, alpha-difluoromethylornithine (DFMO), nicotinamid... được chỉ định phòng bệnh cho các đối tượng nguy cơ cao: loạn sản thượng bì, bệnh da do ánh sáng, khô da sắc tố, sử dụng thuốc ức chế miễn dịch, ghép tạng...

UNG THƯ BIỂU MÔ TẾ BÀO VỎY (Squamous cell carcinoma - SCC)

1. Đại cương

1.1. Khái niệm

Ung thư biểu mô tế bào vảy (squamous cell carcinoma - SCC) là ung thư không hắc tố chiếm khoảng 20% các ung thư da và đứng hàng thứ hai sau ung thư biểu mô tế bào đáy. Khác với ung thư biểu mô tế bào đáy, ung thư biểu mô tế bào vảy nguy hiểm hơn vì nguy cơ xâm lấn, tái phát và di căn xa.

1.2. Dịch tễ học

Trên thế giới, ung thư biểu mô tế bào vảy hay gặp ở những người da trắng với tỷ lệ mắc mới ở Mỹ khoảng hơn 100/100.000 dân, ở Úc là 250/100.000 dân. SCC ít gặp hơn ở những người có da type IV-V theo phân loại của Fitzpatrick.

1.3. Căn nguyên/ Cơ chế bệnh sinh

- Yếu tố môi trường:
 - + Ánh nắng mặt trời, bức xạ ion hoá.
 - + Chất hoá học: thuốc trừ sâu, nhựa đường, hydrocarbon vòng, thơm, arsen.
 - + Nhiễm HPV: liên quan đến SCC da với nhiều type như 8, 36 và 38...
- Suy giảm miễn dịch: ung thư, sử dụng thuốc ức chế miễn dịch, HIV/AIDS.
- Khô da sắc tố, loạn sản thượng bì dạng hạt cơm, ly thượng bì bong nước...
- Yếu tố nguy cơ khác: loét mạn tính, sẹo bỏng, hút thuốc lá (SCC ở môi).

2. CHẨN ĐOÁN

2.1. Triệu chứng lâm sàng

Biểu hiện thay đổi tùy thuộc vào từng thể lâm sàng

2.1.1. Tổn thương tiền ung thư

- Dày sừng ánh sáng: Tổn thương ban đầu là chấm nhỏ, gồ ghề như giấy nhám. Tăng dần kích thước, đỏ da, bong vảy, ở vùng tiếp xúc với ánh sáng.
- Bạch sản miệng: tổn thương là một mảng màu trắng bám chắc ở niêm mạc miệng, lưỡi, ranh giới thường rõ, không có triệu chứng cơ năng.
- Hồng sản Queyrat: tổn thương là mảng đỏ giới hạn rõ, bề mặt ướt, khu trú ở niêm mạc sinh dục nam, không ngứa, không đau, tiến triển chậm.

2.1.2. Ung thư biểu mô tế bào vảy tại chỗ (in-situ)

Bệnh Bowen: Tổn thương là mảng da màu hồng hoặc đỏ, trên có vảy, giới hạn rõ với da lành. Vị trí ở vùng da tiếp xúc với ánh nắng. Cần xét nghiệm mô bệnh học để xác định chẩn đoán.

2.1.3. Ung thư biểu mô tế bào vảy xâm nhập (invasive)

- Tổn thương cơ bản: dạng sẩn hoặc mảng, dày sừng bong vảy ở các mức độ khác nhau, có thể loét, sùi, trợt, đóng vảy tiết. Tiến triển tự nhiên của khối u thay đổi khác nhau. Tổn thương do ánh sáng thường ở giai đoạn sớm, tỷ lệ di căn thấp (0,5%), những tổn thương có kích thước > 2cm và ở các vị trí như môi, tai, sinh dục (âm hộ,

ương vật) có nguy cơ di căn cao hơn. Hạch vùng lân cận tổn thương có thể to do viêm phản ứng hoặc là hạch di căn (to, dính, mật độ không đều)

- Một số thể đặc biệt của ung thư biểu mô tế bào vảy:
 - + SCC quanh miệng: thường gặp ở môi dưới, tổn thương là mảng cứng thâm nhiễm, màu hồng, loét, dễ chảy máu, xâm lấn tổ chức xung quanh, dễ di căn xa.
 - + SCC quanh móng: dễ nhầm với hạt cơm, chẩn đoán dựa vào sinh thiết, thường liên quan đến HPV tuýp 16
 - + U quá sần sừng (Keratoacanthoma): tổn thương là u màu đỏ, nổi cao, bóng, trung tâm có tổ chức sừng như miệng núi lửa, xuất hiện và tiến triển nhanh.
- Một số thể SCC nguy cơ di căn thấp:
 - + Ung thư biểu mô tế bào vảy thể sùi (verrucous carcinoma): tổn thương khối sùi lớn, bề mặt nhiều thùy, mủi.
 - + Ung thư biểu mô tế bào vảy – đáy (BSCC): biểu hiện mô bệnh học cả ung thư biểu mô tế bào vảy, xu hướng xâm lấn và di căn cao hơn BCC.

2.2. Cận lâm sàng

- Mô bệnh học:
 - + Ung thư biểu mô tế bào vảy tại chỗ: dày sừng, loạn sản toàn bộ chiều dày của thượng bì và không có sự xâm nhập vào lớp trung bì. Các tế bào sừng với nhân bất màu đậm kiềm tính, có nhân chia.
 - + Ung thư biểu mô tế bào vảy xâm nhập: thượng bì biến đổi như trong SCC tại chỗ và có sự xâm nhập của tế bào ung thư đến lớp trung bì hoặc lớp sâu hơn. Mức độ xâm lấn của khối u được tính bằng chỉ số Breslow hoặc phân độ Clack.
 - + Đánh giá các đặc điểm nguy cơ cao: các thể ung thư nguy cơ cao, mức độ biệt hoá, độ dày của khối u (Breslow hoặc Clark), hiện tượng xâm lấn mạch máu và quanh thần kinh.
- Hóa mô miễn dịch xác định nguồn gốc tế bào vảy
 - + Kháng định chẩn đoán: AE1/AE3 (+), EMA (+), p63(+)
 - + Phân biệt với tế bào đáy: BerEp4 (-)
 - + Phân biệt với tế bào hắc tố: S100 (-), HMB45 (-)
- Xét nghiệm xác định tình trạng di căn:
 - + Siêu âm hạch tại chỗ, chọc hạch dưới hướng dẫn siêu âm
 - + Xác định di căn xa: chụp PET-CT là phương pháp tổng quát nhất. Có thể sàng lọc bằng chụp Scan CT, MRI sọ não, lồng ngực, bụng, siêu âm ổ bụng...

2.3. Chẩn đoán xác định

Dựa trên:

- Lâm sàng
- Mô bệnh học.
- Hóa mô miễn dịch: trong 1 số trường hợp để xác định nguồn gốc tế bào

2.4. Chẩn đoán thể

- Ung thư biểu mô tế bào vảy tại chỗ
- Ung thư biểu mô tế bào vảy xâm nhập

2.5. Chẩn đoán phân biệt

- Lao da
- Nấm sâu (Chromoblastomycosis)
- Ung thư tế bào đáy
- Mycosis fungoides
- Ung thư tế bào hắc tố

2.6. Chẩn đoán giai đoạn

- Chẩn đoán TNM (T: Tumour - khối u, N: Node - Hạch, M: metastases - di căn) theo UICC (Union for International Cancer Control) lần thứ 8 năm 2017.

Xâm lấn tại chỗ (pT tương tự cT)	
Tx	Khối u nguyên phát không đánh giá được
T0	Không có bằng chứng của khối u nguyên phát
Tis	Ung thư biểu mô tại chỗ
T1	Khối u có kích thước $\leq 20\text{mm}$
T2	Khối u có kích thước $> 20 - \leq 40\text{mm}$
T3	Khối u có kích thước $> 40\text{mm}$, hoặc T1/T2 xâm lấn quanh thần kinh, xâm lấn sâu ($> 6\text{mm}$ hoặc đến hạ bì)
T4	Xâm lấn xương, sụn
Xâm lấn hạch vùng (pN)	
pNx	Không đánh giá được xâm lấn hạch vùng
pN0	Không phát hiện di căn hạch vùng
Đối với thân mình (Hạch đối bên được coi là di căn xa)	
pN1	Di căn hạch vùng cùng bên, 1 hạch $\leq 30\text{mm}$
pN2	Di căn hạch vùng cùng bên, 1 hạch $> 30 - 60\text{mm}$, nhiều hạch $\leq 60\text{mm}$
pN3	Di căn 1 hạch $> 60\text{mm}$
Đối với vùng đầu cổ (trừ vị trí môi)	
pN1	Di căn 1 hạch cùng bên $\leq 30\text{mm}$, không xâm lấn ngoài hạch
pN2a	Di căn 1 hạch cùng bên $> 30 - 60\text{mm}$, không xâm lấn ngoài hạch
pN2b	Di căn nhiều hạch cùng bên $\leq 60\text{mm}$, không xâm lấn ngoài hạch
pN2c	Di căn hạch đối bên hoặc hai bên $\leq 60\text{mm}$, không xâm lấn ngoài hạch
pN3a	Di căn 1 hạch $> 60\text{mm}$, không xâm lấn ngoài hạch
pN3b	Di căn 1 hạch kích thước bất kỳ, xâm lấn ngoài hạch
Di căn xa	
M0	Không có di căn xa
M1/pM1	Phát hiện di căn xa

Chẩn đoán giai đoạn

Giai đoạn 0	Tis	N0	M0
Giai đoạn I	T1	N0	M0
Giai đoạn II	T2	N0	M0
Giai đoạn III	T3	N0	M0
	T1, T2, T3	N1	M0
Giai đoạn IVA	T1, T2, T3	N2, N3	M0
	T4	N bất kỳ	M0
Giai đoạn IVB	T bất kỳ	N bất kỳ	M1

2.6. Chẩn đoán mức độ nguy cơ của SCC:

	Nguy cơ thấp	Nguy cơ cao
Lâm sàng		
Vị trí/kích thước	Vùng M < 10mm Vùng L < 20mm	Vùng H Vùng M ≥ 10mm Vùng L ≥ 20mm
Giới hạn bờ tổn thương	Rõ ràng	Không rõ
Tiên phát/tái phát	Tiên phát	Tái phát
Suy giảm miễn dịch	Không	Có
Nền chiếu xạ hoặc viêm mạn tính	Không	Có
Tiến triển nhanh	Không	Có
Triệu chứng thần kinh	Không	Có
Mô bệnh học		
Mức độ biệt hoá	Tốt đến trung bình	Kém
Các thể mô bệnh học nguy cơ cao	Không	Có
Phân độ Clark hoặc Chỉ số Breslow	I, II, III hoặc < 4mm	IV, V hoặc ≥ 4mm
Xâm lấn mạch máu hoặc quanh thần kinh	Không	Có
- Vùng nguy cơ: + Vùng H gồm: mặt (trung tâm khuôn mặt, mí mắt, lông mày, da quanh hốc mắt, mũi, môi, cằm, hàm dưới, da/lỗ rãnh tai và da sau tai, thái dương, tai) cơ quan sinh dục, bàn tay và bàn chân. + Vùng M gồm: mặt (má, trán, da đầu, cổ), xương chày, mắt cá chân + Vùng L gồm: thân và tứ chi (phần còn lại) - Các thể mô bệnh học nguy cơ cao: + Thể ly gai + Thể tuyến + Thể xơ (carcinosarcomatous) - Chỉ số Clark đánh giá mức độ xâm lấn của khối u: + Mức I: Xâm lấn ở thượng bì hay ung thư tại chỗ. + Mức II: Xâm lấn trung bì nông, chỉ có một vài tế bào ở nhú bì. + Mức III: Xâm lấn toàn bộ nhú bì. + Mức IV: Xâm lấn trung bì sâu.		

3. ĐIỀU TRỊ

3.1. Nguyên tắc điều trị

- Phẫu thuật loại bỏ triệt để tổ chức ung thư
- Kiểm soát hạch và di căn
- Điều trị che phủ tổn khuyết.
- Kết hợp phẫu thuật với các phương pháp khác trong trường hợp cần thiết.

3.2. Điều trị cụ thể

3.2.1. Loại bỏ tổ chức ung thư

- Phẫu thuật cắt rộng tiêu chuẩn:
 - + Chỉ định: SCC nguy cơ thấp, SCC nguy cơ cao không thể thực hiện phẫu thuật Mohs
 - + Cách thức: cắt cách bờ tổn thương 4 - 6 mm, độ sâu đến hạ bì (nên kết hợp với kiểm soát tế bào ung thư bằng mô bệnh học).
- Phẫu thuật Mohs:
 - + Chỉ định: SCC nguy cơ cao, SCC nguy cơ thấp cần tiết kiệm da lành
 - + Cách thức: Kiểm soát hoàn toàn bờ và đáy của tổn thương bằng mô bệnh học.
- Nạo và đốt điện: chỉ định cho các khối u nhỏ, nguy cơ thấp (không chỉ định ở vùng đầu cực có lông tóc: da đầu, nách, vùng mu, vùng mọc râu ở nam).
- Áp Nitơ lỏng: chỉ định cho khối u có nguy cơ thấp, không điều trị được bằng các phương pháp khác

3.2.2. Kiểm soát hạch và di căn

- Sinh thiết hạch gác: ít có giá trị với điều trị và quản lý bệnh
- SCC nguy cơ cao, khám thấy hạch vùng trên lâm sàng: vét hạch toàn bộ
- SCC di căn hạch
 - + Nạo vét hạch toàn bộ và xạ trị bổ trợ
 - + Không nạo vét hạch được: hóa xạ trị

3.2.3. Che phủ tổn khuyết

Phẫu thuật che phủ tổn khuyết sau cắt bỏ tổn thương theo bậc thang tạo hình, đảm bảo chức năng và thẩm mỹ.

3.2.4. Các phương pháp điều trị khác

- Xạ trị: Chỉ định cho khối u nguy cơ thấp nhưng không thể thực hiện phẫu thuật hoặc sau khi cắt bỏ tổn thương mà vẫn còn tế bào ung thư tại bờ tổn thương và không tiếp tục thực hiện phẫu thuật được; hoặc SCC nguyên phát xâm lấn quanh thần kinh hoặc có nguy cơ cao di căn xa, di căn vùng sau điều trị phẫu thuật.
- Hóa trị gồm cisplatin đơn trị hoặc kết hợp 5-fluorouracil (5-FU) được khuyến cáo, tuy nhiên các thử nghiệm lâm sàng có cỡ mẫu không đủ lớn. Cetuximab, gần đây có thêm panitumumab, cho thấy hiệu quả ở bệnh nhân ung thư giai đoạn tiến triển không cắt bỏ được. FDA gần đây đã chấp thuận pembrolizumab cho các bệnh nhân ung thư tế bào vảy tiến triển ở đầu và cổ.

3.3. Theo dõi, quản lý bệnh

3.3.1. Theo dõi

- SCC nguy cơ thấp: tái khám 1 lần duy nhất và tự theo dõi trong 5 năm sau khi được giải thích về nguy cơ tái phát và xuất hiện tổn thương ung thư da mới.
- SCC nguy cơ cao tái khám mỗi 4 tháng trong năm đầu, mỗi 6 tháng trong năm thứ 2. Sau đó, tự theo dõi như đối với SCC nguy cơ thấp.

3.3.2. Quản lý

- Tầm soát tái phát SCC, sự xuất hiện ung thư da khác như BCC và MM
- Đánh giá hạch được khuyến cáo cho những tổn thương nguy cơ cao.
- Bệnh nhân có tiền sử SCC nên được tư vấn để tự kiểm tra da, chống nắng.

4. THEO DÕI, QUẢN LÝ VÀ PHÒNG BỆNH

- Điều trị tích cực các tổn thương da mạn tính như loét mạn tính, viêm da do quang tuyến, lao da.
- Tránh ánh sáng mặt trời: mặc quần áo dài tay, mang mũ rộng vành, sử dụng sản phẩm chống nắng đúng quy cách, đặc biệt là đối với trẻ em.
- Chẩn đoán và điều trị sớm tổn thương tiền ung thư.

UNG THƯ TẾ BÀO HẮC TỔ (Malignant melanoma)

1. ĐẠI CƯƠNG

1.1. Khái niệm

Ung thư tế bào hắc tố (malignant melanoma - MM) là một trong những loại ung thư ác tính nhất trong các loại ung thư da, tỉ lệ tử vong cao nếu phát hiện và điều trị muộn.

1.2. Dịch tễ

Ung thư tế bào hắc tố chiếm khoảng 5% các ung thư da và khoảng 1% các loại ung thư nói chung. Bệnh gặp ở mọi chủng tộc, thường gặp ở người da trắng, người lớn tuổi. Tỉ lệ mắc bệnh ở cả hai giới là tương đương nhau.

1.3. Căn nguyên/ Cơ chế bệnh sinh

- Ánh nắng mặt trời là tác nhân chủ yếu gây ung thư tế bào hắc tố.
- Bớt hắc tố bẩm sinh khổng lồ có nguy cơ ung thư tế bào hắc tố trên 5%.
- Ung thư tế bào hắc tố liên quan đến gen p16 trên chromosome 9p21.
- Tuýp da 1, 2, 3 có nguy cơ ung thư tế bào hắc tố cao hơn tuýp da 4, 5, 6.

2. CHẨN ĐOÁN

2.1. Triệu chứng lâm sàng

Biểu hiện thay đổi tùy thuộc vào thể lâm sàng:

- Thể u: thường gặp ở tuổi 50 đến 60, tổn thương là khối u, nổi cao, hình vòm, đôi khi có cuống, màu nâu đen không đồng nhất, có thể loét, dễ chảy máu, thường gặp ở thân mình, tiến triển nhanh và tiên lượng xấu.
- Thể nốt: thường gặp ở người da trắng, tuổi từ 40 đến 50. Nữ thường gặp ở cẳng chân, nam thường gặp ở lưng. Tổn thương có màu không đều, nâu xen lẫn xanh, bờ không đều, bề mặt phẳng, xu hướng lan rộng.
- Ung thư tế bào hắc tố của Dubreuilh: thường gặp ở người lớn tuổi. Tổn thương là các dát màu nâu hoặc đen, không đều, thường xuất hiện ở vùng da hờ, tiến triển chậm, có xu hướng lan rộng, lành ở giữa, sau đó xâm lấn xuống sâu.
- Thể đầu chi: thường gặp ở bàn tay, bàn chân, đặc biệt là ở gót chân. Khởi phát là mảng da tăng sắc tố, màu không đều, màu nâu xen lẫn đen xám, ranh giới không rõ, nổi cao hơn mặt da, có thể loét, dễ chảy máu, không đau, không ngứa.
- + Ung thư tế bào hắc tố dưới móng: thường được chẩn đoán muộn vì dễ nhầm lẫn được khám kỹ, phát hiện dấu hiệu Hutchinson và các bất thường khác bằng Dermoscopy để chẩn đoán ung thư tế bào hắc tố dưới móng.
- Thể niêm mạc: hiếm gặp, có thể xuất hiện ở miệng, sinh dục, quanh hậu môn. Tổn thương là mảng da tăng sắc tố, tiến triển nhanh, lan ra xung quanh. Trường hợp nghi ngờ cần làm sinh thiết mặc dù chưa có biểu hiện ác tính.
- Thể không nhiễm hắc tố: hiếm gặp, tổn thương là u sùi, màu đỏ, có thể loét, dễ chảy máu, giống với u hạt nhiễm khuẩn. Trường hợp này cần làm mô bệnh học và hóa mô miễn dịch để chẩn đoán xác định.
- Ung thư tế bào hắc tố thứ phát: khoảng 5% trường hợp không thấy tổn thương nguyên phát. Tổn thương thường là khối u đơn độc, không tăng sắc tố, khu trú dưới da, niêm mạc. Di căn đến từ u hắc tố ở tạng hoặc da đã thoái triển.

2.2. Cận lâm sàng

- **Dermatoscopy:** Có hình ảnh mạng lưới sắc tố không điển hình, đường sọc không đều, sắc tố dạng chấm, nốt, hình cầu, mạng xanh trắng, mạch máu dạng chấm, cành cây.
- **Mô bệnh học**
- + Đặc điểm mô bệnh học: Hình ảnh xâm nhập các tế bào u kém biệt hóa, nhân to, bắt màu đậm, có hiện tượng rối loạn phân bào, thâm nhiễm bạch cầu, tăng sinh mạch máu, có thể loét.
- + Cần xác định các đặc điểm giúp chẩn đoán, điều trị và tiên lượng: chỉ số Breslow, loét, tỷ lệ phân bào, phân độ Clark, vi vệ tinh, xâm lấn mạch bạch huyết, thể mô bệnh học, xâm lấn quanh thần kinh, thâm nhiễm lympho bào tại khối u.
- + Phân độ Clark đánh giá sự xâm lấn của khối u theo 5 mức độ:
 - Độ 1: xâm lấn ở thượng bì
 - Độ 2: xâm lấn trung bì nông, chỉ có một vài tế bào ở nhú bì
 - Độ 3: xâm lấn toàn bộ nhú bì
 - Độ 4: xâm lấn trung bì lưới
 - Độ 5: xâm lấn mô mỡ.
- + Chỉ số Breslow được coi là yếu tố quan trọng dùng để đánh giá mức độ xâm lấn của tổ chức ung thư, giúp cho việc quyết định mức độ cắt bỏ rộng của khối u và tiên lượng bệnh.
- **Hóa mô miễn dịch:** Marker Melan-A, S100 và HMB-45 dương tính.
- **Xét nghiệm chẩn đoán di căn:** Chẩn đoán hình ảnh có giá trị khi bệnh ở giai đoạn từ IIB. Chụp Scan CT, MRI và PET-CT... được khuyến cáo khi có di căn hạch gác (từ giai đoạn III).

2.3. Chẩn đoán xác định

Dựa vào:

- Lâm sàng: Dựa vào hệ thống triệu chứng ABCDE. Cụ thể:
 - + A (Asymetry): Tổn thương không đối xứng
 - + B (Border): Bờ không đồng đều
 - + C (Color): Màu không đều
 - + D (Diameter): Kích thước trên 6 mm
 - + E (Evolution): Tiến triển nhanh trong thời gian 6 tháng trở lại.
- Dermatoscopy
- Mô bệnh học và hóa mô miễn dịch.

2.4. Chẩn đoán thể lâm sàng

- Ung thư tế bào hắc tố thể u
- Ung thư tế bào hắc tố thể nông
- Ung thư tế bào hắc tố của Dubreuilh
- Ung thư tế bào hắc tố thể đầu chi
- Ung thư tế bào hắc tố thể niêm mạc
- Ung thư tế bào hắc tố thể không nhiễm hắc tố
- Ung thư tế bào hắc tố thứ phát

2.5. Chẩn đoán giai đoạn bệnh

- Chẩn đoán TNM

Giai đoạn T (T: tumor - khối u)	
T1 ≤ 1.0 mm	T1a: Độ dày < 0.8 mm, không có loét T1b: < 0.8 mm có loét hoặc 0.8 - 1.0 mm
T2 > 1.0 – 2.0 mm	T2a: Không có loét. T2b: Có loét
T3 > 2.0 – 4.0 mm	T3a: Không có loét. T3b: Có loét
T4 > 4.0 mm	T4a: Không có loét. T4b: Có loét
Giai đoạn N (Node - hạch vùng và M: Metastasis – di căn)	
N1: di căn 1 hạch hoặc Không di căn hạch nhưng có in-transit hoặc vệ tinh hoặc vi vệ tinh	N1a. Không phát hiện hạch trên lâm sàng N1b. Phát hiện hạch trên lâm sàng N1c. Không di căn hạch. Di căn bạch huyết
N2. Di căn 2 - 3 hạch hoặc Di căn 1 hạch và có in-transit hoặc vệ tinh hoặc vi vệ tinh	N2a. Không phát hiện hạch trên lâm sàng N2b. Phát hiện hạch trên lâm sàng N2c. Di căn 1 hạch và di căn bạch huyết
N3: Di căn ≥ 4 hạch hoặc Di căn hạch chùm hoặc di căn ≥ 2 hạch kèm in-transit hoặc vệ tinh hoặc vi vệ tinh	N3a: Không phát hiện hạch trên lâm sàng. N3b: Phát hiện hạch trên lâm sàng hoặc có hạch chùm và không có di căn bạch huyết N3c: Di căn ≥ 2 hạch và di căn bạch huyết
M1a. Di căn xa ở da, hạch xa	LDH tăng hoặc bình thường
M1b: Di căn phổi	LDH tăng hoặc bình thường
M1c: Di căn tạng	LDH tăng hoặc bình thường
M1d: Di căn thần kinh trung ương	LDH tăng hoặc bình thường

- Chẩn đoán giai đoạn

T	N	M	Giai đoạn
Tis	N0	M0	0
T1a/T1b	N0	M0	IA
T2a	N0	M0	IB
T2b/T3a	N0	M0	IIA
T4a	N0	M0	IIB
T4b	N0	M0	IIC
T1a/T1b/T2a/T2b	N1a/N2a	M0	IIIA
T0	N1b/N1c	M0	IIIB
T1a/T1b/T2a	N1b/N1c/N2b	M0	IIIB
T2b/T3a	N1a/N1b/N1c/N2a/N2b	M0	IIIB
T0	N2b/N2c/N3b/N3c	M0	IIIC
T1a-T3a	N2c/N3a/N3b/N3c	M0	IIIC
T3b/T4a	N bất kỳ ≥ N1	M0	IIIC
T4b	N1a/N1b/N1c/N2a/N2b/N2c	M0	IIIC
T4b	N3a/N3b/N3c	M0	IIID
T bất kỳ, Tis	N bất kỳ	M1	IV

* Melanoma tại chỗ và T1 không cần sinh thiết hạch gác để chẩn đoán giai đoạn.

** T0: Không xác định được khối u nguyên phát.

2.6. Chẩn đoán phân biệt

- U mạch máu, u máu xơ hóa.
- Ung thư biểu mô tế bào đáy thể tăng sắc tố.
- Nốt ruồi không điển hình (Atypical Lentigo).
- Xuất huyết do sang chấn, đặc biệt là ở dưới móng, gót chân.

3. ĐIỀU TRỊ

3.1. Nguyên tắc điều trị

- Phẫu thuật loại bỏ triệt để tổ chức ung thư
- Kiểm soát hạch và di căn
- Điều trị che phủ tổn khuyết.
- Kết hợp phẫu thuật với các phương pháp khác trong trường hợp cần thiết.

3.2. Điều trị cụ thể

3.2.1. Phẫu thuật loại bỏ triệt để tổ chức ung thư

- Phẫu thuật cắt rộng được lựa chọn hàng đầu, dựa vào chỉ số Breslow:

- + Ung thư tại chỗ: cắt cách bờ tổn thương 0,5 - 1 cm
- + Chỉ số Breslow ≤ 1 mm: cắt cách bờ tổn thương 1 cm
- + $1 < \text{Chỉ số Breslow} \leq 2$ mm: cắt cách bờ tổn thương 1 - 2 cm
- + Chỉ số Breslow > 2 mm: cắt cách bờ tổn thương 2 cm

- Đảm bảo bờ tổn thương không còn tế bào u bằng mô bệnh học.
- Phẫu thuật Mohs: được chỉ định trong ung thư tế bào hắc tố tại chỗ, nốt ruồi ung thư hoá vùng đầu mặt, một số trường hợp đặc biệt cần tiết kiệm da lành.

3.2.2. Kiểm soát hạch và di căn

- Sinh thiết hạch gác được chỉ định cho MM từ T1b đến T4b và T1a nếu kèm theo các yếu tố nguy cơ: bệnh nhân dưới 40 tuổi, xâm lấn mạch bạch huyết, bờ mảnh sinh thiết có tế bào u (nếu gần 0.8 mm), tỷ lệ nhân chia cao.
- Nạo vét hạch vùng được chỉ định cho ung thư tế bào hắc tố nghi ngờ di căn trên siêu âm hạch hoặc chọc hút hạch có tế bào ung thư hoặc di căn hạch gác.

3.2.3. Che phủ tổn khuyết

Phẫu thuật che phủ tổn khuyết sau cắt bỏ tổn thương theo bậc thang tạo hình, đảm bảo chức năng và thẩm mỹ.

3.2.4. Các phương pháp khác

- Xạ trị: chỉ định trong trường hợp bệnh nhân không phẫu thuật được, MM tại chỗ, nốt ruồi ung thư hoá, hỗ trợ sau cắt rộng MM thể Desmoplastic, nguy cơ cao (Breslow > 4 mm, Clark V, xâm nhập thần kinh, quanh thần kinh, vị trí đầu mặt cổ, và/hoặc cắt bỏ bờ tổn thương hẹp).
- Các thuốc sinh học: nhóm ức chế BRAF (vemurafenib và dabrafenib), nhóm MEKI (trametinib và cobimetinib) và một số nhóm khác (ipilimumab, pembrolizumab, nivolumab, atezolizumab) điều trị ung thư hắc tố di căn.

3.3. Tiên lượng, theo dõi sau điều trị

3.3.1. Tiên lượng

Tiên lượng bệnh phụ thuộc vào nhiều yếu tố trong đó độ dày của tổn thương (chỉ số Breslow) quan trọng nhất. Trường hợp có di căn, tiên lượng xấu. Di căn chủ yếu ở phổi, gan, não và xương. Người bệnh thường tử vong sau 3-6 tháng.

Độ dày của tổn thương (mm)	Tỉ lệ % sống trên 5 năm
< 0,75	96
0,75 - 1,49	87
1,5 - 2,49	75
2,5 - 3,99	66
> 4	47

3.3.2. Theo dõi sau điều trị

Giai đoạn	Thời gian theo dõi	Khám lâm sàng	Chẩn đoán hình ảnh*
0 (MM tại chỗ)	6-12 tháng trong 1-2 năm Sau đó hàng năm	Đánh giá tái phát (đặc biệt thể Malignant Lentigo), phát hiện MM mới	Không khuyến cáo
IA-IIA	6-12 tháng trong 2-5 năm Sau đó hàng năm	Khám tổng thể, chú ý tổn thương da và hạch vùng	Không khuyến cáo
Từ IIB trở đi	3-6 tháng trong 2 năm đầu 6 tháng trong 3-5 năm tiếp Sau đó hàng năm	Khám tổng thể, chú ý tổn thương da và hạch vùng	Thực hiện đến 3-5 năm**
* Gồm xquang ngực (tầm soát di căn phổi); chụp cắt lớp vi tính ngực, bụng, khung chậu; Chụp cộng hưởng từ sọ não; và/hoặc PET-CT. ** Nguy cơ tái phát cao nhất			

4. PHÒNG BỆNH

- Chống nắng
- Điều trị sớm các nốt tế bào hắc tố bẩm sinh đặc biệt là nốt khổng lồ
- Loại bỏ sớm nốt tế bào hắc tố khi có các dấu hiệu, triệu chứng thay đổi.

U ỚNG TUYẾN MỜ HÔI (Syringoma)

1. ĐẠI CƯƠNG

1.1. Khái niệm

U ống tuyến mờ hôi thuộc u lành tính của phần phụ da, do sự phát triển quá mức của các tế bào ống tuyến mờ hôi.

1.2. Dịch tễ

- Bệnh thường gặp, người da trắng có tỉ lệ mắc bệnh cao hơn người da đen, thường xảy ra ở tuổi từ 30 – 40, nữ nhiều hơn nam.
- Bệnh ảnh hưởng đến thẩm mỹ và tác động nhiều đến tâm lý, khiến người bệnh kém tự tin khi giao tiếp trong cuộc sống.

1.3. Căn nguyên/ Cơ chế bệnh sinh

- Nguyên nhân của bệnh chưa rõ
- Một số yếu tố thuận lợi như mùa hè, môi trường làm việc có nhiệt độ cao, stress, hormon sinh dục, đặc biệt là progesteron.
- Bệnh có tính chất gia đình.

2. CHẨN ĐOÁN

2.1. Triệu chứng lâm sàng

- Tổn thương cơ bản: là các sẩn nhỏ, kích thước 1-5mm, màu da hay màu vàng nhạt, nâu nhạt, trắng, chắc, trơn nhẵn và thường có tính phân bố đối xứng. Một số tổn thương lớn hơn, tập trung thành mảng.
- Vị trí: thường ở vùng quanh mắt, nhất là mi dưới, gò má, trán, mặt, cổ, nách, ngực, bụng, đùi, sinh dục, cẳng chân. Đôi khi có ở vùng đầu và gây ra tình trạng rụng tóc không sọc.
- Triệu chứng cơ năng: thường không có triệu chứng cơ năng, có thể có ngứa khi tăng tiết mờ hôi.
- Toàn trạng không bị ảnh hưởng.

2.2. Cận lâm sàng

Mô bệnh học: tăng sinh các ống tuyến mờ hôi, lòng ống chứa mảnh vụn không bắt màu thuốc nhuộm, một số ống có đuôi hình dấu phẩy.

2.3. Chẩn đoán xác định

- Chủ yếu dựa vào lâm sàng.
- Mô bệnh học trong trường hợp cần thiết.

2.4. Chẩn đoán thể lâm sàng

Các thể lâm sàng :

- Thể khu trú: Tổn thương gồm nhiều sẩn nhỏ và phân bố ở một vị trí giải phẫu, gặp ở vùng dưới mi mắt, vùng má. Tuy nhiên, các sẩn cũng có thể gặp ở vùng nách, cổ, ngực, bụng, sinh dục, cánh tay, ria mép.
- Thể gia đình:
 - + Hiếm gặp, di truyền trội trên nhiễm sắc thể thường. Có gia đình ghi nhận đặc tính di truyền bệnh đến 3 thế hệ.
 - + Lâm sàng thường các sẩn tập trung thành đám như khám trai.
- Thể kết hợp hội chứng Down:
 - + Tỷ lệ hiện mắc bệnh ở những người bệnh Down nhiều gấp 30 lần so với tỷ lệ hiện mắc của dân số không bị bệnh Down.
 - + Tổn thương có thể xuất hiện ở dạng khu trú hay lan tỏa.
- Thể lan tỏa: hiếm gặp. Khởi phát đột ngột ở tuổi thanh thiếu niên với hàng loạt tổn thương lan tỏa, tiến triển từng đợt ở vùng thân trước như cổ, nách, ngực, bụng trên, vùng quanh rốn và tay, thậm chí còn xuất hiện trên vùng da sau khi tẩy lông bằng sáp. Tổn thương thể lan tỏa thường xảy ra ở hai bên và có khuynh hướng đối xứng.

2.5. Chẩn đoán phân biệt

- Hạt com phẳng
- U tuyến bã
- Trichoepithelioma

3. ĐIỀU TRỊ

3.1. Nguyên tắc điều trị

Loại bỏ tổn thương

3.2. Điều trị cụ thể

- Thuốc bôi tại chỗ:
 - + Tretinoin: bôi mỏng đúng các sẩn vào buổi tối có tác dụng làm phẳng tổn thương hơn. Isotretinoin uống có tác dụng trên u ống tuyến mồ hôi thể phát ban.
 - + Chấm TCA 33%
- Can thiệp:
 - + Laser CO2 sử dụng chế độ siêu xung, đục lỗ với công suất 0,5-1W, khoảng cách mỗi lần điều trị 4 - 6 tuần, thường chỉ cần 1 - 3 lần điều trị là đáp ứng. Không ghi nhận tác dụng phụ như đỏ da kéo dài hay thay đổi sắc tố.

+ Laser Er:YAG: mật độ năng lượng 9 J/cm², độ rộng xung 250 giây, đường kính điều trị hình trứng 2 - 4mm, điều trị dừng lại khi nhìn thấy trung bì. Với thể sản điều trị 1 lỗ, thể mảng dùng nhiều lỗ cách nhau 2mm, điều trị 2 tháng/lần.

+ Phẫu thuật cắt bỏ: có thể lấy đi u ống tuyến mồ hôi hoàn toàn song dễ bị sẹo hay bị biến dạng nên chỉ có thể áp dụng trong trường hợp có diện tích nhỏ.

+ Radio surgery: sử dụng sóng cao tần gây phá hủy đúng mô của u ống tuyến mồ hôi.

4. PHÒNG BỆNH

Không có biện pháp phòng bệnh đặc hiệu.

BỚT HẮC TỔ BẨM SINH (Congenital Melanocytic Nevus)

1. ĐẠI CƯƠNG

1.1. Khái niệm

Bốt hắc tổ bẩm sinh (CMN) là một tổn thương da đặc trưng bởi sự tăng sinh lành tính của tế bào hắc tố, thường xuất hiện từ ngay khi mới sinh hoặc phát triển trong hai năm đầu tiên.

1.2. Dịch tễ

Bốt hắc tổ bẩm sinh gặp ở nữ nhiều hơn nam với tỷ lệ 3:2. Bốt nhỏ (đường kính dưới 1,5cm) tương đối phổ biến, gặp khoảng 1/100 trẻ sơ sinh. Bốt lớn (đường kính từ 1,5 đến dưới 20cm) có tỷ lệ là 1/1.000 trẻ sơ sinh. Bốt khổng lồ (đường kính trên 20cm) hiếm gặp hơn, tỷ lệ xuất hiện từ 1/200.000 đến 1/500.000 trẻ sơ sinh.

1.3. Căn nguyên/ Cơ chế bệnh sinh

Nguyên nhân gây bệnh là do sự phát triển bất thường của các nguyên bào hắc tố thần kinh có nguồn gốc từ trung mô. Người ta đã xác định được đột biến gen mã hóa protein NRAR và KRAS.

2. Chẩn đoán

2.1. Triệu chứng lâm sàng

- Hầu hết các bớt hắc tổ bẩm sinh có kích thước nhỏ và đơn độc, có thể xuất hiện ở bất kể vị trí nào trên cơ thể, ngay sau sinh. Bốt lớn cũng thường có 1 tổn thương đơn độc, một số ít đi kèm các vệ tinh nhỏ.
- Tổn thương cơ bản là các mảng có màu sắc nâu đen, ranh giới rõ ràng, bề mặt xù xì, nhiều lông đen cứng. Một số ít các trường hợp, bớt có màu nâu nhạt, ranh giới không rõ, bề mặt bằng phẳng, lông màu nâu, mềm.
- Bốt hắc tổ bẩm sinh khổng lồ thường đi kèm nhiều tổn thương vệ tinh, có trường hợp trên 100 vệ tinh và hội chứng hắc tố thần kinh da với biểu hiện cơn động kinh, tăng áp lực nội sọ, liệt dây thần kinh sọ khu trú, não úng thủy...
- Tỷ lệ tiến triển thành ung thư tế bào hắc tố trên các bớt nhỏ thấp, chiếm khoảng 0,7% đến 2,2% nhưng cao hơn ở những bớt khổng lồ, có thể lên đến 3% đến 8%.

2.2. Cận lâm sàng

2.2.1. Dermoscopy

Trên dermoscopy có thể thấy hình ảnh mạng lưới sắc tố dạng cầu hoặc dạng đá cuội, đồng nhất hoặc hỗn hợp của các dạng này.

2.2.2. Mô bệnh học

Tế bào hắc tố tập trung thành đám ở hạ bì, trung bì, ranh giới giữa thượng bì và trung bì, chúng thường phân bố dọc theo cấu trúc mạch máu thần kinh và phần phụ của da.

2.2.3. Hóa mô miễn dịch

Dương tính với Melan A, S100 và HMB-45

2.3. Chẩn đoán xác định

- Dựa trên biểu hiện lâm sàng, tiền sử bệnh.
- Trường hợp không điển hình, cần dựa vào dermoscopy, mô bệnh học và hóa mô miễn dịch (nếu cần).

2.4. Chẩn đoán phân biệt

- Bớt hắc tố mắt phải
- Bớt xanh
- Bớt Mông Cổ
- Bớt Becker
- Dát cà phê sữa
- Bớt thượng bì tăng sắc tố
- Ung thư tế bào hắc tố.

3. ĐIỀU TRỊ

3.1. Nguyên tắc điều trị

- Trẻ mắc bớt hắc tố bẩm sinh lớn và khổng lồ cần có kế hoạch điều trị sớm
- Theo dõi tiến triển ung thư hóa
- Loại bỏ tổn thương để phòng ngừa ung thư và cải thiện thẩm mỹ
- Lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp.

3.2. Điều trị cụ thể:

3.2.1. Lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp

Cần dựa trên: đặc điểm tổn thương, kích thước, vị trí,... đặc điểm da lành xung quanh như diện tích, tính chun giãn,... tuổi người bệnh, quyết định của người bệnh và gia đình...

3.2.2. Loại bỏ tổn thương

- Phẫu thuật loại bỏ tổn thương bao gồm cắt bỏ tổn thương và che phủ khuyết da sau cắt bỏ. Cắt bỏ tổn thương có thể toàn bộ hay 1 phần, cắt bỏ 1 lần hay nhiều lần.

Che phủ khuyết da bằng các biện pháp tạo hình theo bậc thang tạo hình, đơn thuần hay kết hợp: vạt da tại chỗ, ghép da tự do, giãn da...

- Loại bỏ tổn thương bằng thủ thuật: các thủ thuật điều trị gồm nhiều loại khác nhau: laser CO2, laser phân hủy quang nhiệt chọn lọc, đốt điện, liệu pháp lạnh, mài da, lột da hóa chất...

4. PHÒNG BỆNH

- Hướng dẫn bệnh nhân và người nhà tự theo dõi, ghi nhận những thay đổi về màu sắc, ranh giới, kích thước, bề mặt hoặc bất kỳ dấu hiệu, triệu chứng bất thường nào khác như ngứa, rát, chảy máu, loét...

- Khám lâm sàng định kỳ đánh giá sự thay đổi của tổn thương.

- Dermoscopy là công cụ hữu ích để đánh giá sự thay đổi.

- Sinh thiết tổn thương nếu bệnh nhân có những dấu hiệu thay đổi như:

+ Tiến triển lớn nhanh bất thường, vượt qua ranh giới ban đầu của nốt.

+ Màu sắc thay đổi: tăng hoặc giảm sắc tố, xuất hiện các màu lạ...

+ Ranh giới thay đổi, bị xóa nhòa, xuất hiện các tổn thương vệ tinh mới.

+ Bề mặt thay đổi, xù xì hơn, xuất hiện nhiều u cục...

- Hoặc các dấu hiệu, triệu chứng bất thường như:

+ Loét, chảy máu

+ Đau, ngứa dai dẳng.

BÓT SÙI THƯỢNG BÌ (**Verrucous epidermal nevus**)

1. ĐẠI CƯƠNG

1.1. Khái niệm

- Bớt sùi thượng bì đặc trưng bởi sự quá sản lành tính của các tế bào thượng bì với triệu chứng điển hình là đám tổn thương dạng mảng sùi màu da hoặc màu nâu, có xu hướng đi theo các đường tuyến tính trên da (đường Blaschko).
- Tổn thương thường xuất hiện từ ngay sau khi sinh (khoảng 50%) hoặc phát triển trong năm đầu tiên của cuộc đời.

1.2. Dịch tễ

Bớt sùi thượng bì có tỷ lệ khoảng 1-3/1000 trẻ em, bệnh có thể gặp cả hai giới và mọi chủng tộc.

1.3. Căn nguyên/ Cơ chế bệnh sinh

Căn nguyên gây bệnh đến nay chưa được rõ ràng, có thể liên quan tới đột biến một số gen.

2. CHẨN ĐOÁN

2.1. Triệu chứng lâm sàng

- Tổn thương da:
 - + Tổn thương cơ bản: là dát hoặc mảng sần sùi, ranh giới rõ, màu da hoặc màu nâu, dày hơn và sẫm màu hơn theo thời gian, phân bố theo đường Blaschko có dạng dải.
 - + Tổn thương có thể phát triển quá sản dạng u nhú, viêm, loét, mùi hôi do sự phát triển của vi khuẩn tại chỗ.
 - + Vị trí: vùng thân mình, các chi và ít khi gặp ở mặt hay da đầu, ở một bên cơ thể, đối xứng hai bên hoặc lan tỏa toàn thân.
- Một số ít trường hợp có thể kèm theo bất thường ở các cơ quan khác như tim mạch, thần kinh và mắt.
- Triệu chứng cơ năng: có thể có ngứa trong trường hợp viêm (inflammatory linear verrucous epidermal nevus - ILVEN).
- Tiến triển: lành tính, không ảnh hưởng tới chức năng các cơ quan, chủ yếu gây mất thẩm mỹ.

2.2. Cận lâm sàng

- Mô bệnh học: đặc trưng bởi quá sản thượng bì dạng u nhú, tăng gai, tăng sừng. Không có hình ảnh quá sản tuyến bã giống như trong bớt tuyến bã.

2.3. Chẩn đoán xác định

Dựa vào:

- Lâm sàng
- Mô bệnh học

2.4. Chẩn đoán phân biệt

- Lichen thành dải
- Vảy nến thành dải
- Porokeratosis thành dải
- Bệnh Darier thành dải
- Bệnh sắc tố đám dề

3. ĐIỀU TRỊ

3.1. Nguyên tắc điều trị

- Điều trị càng sớm càng tốt.
- Loại bỏ tổn thương bằng các biện pháp can thiệp.

3.2. Điều trị cụ thể

Điều trị bớt sùi thượng bì còn gặp nhiều khó khăn, với tỷ lệ tái phát cao và nguy cơ để lại sẹo.

- Tổn thương ít, kích thước nhỏ: phẫu thuật cắt bỏ là phương pháp điều trị triệt để nhất. Ngoài ra có thể sử dụng laser bào mòn hoặc liệu pháp lạnh.
- Tổn thương rộng, lan tỏa: laser bào mòn là phương pháp phổ biến nhất, bao gồm laser CO2 và laser Erbium YAG. Laser CO2 là phương pháp dễ tiếp cận hơn, tuy nhiên tỷ lệ hình thành sẹo cao, do đó, nên điều trị từng phần tổn thương và chăm sóc sau laser một cách tích cực. Laser Erbium YAG có tỷ lệ sẹo thấp hơn tuy nhiên tỷ lệ tái phát khá cao.
- Với bớt sùi thượng bì thành dải có viêm (inflammatory linear verrucous epidermal nevus) có thể kết hợp với các thuốc bôi chống viêm.

4. PHÒNG BỆNH

Không có biện pháp phòng bệnh đặc hiệu. Điều trị sớm là cách dự phòng tổn thương tiến triển.

U MẠCH MÁU TRẺ EM

(Infantile hemangioma)

1. ĐẠI CƯƠNG

1.1. Khái niệm

- Tổn thương mạch máu ở trẻ em được chia thành hai loại chính: u mạch máu và dị dạng mạch máu.

- U mạch máu là những khối u do sự tăng sinh tế bào nội mô quá mức, bao gồm u mạch máu sơ sinh và u mạch máu bẩm sinh.

- U mạch máu sơ sinh là những khối u mạch máu chưa phát triển đầy đủ khi trẻ mới sinh ra và tiến triển nhanh trong những tháng đầu đời. U mạch máu bẩm sinh là loại u mạch máu đã phát triển đầy đủ khi mới sinh.

1.2. Dịch tễ

- U mạch máu sơ sinh là khối u mạch máu lành tính thường gặp nhất ở trẻ sơ sinh.

- Bệnh thường gặp ở người da trắng (gấp 10 - 12 lần so với người châu Á và châu Phi), nữ thường gặp nhiều hơn nam (tỷ lệ 3/1).

- Một số yếu tố nguy cơ: trẻ gái, da trắng, đẻ non, sinh đôi, sinh ba, tuổi mẹ khi sinh cao, gia đình có tiền sử u mạch máu sơ sinh.

1.3. Căn nguyên/ Cơ chế bệnh sinh

Căn sinh bệnh học của bệnh chưa được sáng tỏ.

2. CHẨN ĐOÁN

2.1. Triệu chứng lâm sàng

2.1.1. Giai đoạn tăng sinh (sau sinh đến khoảng 5 - 6 tháng tuổi)

- Khi trẻ mới sinh tổn thương chỉ là các tia máu hoặc các dát hơi đỏ, sau đó có màu đỏ tươi hoặc đỏ thẫm. Tổn thương tiến triển nhanh, gồ cao lên mặt da trong vòng 4 tuần đầu tiên.

- Tùy thuộc vào kích thước và độ sâu mà tổn thương có thể có dạng vòm, dạng thùy, dạng khối u hoặc hỗn hợp. Màu sắc của u mạch máu phản ánh mức độ sâu của tổn thương, thay đổi từ màu đỏ nhạt hoặc đỏ đậm (u mạch máu nông), xanh, tím hoặc hồng nhạt (u sâu hơn).

- Tổn thương căng, chắc, đàn hồi và màu đậm hơn khi tăng áp lực trong mạch máu (như khi trẻ khóc).

- U mạch máu có kích thước trung bình từ 0,5 - 5cm, có thể tới 20cm đường kính.

- Tổn thương có thể khu trú (ở một vùng nhỏ) hoặc phân đoạn (đơn vị da thần kinh lớn hơn - neuroectodermal unit). U mạch máu thể phân đoạn nặng hơn u mạch máu thể khu trú và có thể kèm theo các bất thường bẩm sinh khác như hội chứng PHACE, hội chứng PELVIS.

- U mạch máu được chia thành: thể nông, thể sâu và thể hỗn hợp.
- + Thể nông còn được gọi là u mạch máu mao mạch (capillary haemangioma) hay u mạch máu đơn giản, do sự bất thường của các mạch máu ở lớp nông của da, biểu hiện thường là các dát, mảng màu đỏ tươi.
- + Thể sâu: còn được gọi là u mạch máu dạng hang, nằm sâu hơn ở lớp trung bì và hạ bì, biểu hiện là những khối dưới da và có màu xanh nhạt hoặc không màu, mật độ mềm hoặc chắc.
- + Thể hỗn hợp: mang đặc điểm của cả hai thể.
- U mạch máu thường xuất hiện ở vùng đầu cổ, tiếp đến là thân mình và tay chân. Ngoài ra, bệnh có thể xuất hiện ở cơ quan nội tạng như gan, ruột, lách, tuyến giáp...

2.1.2. Giai đoạn thoái lui (sau 1 tuổi)

- Giai đoạn này có thể xảy ra sớm vài tháng sau sinh hoặc muộn 2 - 3 năm sau sinh. Tổn thương trở nên nhạt màu hơn, mềm dần từ trung tâm ra ngoại vi và thường không để lại di chứng.
- Với tổn thương thoái lui muộn, đa số các trường hợp để lại thay đổi vĩnh viễn ở da như giãn mạch nông, teo da, giảm sắc tố hoặc thừa da.
- Khoảng 50% thoái lui hoàn toàn sau 5 năm, 70% sau 7 năm và thoái lui hoàn toàn sau 9 năm mà không cần can thiệp.

2.1.3. Biến chứng

- Loét: xảy ra khoảng 10% với tuổi trung bình là 4 tháng, đặc biệt là những tổn thương ở môi, vùng hậu môn sinh dục hoặc vùng nếp gấp.
- Chảy máu: hiếm khi chảy máu nhiều và thường có thể cầm được bằng cách ấn trực tiếp lên tổn thương.
- Biến dạng ảnh hưởng đến chức năng:
 - + Vị trí ở khoang miệng, lưỡi gây cản trở việc ăn, nuốt hoặc nói
 - + Vị trí quanh mắt gây ảnh hưởng tới thị giác: giảm thị lực, chứng loạn thị, lác mắt, một số ảnh hưởng khác như tắc nghẽn tuyến lệ, viêm giác mạc, lồi mắt.
 - + Vị trí đầu mũi, nhân trung, môi (đặc biệt khi u vượt qua viền môi): nguy cơ cao gây biến dạng cấu trúc mặt (cũng như gây loét với u mạch máu môi).
 - + Vị trí ở tai: gây giảm/mất thính giác nếu gây bít ống tai
 - + Vị trí ở ngực (nữ): có thể ảnh hưởng tới quần vú
- Biến chứng liên quan tới nội tạng: nguy cơ có u mạch máu nội tạng khi có trên 5 tổn thương ở da.
 - + U mạch máu vùng mặt dưới thường liên quan tới u mạch máu đường thở, gây thở khò khè, tiếng thở lớn.
 - + Hội chứng Kasabach-Merritt (Kasabach-Merritt syndrome)

- + Suy tim: có thể xảy ra với những u mạch máu lớn ở gan với thông động tĩnh mạch gan dẫn đến suy tim sung huyết.
- + Biểu chứng liên quan tới một số hội chứng: hội chứng PHACE, hội chứng PELVIS.

2.2. Cận lâm sàng

- Dermoscopy: hình ảnh mạch máu dạng thùy (globular vessel) gợi ý tổn thương nông. Các dạng mạch máu gợi ý tổn thương sâu là dạng dài (linear vessel), dạng sóng (wavy vessel) và giãn mạch (dilated vessel).
- Các thăm dò chẩn đoán hình ảnh bao gồm: siêu âm, chụp mạch, mô bệnh học... để xác định và khảo sát các bất thường mạch máu ở sâu hơn và mức độ xâm lấn.

2.3. Chẩn đoán phân biệt

- Dị dạng mạch máu.
- U mạch máu khác.
- Các khối u khác ở da.
- Đối với u mạch máu ở da:
 - + U mạch máu bẩm sinh (congenital hemangioma)
 - + U mỡ ở da (cutaneous lipoma)
 - + U mạch máu anh đào (cherry angioma)
 - + U xơ ác tính ở trẻ sơ sinh
 - + Dị dạng mạch máu (vascular malformation)
 - + U nội mô mạch máu dạng Kaposi
 - + U mạch dạng búi
 - + U hạt sinh mụn
 - + Các u dưới da khác

2.4. Phân tầng nguy cơ

U mạch máu là nguy cơ cao nếu có 1 trong các trường hợp sau:

- Các biểu chứng đe dọa tính mạng (u mạch máu ở đường thở, gan, đường tiêu hóa).
- Suy giảm chức năng (ví dụ, u mạch máu quanh hốc mắt làm giảm thị lực) hoặc loét.
- Các bất thường về cấu trúc liên quan (ví dụ như hội chứng PHACE, PELVIS).
- Nguy cơ biến dạng vĩnh viễn, đặc biệt khi u mạch máu nằm ở khu vực nhạy cảm về mặt thẩm mỹ.
- U mạch máu kích thước lớn ($\geq 5\text{cm}$), phát triển nhanh.
- Các u mạch máu lớn, dạng mảng (phân đoạn) hoặc kết hợp, đặc biệt ở những vị trí dễ bị chấn thương, dễ bị loét và để lại sẹo.
- Bất kỳ tổn thương nào trên mặt, đặc biệt là khi có kích thước lớn hoặc phân đoạn.

3. ĐIỀU TRỊ

3.1. Nguyên tắc điều trị

- Theo phân tầng nguy cơ
- Phòng ngừa các biến chứng đe dọa tính mạng hoặc đe dọa chức năng
- Ngăn ngừa hoặc giảm thiểu biến dạng sau giai đoạn thoái triển hoặc sau điều trị.
- Thời điểm điều trị: càng sớm càng tốt trong giai đoạn tăng sinh của u mạch máu, lý tưởng nhất là trong vòng hai đến ba tháng đầu sau khi sinh.

3.2. Điều trị cụ thể

3.2.1. U mạch máu nguy cơ thấp và không biến chứng

- Không can thiệp và theo dõi: áp dụng với u mạch máu không biến chứng, không ảnh hưởng đến thẩm mỹ và chức năng.

- Liệu pháp tại chỗ:

- + Thuốc chẹn beta:

- Bao gồm propranolol, timolol, carteolol. Thường sử dụng gel hoặc dung dịch timolol maleate 0,5%.

- Chỉ định: Điều trị u mạch máu mỏng (độ dày < 2 mm), nông hoặc các vết loét nhỏ, giảm tái phát ở trẻ đang giảm liều propranolol đường uống.

- Cách bôi: bôi một lớp mỏng được bôi lên bề mặt tổn thương 2-3 lần/ngày cho đến khi đạt hiệu quả.

- Tác dụng phụ: có thể gặp là kích ứng tại chỗ và co thắt phế quản.

- + Corticosteroid bôi tại chỗ và tiêm nội tổn thương:

- Bôi tại chỗ: chỉ định trong điều trị u mạch máu loét nhẹ và/hoặc tái phát.

- Tiêm nội tổn thương: chỉ định ở các u mạch máu khu trú tốt. Liều không vượt quá 3 mg/kg cân nặng, mỗi tháng một lần. Số lần tiêm thay đổi từ 1 đến 12 lần tiêm tùy theo đáp ứng lâm sàng của bệnh nhân, không có khuyến cáo thời gian cụ thể. Đã gặp trường hợp bệnh nhân tái phát. Đối với u mạch máu mí mắt, chỉ nên tiêm corticosteroid nội tổn thương bởi bác sĩ nhãn khoa hoặc chuyên gia khác có kinh nghiệm.

3.2.2. U mạch máu nguy cơ cao, có biến chứng

- Điều trị toàn thân, càng sớm càng tốt.

- Propranolol đường uống:

- + Đánh giá trước điều trị: đánh giá các bất thường về tim mạch, hô hấp (bú kém, khó thở, thở nhanh, toát mồ hôi, thở khò khè, tim có tiếng thổi), tiền sử gia đình có block tim, rối loạn nhịp.

- + Chống chỉ định: Chống chỉ định điều trị propranolol ở trẻ em:

- Sốc tim
- Nhịp chậm xoang
- Hạ huyết áp mạn tính
- Block nhĩ thất cấp II, III
- Suy tim
- Tiền sử co thắt phế quản hoặc thở khò khè
- Quá mẫn với propranolol

- Trẻ sinh non với tuổi hiệu chỉnh < 5 tuần
 - + Bắt đầu điều trị và liều lượng: cả ở trẻ sơ sinh khỏe mạnh mới bốn tuần tuổi và ở trẻ sinh non ở bốn tuần tuổi hiệu chỉnh, việc điều trị có thể được bắt đầu.
 - + Trẻ cần nhập viện dùng propranolol đường uống trong các trường hợp sau:
 - Trẻ < 4 tuần tuổi.
 - Trẻ bất kì lứa tuổi nào nhưng không được chăm sóc đầy đủ.
 - Mặc các bệnh kèm theo ảnh hưởng đến hệ tim mạch hoặc hô hấp, bao gồm u mạch máu đường thở có triệu chứng.
 - Mặc các bệnh ảnh hưởng đến việc duy trì đường huyết.
 - + Bắt đầu điều trị bằng propranolol đường uống với liều 1 mg/kg mỗi ngày chia làm hai lần, tăng lên 2 mg/kg mỗi ngày chia làm hai lần sau một tuần, và sau đó lên đến 3 mg/kg mỗi ngày chia hai lần mỗi ngày, phụ thuộc vào độ nặng và đáp ứng của bệnh nhân. Để giảm nguy cơ hạ đường huyết, propranolol được dùng ngay sau khi ăn.
 - + Nếu trẻ có các triệu chứng nghiêm trọng về hô hấp, bao gồm thở khò khè, nên tạm thời ngừng dùng propranolol và sau đó dùng lại với liều thấp hơn và tăng liều dần dần với sự theo dõi chặt chẽ.
 - + Giám sát:
 - Tại phòng khám: vì tác dụng của propranolol đường uống đạt đỉnh sau một đến ba giờ sau khi dùng, khuyến cáo bệnh nhân nên được theo dõi nhịp tim và huyết áp sau một và hai giờ sau liều ban đầu và sau mỗi lần tăng liều 0,5 mg/kg/ngày.
 - Tại nhà: cha mẹ hoặc người chăm sóc cần nhận biết các dấu hiệu của tác dụng phụ nghiêm trọng, bao gồm hạ huyết áp, nhịp tim chậm, thở khò khè và hạ đường huyết. Các dấu hiệu lâm sàng sớm của hạ đường huyết bao gồm: đổ mồ hôi, bồn chồn, cáu gắt, tím tái, bú kém, hạ thân nhiệt, thờ ơ.
 - Đánh giá đáp ứng và thời gian điều trị: thông thường đáp ứng đáng kể (giảm kích thước) sau ba đến bốn tháng điều trị bằng propranolol, nhưng nhiều chuyên gia vẫn tiếp tục điều trị sau giai đoạn tăng sinh. Do đó, việc điều trị thường được tiếp tục cho đến 6 đến 18 tháng tuổi nhưng thay đổi tùy thuộc vào kích thước u mạch máu, vị trí, biến chứng và đáp ứng cũng như thời điểm (ở độ tuổi) bắt đầu điều trị. Nếu thất bại sau 3 tuần có thể cân nhắc phương pháp điều trị khác.
 - + Tác dụng phụ: hạ đường huyết, hạ huyết áp, nhịp tim chậm, co thắt phế quản và tăng kali máu. Nhẹ hơn có thể là khó ngủ, táo bón hoặc tiêu chảy, lạnh đầu chi.
 - + Điều trị ngoại trú bằng propranolol đường uống cho các trường hợp bệnh nhân:
 - Tuổi hiệu chỉnh > 5 tuần.
 - Cân nặng khi sinh bình thường.
 - Khám tim mạch bình thường trong vòng bốn tuần trước đó.
 - Khám hô hấp bình thường trong vòng bốn tuần trước đó.
 - Không có nguy cơ mắc hội chứng PHACE hoặc PELVIS.
 - Không có vết loét hoặc vết loét nhỏ/nông.
 - Nhiều khối u với siêu âm gan bình thường và không có khối u ở da có nguy cơ

cao.

+ Liều điều trị ngoại trú: liều khởi đầu là 0,5 mg/kg mỗi ngày, chia hai lần mỗi ngày và tăng dần sau mỗi ba đến bốn ngày thêm 0,5 mg/kg mỗi ngày cho mục tiêu liều 2 - 3 mg/kg mỗi ngày chia hai lần.

- Corticosteroid toàn thân:

+ Chỉ định: u mạch máu phức tạp, chống chỉ định thuốc chẹn beta.

+ Liều lượng: liều khởi đầu thông thường cho prednisolon là 1 đến 3 mg/kg mỗi ngày. Đáp ứng thường xuất hiện trong vài tuần đầu tiên. Điều trị thường được tiếp tục trong 4 - 8 tuần hoặc hơn, tùy thuộc vào chỉ định điều trị, đáp ứng và tuổi của trẻ khi bắt đầu điều trị. Sau đó prednisolon sẽ được giảm dần liều 0,5 mg/kg mỗi 2-4 tuần. Nên giảm liều prednisolon từ từ vì việc ngừng đột ngột hoặc giảm liều nhanh chống glucocorticosteroid trong khi u mạch máu vẫn đang trong giai đoạn phát triển tích cực có thể dẫn đến tái phát và suy thượng thận.

- Laser màu xung (bước sóng 585/595nm):

+ Chỉ định: các u mạch máu nhỏ, mỏng, nông sớm trong giai đoạn tăng sinh hoặc u mạch máu loét và ban đỏ sau thoái triển và giãn mao mạch.

+ Tần suất mỗi 2 - 4 tuần cho tới khi lành hẳn.

- Laser Nd:YAG: sử dụng trong trường hợp u mạch máu sâu trên 2cm, đường kính mạch lớn.

- Phẫu thuật: thường được dành cho các tổn thương phức tạp có sẹo hoặc da thừa; u mạch máu ở những khu vực nhạy cảm về mặt thẩm mỹ; và u mạch máu da có cuống. Phẫu thuật cắt bỏ cũng có thể được xem xét đối với các u mạch máu bị loét nghiêm trọng.

- Thuyên tắc mạch (nút mạch): chỉ định trong trường hợp u mạch máu lớn, nội tạng (đặc biệt là ở gan) hoặc những u mạch máu biến chứng chảy máu nặng thất bại với điều trị nội khoa.

3.2.3. Điều trị một số trường hợp đặc biệt

- U mạch máu quanh mắt:

+ U mạch máu quanh mắt lớn hơn 1 cm, liên quan đến mí mắt trên và ở sâu có thể ảnh hưởng đến thị lực và gây ra nhược thị, loạn thị hoặc lác. Những u mạch máu này nên được đánh giá và theo dõi bởi bác sĩ nhãn khoa có kinh nghiệm.

+ U mạch máu nông, quanh mắt có thể được điều trị bằng thuốc chẹn beta tại chỗ. Phẫu thuật cắt bỏ cũng có thể là một lựa chọn cho các tổn thương nhỏ, khu trú.

+ Các trường hợp đe dọa thị lực thường được điều trị toàn thân bằng propranolol hoặc ít phổ biến hơn là tiêm corticosteroid nội tổn thương. Corticosteroid tiêm nội tổn thương nên được quản lý bởi bác sĩ chuyên khoa có kiến thức và kinh nghiệm trong lĩnh vực này.

- U mạch máu loét:

+ Chăm sóc vết thương và thuốc bôi: làm sạch và chăm sóc tại chỗ, sử dụng kháng sinh nếu cần.

+ Có thể sử dụng timolol tại chỗ để điều trị u mạch máu bị loét.

+ Propranolol đường uống: chỉ định cho u mạch máu bị loét có thể gây biến dạng vĩnh viễn, cản trở các hoạt động sinh hoạt hàng ngày (ví dụ: thay tã, tắm, cho ăn, ngủ) và/hoặc là không đáp ứng với việc chăm sóc vết thương, giảm đau và kiểm soát nhiễm trùng.

+ Laser màu xung 595 nm có thể được sử dụng như một phương pháp điều trị hỗ trợ cho các u mạch máu bị loét không lành sau khi điều trị nội khoa và chăm sóc vết thương tối ưu. Điều trị có thể được lặp lại trong khoảng thời gian từ hai đến bốn tuần.

- U mạch máu đường thở: Propranolol toàn thân là phương pháp điều trị đầu tiên cho trẻ em bị u mạch máu đường thở có triệu chứng. Loại bỏ bằng laser, steroid trong tổn thương và/hoặc phẫu thuật cắt bỏ khối u là những liệu pháp điều trị bậc hai không thường xuyên. Trường hợp đặc biệt có thể phải phẫu thuật mở khí quản.

- Suy tim cung lượng cao: trẻ sơ sinh có u mạch máu ở gan hoặc rất lớn có thể gây suy tim cung lượng cao trong vài tháng đầu đời. Điều trị trong những trường hợp như vậy có thể bao gồm propranolol đường uống và/hoặc glucocorticosteroid, thuyên tắc động mạch gan trong một số trường hợp và/hoặc điều trị suy tim (với hạn chế dịch, thuốc lợi tiểu và digoxin theo chỉ định).

- Hội chứng PHACE: sự bất thường động mạch nghiêm trọng có thể hạn chế hoặc thay đổi việc sử dụng propranolol ở bệnh nhân mắc hội chứng PHACE. Ngoài các u mạch máu lớn ở mặt, bệnh nhân mắc chứng rối loạn này có thể biểu hiện các bất thường về mạch máu não, cổ và tim. Do đó, việc điều trị nên được thảo luận với sự tư vấn của các chuyên gia về thần kinh và/hoặc tim mạch.

4. PHÒNG BỆNH

- Hiện tại chưa có biện pháp phòng bệnh hữu hiệu.
- Cần quản lý thai sản tốt.
- Phát hiện sớm, giám sát chặt chẽ, tránh biến chứng.

TĂNG SẮC TỔ SAU VIÊM

(Postinflammatory hyperpigmentation- PIH)

1. ĐẠI CƯƠNG

1.1. Khái niệm

Tăng sắc tố sau viêm (PIH) là tình trạng tăng sắc tố mắc phải, xảy ra sau phản ứng viêm của da với các yếu tố nội sinh và ngoại sinh.

1.2. Dịch tễ

PIH có thể gặp ở mọi chủng tộc, mọi tuýp da, tuy nhiên thường gặp hơn ở người có tuýp da tối màu.

1.3. Căn nguyên/ Cơ chế bệnh sinh

PIH là kết quả của việc sản xuất quá nhiều melanin hoặc sự phân tán sắc tố không đều sau khi bị viêm da. Sự gia tăng hoạt động của tế bào hắc tố này được kích thích bởi các cytokin, chemokin (prostaglandin, leucotrien,...) và các chất trung gian gây viêm khác cũng như các gốc oxy hóa được giải phóng trong quá trình viêm.

2. CHẨN ĐOÁN

2.1. Triệu chứng lâm sàng

- Tổn thương cơ bản là dát tăng sắc tố, đa dạng về hình dáng và kích thước, xuất hiện tại nơi chấn thương hay viêm trước đó. Theo độ sâu của tổn thương, PIH được phân thành 2 loại:

+ PIH nông (thượng bì):

- Dát màu nâu, nâu đen hay đen.
- Có thể tự hết sau vài tháng đến vài năm mà không điều trị.
- Nhìn rõ dưới ánh sáng đèn Wood.

+ PIH sâu (trung bì):

- Dát màu xanh xám.
- Có thể tồn tại vĩnh viễn hoặc tự hết sau một thời gian rất dài không điều trị.
- Không nhìn rõ dưới ánh sáng đèn Wood.

- PIH thường xuất hiện sau quá trình viêm trung bình 1-2 tháng. Đa số các trường hợp có thể tự biến mất mà không cần điều trị. Thời gian trung bình là 6 tháng ở mặt, 1-2 năm ở thân mình, chi trên và 2-4 năm ở chi dưới. PIH ở người trẻ có tiên lượng tốt hơn ở người già, ở thượng bì tốt hơn ở trung bì.

2.2. Cận lâm sàng

- Soi đèn Wood: Giúp đánh giá PIH nông hay sâu
- Mô bệnh học: Thường không cần thiết cho chẩn đoán, mô bệnh học không đặc hiệu.
 - + Thượng bì: quá sản thượng bì, tăng số lượng tế bào hắc tố và tăng lắng đọng melanin.
 - + Trung bì: lắng đọng melanin, thâm nhập các đại thực bào sắc tố.
 - + Nhuộm Fontana - Masson bạc (+).

2.3. Chẩn đoán xác định

Chủ yếu dựa vào lâm sàng với các tiêu chí chính:

- Có phản ứng viêm trước đó
- Dát tăng sắc tố xuất hiện trên nền tổn thương viêm

2.4. Chẩn đoán phân biệt

Tùy thuộc vào vị trí có phản ứng PIH trên cơ thể mà cần phân biệt với các bệnh lý khác nhau.

3. ĐIỀU TRỊ

3.1. Nguyên tắc điều trị

- Tránh nắng
- Điều trị tại chỗ
- Điều trị toàn thân

3.2. Điều trị cụ thể

3.2.1. Thuốc bôi

- Hydroquinon 2-4%:
 - + Lựa chọn đầu tay trong điều trị PIH.

- + Cơ chế: ức chế tyrosinase, ngăn chặn sự chuyển đổi DOPA thành melanin
- + Cách dùng: bôi ngày 2 lần, bắt đầu bôi thử trên diện tích da nhỏ, sau 24h không bị ngứa hay rát thì bắt đầu điều trị chính thức.
- + Bắt đầu có tác dụng sau 4 tuần. Nếu sau 12 tuần không có đáp ứng thì nên ngừng điều trị.
- Mequinol: mequinol, 4-hydroxyanisol là các dẫn xuất của hydroquinon
 - + Cơ chế: có thể liên quan đến sự ức chế cạnh tranh của tyrosinase; tuy nhiên con đường chính xác vẫn chưa rõ ràng
 - + Mequinol/tretinoin bôi tại chỗ đã được chứng minh là không thua kém 4% HQ
- Retinoid: tretinoin, adapalen và tazaroten
 - + Cơ chế: ức chế sự hình thành melanin bằng cách tăng chu kì đổi mới tế bào gai, giảm quá trình vận chuyển melanosome và ức chế sự dịch mã tyrosinase.
 - + Retinoid an toàn và hiệu quả trong điều trị PIH, đặc biệt là PIH do mụn trứng cá. Có thể dùng kéo dài.
 - + Tác dụng phụ thường gặp là viêm da kích ứng, có thể làm PIH nặng lên sau điều trị.
 - + Cách dùng: bắt đầu ở nồng độ thấp hơn và tăng dần dựa trên đáp ứng điều trị và lựa chọn các công thức dễ dung nạp hơn, chẳng hạn như kem thay vì gel, có thể giúp giảm nguy cơ làm trầm trọng thêm PIH. Nếu có kích ứng nhiều thì dùng thêm kem dưỡng ẩm.
- Kết hợp thuốc bôi:
 - + Công thức hay dùng: hydroquinon 4%, tretinoin 0,05%, và fluocinolon acetonid 0,01%.
 - + Vừa an toàn vừa hiệu quả trong điều trị PIH.
 - + Cách dùng: bôi ngày một lần buổi tối trong 8 tuần sau đó bôi cách ngày trong 8 tuần, sau đó bôi duy trì tuần hai lần.
- Acid azelaic:
 - + Cơ chế: ức chế có hồi phục với tyrosinase và ức chế tổng hợp DNA và gây độc tế bào có chọn lọc trên tế bào hắc tố tăng hoạt hóa.

+ Acid azelaic 20% bôi hai lần một ngày có hiệu quả tương đương hydroquinon 4%, ít tác dụng phụ hơn hydroquinon. Hiệu quả bắt đầu thấy được sau 2 - 4 tuần, có thể dùng kéo dài.

- Acid kojic 1-4%: được sản xuất bởi nhiều loài nấm (ví dụ: *Aspergillus oryzae*, *Penicillium spp*, *Acetobacter spp*) có tác dụng điều trị PIH theo cơ chế ức chế enzym tyrosinase.

- Đậu nành: làm giảm PIH thông qua cơ chế ức chế vận chuyển melanin vào tế bào sừng và ức chế tia UVB.

- Arbutin/deoxyarbutin: một hydroquinon được glycosyl hóa, có tác dụng ức chế cạnh tranh với tyrosinase, ức chế hình thành melanosome nhưng ít gây độc tế bào hơn hydroquinon.

+ Cách dùng: bôi ngày 1 lần, thường dùng kết hợp với các thuốc khác.

- Acid ascorbic:

+ Cơ chế: ức chế tyrosinase và trung hòa các gốc tự do hay các gốc oxy phản ứng do quá trình viêm sinh ra và ức chế miễn dịch tại chỗ

+ Chế phẩm: có nhiều dạng như cream, lotion, serum,... đơn độc hay kết hợp với vitamin E, retinoid. Nồng độ vitamin C để có tác dụng sinh học cần cao > 8%. Hiện nay các sản phẩm vitamin C thường có nồng độ khoảng 10 - 20%.

- Niacinamid: một dạng amid của niacin (vitamin B3). Cơ chế: ức chế chuyển melanosome đến tế bào gai.

- Phương pháp bôi là phương pháp chính và hiệu quả trong điều trị PIH. Các thủ thuật khác như laser, lột da nên được cân nhắc thận trọng, chỉ trong các trường hợp kháng trị với các phương pháp thông thường hoặc PIH ở trung bì.

3.2.2. Lột da (peeling)

- Phân loại:

+ Rất nông (very superficial): loại bỏ lớp sừng (độ sâu 0,06 mm).

+ Nông (superficial): loại bỏ tổn thương từ lớp hạt đến trên lớp màng đáy (độ sâu 0,45 mm).

+ Trung bình (medium): đạt đến nhú trung bì (độ sâu 0,6 mm).

+ Sâu (deep): đạt đến giữa lớp lưới trung bì (độ sâu 0,8 mm).

- Chống chỉ định:

- + Nhiễm khuẩn cấp (virus, vi khuẩn, nấm) hoặc đang có viêm da ở vùng lột.
- + Suy giảm miễn dịch tự nhiên/mắc phải.
- + Đang dùng các thuốc làm tăng nhạy cảm da với ánh sáng (doxycyclin, vitamin A acid,...),
- + Điều trị bằng isotretinoin trong vòng 1 tháng gần đây (chống chỉ định tương đối hay tuyệt đối phụ thuộc loại lột, liều và thời gian dùng isotretinoin).
- + Cơ địa sẹo lồi, bệnh lý tim mạch (lột bằng phenol),...
- **Biến chứng:**
 - + Tăng sắc tố sau viêm nhất là những người da tối màu (type da IV - VI).
 - + Nhiễm trùng, nhiễm độc: hiếm gặp.
 - + Viêm da dạng trứng cá: thường xuất hiện ở giai đoạn tái tạo biểu mô.
 - + Milia: gặp khoảng 20%, thường ở tuần thứ 8 - 16 sau lột.
 - + Sẹo lõm: thường khi dùng peel sâu.
- **Các hóa chất thường dùng:**
 - + Alpha-hydroxyacids (AHAs): α -Hydroxyacids (AHA) là các acid hữu cơ yếu có trong trái cây, thực vật và đường sữa, gồm có glycolic acid (GA), lactic acid, pyruvic acid, malic acid, tartaric acid, citric acid.
 - + Acid glycolic (GA): là AHAs được sử dụng để peel nhiều nhất có ưu điểm: ổn định, không nhạy cảm ánh sáng, rẻ tiền, an toàn không cần thời gian nghỉ dưỡng. Cách dùng: peel rất nông: 30% - 50% GA để 1 - 2 phút; peel nông: 50% - 70% GA để 2 - 5 phút; peel trung bình: 70% GA để 3 - 15 phút. Mỗi đợt điều trị khoảng 3 - 6 lần, khoảng cách giữa các lần là 2 - 4 tuần.
 - + Acid lactic (LA): là cũng là một AHAs có tính chất tương tự GA, hiệu quả peel tốt mà giá thành rẻ và có sẵn. Cách dùng: thường dùng dung dịch LA 92% (pH = 3,5), mỗi đợt điều trị có thể lên đến 6 lần, khoảng cách giữa các lần là 3 tuần.
 - + Acid pyruvic: thường dùng dạng gel 40%, mỗi đợt điều trị khoảng 4 - 5 lần, 1 tháng/lần.
 - + Acid mandelic: thường dùng nồng độ 30 - 50%, mạnh hơn GA.
 - + Beta-hydroxyacids (BHAs): thường dùng nhất là acid salicylic (SA). Cách dùng: acid salicylic (SA) 20 - 30%, mỗi đợt 5 lần, cách nhau 2 tuần. Hiệu quả cho

thấy cải thiện rõ, không tái phát sau 6 tháng điều trị, không gây tăng sắc tố sau viêm nên an toàn cho da tối màu.

+ Acid trichloroacetic (TCA): Là acid mạnh, $pH = 0,26$, ít được sử dụng cho tuýp da tối màu và thường peel nông do tăng nguy cơ sẹo và rối loạn sắc tố sau peel. Nồng độ TCA 35% có thể đạt đến nhú trung bì, do đó peel TCA thích hợp cho điều trị tăng sắc tố trung bì và hỗn hợp. Cách dùng: TCA 10 - 25%, mỗi 2 tuần, cho thấy cải thiện nhanh và rõ hơn so với GA 55 75%. Tuy nhiên, tỷ lệ tái phát cao hơn so với GA.

3.2.3. Laser

Laser và IPL có hiệu quả điều trị các tổn thương sắc tố thông qua cơ chế quang nhiệt chọn lọc. Tuy nhiên, một trong những tác dụng phụ của laser là gây ra PIH nên laser ít được chỉ định trong điều trị PIH, chỉ trong các trường hợp kháng trị với các phương pháp thông thường hoặc PIH ở trung bì.

3.2.4. Chống nắng

- Chống nắng là biện pháp bắt buộc trong điều trị PIH
- Kết hợp nhiều biện pháp chống nắng khác nhau

+ Biện pháp cơ học: tránh nắng nhất là từ 9h đến 16h, đội mũ rộng vành, mang khẩu trang- găng- tất- quần áo dài tay làm bằng chất liệu vải sợi dày, khít và có màu sậm khi ra nắng.

+ Kem chống nắng:

- Chống nắng vật lý (titanium dioxit, oxid kẽm): khúc xạ và phát tán tia UV, ánh sáng nhìn thấy, tia hồng ngoại.

- Chống nắng hóa học (PABA, cinnamates, salicylates, ensulizole, benzophenons,...): hấp thu tia UV và chuyển thành năng lượng nhiệt.

4. PHÒNG BỆNH

4.1. Đánh giá nguy cơ PIH trước khi làm thủ thuật

- Tuýp da tối màu có nguy cơ PIH cao hơn
- Đánh giá tình trạng tăng sắc tố của các tổn thương cũ, sẹo cũ của bệnh nhân

4.2. Dự phòng

- Khi quá trình viêm đang xảy ra, tích cực điều trị bệnh lý nền để làm giảm tối thiểu phản ứng viêm.

- Trước khi làm thủ thuật: chống nắng trước và sau khi làm thủ thuật ít nhất 2 tuần.
- Trong khi làm thủ thuật:
 - + Nên có hệ thống làm mát trong quá trình làm thủ thuật laser
 - + Lựa chọn năng lượng, mật độ tia phù hợp
- Sau khi làm thủ thuật: bôi corticosteroid loại mạnh trong thời gian vài ngày sau laser

RÁM MÁ

(Melasma)

1. ĐẠI CƯƠNG

1.1. Khái niệm

Rám má (melasma) là tình trạng tăng sắc tố mắc phải ở da vùng mặt, đặc trưng bởi những đốm, mảng nâu, nâu đen hoặc đen, phân bố đối xứng.

1.2. Dịch tễ

- Bệnh thường gặp ở những người tuýp da III - V (phân loại Fitzpatrick).
- Rám má gặp ở nữ nhiều hơn nam, đặc biệt là nữ giới trong độ tuổi sinh đẻ.

1.3. Căn nguyên/ Cơ chế bệnh sinh

Rám má là bệnh da tăng sắc tố mắc phải có căn nguyên và cơ chế bệnh sinh rất phức tạp. Cơ chế bệnh sinh của bệnh chưa rõ ràng, nhiều nguyên nhân được cho là có liên quan đến bệnh: di truyền, ánh sáng mặt trời, bệnh lý tuyến giáp, buồng trứng, hay nội tiết tố khác,...

2. CHẨN ĐOÁN

2.1. Triệu chứng lâm sàng

- Tổn thương cơ bản: các dát tăng sắc tố màu nâu, nâu đen, xanh đen; đồng đều hoặc không; ranh giới thường không rõ; không ngứa, không đau; đối xứng ở hai bên gò má, thái dương, trán, mũi, cằm.
- Tổn thương tăng đậm về mùa xuân hè, giảm về mùa thu đông.
- Phân loại: có nhiều cách phân loại rám má.
 - + Dựa vào vị trí tổn thương: thể trung tâm (tổn thương ở trán, má, môi trên, mũi, cằm); thể má và mũi; thể góc hàm.
 - + Phân loại theo độ sâu của tổn thương (Gilchrest 1977): thượng bì, trung bì, hỗn hợp.
 - + Phân loại theo mức độ nặng: dựa theo thang điểm MSS (Melasma Severity Scale) và MASI (Melasma area and severity index).

2.2. Cận lâm sàng

- Đèn Wood: giúp xác định vị trí tăng sắc tố ở trung bì hay thượng bì.
- Dermoscopy: rám má thượng bì quan sát bằng ánh sáng không phân cực thấy hình ảnh tăng sắc tố màu nâu, không đồng đều. Rám má ở trung bì quan sát bằng ánh sáng phân cực thấy hình ảnh tăng sắc tố màu xám xanh hoặc xám nâu, không đồng đều; rám má hỗn hợp có cả 2 đặc điểm trên. Ngoài ra, có thể quan sát thấy sự thay đổi về phân bố và hình thái mạch máu.
- Mô bệnh học:
 - + Độ dày của thượng bì hoàn toàn bình thường.
 - + Tăng sắc tố thượng bì và/hoặc trung bì.
 - + Số lượng tế bào sắc tố bình thường hoặc tăng nhẹ.
 - + Có thể thấy tế bào đại thực bào chứa các hạt sắc tố ở trung bì.

2.3. Chẩn đoán xác định:

Dựa vào:

- Lâm sàng

- Cận lâm sàng

2.4. Chẩn đoán phân biệt

- Tăng sắc tố sau viêm
- Bớt tăng sắc tố, đặc biệt bớt Hori.
- Tàn nhang.
- Dày sừng da đầu.
- Tăng sắc tố do các bệnh da khác.

3. ĐIỀU TRỊ

3.1. Nguyên tắc chung

- Tránh ánh nắng mặt trời.
- Điều trị tại chỗ.
- Điều trị toàn thân.
- Kết hợp điều trị các bệnh lý liên quan.

3.2. Điều trị cụ thể

Có thể áp dụng một hoặc nhiều phương pháp tùy thuộc cá thể.

3.2.1. Áp dụng các biện pháp tránh ánh nắng mặt trời

- Đội mũ nón rộng vành, mặc quần áo chống nắng, kính...
- Sử dụng các sản phẩm chống nắng.

3.2.2. Điều trị tại chỗ

Bảng phân loại các tác nhân làm trắng da dựa trên cơ chế hoạt động

Các giai đoạn tổng hợp melanin	Cơ chế tác dụng	Phân tử hoạt động
Trước tổng hợp Melanin	Ức chế phiên mã Tyrosinase	Tretinoin, c-2 ceramide
	Glycosyl hóa Tyrosinase	PaSSO ₃ Ca
	Ức chế plasmin	Tranexamic acid
Trong quá trình tổng hợp Melanin	Ức chế hoạt động Tyrosinase	Hydroquinon, mequinol, azelaic acid, kojic acid, arbutin, deoxyarbutin, licorice extract, elanosome, 2,5-dimethyl-4-hydroxy-3(2H)-furanone, N-acetyl glucosamine, resveratrol, oxyresveratrol, ellagic acid, methyl gentisate, 4-hydroxyanisole
	Ức chế Peroxidase	Hợp chất Phenolic

	Dọn dẹp phản ứng oxy hóa	Ascorbic acid, ascorbic acid palmitate, glutathione, hydrocumarins
Sau quá trình tổng hợp Melanin	Thoái hóa Tyrosinase	Linoleic acid, α -linoleic acid
	Ức chế vận chuyển elanosome	Niacinamid, ức chế serine protease, retinoids, lecithins, neoglycoproteins, Ức chế trypsin nguồn gốc đậu nành
	Tăng tốc độ luân chuyển da	Lactic acid, glycolic acid, linoleic acid, retinoic acid
	Điều hòa môi trường của các tế bào hắc tố	Corticosteroids, glabiridin
	Tương tác với đồng	Kojic acid, ascorbic acid
	Ức chế hình thành elanosome	Arbutin, deoxyarbutin
	Ức chế protease activated receptor 2	Ức chế trypsin nguồn gốc đậu nành

3.2.3. Điều trị toàn thân

- Tranexamic uống
- Glutathion
- Thuốc uống chống oxy hoá: Vitamin C, vitamin E, pycnogenol,...

3.2.4. Các phương pháp điều trị khác

- Điện chuyên ion: đưa hoạt chất vào da bằng phương pháp dòng điện 1 chiều.
- Mesotherapy: sử dụng phương pháp tiêm trong da (thường tiêm trung bì) để đưa các thành phần hoạt chất vào da hoặc sử dụng bằng máu tự thân (phương pháp tiêm huyết tương giàu tiểu cầu - PRP).
 - Chemical peels (Jessner, Vitalize, Yellow peel, TCA, AHA, Mandelic acid,...): tăng bong tróc da, tẩy các tế bào sừng chứa sắc tố, hiệu quả cho nám mức độ trung bình – nhẹ. Nên phối hợp với thuốc thoa tại chỗ.
 - Laser: ưu tiên dùng cho các trường hợp nám má trung bì, nám má hỗn hợp, ưu tiên dùng IPL cho làn da người Châu Á, có thể sử dụng các loại laser khác như: Q-switch Ruby, Alexandrite, 532-nm Nd: YAG, Yellow laser, 510-nm Pulsed-dye laser...

- Fractional photothermolysis/ Fractional Radiofrequency: Fractional CO2 và Erbium laser là lựa chọn mới trong điều trị nám da với cơ chế làm bốc bay tế bào thượng bì, hiệu quả trong điều trị nám thượng bì.

4. PHÒNG BỆNH

- Áp dụng các biện pháp tránh ánh nắng mặt trời để tránh tái phát và làm nặng tình trạng bệnh.
- Loại trừ các yếu tố nguy cơ.

TRÚNG CÁ (Acnes)

1. ĐẠI CƯƠNG

1.1. Khái niệm

Trúng cá là một bệnh viêm mạn tính của đơn vị tuyến bã – nang lông, đặc trưng bởi các tổn thương không viêm như mụn đầu đen, đầu trắng, hoặc tổn thương viêm như các sẩn viêm, sẩn mủ, cục, nang. Các tổn thương phân bố chủ yếu vùng nhiều tuyến bã như mặt, ngực, lưng. Bệnh thường gây ảnh hưởng tới thẩm mỹ, tâm lý và sự tự tin của người bệnh.

1.2. Dịch tễ

Bệnh có thể gặp ở mọi lứa tuổi (thời thơ ấu, tuổi thanh thiếu niên và người trưởng thành). Đối với trúng cá khởi phát ở tuổi dậy thì, tỉ lệ gặp ở nam nhiều hơn nữ. Đối với trúng cá xuất hiện sau thời kì dậy thì, tỷ lệ gặp ở nữ nhiều hơn nam.

1.3. Căn nguyên/ Cơ chế bệnh sinh

Có nhiều nguyên nhân và yếu tố liên quan tới cơ chế bệnh sinh của bệnh. Một số yếu tố như: gia đình, nội tiết, môi trường, vệ sinh, ăn uống, căng thẳng, sử dụng mỹ phẩm, thuốc bôi không hợp lý... là tác nhân làm xuất hiện trúng cá hoặc làm bệnh nặng thêm. Có 4 cơ chế chính gây bệnh trúng cá đã được xác định, đó là tăng bài tiết chất bã, dày sừng cổ nang lông, vai trò của vi khuẩn *Cutibacterium acnes* (*C. acnes*) và các chất trung gian viêm.

2. CHẨN ĐOÁN

2.1. Triệu chứng lâm sàng

- Tổn thương da: các tổn thương phân bố điển hình ở vùng có nhiều tuyến bã như mặt, cổ, ngực, lưng trên, cánh tay trên. Bao gồm một hoặc nhiều dạng tổn thương:
 - + Mụn nhân đóng (closed comedone) hay mụn đầu trắng: kích thước < 5mm, sẩn có màu da, trắng hoặc xám hình vòm, nhẵn hơi nhô cao hơn mặt da.
 - + Mụn nhân mở (open comedone) hay mụn đầu đen: sẩn kích thước < 5mm, trung tâm có lỗ mở chứa chất sừng xám, nâu hoặc đen.
 - + Mụn mủ (pustule): đường kính tổn thương dưới 5mm, chứa đầu mủ màu trắng hoặc vàng ở trung tâm nền đỏ.
 - + Sẩn mủ (papulopustular): sẩn và mụn mủ tương đối nông ở bề mặt, đường kính < 5 mm.

+ Cục (nodule): sần to ($> 5\text{mm}$) hoặc cục ($> 1\text{mm}$) viêm sâu, ấn đau do tổn thương viêm sâu hơn xuống trung bì.

+ Nang (cyst): tổn thương trứng cá dạng nang do tổn thương viêm chứa dịch mủ, sờn sệt lẫn máu, thường mềm, dễ vỡ.

– Các di chứng sau trứng cá:

+ Tăng sắc tố sau viêm

+ Ban đỏ sau viêm

+ Sẹo: bao gồm sẹo lõm, sẹo quá phát, sẹo lồi.

● Sẹo lõm trứng cá chia làm 3 loại:

✓ Sẹo hình phễu (ice pick): hay gặp nhất, đường kính $< 2\text{mm}$, bờ rõ, có thể sâu tới lớp hạ bì.

✓ Sẹo lòng chảo (rolling scars): đường kính 4 - 5mm, do sợi xơ trung bì dính với thượng bì gây co kéo tạo thành đáy lòng chảo.

✓ Sẹo đáy phẳng (box scars): hình tròn hay ovan, bờ sẹo thẳng đứng, đường kính 1,5 - 4mm.

● Sẹo quá phát, sẹo lồi: do sự tăng sinh xơ bất thường trong quá trình lành thương, thường gặp ở vị trí ngực, lưng, bả vai, góc hàm, mặt.

– Các biểu hiện của bệnh lý liên quan:

Cường androgen: rậm lông thứ phát ở nách, mu, ngực, râu cằm, rụng tóc hói. Nữ giới có kinh nguyệt bất thường (không đều, vòng kinh kéo dài quá 35 ngày hoặc ngắn dưới 21 ngày, ...), phì đại âm vật, giọng trầm.

– Biến chứng:

+ Trứng cá tối cấp (Acne fulminans): Sự bùng phát cấp tính các nang, cục viêm lớn kèm theo các vết trợt, loét, đóng vảy xuất huyết. Có thể kèm theo triệu chứng toàn thân như sốt, mệt mỏi, đau xương, khớp, hồng ban nút. Xét nghiệm thấy tăng bạch cầu, máu lắng, Protein phản ứng C, thiếu máu. Tình trạng này hiếm gặp, gặp chủ yếu ở nam giới tuổi vị thành niên. Có thể xảy ra sau dùng isotretinoin đường uống hoặc xuất hiện tự nhiên.

+ Viêm nang lông do vi khuẩn gram âm: gặp ở những bệnh nhân điều trị kháng sinh lâu dài dẫn đến kháng thuốc. Biểu hiện là các sần, cục viêm, mụn mủ trung tâm mặt, quanh mũi.

+ Phù nề cứng mặt (bệnh Morbihan's): ban đỏ và phù nề mô mềm vùng mặt.

+ Ảnh hưởng tâm lý do trứng cá.

2.2. Cận lâm sàng

- Soi tươi tìm nấm, demodex để chẩn đoán phân biệt
- Đèn Wood: vi khuẩn *C.acnes* bắt màu cam
- Xét nghiệm chẩn đoán cường androgen:
 - + Siêu âm ổ bụng tìm dấu hiệu buồng trứng đa nang, khối u buồng trứng, tuyến thượng thận
 - + Nồng độ testosterone tự to, toàn phần và DHEA-S tăng
 - Đánh giá tình trạng nhiễm khuẩn (nếu cần đặc biệt khi có biến chứng trứng cá tối cấp): xét nghiệm máu thấy tăng bạch cầu, máu lắng, protein phản ứng C.
 - Chụp X quang (nếu có triệu chứng liên quan đến xương, khớp): hình ảnh tiêu xương.
 - Chuẩn bị cho liệu pháp điều trị với isotretinoin đường uống: chức năng gan, mỡ máu, thử thai bằng nước tiểu hoặc huyết thanh

2.3. Chẩn đoán xác định

Chẩn đoán xác định dựa vào triệu chứng lâm sàng.

2.4. Chẩn đoán thể

- Trứng cá thông thường
- Trứng cá mạch lươn: thường gặp ở nam giới trẻ tuổi. Biểu hiện là các cục, nang lớn, thường tập trung lại, đi vào vào thành dạng dải, hang với nhiều lỗ dò. Tổn thương chảy dịch máu mủ. Tổn thương để lại sẹo nghiêm trọng hình thành các cầu da, dải xơ. Không có triệu chứng toàn thân.
- Trứng cá ở trẻ sơ sinh: thường bắt đầu ở độ tuổi 3-6 tháng do tuyến thượng thận chưa trưởng thành dẫn đến tăng nồng độ androgen. Nồng độ androgen giảm dần từ 1-2 tuổi kèm theo sự cải thiện mụn trứng cá
- Trứng cá do cào gãi: tổn thương không viêm tương đối nhẹ hoặc các sản viêm thường xuyên bị cào gãi để lại vết trợt và sẹo. thường gặp ở phụ nữ trẻ có các vấn đề tâm lý, sử dụng thuốc chống trầm cảm.

2.5. Chẩn đoán mức độ bệnh

Hiện nay có nhiều phân loại khác nhau về mức độ nặng trong trứng cá như phân loại theo Karen McCoy, trứng cá thông thường chia làm 3 mức độ (nhẹ, vừa và nặng) hay phân loại theo IGA (Investigator Global Assessment) 2005, chia làm 4 mức độ (mụn nhân, trứng cá sẩn mủ nhẹ - trung bình, trứng cá sẩn mủ nặng/trứng cá bọc trung bình, trứng cá bọc nặng/trứng cá bùng phát). Tuy nhiên, chưa có một phân loại mức độ trứng cá nào được chấp nhận trên toàn cầu.

Trên lâm sàng, cách phân loại mức độ nặng trứng cá dễ tiếp cận cho điều trị nhất như sau:

- Trứng cá mức độ nhẹ:
- + Các mụn nhân đóng hoặc sẩn viêm hoặc sẩn mủ nhỏ ($< 5\text{mm}$), rải rác, không có sẹo trứng cá
- + Vùng da tổn thương giới hạn (chỉ bị ở 1 vùng cơ thể hoặc nếu bị hơn 1 vùng cơ thể thì chỉ có một vài tổn thương ở mỗi vùng)
- + Không có tổn thương cục
- Trứng cá mức độ trung bình và nặng:
- + Nhiều tổn thương mụn nhân đóng hoặc sẩn viêm hoặc mụn mủ
- + Có tổn thương cục
- + Bị ở nhiều vùng cơ thể, mỗi vùng có nhiều tổn thương
- + Có sẹo trứng cá

2.4. Chẩn đoán phân biệt

- Quá sản tuyến bã
- Nevus comedonicus
- Đa u tuyến bã
- U xơ mạch vùng mặt trong bệnh xơ cứng củ
- Viêm nang lông
- Trứng cá đỏ
- Viêm da quanh miệng
- Giả viêm nang lông vùng râu
- Hội chứng Favre-Racouchot
- Viêm tuyến mồ hôi mủ
- Tổn thương dạng trứng cá:
- + Trứng cá do thuốc
- + Bệnh mụn mủ ở trẻ sơ sinh
- + Trứng cá do mỹ phẩm
- + Trứng cá do tỳ đề
- + Trứng cá do nghề nghiệp và do clo

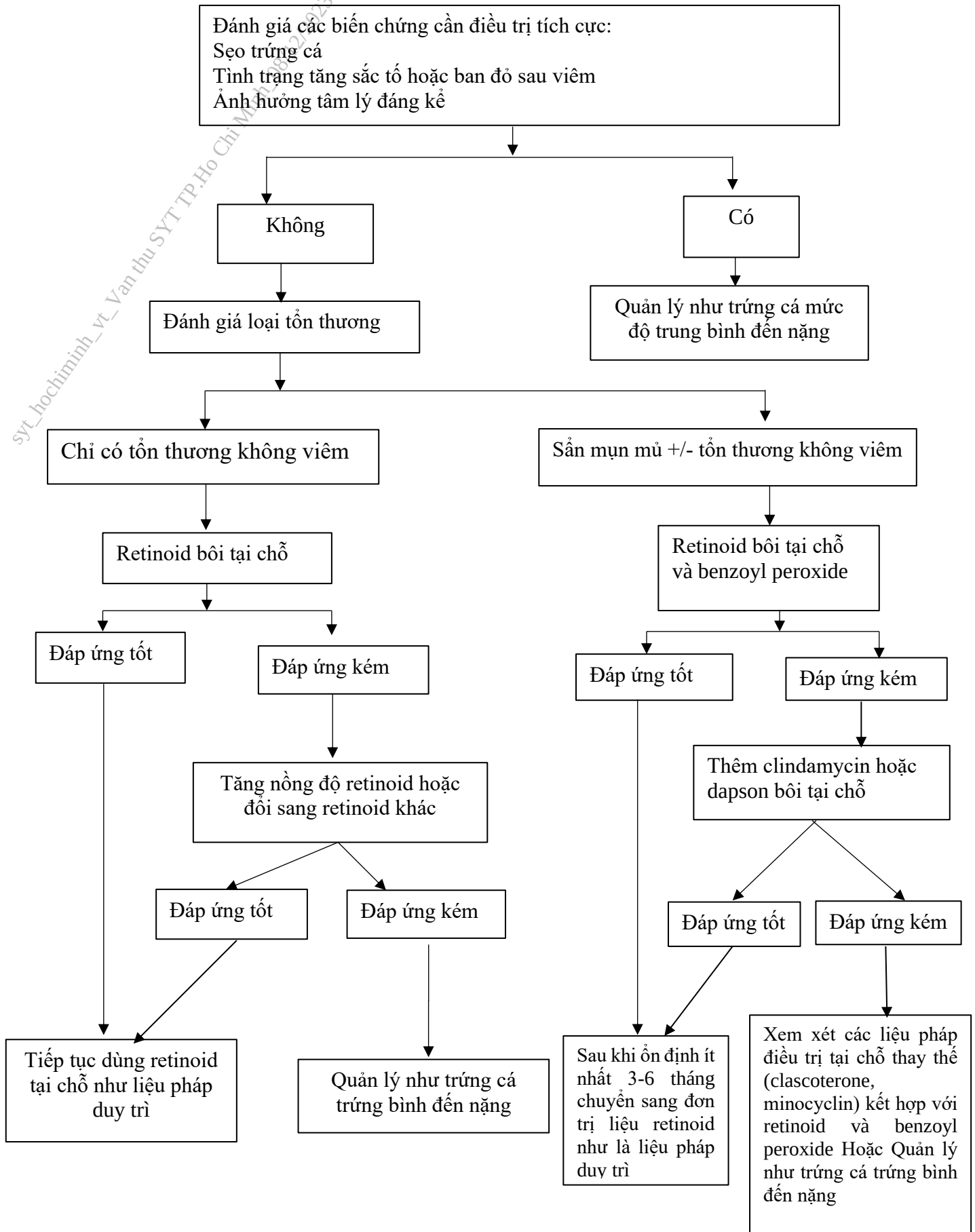
3. ĐIỀU TRỊ

3.1. Nguyên tắc điều trị

- Lựa chọn thuốc tác động vào một hoặc nhiều hơn trong bốn yếu tố: sừng hóa cổ nang lông, sản xuất bã nhờn, vi khuẩn *C.acnes*, yếu tố viêm.
- Điều trị sớm tránh biến chứng.
- Điều trị bệnh theo mức độ.
- Cần điều trị duy trì để tránh tái phát

3.2. Điều trị cụ thể

Phác đồ điều trị trứng cá thông thường mức độ nhẹ:



Phác đồ điều trị trứng cá thông thường mức độ trung bình đến nặng ở thanh thiếu niên và người lớn: Lựa chọn liệu pháp toàn thân

Có bất kỳ dấu hiệu nào sau đây:

Trứng cá cục, nang, lan rộng

Sẹo trứng cá

Ảnh hưởng tâm lý đáng kể

Có

Không

Tư vấn bắt đầu sử dụng isotretinoin
đường uống

Bệnh nhân từ chối hoặc không phù
hợp với isotretinoin

Có tổn thương sẩn mủ và/hoặc cục, nang

Có

Không

Chỉ tổn thương không viêm

Các lựa chọn bao gồm:

- Tetracyclin đường uống (doxycyclin, minocyclin, sarecyclin),
hoặc

- Thuốc tránh thai đường uống (chỉ định cho nữ), hoặc

- Spironolacton đường uống (chỉ định cho nữ), hoặc

- Isotretinoin đường uống

Sử dụng tetracyclin, thuốc tránh thai đường uống và
spironolacton kết hợp với liệu pháp bôi tại chỗ => Đánh giá lại
sau 3 tháng

Nếu không cải thiện kết hợp các thuốc này (kết hợp
spironolacton và thuốc tránh thai đường uống hoặc thêm
tetracyclin vào thuốc tránh thai đường uống hoặc liệu pháp
spironolacton), chuyển thuốc hoặc chuyển sang dùng
isotretinoin đường uống

Các lựa chọn bao gồm:

- Thuốc tránh thai đường uống (chỉ định cho nữ),
hoặc

- Spironolacton đường uống (chỉ định cho nữ), hoặc

- Isotretinoin đường uống

Sử dụng thuốc tránh thai đường uống và
spironolacton kết hợp với liệu pháp bôi tại chỗ =>
Đánh giá lại sau 3 tháng

Nếu không cải thiện kết hợp các thuốc này hoặc
chuyển sang dùng isotretinoin đường uống

Điều trị duy trì: Sử dụng retinoid đường bôi để điều trị duy trì (theo dõi sơ đồ điều trị trứng cá mức độ nặng).

Các thuốc điều trị cụ thể

– Retinoid tại chỗ

Lựa chọn một trong các hoạt chất sau:

- + Adapalen (0,1%, 0,3% kem hoặc lotion 0,1%)
- + Retinoic acid (0,025 - 0,1% dạng kem, gel)
- + Tazaroten (0,05%, 0,1% kem, gel hoặc bột).
- + Trifaroten

Cách dùng: Bôi thuốc mỏng 1 lần/ngày vào buổi tối. Có thể giảm tần suất bôi trong một vài tuần đầu (bôi cách ngày hoặc sau dưỡng ẩm để hạn chế kích ứng).

Lưu ý:

- + Tác dụng phụ như khô, kích ứng, bong da, tăng nhạy cảm ánh sáng thường gặp trong 2 tuần đầu. Tretinoin không sử dụng cùng lúc hoặc kết hợp với benzoyl peroxide (BP).
- + Tretinoin và adapalen thuộc phân loại thai kỳ C đối với phụ nữ có thai.
- + Tazaroten không chỉ định cho phụ nữ mang thai, phân loại thai kỳ X.
- + Adapalen, tazaroten được FDA chấp thuận cho bệnh nhân ≥ 12 tuổi và tretinoin cho bệnh nhân ≥ 10 tuổi.

– Kháng sinh bôi tại chỗ

Lựa chọn một trong các dạng hoạt chất sau:

- + Clindamycin 1% (dung dịch hoặc gel)
- + Erythromycin 2% (kem, gel, lotion, xịt)
- + Minocyclin bột 4%: FDA phê duyệt cho điều trị trứng cá thông thường mức độ trung bình đến nặng

Lưu ý:

- + Ưu tiên lựa chọn clindamycin hơn erythromycin do tỷ lệ kháng với tụ cầu và *C.acnes* của erythromycin cao hơn.
- + Bôi 1-2 lần/ngày vào vùng da có tổn thương viêm.
- + Không khuyến cáo sử dụng đơn trị liệu trong trứng cá.
- + Dùng dạng phối hợp với BP giúp làm tăng hiệu quả và giảm nguy cơ kháng kháng sinh. (ví dụ erythromycin 3% với BP 5% hay clindamycin 1% với BP 5%).

+ Clindamycin và erythromycin chỉ định được cho phụ nữ có thai (Phân loại thai kỳ nhóm B).

– *Benzoyl peroxid (BP)*

Dạng chế phẩm: gel, kem, xà phòng rửa (nồng độ 2,5 - 10%).

Cách dùng: bôi ngày 1 lần vào buổi tối sau khi rửa mặt.

Hiện tại chưa có trường hợp kháng thuốc nào được báo cáo.

Lưu ý:

+ Tác dụng phụ: kích ứng, thay đổi màu sắc áo, tóc, nhạy cảm ánh sáng.

+ Khuyến cáo thai kỳ C, tuy nhiên tỷ lệ hấp thu toàn thân rất thấp, cân nhắc chỉ định ở phụ nữ mang thai.

+ Chưa chứng minh an toàn và hiệu quả ở trẻ em <12 tuổi.

– *Acid azelaic*

+ Dạng thuốc: nồng độ 20% (kem hoặc gel)

+ Cách dùng: Bôi 2 lần/ngày vào vùng da có tổn thương,

+ Tác dụng phụ: kích ứng tại chỗ, tuy nhiên tỷ lệ thấp và nhẹ.

+ Thích hợp cho những bệnh nhân có da nhạy cảm hoặc type da tối màu, có những tổn thương tăng sắc tố sau viêm do có tác dụng ức chế melanin làm sáng da.

+ Chỉ định được cho phụ nữ có thai (Phân loại thai kỳ nhóm B)

– Sản phẩm điều trị kết hợp: sản phẩm kết hợp các thuốc bôi như adapalene + *Benzoyl peroxid*, clindamycin + tretinoin, erythromycin + isotretinoin: hiệu quả cao hơn so với điều trị đơn độc một thành phần.

– *Dapson*

+ Cách dùng: gel 5% bôi 2 lần/ngày, 7,5% bôi 1 lần/ngày

+ Không dùng cùng lúc với BP nếu bệnh nhân đang dùng cả 2 thuốc này.

– Clascoterone bôi tại chỗ: thuốc kháng androgen tại chỗ

+ Đã được FDA phê duyệt để điều trị mụn trứng cá ở người từ 12 tuổi trở lên

+ Cách dùng: clascoterone 1% bôi 2 lần/ngày

+ Tác dụng phụ: có thể kích ứng da, có báo cáo về tác dụng phụ gây ức chế trục dưới đồi – tuyến yên – tuyến thượng thận.

Các thuốc điều trị toàn thân

– *Kháng sinh toàn thân*

Lựa chọn một trong những phác đồ ưu tiên sau:

+ Doxycyclin: uống 100mg x 2 lần/ ngày hoặc phác đồ 200 mg/ngày trong ngày đầu chia 2 lần cách nhau mỗi 12h, sau đó duy trì 100mg/ngày (đối với dạng giải phóng chậm). Có thể sử dụng liều dưới ngưỡng kháng khuẩn < 50mg/ngày điều trị duy trì dạng viên phóng thích chậm.

+ Minocyclin: 50mg – 100mg, 1-2 lần/ngày.

+ Tetracyclin: 1 g/ngày chia nhiều lần, khi cải thiện giảm dần liều từ từ, duy trì 125 – 500 mg/ngày.

Trường hợp không có chỉ định của nhóm cyclin, có thể dùng:

+ Azithromycin 500mg/ngày x 3 ngày/tuần (liên tiếp hoặc cách ngày) trong tháng thứ 1 sau đó 500mg/ngày x 2 ngày/tuần trong tháng 2 và 500mg/ngày x 1 ngày/tuần trong tháng thứ 3. Uống thuốc xa bữa ăn (trước ăn 1h hoặc sau ăn 2h).

+ Trimethoprim/sulfamethoxazol 160/800 mg x 2 lần/ngày, uống trong hoặc ngay sau ăn.

Lưu ý:

+ Thời gian sử dụng không quá 3 - 4 tháng, không sử dụng điều trị duy trì, không dùng kháng sinh như biện pháp điều trị đơn độc, không phối hợp với kháng sinh tại chỗ.

+ Nên sử dụng kết hợp với retinoid và/hoặc BP tại chỗ.

+ Không dùng doxycyclin, minocyclin, tetracyclin và trimethoprim/sulfamethoxazol cho phụ nữ mang thai, cho con bú và trẻ em < 8 tuổi.

+ Azithromycin chỉ định được cho phụ nữ có thai và trẻ em.

– *Isotretinoin*

+ Chỉ định cho trứng cá mức độ trung bình và nặng, liều điều trị: 0,5 - 1 mg/kg/ngày

+ Cách dùng: uống thuốc trong hoặc ngay sau bữa ăn, dạng thuốc dạng lidose có thể dùng được cả khi đói.

+ Thời gian điều trị: thời gian điều trị nên kéo dài 4-6 tháng. Trong trường hợp chưa đáp ứng có thể kéo dài thêm. Có thể chỉ định dùng liên tục đủ tổng liều 120-150mg/kg để hạn chế tái phát.

Lưu ý:

+ Isotretinoin có thể tác động lên da, niêm mạc gây khô, đỏ mặt, chảy máu cam, viêm kết mạc, rụng tóc,...

+ Không dùng cho phụ nữ mang thai và cho con bú (phân loại thai kỳ X) và trẻ em dưới 12 tuổi. Dùng thuốc ít nhất 1 tháng hoặc 1 chu kỳ kinh mới có thai.

- + Kiểm tra mỡ máu, men gan trước khi điều trị, sau 1 tháng điều trị và mỗi 3 tháng sau đó.
- + Không dùng phối hợp với kháng sinh nhóm cyclin đường uống.
- *Liệu pháp hormon đường uống*
- + Thuốc thường được dùng phối hợp với: isotretinoin, kháng sinh, thuốc bôi,...
- + Chỉ định: một số trường đặc biệt hội chứng buồng trứng đa nang (PCOS), trứng cá ở bệnh nhân nữ muốn tránh thai, tăng sản xuất androgen do buồng trứng hoặc tuyến thượng thận...
- + Thuốc tránh thai kết hợp cả estrogen và progestin: 3 loại được FDA phê duyệt cho điều trị trứng cá gồm:
 - Ethinyl estradiol 20/30/35 mcg/norethindrone 1 mg
 - Ethinyl estradiol 35 mcg/norgestimate 180/215/250 mcg
 - Ethinyl estradiol 20 mcg/drospirenone 3 mg.
- + Spironolacton: uống 50-100mg/ngày chia 1 hoặc 2 lần
- + Có thể kết hợp spironolacton và thuốc tránh thai

4. PHÒNG BỆNH

- Tránh các yếu tố khởi động, kích thích làm bệnh nặng lên như stress, thức khuya, làm việc quá sức, ăn uống quá nhiều đường, sữa.
- Sử dụng sản phẩm chăm sóc da phù hợp: sản phẩm rửa mặt, dưỡng ẩm kiềm dầu.

RỤNG TÓC MẢNG

(Alopecia areata)

1. ĐẠI CƯƠNG

1.1. Khái niệm

Rụng tóc mảng (hay rụng tóc vùng, alopecia areata) là rụng tóc không sọc do rối loạn miễn dịch, khởi phát cấp tính với biểu hiện là các mảng rụng tóc ranh giới rõ, hình tròn hoặc bầu dục ở da đầu hoặc các vùng lông khác của cơ thể.

1.2. Dịch tễ

Tỷ lệ nam nữ tương đương nhau. Bệnh thường gặp ở người trẻ, là thể rụng tóc phổ biến nhất ở trẻ em.

1.3. Căn nguyên/Cơ chế bệnh sinh

Bệnh được cho là một bệnh mạn tính tự miễn đặc hiệu cơ quan, trung gian bởi tế bào T-CD8 tự phản ứng chống lại nang tóc, đôi khi cả móng. Bệnh có thể liên quan đến bệnh tự miễn khác như viêm tuyến giáp Hashimoto và bạch biến. Một số yếu tố liên quan cần chú ý như, stress, nhiễm khuẩn, thuốc, thiếu vitamin D...

2. CHẨN ĐOÁN

2.1. Triệu chứng lâm sàng

- Rụng tóc mảng thường xuất hiện đột ngột, rụng hoàn toàn để lại một hoặc nhiều dát hình tròn hoặc oval.
- Vị trí: Da đầu hoặc các vùng có lông khác.
- Da vùng rụng tóc, rụng lông bình thường, không có viêm. Sắc tố của tóc có thể bạc màu, sợi tóc thanh mảnh, nếu mọc lại thường tóc bạc và dễ gãy.
- Không đau, không ngứa tại vùng tổn thương.
- Test kéo tóc dương tính ở giai đoạn hoạt động.
- Tổn thương móng kèm theo: rỗ móng, móng ráp như giấy cát, giòn, dễ gãy, tách móng, đường lõm ngang, dọc...
- Tiến triển của bệnh đa dạng và đặc trưng bởi các đợt tái phát, khoảng 25% bệnh nhân chỉ bị duy nhất một lần, đa phần tóc mọc lại tự nhiên, có khi xuất hiện các đám rụng tóc mới trong khi các đám cũ đang mọc lại. Tuy nhiên, có thể tiến triển thành các thể nặng hơn.

2.2. Cận lâm sàng

- Dermoscopy: Sợi tóc loạn dưỡng (tóc gãy, tóc hình dấu chấm than hoặc chấm

đen), chấm vàng, dấu hiệu tóc tơ.

- Xét nghiệm soi tươi tìm nấm ở da đầu và sợi tóc.
- XN máu: công thức máu, sinh hóa máu để loại trừ các bệnh lý như tuyến giáp, vitamin D.
- Mô bệnh học: nang tóc giảm kích thước, thâm nhiễm lympho quanh mạch, thâm nhiễm lympho quanh nang lông ở tổn thương đang hoạt động.

2.3. Chẩn đoán xác định

- Dựa vào hình ảnh lâm sàng và dermoscopy điển hình.
- Cận lâm sàng: có giá trị khẳng định chẩn đoán và giúp chẩn đoán phân biệt với rụng tóc do nguyên nhân khác.

2.4. Chẩn đoán thể lâm sàng

- Rụng tóc vùng (alopecia areata): có các thể hiếm gặp khác như ophiasis pattern (ngoại vi), sisaipho pattern (trung tâm), diffuse alopecia areata (lan tỏa).
- Rụng tóc toàn bộ (alopecia totalis): rụng toàn bộ tóc trên da đầu.
- Rụng tóc toàn thể (alopecia universalis): rụng toàn bộ tóc trên da đầu và lông trên cơ thể (lông mày, lông mi, râu, lông nách, lông mu, lông tơ).

2.5. Chẩn đoán phân biệt: Rụng tóc có sẹo và rụng tóc không sẹo khác

- Nấm da đầu.
- Rụng tóc có sẹo giai đoạn sớm.
- Rụng tóc do tật nhổ tóc.
- Giang mai 2.
- Rụng tóc androgen.
- Rụng tóc ở giai đoạn ngừng phát triển của tóc.
- Rụng tóc ở giai đoạn phát triển của tóc.

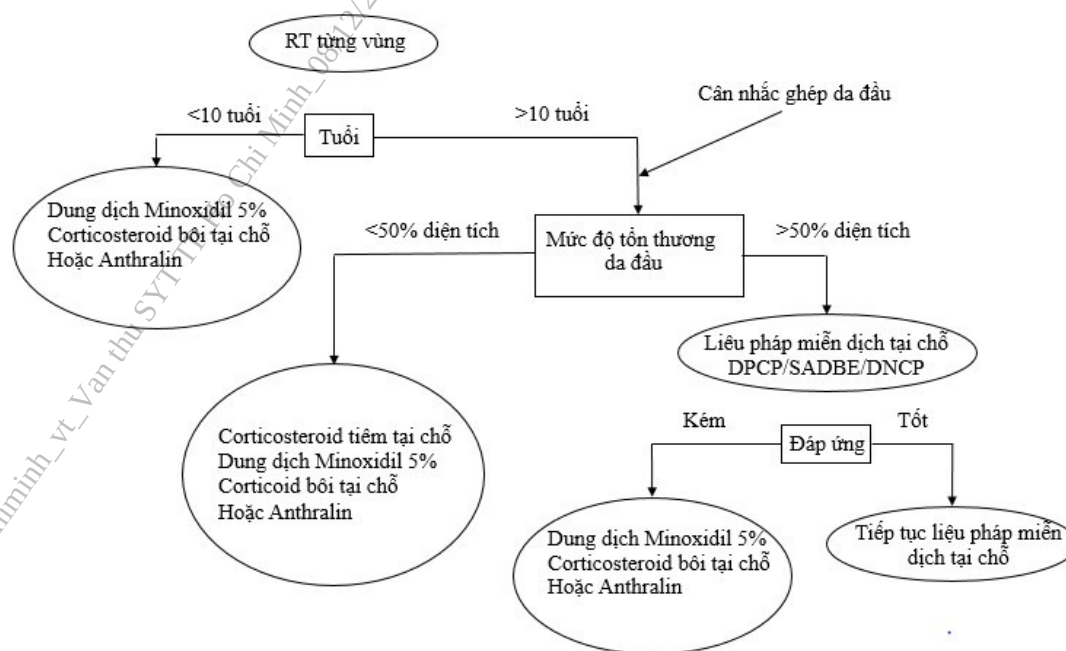
3. ĐIỀU TRỊ

3.1. Nguyên tắc điều trị

- Điều trị càng sớm càng tốt.
- Điều trị các thuốc ức chế miễn dịch và kích thích mọc tóc.
- Tư vấn tâm lý, hỗ trợ thẩm mỹ.

3.2. Điều trị cụ thể

Phác đồ điều trị rụng tóc từng vùng theo nhóm tuổi



3.2.1. Corticosteroid

– Corticosteroid bôi tại chỗ: loại cực mạnh (nhóm 1) và mạnh (nhóm 2) được sử dụng rộng rãi trong điều trị rụng tóc mảng. Bôi 2 lần/ngày trong thời gian dài, thường phải bôi liên tục ít nhất 3 tháng, có thể đến 6 tháng. Có thể bôi 5 ngày/tuần, nghỉ 2 ngày sau đó bôi tiếp để tránh tác dụng phụ.

– Corticosteroid tiêm tại chỗ cho các bệnh nhân bị rụng tóc mảng có tổn thương giới hạn ở da đầu, chân mày và râu. Thuốc thường dùng là triamcinolon acetonide nồng độ 2,5-10 mg/ml tùy vị trí rụng tóc/lông. Da đầu tiêm nồng độ 10 mg/ml. Lông mày tiêm nồng độ 2,5-5 mg/ml. Tiêm dưới da với liều rất nhỏ, mỗi vị trí tiêm 0,05-0,1ml; cách nhau khoảng 1 cm. Sau mỗi 4-6 tuần lặp lại 1 lần tiêm. Tóc mới thường mọc sau 4 tuần, tác dụng phụ chủ yếu là teo da. Sau 3-6 tháng không đáp ứng thì ngừng điều trị. Đây được coi là phương pháp hiệu quả nhất điều trị cho trẻ >10 tuổi.

– Corticosteroid toàn thân chỉ định cho các bệnh nhân bị rụng tóc mảng dạng tiến triển nhanh hay các trường hợp chậm đáp ứng với các phương pháp điều trị khác. Liều trung bình 0.5 mg/kg/ngày trong 6 tuần. Có thể sử dụng liều xung nhỏ, tuần uống 2-3 ngày liên tiếp hoặc liều thấp < 0.5 mg/kg/ngày trong 6 tháng. Thuốc có hiệu quả nhưng hay tái phát sau dừng thuốc cùng với nhiều tác dụng phụ khi sử dụng lâu dài nên không được ưu tiên lựa chọn.

Corticosteroid bôi hoặc tiêm tại chỗ sẽ có tác dụng tốt nếu có sự phối hợp với các phương pháp điều trị khác như: minoxidil, chiếu UVA hay UVB dải hẹp hoặc corticosteroid toàn thân.

3.2.2. Minoxidil

– Dung dịch minoxidil: Hiệu quả đối với rụng tóc mảng nhưng kém đối với rụng tóc toàn thể và rụng tóc toàn bộ. Minoxidil có thể dùng tại chỗ ở da đầu, chân mày hay vùng có râu của nam giới. Nên dùng hàm lượng 5%, xịt tại chỗ 2 lần/ngày, không quá 25 giọt/ngày. Trẻ em cân nhắc dùng nồng độ 2% để hạn chế tác dụng phụ như rậm lông ở mặt, cổ. Tóc thường mọc lại sau khoảng 12 tuần điều trị. Nên dùng kéo dài sau khi tóc đã mọc lại.

– Minoxidil cho hiệu quả tốt khi điều trị phối hợp với corticosteroid nhóm II bôi tại chỗ hoặc corticosteroid tiêm tại chỗ hoặc anthralin. Dùng minoxidil kéo dài sau khi ngừng corticosteroid tại chỗ để duy trì hiệu quả của thuốc, hạn chế tóc rụng lại.

3.2.3. Kích thích miễn dịch tại chỗ

– Đây là phương pháp điều trị tương đối hiệu quả cho các bệnh nhân bị rụng tóc mảng mạn tính với số lượng tóc rụng >50% da đầu. Bệnh nhân được gây cảm ứng bằng cách bôi vào da đầu vùng rụng tóc khoảng 2cm một loại dung dịch có chứa một loại kháng nguyên mạnh ví dụ diphencylcyclopropenone (DPCP) hay diphenycyprone và squaric acid dibutyl ester (SADBE) nồng độ 2%, rửa sạch sau 24 giờ. SADBE là một chất nhạy cảm mạnh nhưng không ổn định trong axeton và thường xuyên bị thủy phân trong quá trình bảo quản nên ưu tiên sử dụng DPCP. Đánh giá lại bệnh nhân sau 2 tuần. Nếu vùng da bôi thuốc xuất hiện phản ứng chàm, tiến hành điều trị trên cả vùng rụng tóc. Bôi toàn bộ vùng da bị rụng tóc mỗi tuần 1 lần, lưu trên da 24h rồi rửa sạch với nồng độ kháng nguyên pha loãng tăng dần, bắt đầu ở nồng độ 0,0001% với mục tiêu gây ra phản ứng chàm nhẹ và ngứa có thể chịu được kéo dài 1-2 ngày. Vì DPCP bị suy giảm bởi ánh sáng, bệnh nhân nên che chắn vùng điều trị khỏi ánh sáng trong 24 giờ sau khi sử dụng. Da chỗ bôi thuốc sẽ nổi hồng ban tróc vảy, ngứa ít và tóc sẽ mọc sau 3 đến 12 tháng.

– Tác dụng phụ của điều trị miễn dịch tại chỗ thường là ngứa và nổi hạch bạch huyết vùng cổ. Có thể xuất hiện viêm da tiếp xúc kích ứng, chàm toàn thân, tăng sắc tố, giảm sắc tố, mày đay, hồng ban đa dạng. Do đó, điều trị bằng phương pháp này chỉ được thực hiện ở bệnh viện.

3.2.4. Anthralin

Anthralin dùng dưới dạng cream hoặc mỡ 0,2-1%, bôi vào vùng tổn thương hàng ngày, lưu thuốc 20-30 phút trong 2 tuần đầu, sau đó 45 phút trong 2 tuần tiếp theo, thời gian lưu thuốc tối đa là 60 phút mỗi ngày. Nếu bệnh nhân có đáp ứng, tóc sẽ mọc lại sau 2-3 tháng. Anthralin có thể dùng ở trẻ em. Không bôi vào lông mày

hoặc râu, tránh UV, rửa thuốc sau thời gian lưu thuốc bằng nước mát hoặc ấm, tránh dùng nước nóng.

3.2.5. Thuốc ức chế Janus kinase đường uống

Tofacitinib là thuốc hay dùng nhất. Liều dùng 5mg x 2 lần/ngày. Thuốc tác dụng sau 3 tháng. Tỷ lệ đáp ứng cao, tác dụng phụ ít nhưng hay tái phát sau dùng nên cần dùng thuốc kéo dài. Nên sử dụng nếu rụng tóc lan tỏa > 50 % diện tích.

3.2.6. Liệu pháp ánh sáng

PUVA và UVB cần nhắc chỉ định trong một số trường hợp kém đáp ứng hoặc phối hợp với thuốc khác. Nên chiếu tối đa 20-40 lần. Thường thì bệnh nhân hay tái phát sau vài tháng ngừng điều trị (4-8 tháng).

3.2.7. Một số thuốc điều trị khác

– Cyclosporin: uống với liều 4-6 mg/kg/ngày cho hiệu quả điều trị trong một số trường hợp rụng tóc mảng. Kết hợp cyclosporin với liều thấp corticosteroid có thể được chỉ định trong rụng tóc mảng. Chú ý tác dụng phụ lên huyết áp và thận. Do tác dụng phụ và tỉ lệ tái phát cao sau khi ngừng thuốc, thuốc này ít được chỉ định.

– Methotrexat: Lựa chọn khi các phương pháp khác không hiệu quả. Liều dùng 2,5-25 mg/tuần. Sau khi dùng thuốc, tóc bắt đầu mọc lại sau 3 tháng, mọc hoàn toàn sau 6-12 tháng. Có thể phối hợp cùng với corticosteroid đường uống. Chú ý các tác dụng phụ trên đường tiêu hóa, tăng men gan, bất thường công thức máu. Hiệu quả ở người lớn hơn trẻ em, tuy nhiên trẻ em ít tái phát hơn người lớn sau khi ngừng điều trị.

– Ức chế calcineurin tại chỗ: Có thể sử dụng tacrolimus hay pimecrolimus bôi ngày 2 lần sáng tối thấy hiệu quả trong một số trường hợp.

4. PHÒNG BỆNH

- Loại bỏ các yếu tố khởi phát: căng thẳng, nhiễm khuẩn.
- Điều trị thiếu hụt vitamin D.
- Điều trị duy trì trong các trường hợp bệnh nặng, tái phát.

RỤNG TÓC DO NỘI TIẾT TỔ NAM (Androgenetic alopecia)

1. ĐẠI CƯƠNG

1.1. Khái niệm

Rụng tóc androgen - rụng tóc do nội tiết tố nam tính (androgenetic alopecia - AGA) hay rụng tóc kiểu hói là tình trạng rụng tóc không sẹo khu trú thường gặp ở cả nam và nữ. Bệnh đặc trưng bởi tình trạng tóc thưa, mỏng đi một cách từ từ tập trung chủ yếu ở vùng trán, đỉnh.

1.2. Dịch tễ

- Thường gặp hơn ở người da trắng, sau đó là châu Á và người Mỹ gốc Phi.
- Bệnh thường có tính chất gia đình, tăng dần theo tuổi.

1.3. Căn nguyên/Cơ chế bệnh sinh

- Bệnh do di truyền đa gen.
- Phần lớn bệnh nhân (cả nam và nữ) có nội tiết bình thường nhưng có tăng biểu hiện của các thụ thể androgen. Một số bệnh nhân có tăng nồng độ androgen. Cơ chế tác động của androgen lên tế bào nang lông dẫn đến rụng tóc androgen chưa rõ. Ở nữ giới, rụng tóc androgen còn liên quan đến vai trò của thiếu chất trung gian thần kinh P.
- Tại các tế bào nang tóc trên da đầu, hormon sinh dục dihydrotestosterone liên kết với các thụ thể androgen tạo phức hợp hormon-receptor, kích hoạt sớm gen có trách nhiệm tác động vào chu trình mọc tóc, làm cho giai đoạn tăng triển ngắn lại, các nang tóc trở nên teo nhỏ, tạo nên các sợi tóc ngắn, mỏng và mảnh.

2. CHẨN ĐOÁN

2.1. Triệu chứng lâm sàng

2.1.1. Rụng tóc androgen ở nam giới

- Tóc rụng thưa mỏng một cách từ từ, thường bắt đầu ở vùng thái dương, vùng trán giữa hoặc vùng đỉnh, vùng chẩm ít bị ảnh hưởng hơn, hậu quả là để lại một vành tóc ở hai bên và vùng chẩm của đầu.
- Nam giới cũng có thể có kiểu hình giống với rụng tóc kiểu hói ở nữ giới, vẫn còn vùng chân tóc phía trước, rụng tóc, thưa mỏng dần phần đỉnh đầu, nhưng ít gặp hơn.
- Thường có rậm lông thứ phát ở nách, mu, ngực, râu cằm.

2.1.2. Rụng tóc androgen ở nữ giới

- Tóc thưa dần trên toàn bộ da đầu, nhưng chủ yếu vùng đỉnh. Vùng tóc ở phía trước thường ít rụng hơn nên không thấy thay đổi đường chân tóc phía trán. Rụng tóc kiểu cây thông Noel.
- Tóc ở vùng rụng mảnh hơn, ngắn hơn trở thành lông tơ và nang tóc gần như teo hoàn toàn. Thường rụng tóc kiểu hói nữ không gây hói toàn bộ.
- Có các dấu hiệu nam hoá do cường androgen như có trứng cá, rậm lông ở thân mình và vùng mặt, kinh nguyệt bất thường (không đều, vòng kinh kéo dài quá 35 ngày hoặc ngắn dưới 21 ngày...).

2.2. Cận lâm sàng

- Dermoscopy:
 - + Đường kính sợi tóc đa dạng.
 - + Tăng tỷ lệ tóc tơ, giảm tóc trưởng thành
 - + Brown halo: vòng màu nâu xung quanh cổ nang tóc.
 - + Yellow dots: chấm tròn màu vàng đến vàng đỏ.
 - + Tăng sắc tố quanh nang lông ở phụ nữ bị rụng tóc androgen.
- Mô bệnh học: nhiều nang tóc ở pha thoái triển, nang tóc giảm kích thước gần như teo hoàn toàn. Tóc chuyển thành lông tơ, sợi tóc ngắn giảm đường kính.
- Xét nghiệm khác: ferritin huyết thanh, TSH (Thyroid Stimulating hormone); testosterone tự do, toàn phần và DHEA-S (Dehydroepiandrosterone - sulfate) tăng đối với phụ nữ có chu kỳ kinh nguyệt không đều hoặc có dấu hiệu tăng tiết androgen. Xét nghiệm được tiến hành vào buổi sáng, trong kỳ kinh và bệnh nhân phải ngừng thuốc tránh thai trong ít nhất 1 tháng.

2.3. Chẩn đoán xác định

Chủ yếu dựa vào triệu chứng lâm sàng và yếu tố giới, tiền sử gia đình.

2.4. Chẩn đoán phân biệt

- Nam giới:
 - + Rụng tóc mảng
 - + Rụng tóc sọc
 - + Tật nhỏ tóc
 - + Rụng tóc do lực kéo
- Nữ giới:
 - + Rụng tóc mảng thể lan tỏa
 - + Rụng tóc telogen
 - + Rụng tóc sọc

- + Rụng tóc xơ hóa vùng trán
- + Rụng tóc do lực kéo

3. ĐIỀU TRỊ

3.1. Nguyên tắc điều trị

- Làm chậm lại sự rụng tóc và tăng lượng tóc bao phủ da đầu.
- Điều trị theo giới.
- Phối hợp nhiều phương pháp.
- Điều trị duy trì.

3.2. Điều trị cụ thể

3.2.1. Điều trị rụng tóc do nội tiết tố nam ở nam giới

- Minoxidil 5%: được FDA cấp phép cho điều trị rụng tóc hói ở nam giới:
 - + Cơ chế tác dụng: Làm mở kênh kali ở cơ trơn của động mạch ngoại vi, tăng tổng hợp DNA, kích thích tế bào gốc nang lông tăng sinh và biệt hóa. Thuốc gây giãn mạch làm tăng cung cấp oxy và dinh dưỡng cho các nang tóc.
 - + Dạng dung dịch: dùng 1ml/lần, 2 lần/ngày; dạng bọt: dùng nửa nắp/lần/ngày thoa nhẹ đều
 - + Lưu ý: minoxidil có thể gây châm chích, viêm da tiếp xúc, tăng rậm lông ở vùng tiếp xúc và rụng tóc xuất hiện tăng từ 2 tuần – 2 tháng đầu sau dùng thuốc do chuyển tóc từ telogen sang anagen).
- Finasterid:
 - + Cơ chế tác dụng: Là chất ức chế 5 α reductase ngăn quá trình chuyển hóa từ testosterone thành dihydrotestosterone.
 - + Finasterid 1mg, uống 1 lần/ngày: được FDA cấp phép cho điều trị rụng tóc hói ở nam giới, hoặc Dutasterid 0,5mg, uống 1 lần/ngày.
 - + Thời gian điều trị tối thiểu trong 1 năm đến lúc đạt hiệu quả sau đó nên điều trị duy trì lâu dài.
 - + Thời gian duy trì không có khuyến cáo cụ thể, tuy nhiên nhiều nghiên cứu dùng thuốc này trong 5 năm cho cải thiện bệnh trên 99,4% các trường hợp.
 - + Thuốc có hiệu quả kém ở người > 40 tuổi và rụng tóc androgen nặng, vậy nên khuyến cáo dùng sớm ở những người trẻ 18 - 40 tuổi, rụng tóc androgen giai đoạn sớm.
 - + Kết hợp với minoxidil 5% để tăng hiệu quả.
 - + Lưu ý: finasterid và dutasterid có thể ảnh hưởng đến khả năng tình dục (nguy cơ

tương đối trên rối loạn chức năng tình dục là 1,21, trên khả năng cương dương là 0,66 và trên ham muốn tình dục là 1,16 trong một số nghiên cứu).

– Lựa chọn khác:

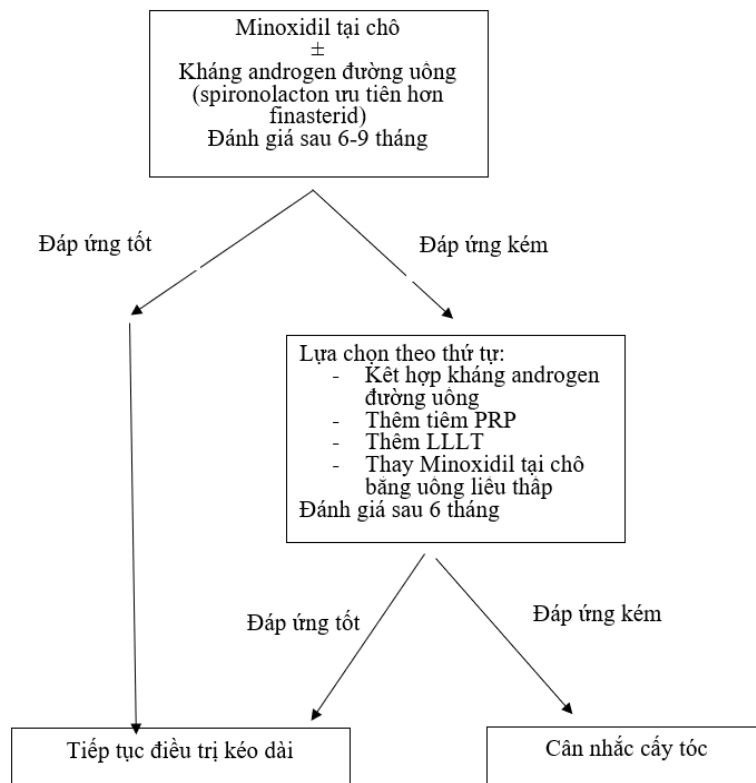
+ Cây tóc: chỉ khuyến cáo cây tóc tự thân. Để tăng hiệu quả, kết hợp với finasterid/dunasterid, minoxidil và các phương pháp khác.

+ Laser năng lượng thấp: được FDA cấp phép cho điều trị rụng tóc hói, chiếu tuần 3 lần/tuần (2 ngày/lần) trong 26 tuần (không khuyến cáo dùng > 6 tháng). Phối hợp với các phương pháp khác để tăng tác dụng.

+ Huyết tương giàu tiểu cầu: phối hợp với các phương pháp khác để tăng tác dụng.

+ Lăn kim, laser, liệu pháp meso: kết hợp cùng với minoxidil tại chỗ, huyết tương giàu tiểu cầu hoặc các yếu tố tăng trưởng khác. Dữ liệu về hiệu quả còn hạn chế.

3.2.2. Điều trị rụng tóc androgen ở nữ



Sơ đồ điều trị rụng tóc do nội tiết tố nam ở nữ giới

- Lựa chọn ưu tiên: Minoxidil:

+ Dạng dung dịch 2%: dùng 1ml/lần, 2 lần/ngày, được FDA cấp phép cho điều trị rụng tóc hói ở nữ giới.

+ Dạng bọt 5%: dùng nửa nắp/lần/ngày thoa nhẹ đều.

– Lựa chọn khác: thuốc kháng androgen:

- + Spironolacton: là một chất đối kháng cạnh tranh yếu trong sự kết nối giữa androgen với receptor và làm giảm sự tổng hợp testosterone, liều uống 200mg/ngày có thể ức chế androgen sau 4-12 tháng.
- + Cyproterone acetate uống 50mg/ngày.
- + Finasterid và dutasterid không được khuyến cáo ưu tiên trong điều trị rụng tóc androgen ở nữ đặc biệt trong độ tuổi sinh sản vì phân loại thai kỳ X.
- + Lưu ý: không sử dụng thuốc kháng androgen cho phụ nữ mang thai. Theo dõi huyết áp và điện giải khi dùng spironolacton.
- Các phương pháp điều trị khác tương tự điều trị rụng tóc androgen ở nam giới. Kết hợp với minoxidil, thuốc kháng androgen và các phương pháp với nhau để tăng hiệu quả điều trị.

4. PHÒNG BỆNH

Rụng tóc androgen là bệnh lý liên quan đến hormon và yếu tố di truyền nên phòng bệnh không phải là yếu tố chính.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Bộ môn Da liễu - Trường Đại học Y Hà Nội. *Bệnh học Da liễu*, tập I, tập II, tập III. Nhà xuất bản Y học, Hà Nội 2017.
2. Bệnh viện Da Liễu Trung Ương – Trường Đại học Y Hà Nội. *Hình ảnh lâm sàng, chẩn đoán và điều trị trong chuyên ngành Da liễu*, tập I, tập II. Nhà xuất bản Y học, Hà Nội 2019.
3. Nguyễn Hữu Sáu. *Bệnh da nhiễm trùng*. Nhà xuất bản Y học, Hà Nội 2018.
4. Nguyễn Hữu Sáu, Trần Hậu Khang. *Chẩn đoán, điều trị và dự phòng ung thư da*. Nhà xuất bản Y học, Hà Nội 2018.
5. Tổng hội Y học Việt Nam. *Hướng dẫn chăm sóc và điều trị bệnh vảy nến*. Nhà xuất bản y học, Hà Nội 2017.
6. Trần Văn Thuấn, Lê Văn Quảng, Nguyễn Tiến Quang. *Hướng dẫn chẩn đoán điều trị bệnh ung thư thường gặp*. Nhà xuất bản Y học, Hà Nội 2019.
7. Nguyễn Đại Bình. *Chẩn đoán và điều trị bệnh ung thư*. Nhà xuất bản Y học, Hà Nội 2007.
8. Nguyễn Bá Đức, Trần Văn Thuấn, Nguyễn Tuyết Mai. *Điều trị nội khoa bệnh ung thư*. Nhà xuất bản Y học, Hà Nội 2010.
9. Bộ Y Tế. *Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị*. Nhà xuất bản Y học, Hà Nội 2016.
10. Hướng dẫn chẩn đoán điều trị và dự phòng bệnh lao (Ban hành kèm theo Quyết định số: 1314/QĐ-BYT ngày 24 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế).
11. Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị các bệnh da liễu (ban hành kèm theo Quyết định số 75/QĐ-BYT ngày 13/01/2015)
12. Hội Da Liễu Nhật Bản, *Hướng dẫn chẩn đoán điều trị*, 2018
<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/1346-8138.14523>
13. Tran Hau Khang. *Research of Leprosy in Viet nam*, LAP LAMBERT Academic Publishing House, 2020.
14. Tran Hau Khang, Ngo Minh Thao and Le Huu Doanh. *Epidemiology of Leprosy in Viet nam and the Effectiveness of Multidrug Therapy (MDT) in the Managemant of the Disease*. Book: *Current Topics in Neglected Tropical Diseases*. INTCHOPEN BOOK SERIES. INFECTIOUS DISEASES, Vol 3. Published in London, United Kingdom 2019; P: 93-109.
15. Stephen I. Katz. *Fitzpatrick's Dermatology*, 9th edition. McGraw Hill Education-2019.